

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ELISANGELA REINHEIMER DE BITTENCOURT

**A ESCUTA DA CRIANÇA NOS PROCESSOS DE MEDICALIZAÇÃO NA
APRENDIZAGEM**

Porto Alegre

2026

ELISANGELA REINHEIMER DE BITTENCOURT

**A ESCUTA DA CRIANÇA NOS PROCESSOS DE MEDICALIZAÇÃO NA
APRENDIZAGEM**

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Educação.

Orientador: Prof. Dr. Elisandro Rodrigues

Linha de Pesquisa: Educação Especial, Saúde e Processos Inclusivos

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Reinheimer de Bittencourt , Elisangela
A escuta da criança nos processos de medicalização
na aprendizagem / Elisangela Reinheimer de
Bittencourt . -- 2026.
202 f.
Orientadora: Elisamdro Rodrigues.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, Programa de
Pós-Graduação em Educação, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Infância . 2. Medicalização . 3. Escola. 4.
Diagnóstico . 5. Patologização . I. Rodrigues,
Elisamdro, orient. II. Título.

BANCA EXAMINADORA

Dissertação defendida em: 07 de Abril de 2026.

Dr. Elisandro Rodrigues – Orientador
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dra. Claudia Rodrigues de Freitas
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Dra. Larissa Costa Beber Scherer
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)

Dr. Tiago Almeida
Universidade Instituto Politécnico de Lisboa

A todas as crianças

AGRADECIMENTOS

Agradeço, antes de tudo, a Deus, pela vida e pela oportunidade que me foi concedida. À minha família, meu alicerce e direção, especialmente aos meus pais, Enio e Zilá, que são, em todos os tempos, a minha bússola.

Ao Natan, meu filho, expressão do amor mais profundo que pude conhecer e sentir. Ao Osmar pelo apoio e companheirismo que têm sustentado tantos passos.

Ao Professor Orientador, Dr Elisandro Rodrigues, pela dedicação, escuta atenta, orientação e generosa disponibilidade ao longo de todo o percurso.

Às crianças que cruzaram meu caminho e, em especial, àquelas que, com tanta generosidade, se dispuseram ao encontro e à pesquisa: Riley, Bing Bong, Dave, Frank, Clow e Jangles. Vocês tornaram tudo mais vivo, mais possível e mais verdadeiro. Vocês foram *Maravilhantes!* Aos amigos e colegas do NAE, pelas trocas, pela parceria e pelos caminhos compartilhados.

À amiga e Professora Dra Magale Machado de Camargo, pela escuta, pelo tempo partilhado, pela troca, dedicação e amizade, minha profunda gratidão.

Ao Professor e Diretor Glauco e a toda a equipe da Escola Ana Maria Fay, que, no início de tudo, abriram para mim as portas do mundo da educação.

Aos funcionários, professores e colegas do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS e do Palavrar, pela convivência, pelas interlocuções e pelas construções coletivas.

In memoriam de Juninho, que hoje brinca nos céus e permanece vivo nas lembranças, nos afetos e na delicadeza de sua existência. À minha prima Rafaela Reinheimer, terapeuta ocupacional e trabalhadora da saúde mental, cuja trajetória de cuidado, escuta e compromisso com o outro segue ecoando como presença e inspiração.

A todos que, de diferentes formas, caminharam comigo neste percurso, deixo minha profunda gratidão. Esta dissertação também é feita dos encontros, afetos, escutas e marcas compartilhadas ao longo do caminho.

RESUMO

A presente pesquisa tem como foco a escuta de crianças, com o objetivo de compreender sua percepção e experiência subjetiva nos processos de medicalização da aprendizagem, incluindo a patologização das dificuldades escolares e o uso de psicofármacos. O estudo foi realizado com seis crianças atendidas em um Serviço de Atendimento Especializado em um município da região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O objetivo central foi compreender como as crianças vivenciam e atribuem sentidos aos processos de saúde e aprendizagem, valorizando sua subjetividade e sua voz como elementos centrais da análise. A metodologia, de caráter qualitativo, exploratório e transversal, fundamenta-se na perspectiva psicanalítica, utilizando brincadeiras, desenhos e outras formas de expressão como ferramentas de diálogo. Os instrumentos incluíram diário de campo, gravações de áudio, análise documental de laudos e pareceres, momentos lúdicos, questionário sociodemográfico e entrevistas. Além disso, familiares e educadores foram entrevistados para compreender suas percepções sobre a relação da criança com o processo de aprendizagem. A pesquisa evidenciou a visão singular, contextualizada e dinâmica de cada criança, mostrando que aprender envolve relações, vínculos e experiências de pertencimento. Os resultados indicam que as crianças não compreendem suas dificuldades apenas a partir de diagnósticos ou categorias médicas; suas falas revelam que a aprendizagem está ligada a relações, interesse pelas atividades e experiências de inclusão ou exclusão. A análise dos dados foi organizada em cinco categorias emergentes dos relatos das crianças: Desejo de aprender; Ajudação: aprender em relação e processos inclusivos; A (des)atenção para além do déficit: significados e contextos; Infância, brincadeira e laço social: o aprender no encontro; e A participação infantil na pesquisa: escuta e lugar. Os resultados apontam a escola como espaço de encontro e laço social.

Palavras-chave: Infância, Medicalização, Escola, Subjetividade, Diagnóstico, Patologização.

ABSTRACT

This research focuses on listening to children, aiming to understand their perception and subjective experience in the processes of medicalization of learning, including the pathologization of school difficulties and the use of psychotropic medications. The study was conducted with six children attending a Specialized Learning Support Service in a municipality of the metropolitan region of Porto Alegre, Rio Grande do Sul. The central objective was to comprehend how children experience and attribute meaning to health and learning processes, valuing their subjectivity and voice as central elements of analysis. The methodology, qualitative, exploratory, and cross-sectional in nature, is grounded in a psychoanalytic perspective, using play, drawings, and other forms of expression as tools for dialogue. Instruments included a field diary, audio recordings, documentary analysis of reports and evaluations, playful sessions, a sociodemographic questionnaire, and interviews. Additionally, family members and educators were interviewed to understand their perceptions regarding the child's relationship with the learning process. The research revealed each child's singular, contextualized, and dynamic perspective, showing that learning involves relationships, bonds, and experiences of belonging. The results indicate that children do not understand their difficulties solely through diagnoses or medical categories; their narratives demonstrate that learning is linked to relationships, interest in activities, and experiences of inclusion or exclusion. Data analysis was organized into five categories emerging from the children's reports: *Desire to Learn*; *Helping: learning in relation and inclusive processes*; *(Dis)attention beyond deficit: meanings and contexts*; *Childhood, play, and social bonds: learning in encounter*; and *Children's participation in research: listening and space*. The results point to the school as a space for encounter and social bonding.

Keywords: Childhood, Medicalization, School, Subjectivity, Diagnosis, Pathologization

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Pesquisa realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, com os descritores	76
Quadro 2 – Síntese dos procedimentos da coleta de dados	88
Quadro 3 – Sequência de procedimentos de pesquisa.....	88
Quadro 4 – Descrição dos participantes	96

LISTA DE FIGURAS

Desenho 1 – Bing Bong, 07/08/2025.....	132
Desenho 2 – Clow, 05/08/2025	148
Desenho 3 – Jangles, 04/08/2025.....	149

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AEE: Atendimento Educacional Especializado
ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APA: Associação Americana de Psiquiatria
CAPES: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES
CAPSi: Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência
CNS: Conselho Nacional de Saúde
CONANDA: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
CRAS: Centro de Referência em Assistência Social
CREAS: Centro de Referência Especializado em Assistência Social
CT: Conselho Tutelar
DDA: Distúrbio de Déficit de Atenção
DCM: Disfunção Cerebral Mínima
DSM: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente
ESF: Estratégia de Saúde da Família
IBGE: Instituto Brasileiro de Pesquisas
LBI: Lei Brasileira de Inclusão
LDBEN: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
PNEEPEI: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva
SSI: Sistema de Saúde Americano
SUS: Sistema Único de Saúde
TDA: Transtorno de Déficit de Atenção
TDAH: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade
TEA: Transtorno do Espectro do Autismo
TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TALE: Termo de Assentimento Livre e Esclarecido
UBS: Unidade Básica de Saúde
UFRGS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UNICEF: Fundo das Nações Unidas para a Infância

SUMÁRIO

1 RISCOS, RASTROS E RABISCOS NO CHÃO	14
1.1 Primeiros rastros - Prólogo	14
1.2 Rabiscos introdutórios	17
1.3 Labirinto e descaminhos: medicalização, escola e subjetividade	19
1.4 O desenho inacabado: a pergunta que nos move.....	23
1.5 Objetivos	24
1.5.1 Objetivo geral	24
1.5.2 Objetivos específicos	24
2 BALIZADORES TEÓRICOS.....	24
2.1 Construções históricas da infância e da medicalização.....	25
2.1.1 Caminhos da infância: uma trajetória até a modernidade	26
2.1.2 Processos de medicalização da vida: um pouco de história	31
2.1.3 Laço Social, neoliberalismo, subjetividade e a escola contemporânea.....	35
2.2 O encontro entre educação, saúde e medicalização na aprendizagem	41
2.2.1 Processo de medicalização e patologização na educação	42
2.2.2 Do guarda-chuva ao espectro: considerações sobre a expansão diagnóstica na infância.....	45
2.2.3 Repetir, diagnosticar e medicalizar: problematizações sobre a aprendizagem na educação contemporânea.....	51
2.3 Processos de aprendizagem e a construção do laço social na escola.....	55
2.3.1 Processos de aprendizagem	56
2.3.2 Atenção: dimensão fundamental	58
2.3.3 Escola: afeto, laço e socialização.....	64
2.3.4 Educação Especial e Processos Inclusivos.....	68
2.4 Novos caminhos: da crítica às possibilidades	70
2.4.1 Trilhas para a singularidade: a escuta da criança e sua participação nas pesquisas	71
2.4.2 Medicalização na infância: que caminhos apontam as pesquisas da CAPES?	75
3 METODOLOGIA	78
3.1 Delineamento	80
3.2 Contexto do Estudo	81
3.3 Participantes do estudo.....	82

3.4 Técnicas e instrumentos para coleta de dados.....	82
3.4.1 Momento lúdico: Brincar e imaginar	83
3.4.2 Questionário e entrevistas - levantamento de dados sociodemográficos e narrativos.....	86
3.4.3 Imagens que contam histórias: recurso metodológico de foto-elicitação	87
3.4.4 Quadro de síntese dos procedimentos de coleta de dados.....	88
3.4.5 Sequência de procedimentos de pesquisa.....	88
3.5 Questões éticas.....	89
3.6 Organização e estratégia para análise de dados.....	92
4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS PARTICIPANTES	94
4.1 Percursos da aprendizagem: trilhas singulares das crianças participantes	94
4.1.1 Dave	97
4.1.1.1 Trajetória em Educação e Saúde	98
4.1.2 Bing Bong.....	99
4.1.2.1 Trajetória em Educação e Saúde	100
4.1.3 Frank	100
4.1.3.1 Trajetória em Educação e Saúde	101
4.1.4 Jangles.....	102
4.1.4.1 Trajetória em Educação e Saúde	103
4.1.5 Riley	105
4.1.5.1 Trajetória em Educação e Saúde	105
4.1.6 Clow	106
4.1.6.1 Trajetória em Educação e Saúde	107
4.2 Apresentação dos resultados e análise dos dados: vozes, trajetórias e significados	108
4.2.1 Traçando o percurso analítico	108
4.3 Desejo de aprender	109
4.4 Ajudação: aprender em relação e processos inclusivos.....	128
4.5 A (des)atenção para além do déficit: significados e contextos	134
4.6 Infância, brincadeira e laço social: o aprender no encontro	146
4.7 A participação infantil na pesquisa: escuta e lugar	155
5 PALAVRAS E RABISCOS FINAIS.....	162
REFERÊNCIAS	165

APÊNDICES	178
APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE (Famíliares e/ou Responsáveis).....	178
APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE (Profissionais)	183
APÊNDICE 3 TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE (Crianças Maiores 9-12 Anos)	188
APÊNDICE 4 TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE (Crianças Menores 6-9 Anos)	190
APÊNDICE 5 - FICHA QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICOS E CONTEXTO DA FAMÍLIA	192
APÊNDICE 6: ENTREVISTA FAMILIAR.....	194
APÊNDICE 7: ENTREVISTA DA CRIANÇA	195
APÊNDICE 8: ENTREVISTA ESCOLAR	197
APÊNDICE 9: FIGURAS DE FOTO ELICITAÇÃO.....	198
APÊNDICE 10: EU NA MINHA ESCOLA.....	200

1 RISCOS, RASTROS E RABISCOS NO CHÃO

Este capítulo percorre os riscos, rastros e rabiscos que compõem o caminho até esta dissertação. No prólogo, compartilho fragmentos da minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, marcados por encontros, inquietações e experiências que mobilizaram meu olhar para a infância, a aprendizagem e os processos de medicalização. Em seguida, os rabiscos introdutórios conduzem às reflexões sobre escola, subjetividade e medicalização, em um percurso atravessado por descaminhos, tensionamentos e perguntas. Por fim, apresento a questão de pesquisa que emerge desse trajeto e que sustenta a construção desta investigação.

1.1 Primeiros rastros - *Prólogo*

No processo de formação e na atuação profissional em psicologia, imergimos em diferentes contextos, dentre eles, o espaço escolar, e somos levados a refletir sobre a atuação dos profissionais de saúde e educação em diversas situações. No decorrer dessa trajetória, temos a possibilidade de observar os processos pedagógicos, o ambiente da escola e da rede intersetorial, onde ocorrem as práticas profissionais, para ampliar nossas perspectivas e assim fazer dialogar com os diversos atores que estruturam esse cenário.

Trata-se de um chão onde deixamos e encontramos riscos, rastros e rabiscos, marcas que indicam caminhos, incertezas e possibilidades, como uma grande folha em branco sobre a qual se escreve a experiência. Com base no exposto, cabe dizer que a presente pesquisa se estrutura contando com essas experiências, uma vez que elas oportunizam o encontro com crianças no ambiente educacional. Diante do compartilhamento dessas vivências, surgiram inquietações e desafios, aqui tomados como rastros de um percurso, como rabiscos de uma escuta e como propostas à reflexão conjunta.

O termo *conjunta* e o pronome “nós”, empregados no decorrer da escrita, são utilizados em razão de algumas considerações que traço a partir da minha subjetividade e das minhas leituras, e também por agregar olhares de professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da linha de pesquisa *Educação Especial, Saúde e Processos Inclusivos*, no grupo *Palavrar - Laboratório de práticas e montagens pedagógicas do*

ler, escrever, pesquisar e, principalmente, do meu orientador, Prof. Dr. Elisandro Rodrigues. Minha escolha por este Programa de Pós-Graduação em Educação deve-se ao alinhamento entre a linha de pesquisa mencionada e a temática que me acompanha desde a graduação: as imbricações entre infância, educação e processos de medicalização.

Formada em Psicologia, minha trajetória profissional foi marcada pela intersectorialidade. Atuei em diferentes espaços da rede de cuidado, como no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), na Estratégia de Saúde da Família (ESF), no Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSi) e em escolas. Estas experiências compuseram um percurso formativo e ampliaram meu interesse pela articulação entre as políticas públicas e o cuidado infantil. Foi, entretanto, a minha inserção no campo educacional que se constituiu como um dos principais marcos dessa trajetória. Ao atuar como psicóloga escolar e educacional, comecei a delinear novos caminhos na minha formação.

Essa articulação entre saúde e educação já me chamava a atenção e percebi que, com grande força e regularidade, as questões educativas e de aprendizagem apareciam nos serviços de saúde, cujas queixas oscilavam desde o comportamento escolar até as dificuldades de concentração ou de aprendizagem. Assim, essas experiências clínicas apresentavam o público infantil também ligado às vivências e fraturas educacionais.

Ao final da graduação em Psicologia, já era possível perceber que a infância e a psicanálise, especialmente pela potente ferramenta da escuta, seriam centrais na minha trajetória acadêmica e profissional. Meu Trabalho de Conclusão de Curso foi construído com base nesses temas e buscou investigar, em 2019, como os estudos sobre medicalização escutavam a criança. Naquele momento, não encontrei resultados que respondessem a essa indagação. Ao longo do tempo, a lacuna intensificou o meu desejo de escutar e compreender os sentidos produzidos pela criança nesse processo, conduzindo-me até a presente pesquisa.

A partir das vivências intersectoriais e da entrada na educação, iniciou-se um novo caminho com inúmeros desdobramentos. A experiência direta com as crianças nesses diferentes contextos, somada às experiências profissionais e inquietações que surgiram ao longo da prática profissional, me fizeram emergir e sustentar o desejo de aprofundar os estudos sobre os processos de medicalização, bem como seus efeitos e desdobramentos na infância. Isso porque, no contexto escolar, refletem-se as

dificuldades que podem ser experimentadas pelas crianças e pelos adolescentes, as quais estão relacionadas ao aumento de diagnósticos, ao processo de medicalização infantil e à pressão por desempenho escolar a que eles são submetidos. Muitas vezes estas ações se sobrepõem às necessidades do desenvolvimento emocional e subjetivo de cada um.

Com frequência percebe-se que a busca por atendimento em saúde infantil é pautada por questões ligadas aos impasses escolares e, ao recorrer ao saber da medicina e dos especialistas, exclui-se as potencialidades da escola e do professor que, na grande maioria das vezes, não têm suporte adequado para resolver tais questões dentro do ambiente escolar. Entretanto, a entrada do especialista, geralmente da área da saúde, marca como possíveis diagnósticos a diversidade da expressão humana e as diferentes formas de aprendizagem, podendo com isso silenciar as reais causas dos problemas enfrentados (Collares, Moysés, 1994). Dado o exposto, o presente estudo versa sobre a percepção das crianças e os sentidos atribuídos por elas, a partir da sua própria experiência, para compreender as implicações de intervenções medicalizantes e refletir sobre alternativas que respeitem e acolham a subjetividade do infante.

Ressalto que suscitar este debate não se trata de desqualificar os saberes médicos ou os desafios pedagógicos. Configura-se, antes, de insistir na reflexão sobre os acontecimentos que rodeiam a criança, considerando a compreensão das dificuldades de aprendizagem, do diagnóstico de transtornos em saúde mental, da patologização e dos processos de medicalização. Em outras palavras, trata-se de investir na construção de mais possibilidades pedagógicas voltadas ao encontro entre educação e saúde. É desse lugar, entre a inquietação ética e o compromisso com a práxis, que este prólogo se inscreve e daqui que a investigação se lança.

Considerando que a psicologia utiliza a escuta como uma forma de cuidado, este estudo se propõe a ouvir a criança, a partir de sua experiência e percepção, sobre os processos que as envolvem. Assim, torna-se essencial escutar a criança também em seu processo educativo, uma vez que, conforme Baptista (2019), o fazer pedagógico está diretamente envolvido na interação, no diálogo e nas ações de escuta entre os sujeitos.

Daremos destaque ao que aqui denominamos como uma tríade: a dificuldade de aprendizagem como manifestação nos processos de aprender; a patologização, entendida como um amplo campo da saúde no qual se constroem formulações

diagnósticas; e o processo de medicalização, que, por sua vez, pode estar relacionado ao consumo de psicofármacos na infância, considerando seu aumento nos últimos anos (Brasil, 2013; Carneiro, Reys, 2024). Nesse sentido, consideramos neste estudo três eixos centrais: dificuldade de aprendizagem, patologização e medicalização. Diante dessa tríade, propomos uma escuta que valorize os aspectos subjetivos e contextuais do infante, a fim de corroborar seu desenvolvimento integral.

É importante destacar que o presente estudo volta-se à escuta da criança, não necessariamente a que se encontra inserida nas políticas públicas de educação especial na perspectiva inclusiva, mas sim àqueles alunos que apresentam dificuldades e desafios em suas experiências de aprendizado e enfrentam adversidades no ambiente escolar. Esses alunos podem não possuir deficiências e se encontram no contexto educacional no sentido mais abrangente como alunos regulares; no entanto, enfrentam obstáculos que necessitam de um olhar ampliado e cuidadoso, bem como uma aprendizagem fundamentada em estratégias pedagógicas diferentes das convencionais.

1.2 Rabiscos introdutórios

Por rabiscos. É assim que muitas vezes a infância se expressa e se inscreve no mundo, com traços imprecisos, linhas que fogem à forma esperada, gestos que ultrapassam os limites do papel. Assim como a própria criança, os rabiscos carregam movimento, exploração e invenção. No entanto, em uma sociedade que busca alinhar e corrigir o traço, o que é expressão singular pode ser lido como desvio.

É nesse ponto que a presente pesquisa se situa: nos espaços em que o ato de aprender se encontra com o ato de normatizar e onde o que é próprio da infância, como brincar, experimentar, errar, corre o risco de ser transformado em sintoma. O estudo propõe refletir sobre os processos de medicalização e patologização da infância na aprendizagem e especialmente sobre como os adultos, ao tentar enquadrar o traço infantil, acabam por silenciar parte daquilo que o torna humano.

Diante dessa reflexão, a presente pesquisa tem como tema o processo de medicalização no contexto da infância buscando compreender como esse fenômeno se constitui e se legitima nas práticas sociais e educacionais. A medicalização é entendida como um processo pelo qual problemas que não são de ordem médica passam a ser concebidos como doenças e transtornos que necessitam de tratamento

e intervenção da medicina (Conrad, 2007). Os processos medicalizantes se estenderam para diversas áreas da vida, inclusive a infância, em que comportamentos e dificuldades consideradas destoantes do desenvolvimento esperado passam a ser vistos pela ótica médica, desconsiderando seus contextos sociais e políticos (Zorzanelli, Ortega, Bezerra Junior, 2014; Moysés, Collares, 2026; Christofari, Freitas, Baptista, 2015; Guarido, 2007). Os processos medicalizantes são tidos como a solução mais rápida aos impasses infantis, mas podem impedir um olhar ampliado às demandas subjetivas e educacionais da criança (Christofari, Freitas, Baptista, 2015).

Dessa forma, a normatização no ambiente escolar, ao tentar endireitar os traços imprecisos, corre o risco de apagar expressões que compõem a subjetividade da criança, silenciando o sintoma, justamente a via pela qual a criança precisa para ser escutada, para que possa produzir novos significados que resultem em experiências significativas nos seus processos de aprendizagem. É nesse cenário, marcado por tensionamentos, que se insere o presente estudo. A pesquisa foi realizada em um Serviço de Atendimento Especializado localizado em um município da região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de um serviço multiprofissional que atende crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e questões psicossociais. Os participantes são estudantes da rede municipal de ensino, encaminhados pelas escolas em função de entraves e dificuldades em seu processo educativo.

Enquanto desenho metodológico, essa pesquisa é de abordagem qualitativa, privilegiando a interpretação dos fenômenos a partir da escuta e da análise das experiências narradas por crianças, educadores e responsáveis. Também foi realizada análise documental, incluindo encaminhamentos, laudos e relatórios, com o objetivo de contextualizar a trajetória de saúde e escolar das crianças. A escuta, orientada pelos referenciais teóricos, considerou os discursos familiar, escolar e clínico, possibilitando compreender a posição subjetiva das crianças, além dos efeitos dos processos de medicalização e patologização em suas formas de expressão.

O referencial teórico desta pesquisa está ancorado em conceitos que abordam a infância como construção social, os processos de subjetivação, as relações entre educação e não aprendizagem, somados aos processos de medicalização e patologização em uma perspectiva crítica. Também contempla a escuta da criança nas pesquisas, considerando a sua participação a partir de diferentes campos do conhecimento e constituindo-se como eixo central desta

investigação. Esses elementos possibilitam articular medicalização, aprendizagem, subjetividade e infância como uma base para as análises desenvolvidas neste estudo.

Nesse contexto, a presente pesquisa busca compreender os efeitos subjetivos e sentidos dos processos de medicalização no campo educacional, apostando na escuta das crianças como via fundamental para compreender as suas experiências e para produzir deslocamentos que possibilitem outras formas de significar as dificuldades de aprendizagem para além da lógica normatizante.

1.3 Labirinto e descaminhos: medicalização, escola e subjetividade

Entre rabiscos traçados no chão, alguns delineiam caminhos, nem sempre lineares, que compõem os labirintos e descaminhos das dificuldades de aprendizagem na infância. No cenário educacional atual, a crescente preocupação com as dificuldades de aprendizagem geram evidente angústia na sociedade em relação ao desempenho das crianças, algo que, com frequência, resulta na patologização dos problemas de aprendizagem (Moysés, Collares, 2026). Para Moysés (2001), os processos de medicalização adentram a educação ao incidirem sobre questões de aprendizagem e comportamento, atribuídas socialmente à medicina, à qual se delega não apenas a normatização, mas também funções de regulação e vigilância da vida. Moysés e Collares (2026) afirmam que esse processo se instaura no campo educacional quando dificuldades de aprendizagem ou comportamentos considerados inadequados passam a demandar correção. Desse modo, inicia-se um reducionismo terapêutico que centra no indivíduo a responsabilidade pelo não aprender.

Em virtude disso, abre-se um vasto campo de estudos, marcado por impasses, discussões e pela busca de respostas para as dificuldades escolares (Collares, Moysés, 1994). Uma das vias encontradas tem sido a crescente procura por diagnósticos, exames, medicação e especialistas em transtornos de comportamento e aprendizagem (Arantes, 2017). Nesse contexto, o espaço escolar passa a reforçar ideais de normalidade, incorporando como doenças os problemas de aprendizagem e atribuindo à criança o peso dessas dificuldades (Collares, Moysés, 1994). Ao estabelecer a relação entre problemas de aprendizagem e doenças, temos como referência uma ideia de normalidade, ou seja, de uma norma a ser seguida. No entanto, considerando a relação da doença com o meio social, atravessado por

histórias e acontecimentos imprevisíveis, compreende-se que, como afirma Canguilhem, “o normal é viver num meio onde flutuações e novos acontecimentos são possíveis” (2017, p.188). Nessa perspectiva, Winnicott (2000) assinala que em determinadas situações pode ser mais comum a criança estar mais doente do que bem, podendo ser o sintoma ou o adoecimento uma forma de comunicação com aquele ambiente. Assim, torna-se necessário um olhar ampliado aos aspectos subjetivos, a fim de evitar reducionismos, sobretudo diante de classificações amplamente adotadas na organização diagnóstica dos transtornos mentais.

A partir de classificações utilizadas mundialmente, como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), publicado pela Associação Americana de Psiquiatria (APA), que apresentam critérios padronizados baseados na descrição de sintomas e comportamentos na descrição de transtornos mentais, podem ocorrer simplificações para a compreensão das questões mentais (Lima, 2005). Neste sentido, Lima (2005) discute que estes manuais podem ser comparados a procedimentos de *checklist*, fornecendo informações limitadas sobre a criança, uma vez que desconsidera os aspectos sociais, subjetivos e contextuais relacionados a ela.

Torna-se pertinente assinalar o conceito de sintoma na perspectiva psicanalítica, entendido como manifestação de conflitos inconscientes que podem se expressar, por exemplo, em dificuldades de aprendizagem ou questões comportamentais. No ambiente escolar, tais manifestações apontam para conteúdos singulares da criança, exigindo acolhimento e produção de sentido (Lajonquière, 1997). De acordo com Mannoni (2004), o sintoma se manifesta por fatores atuais e antigos, ou seja, podem ser disparados no ambiente escolar, contudo se relacionam a conflitos estruturais já presentes na constituição subjetiva dos indivíduos. Mannoni (2004, p.73) preconiza que o “sintoma é uma linguagem que nos cabe decifrar”. Para a autora, o declínio escolar é um sintoma, que passa a ser uma forma pela qual a criança alerta aos adultos de que não está bem e, neste sentido, podemos considerar que o sintoma opera como um pedido de ajuda. Collares e Moysés (1994) afirmam ainda que os processos medicalizantes silenciam tais sintomas, suprimindo assim expressões que são, na verdade, pistas para a resposta do não aprender da criança.

Um exemplo disso é a expansão diagnóstica do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) vista nos últimos anos, que é evidenciada pelo surgimento principalmente no ambiente escolar, devido às características do

transtorno que se tornam mais visíveis nessa fase do desenvolvimento (Caliman, 2010). Esse crescimento relaciona-se à organização da sociedade contemporânea, que tende a restringir a pluralidade dos modos de aprendizagem. Nesse cenário, observa-se também o aumento expressivo do uso de metilfenidato, principal medicamento indicado para o TDAH, cuja produção no Brasil, entre os anos 1996 a 2012, teve uma expansão em torno de 6.322% (Ortega *et al.*, 2010). Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), também indicam aumento no consumo de psicofármacos direcionado ao campo da infância (Brasil, 2013).

O Brasil figura entre os maiores consumidores destes fármacos, indicados para dificuldades relacionadas à atenção e à agitação, amplamente divulgados por seus efeitos na ampliação do foco e na diminuição da inquietação. O metilfenidato é o medicamento mais prescrito para os diagnósticos de TDAH no Brasil e, conforme alguns autores, esse potencial crescimento deriva também das práticas de enquadramento dos problemas que as crianças apresentam nas escolas ao TDAH, tornando-se cada vez mais rotineiras (Ortega *et al.*, 2010).

Esse fenômeno não se restringe ao Brasil. Ponnou (2024) aponta que em estudos realizados na França, o metilfenidato é o medicamento mais prescrito para as crianças com diagnóstico de TDAH, bem como em outros países. Atualmente, em contexto estadunidense, crianças ainda muito pequenas, antes de completarem dois anos de idade, vêm sendo classificadas a partir de supostas limitações relacionadas a um ritmo cognitivo reduzido, considerado mais devagar, e, assim, submetidas ao uso de psicofármacos estimulantes como forma de intervenção (Moysés; Collares, 2026). Tais características, frequentemente classificadas como desvios no cenário atual, acabam sendo rapidamente enquadradas no campo clínico. Nesse contexto, observa-se a centralidade das intervenções medicamentosas, que tendem a ser adotadas como principal estratégia no manejo terapêutico de diagnósticos em saúde mental (Mazon, Bianchi, 2026).

A facilitação do diagnóstico vem adquirindo cada vez mais espaço nos meios de comunicação, o que possibilita que esse enquadramento seja gerado em outros ambientes, como na própria escola (Santos, Freitas, 2016). Em uma experiência norte-americana, Whitaker (2017) denuncia a expansão dos diagnósticos e prescrição de psicofármacos na sociedade atual, que adentra também a infância. Em um recorte temporal, o autor aponta que no ano de 1987 havia no Sistema de Saúde Americano (SSI) 16.200 crianças menores de 18 anos consideradas incapacitadas por doença

mental grave, isto é, um correspondente de 5,5% na totalidade do quadro de invalidez no país. Nota-se uma grande elevação a partir dos anos 90 e, em 2007, o grupo de crianças acometidas por questões mentais e consideradas inválidas atingiu 50% do total (Whitaker, 2017). A exemplo dessa tendência contemporânea, percebemos a inflação diagnóstica evidenciada na transição das classificações do TDAH para o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no decorrer dos últimos anos.

Conforme Brzozowski e Caponi (2013), a medicalização na infância passa por diversas esferas, vindo mais a serviço de tamponar uma queixa do mundo adulto sobre a criança do que propriamente beneficiá-la. Neste sentido, a regulação do comportamento infantil que a sociedade almeja como o ideal para o aprendizado e para a convivência passa a englobar, de maneira generalizada, uma patologização dos comportamentos considerados fora do padrão. Segundo Zorzanelli, Ortega, Bezerra Junior (2014), uma das facetas do processo de medicalização é o estabelecimento de transtornos à comportamentos que se desviam da norma social de sua época, isto é, o fruto de uma idealização imposta sobre determinado grupo populacional. De acordo com Lima (2005), vivemos em uma sociedade que não espera o tempo da aprendizagem da criança, que pode ser variável, e as exigências de bom desempenho e adequação ao sistema de ensino se tornam cada vez maiores, agravando este quadro. Além disso, Sarmento (2005) afirma que a humanidade constituiu, ao longo da história, um lugar para a criança e espera que ela o ocupe.

Para Besset (2024), esse processo vem acompanhado das transformações sociais contemporâneas, como a fragilidade das relações parentais. Papéis ocupados pelos pais anteriormente, suas decisões e percepções, em boa parte, são agora exercidos por um especialista. Esses fenômenos não possuem relação de causa e efeito, mas estão entrelaçados à medida em que a autoridade parental se torna enfraquecida na tarefa de educar os filhos, sendo transferida, muitas vezes, também à escola. Na busca por auxílio para a criança, o diagnóstico atua como um ato de nomeação que produz uma teoria explicativa sobre os sujeitos, dando uma direção à educação parental e escolar. Essa nomeação diagnóstica age como um dispositivo para tratar essas dificuldades e fortalece o discurso patologizante entre a família e a escola (Kamers, 2015).

A partir dos dados supracitados e da problematização apresentada, a comunidade científica precisa avançar nos estudos e na prerrogativa de que tratamentos, encaminhamentos, diagnósticos e recursos medicamentosos, dados

como prioridade, em detrimento da escuta do sofrimento, produzem um reducionismo terapêutico (Brzozowski, Caponi, 2013; Guarido, 2008). Para Birman (2003), os processos de medicalização foram sendo moldados e transformados ao longo do tempo e ganharam novos contornos na contemporaneidade, sendo atravessados pelas novas formas de subjetivação, mal-estar e sofrimento, exigindo uma análise cuidadosa.

1.4 O desenho inacabado: a pergunta que nos move

Diante da incursão apresentada, passamos a nos perguntar sobre a posição da criança e como ela experiencia esses processos relacionados à tríade dificuldades de aprendizagem, patologização e processos de medicalização. Concebemos as dificuldades de aprendizagem como manifestações subjetivas que muitas vezes são desveladas a partir de questões apresentadas na escola. As diferentes formas da criança se colocar nas relações também convocam o Outro¹ nas figuras de pais, professores, pesquisadores, entre outros atores da escola, a lidar com essas manifestações. A aproximação, por parte do pesquisador, do lugar da criança, em uma atitude empática e dialógica, pode auxiliar no posicionamento dos demais adultos frente aos sintomas apresentados. Nesse sentido, como pesquisadores, compondo o universo dos adultos, passamos a nos questionar sobre o lugar da criança nessa lógica arquitetônica discursiva. Especialmente em relação a essa tríade das dificuldades de aprendizagem, da patologização, do processo de medicalização e o uso de psicofármacos, problematizamos sobre como essas práticas impactam as subjetividades infantis, suas vivências escolares e as dinâmicas de cuidado que lhes são oferecidas.

Nessa perspectiva, justificamos este estudo por apresentar o que as crianças têm a dizer sobre sua experiência referente às abordagens dos campos da educação e saúde mental, disparadas por problemas escolares, assim como a percepção da escola e famílias durante esse processo. Dessa forma, a pesquisa busca a participação das crianças envolvidas nesse processo trazendo suas vozes a serem apresentadas na relação entre infância, educação, aprendizagem e processo de

¹ Grande Outro: Termo que se refere à instância simbólica que organiza a linguagem, a lei e os significantes que estruturam o sujeito e a experiência subjetiva (Ferreira, 2022).

medicalização. Intuímos novas possibilidades de vida ao explorar o contexto e o universo no entorno da criança e ao proporcionar intervenções que levem em consideração diferentes aspectos da aprendizagem e da constituição subjetiva dela.

Portanto, interrogamo-nos sobre as percepções e sentidos que a criança atribui aos efeitos da medicalização e patologização de suas dificuldades de aprendizagem em sua subjetividade no espaço escolar, e buscamos compreender de que forma sua participação e sua voz podem ampliar a compreensão desse processo.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo geral

Compreender no contexto escolar como a criança percebe e produz sentidos sobre os efeitos do processo de medicalização e a patologização de suas dificuldades de aprendizagem em sua subjetividade.

1.5.2 Objetivos específicos

- a) Compreender como se constituiu a demanda escolar das crianças participantes do estudo para o encaminhamento aos profissionais de saúde;
- b) Identificar as formas de manifestações das crianças participantes do estudo;
- c) Investigar as percepções da criança sobre as dificuldades de aprendizagem, a patologização e o uso de psicofármacos;
- d) Compreender como a criança vivencia e expressa suas dificuldades e queixas escolares, identificando possíveis caminhos de intervenção no contexto educacional.

2 BALIZADORES TEÓRICOS

O referencial teórico desta pesquisa está balizado em conceitos que, como traços que pouco a pouco se desenham, delineiam deslocamentos na forma de compreender a infância, os processos de medicalização, a educação, a patologização do não aprender e a escuta das crianças nas pesquisas que as envolvem. Realizamos

uma incursão teórica utilizando autores e teorias tradicionais e da atualidade fundamentais para se trabalhar a problemática em questão, os objetivos propostos e realizar as análises dos materiais selecionados para o estudo. Dito de outra forma, buscamos conceitualizações que avaliamos como sendo indispensáveis para tratar sobre a infância e os processos medicalizantes que adentram a educação escolar, bem como os imbricamentos do discurso normatizador e patologizante que se cruzam no contexto.

Podemos, neste sentido, pensar com Freud, em *O mal-estar na civilização* (2020), que versa sobre os conflitos e o sofrimento produzidos a partir das demandas culturais; Ariès (1981), sob a perspectiva da infância na história e como uma construção social; e Lajonquière (1997; 1999), cujas obras se debruçam sobre os processos de subjetivação e os processos pedagógicos. Além disso, buscamos autores que debatem o processo de medicalização a partir de uma perspectiva histórica e crítica, como Conrad (1975; 2007), Moysés e Collares (1994; 2015; 2017; 2026), Ortega *et al.* (2010), Caliman (2008; 2010) e Zorzanelli *et al.* (2014). No tocante à participação das crianças nas pesquisas, dialogamos com alguns estudos de áreas do conhecimento diversas, como a antropologia e a sociologia, a exemplo de Manuel Jacinto Sarmiento (2002; 2005; 2004; 2008; 2011; 2015), Cohn (2005; 2010) e Castro (2013). A escolha por esses autores possibilitou uma costura de conceitos que permitem compor tessituras, unindo processo de medicalização, aprendizagem, escuta, subjetividade e infância.

2.1 Construções históricas da infância e da medicalização

Este capítulo busca estabelecer balizadores teóricos ao explorar as construções históricas e sociais que traçam a compreensão atual da infância e da medicalização. Inicialmente, o subcapítulo 2.1.1, “Caminhos da infância: uma trajetória até a modernidade”, traça a trajetória histórica da infância, situando-a como uma categoria social e culturalmente construída e em constante transformação até a modernidade. Em seguida, o subcapítulo 2.1.2, “Processos de medicalização da vida: um pouco de história”, retoma os processos de medicalização da vida, discutindo a expansão e a evolução desse conceito, trazendo uma perspectiva crítica e histórica. Por fim, o subcapítulo 2.1.3, “Laço Social, neoliberalismo, subjetividade e a escola contemporânea”, analisa o complexo entrelaçamento entre o laço social e o

neoliberalismo na subjetividade contemporânea, refletindo sobre como as exigências de desempenho e produtividade, que também atravessam o espaço escolar, acabam por intensificar os processos de medicalização.

2.1.1 Caminhos da infância: uma trajetória até a modernidade

Este capítulo aborda a constituição histórica e social da infância, compreendendo-a como uma categoria construída culturalmente e em constante transformação. Ao percorrer o trajeto da infância até a modernidade, busca-se evidenciar como mudanças sociais, políticas e econômicas influenciaram as concepções sobre a criança e o seu lugar na sociedade e na educação.

Para Corsaro (2011), um dos principais teóricos da sociologia da infância, a mesma deve ser compreendida a partir de uma perspectiva que reconhece as crianças como agentes ativos que, em interação com seus pares, participam da produção cultural e social. Nessa mesma direção, Sarmento (2003), sustenta que a infância também é produtora de cultura, destacando a capacidade das crianças de interpretar e construir sentidos na sociedade em que estão inseridas.

De acordo com a perspectiva histórica de Philippe Ariès (1981), o conceito e a noção de infância foram socialmente construídos, modificando-se ao longo do tempo conforme fatores econômicos, sociais, culturais, entre outros, e adquirindo diferentes sentidos de acordo com o imaginário social de cada época. Enquanto na Idade Média a criança era vista como um "adulto em miniatura", foi apenas entre os séculos XVI e XVII que emergiu o reconhecimento da infância como uma etapa distinta de desenvolvimento humano. Nesse sentido, compreende-se que o conceito de infância não pode ser universalizado, naturalizado ou homogeneizado. Para analisá-lo, faz-se necessário considerar o contexto da criança, bem como os fatores sociais que influenciam suas vivências (Martins, Garanhani, 2009). Ainda na perspectiva histórica, a infância deixa de ser percebida como um momento transitório e desprovido de relevância, passando a ser considerada como uma etapa constitutiva e determinante para a noção de indivíduo no advento da modernidade. Sarmento (2008) postula a noção de "infâncias", estabelecidas no plural, enfatizando sua multiplicidade de aspectos, referindo-se ao tempo e lugar em que elas são estabelecidas, o que as torna distintas umas das outras por diversos marcadores sociais.

A concepção de infância e a forma como os adultos provêm cuidado e atenção a essa fase do desenvolvimento humano variaram significativamente ao longo da história, diferindo do discurso e das práticas atuais. Enquanto a noção de infância não era entendida como uma fase do desenvolvimento que necessitava de cuidado diferenciado dos adultos, era naturalizado que, em tenra idade, as crianças fossem consideradas capazes de gerir suas próprias vidas. Essas concepções exerciam influência sobre suas funções sociais, uma vez que, mesmo com pouca idade, elas contribuíam de forma significativa no sustento de suas famílias (Ariès, 1981). É válido mencionar que, na atualidade, embora a criança ocupe outro papel no meio social e familiar, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Pesquisas (IBGE), em 2022, cerca de 1,9 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam envolvidos em trabalho infantil. Dentre eles, 756 mil exerciam trabalho infantil, com risco à saúde e de acidentes (Brasil, 2024).

Na discussão proposta por Ariès (1981), o papel da criança no seio familiar estava à margem da atenção principal. Para este autor, a construção social da infância aconteceu de maneira paralela às mudanças na organização familiar e à inserção da criança na escola, sendo influenciada por elas. Ariès (1981) destaca ainda que as brincadeiras e jogos infantis não se distinguiam dos costumes adultos, por exemplo, um bibelô de porcelana, tido como um objeto decorativo, era também utilizado como um brinquedo para a criança.

Contudo, mesmo que a infância não fosse diferenciada, o início da vida já era marcado pela necessidade de cuidado. Foi apenas a partir do século XVII que começou a emergir aspectos da infância que concebemos hoje, pelo chamado “sentimento de infância”. Segundo a historiadora brasileira Clarice Cohn (2010), ao referenciar os estudos de Ariès (1981), o surgimento do *sentimento de infância* contemporâneo não se relaciona a dimensões emotivas e afetivas, mas à ideia de infância como uma fase distinta da vida adulta. Não foi apenas essa cisão que delimitou o conceito de sentimento de infância, mas, paralelamente a esse processo, ocorreu o desenvolvimento da escola enquanto instituição e as transformações da estrutura familiar, que se tornou mais nuclear e menos vinculada ao parentesco extenso.

Ariès (1981) afirma que o *sentimento de infância* surge de forma gradual e não linear, trazendo a ideia de reconhecimento da infância. O *sentimento de infância* também evidencia o lugar que a criança passa a ocupar nas relações familiares,

passando a ser reconhecida a partir de atributos como ingenuidade e inocência. Para Ariès (1981), as inúmeras transformações que moldaram a infância ao longo do tempo na constituição social também podem ser observadas na arte, na educação e em outros costumes influenciados por aspectos sociais do seu tempo.

A história nos mostra ainda que, inicialmente em nossa civilização, apenas um pequeno número de crianças tinha acesso à educação formal, mais precisamente, aquelas provenientes de famílias mais abastadas economicamente. Essa educação era baseada na preparação para o indivíduo adulto, uma vez que visava educá-las com valores morais e disciplinares:

A escola e o colégio que, na Idade Média, eram reservados a um pequeno número de clérigos e misturavam as diferentes idades dentro de um espírito de liberdade de costumes, se tornaram no início dos tempos modernos um meio de isolar cada vez mais as crianças durante um período de formação tanto moral como intelectual, de adestrá-las, graças a uma disciplina mais autoritária, e, desse modo, separá-las da sociedade e dos adultos (Ariès, 1981, p.165).

Esse trecho evidencia a escola da época preservando a disciplina, passando a exercer um papel concomitante e central no isolamento e controle das crianças. Nesta via, em conjunto com o viés da moralidade, o conhecimento e as capacidades racionais são também impostos às crianças, modulando seus comportamentos. Desse modo, ao mesmo tempo em que almejava formar sujeitos que contribuiriam com a sociedade, a escola também produzia separação entre as crianças e adultos.

Assim, por longos períodos na história, poucas crianças tinham acesso à educação formal. Foi apenas a partir do século XVI que a consolidação mais significativa do acesso à escola abrangeu a maior parte da população. Nesse viés, Ariès (1981) aponta que a escola se transformou ao longo do tempo num espaço com uma perspectiva moral e disciplinadora. A consolidação da educação passou a ser mais do que um preparo para a vida através da aquisição de conhecimento e foi constituindo também o estabelecimento de normas e comportamentos socialmente idealizados e aceitos. Isso transcende para uma concepção que modela comportamentos de acordo com o mundo adulto, fortalecendo o ideal de obediência e conformidade.

A uniformização e normatização dos padrões educacionais consolidaram paradigmas alinhados à ideia de desenvolvimento contínuo, derivada do novo sentimento de infância. Esse ideal, orientado pelo progresso e pela evolução, promove

a homogeneização do desenvolvimento infantil, reforçando a ideia de experiência padronizada das vivências infantis (Almeida, 2023). Para Carneiro (2021), o mundo adulto sempre ditou a infância, ou seja, suas delimitações e transformações fazem parte dele. Já Castro (2003) afirma ainda que a infância é dotada de sentidos a partir dos discursos construídos e das interações acerca dela. Nesse sentido, pode-se avançar para uma compreensão mais contemporânea ao dialogarmos esses conceitos com o que propõe Walter Kohan (2003, p. 86):

Com a invenção ou a intensificação dos sentimentos em torno da infância, a educação passa a ser, como de certa forma queria Platão, uma questão de Estado. Não se pode deixar a educação das crianças nas mãos do acaso ou da vida privada das famílias. Vimos, com M. Foucault, como a criação da instituição escolar caminha junto a complexos dispositivos disciplinares que gradualmente disseminam sua produtividade por todo o corpo social e como essas funções, que primeiro são expressas de forma corretiva, aos poucos adquirem uma forma produtiva.

Numa perspectiva longitudinal, a infância, além de perpassada pelo tempo, também é influenciada pela evolução e transformações afetivas e instintivas (Birman, 2016). No século XIX, na era moderna, ela passa a estar regulada pelo estado, uma vez instituído o sistema de educação obrigatória que visa preparar gradativamente a criança para a entrada no mundo adulto.

Dentre essas modificações, além das transformações na organização familiar e individual do sujeito, observa-se hoje o surgimento e o uso cada vez mais precoce das tecnologias da informação. Soma-se a isso a influência da lógica de mercado nas relações interpessoais e o reposicionamento da criança no meio social. A educação na infância, permeada por essas mudanças, resultou na instituição do dever familiar de assegurar o acesso primordial à saúde e, conseqüentemente, à educação (Ariès, 1981). Ao Estado, por sua vez, cabe o papel de proporcionar as condições para tal. Dessa forma, o sistema educacional se desenvolveu para corresponder às novas expectativas de cuidado e ao novo lugar da criança no seio familiar e na sociedade moderna. Portanto, a infância passa a ser considerada uma etapa constituinte e determinante para o indivíduo, sendo também regulada pelo Estado e valorizada como um período propício à qualificação dos sujeitos. Inserida no imaginário social de cada época, a infância é percebida como potencial de mudanças sociais, conferindo à escola um papel fundamental nesse processo.

A partir daí, tornando-se estrategicamente um lugar de investimento para o futuro, a infância teve em seu entorno uma conotação de riqueza e necessitava de investimento do mundo adulto. A criança então começa a ser vista como o “presente de um futuro renovado” (Sarmiento, 2002, p. 280). A exemplo disso, Sarmiento (2005) destaca o conjunto de valores e artefatos culturais presentes na produção de bens voltados à infância, os quais atravessam as práticas discursivas, produzem novas formas de olhar a criança e acrescentam uma nova dimensão simbólica às experiências das infâncias contemporâneas mediadas pelo consumo (Sarmiento, 2005). Essa infância, que significava o início da vida, passou a ser concebida como uma etapa decisiva do desenvolvimento dos sujeitos e implicada diretamente na qualidade de vida da população, a qual já estava perpassada também pela medicina. Conforme as afirmações de Kohan (2003, p. 87),

O papel das crianças na família traz novas regras para as relações entre pais e filhos. Não é apenas uma questão de sorrisos e brincadeiras. A família se ocupa como nunca antes em cuidar da saúde dos filhos. As novas leis morais se concentram na higiene, na amamentação direta pelas mães, na vestimenta cuidada e pulcra, em exercícios físicos para um bom desenvolvimento do corpo, e toda uma série de cuidados afetivos que estreitam os laços entre pais e filhos. Surge uma nova conjugalidade que se organiza não tanto para unir dois adultos, senão para servir de matriz a esse futuro adulto de que os pais cuidam como nunca.

A família, por sua vez, precisou, a partir dali, não apenas reconhecer a infância, mas também investir e se sacrificar para garantir à criança o acesso à saúde e à educação (Birman, 2016). Porém, na proporção destes investimentos em educação e saúde, a disciplina e o retorno através do corpo foram sendo cobrados da criança (Birman, 2016). A infância então passa a ocupar um espaço regulado pelo Estado: seja pela família, introduzindo o bem estar social; pela escola, exigindo o desempenho; ou pela medicina, buscando garantir a saúde do futuro adulto.

Espera-se, portanto, que as crianças correspondam aos ideais desse mundo adulto, o que faz com que as suas dificuldades de aprendizagem gerem impasses que vêm a ser sanados pelo saber da medicina. Consequentemente, na atualidade, o neoliberalismo adentra à educação transformando a aprendizagem e o conhecimento em uma forma instrumental para a preparação ao mundo do trabalho. Observa-se, assim, uma infância atravessada por questões que podem trazer prejuízos ao desenvolvimento integral da criança, uma vez que são elas “as principais vítimas da voracidade capitalista, notadamente no que diz respeito aos resultados da

globalização social, da crise educacional e das mutações do mundo do trabalho” (Sarmiento, 2002, p.16).

Em consonância com nossas lentes teóricas, é essencial entender como as concepções de cuidado e atenção à infância se estruturaram ao longo do tempo para abordar o processo de medicalização da vida, objeto central do próximo subcapítulo. Assim, compreender os processos medicalizantes e suas estruturas é imprescindível para nos debruçarmos na problematização da medicalização e patologização da vida, que se desdobraram na infância e no espaço escolar, conforme será explorado a seguir.

2.1.2 Processos de medicalização da vida: um pouco de história

O conceito de medicalização ampliou-se significativamente ao longo do tempo, perpassando esferas médicas, comportamentais e sociais, o que contribuiu para uma diversificação de sentidos na literatura científica (Zorzanelli, Ortega, Bezerra Jr., 2014; Freitas, Amarante, 2017). Portanto, cabe aqui elucidar a perspectiva que orienta nossas reflexões neste subcapítulo, para auxiliar a compreensão e as análises.

Zorzanelli, Ortega, Bezerra Junior (2014) analisam os processos medicalizantes em relação às especificidades de seus respectivos contextos históricos. Algumas dessas perspectivas apontadas pelos autores sobre o tema são apresentadas por Wootton (1956) e Szasz (2007). Nas décadas de 1950 e 1960, eles observaram a expansão do termo para incluir questões de indisciplina, ou seja, comportamentos desviantes passaram a ser vistos como patológicos e, conseqüentemente, tratados como problemas médicos.

Inspirada pelos trabalhos de Freidson (1988), Zola (1972) e Illich (1976), a medicalização é concebida no âmbito da sociologia médica. Segundo essa perspectiva, os processos de medicalização vinculam-se ao “controle social e ao imperialismo médico”, que culminam na perda de autonomia do indivíduo sobre o próprio corpo.

Já nas obras de Conrad (1975), a medicalização é entendida como a posse do discurso médico sobre situações da vida que não pertenciam originalmente ao campo da medicina. Consoante a essa compreensão, Zorzanelli, Ortega, Bezerra Junior (2014) apontam que a medicina assume também uma função social e moral, e

a medicalização se apresenta como um processo dinâmico, perpassado por aspectos culturais, políticos e econômicos.

Conrad (2007) destaca ainda que a expansão da medicalização envolve diferentes agentes sociais, incluindo instituições médicas, consumidores e indústrias voltadas à produção de tecnologias e fármacos, que atuam como vetores na ampliação do alcance do discurso médico sobre variadas dimensões da vida. Neste sentido, o processo de medicalização não é exatamente igual nas últimas décadas, ele vem sofrendo alterações que seguem o movimento contemporâneo da sociedade. Atualmente observa-se que os processos de medicalização incorporam novas tecnologias e práticas, ampliando sua lógica de intervenção sob a vida. Esse movimento é mencionado por Zorzanelli, Ortega e Bezerra Junior (2014), que evidenciam que a medicalização atual não se reduz às dinâmicas descritas nas décadas anteriores, mas se expande em articulação com transformações científicas e sociais. A partir dos anos 2000, o conceito de biomedicalização emerge para descrever a continuidade dos processos medicalizantes, que se expandem para além do corpo. Este fenômeno caracteriza-se pela apropriação da medicina por tecnologias moleculares e genéticas, bem como pelo consumo de psicofármacos para o aprimoramento cognitivo (Zorzanelli, Ortega e Bezerra Junior, 2014)

Os estudos de Zorzanelli, Ortega e Bezerra Junior (2014) também indicam que a medicalização não se restringe a ações impostas por instituições ou profissionais de saúde; ela pode igualmente ser estimulada por demandas sociais, quando indivíduos e grupos buscam no discurso médico formas de legitimação, alívio ou organização de conflitos cotidianos. Os autores destacam ainda que a crítica à medicalização não implica a negação do sofrimento ou das condições clínicas existentes, mas visa problematizar as formas pelas quais determinados problemas são definidos, regulados e tratados no interior do discurso médico.

Compreende-se, então, que a medicalização ocorre de modo irregular, que muda conforme o contexto, sendo determinada por fatores sociais, assumindo diferentes formas e podendo voltar-se para populações específicas ou culturas distintas. Em linhas gerais, essa variabilidade implica que determinados modos de agir ou expressões de comportamento tendem a ser mais facilmente transformados em questões médicas, tornando alguns grupos mais suscetíveis aos processos medicalizantes, a depender das normas sociais vigentes e das expectativas dirigidas aos sujeitos em cada contexto histórico. Fora do espectro da medicina, a

medicalização assume outras formas: instituições podem ser medicalizadas sem a presença de profissionais da medicina, o que demonstra a ampliação desse processo (Zorzanelli, Ortega e Bezerra Junior, 2014)

O modelo de manejo da saúde em questão silencia o sofrimento individual, ao mesmo tempo que avança sobre a passividade do sujeito. Ele ignora a dimensão subjetiva do mal-estar, descartando elementos relacionais, éticos, sociais, históricos, econômicos e políticos que moldam a realidade psíquica e corporal. Essa abordagem perde de vista a contextualização do adoecimento, focando o tratamento (desde o diagnóstico até sua direção) exclusivamente nos aspectos físicos e químicos do organismo. Em um mundo que tende a suprimir a dor com substâncias químicas e a exaltação da performance, a psicanálise apresenta uma concepção onde o mal-estar pode ser significado, em vez de meramente silenciado ou reprimido. É o que a teoria freudiana sustenta como a ideia de uma transformação psíquica que se efetiva por meio da palavra e dos processos de elaboração.

No texto de Freud (2020), “O mal-estar na civilização”, ele se ocupa do conflito existente entre a experiência de satisfação singular de cada sujeito e as exigências morais da sociedade, encontrando na moral civilizatória um dos fatores como uma das fontes de sofrimento humano. Para Szasz (1991), “a psiquiatria é, entre outras coisas, a negação institucionalizada da natureza trágica da vida” (*apud* Bezerra *et al.*, 2014, p.9), a partir desta afirmação, pode-se fazer uma leitura sobre a relação estabelecida entre a sociedade e o saber médico. Para o autor supracitado, a psiquiatria estaria a serviço do controle social da existência humana, em que transforma a experiência de sofrimento em diagnóstico médico, convertendo a angústia e as doenças mentais em fenômenos passíveis de intervenções técnicas.

Nessa perspectiva, segundo Bezerra (2014), a ciência psiquiátrica está a serviço de salvaguardar os indivíduos do encontro com as questões trágicas da vida que, em outra instância, fazem parte da incompletude humana. Classificando por meio de categorias diagnósticas as angústias dos sujeitos, passa então, pela premissa científica, a produzir discursos normatizadores sobre a vida. Nessa dicotomia entre compreender as diversas e inesgotáveis formas sofrimento perante as experiências da vida, as abordagens biologicistas buscam nas categorias e classificações respostas de forma empírica para todas as nuances inerentes ao comportamento humano (Brendel, 2006, *apud* Bezerra, 2014).

O campo teórico e prático da psiquiatria está intrinsecamente ligado a dimensões sociais, culturais e políticas, mais do que qualquer outro da medicina, atravessado pelo sofrimento e mal-estar contemporâneo, pois entra na dicotomia do “conhecimento e cuidado” (Bezerra *et al.*, 2014, p.11). Para Birman (2003), o mal-estar humano inscreve-se de forma singular pela via do corpo e da ação, impactando diretamente a subjetividade. Como afirma Canguilhem (2017) que “o *pathos* precede o *logos*”, as vivências de dor e sofrimento, que todos padecemos, exigem um enfrentamento que o homem moderno não está disposto a realizar, adentrando assim, em processos medicalizantes.

Para Dunker (2020) a produção diagnóstica inquestionada assume com caráter reducionista, transformando sofrimento psíquico em perturbações neurológicas, colocando-as numa lógica mercantil de como a dor e o sofrimento contemporâneo devem ser reconhecidos. Reside no fato supracitado que a construção diagnóstica se torna simplória, incorporada às formas de tratamento do próprio sofrimento humano pela adição da medicação, tratando a dor e sofrimento subjetivo, como apenas um conjunto de sinapses e ligações químicas, reduzindo as experiências subjetivas e empobrecendo as possibilidades narrativas (Dunker, 2020).

Embora Freud não tenha discutido diretamente o conceito de medicalização, como é entendido contemporaneamente, sua análise do sofrimento psíquico e da tensão entre indivíduo e civilização, sobretudo no texto em questão, oferece um fundamento teórico relevante para pensar os processos de medicalização da vida. Nesta obra, o autor descreve como a civilização impõe renúncias às pulsões humanas, gerando um mal-estar estrutural no sujeito. Esse mal-estar leva o ser humano a buscar saídas, o que pode ser observado na contemporaneidade quando, para muitos, tais experiências passam a ser objeto de intervenções médicas ou farmacológicas. Nesse sentido a psicanálise freudiana permite compreender como a medicalização pode se configurar como resposta aos sofrimentos inerentes à condição humana e à vida em sociedade.

Atualmente, observa-se um crescente deslocamento para o campo da saúde, especialmente o médico, de problemas inerentes à vida. Isso ocorre com a transformação de questões coletivas, de ordem social e política, em questões individuais e biológicas, o que isenta de responsabilidade as instâncias de poder nas quais tais problemas são gerados e perpetuados (Moysés, Collares, 2026; Freitas, Amarante, 2017).

Assim, os processos medicalizantes, de forma cada vez mais intensa, adentram as experiências da vida, deslocando o sofrimento para o domínio da saúde, sobretudo do campo médico e áreas subjacentes, na medida em que questões coletivas passam a ser reinterpretadas como dificuldades de natureza orgânica (Freitas, Amarante, 2017).

Dessa maneira, os discursos em torno das promessas de saúde e bem-estar e ideais de felicidade permeiam esse campo. Os altos índices de psicofármacos evidenciam os processos medicalizantes na contemporaneidade. Na medicalização, a medicina no sentido geral, não apenas a profissão, mas a necessidade de bem estar, se torna um dispositivo de grande controle social, se sobrepondo inclusive, às leis simbólicas e até mesmo à religião. Para os autores a inovação medicamentosa se sustenta nesse discurso, atrelado a indústria farmacêutica, produzindo a ideia de avanço para além da dicotomia saúde-doença (Freitas, Amarante, 2017).

Como apontado pela Guarido (2008) e por Allen Frances (2016), na obra *Voltando ao normal*, a posição contrária em torno do reducionismo biológico e processos medicalizantes não rejeita os avanços da ciência em torno das pesquisas e tratamentos de doenças, mas sim os seus excessos advindos da psiquiatria contemporânea. Mas, dessa forma, compreender as nuances desse processo é fundamental para desvelar as relações entre a saúde, a doença e as experiências subjetivas.

2.1.3 Laço Social, neoliberalismo, subjetividade e a escola contemporânea

Na análise da história dos processos de medicalização, observa-se que, gradualmente, as dificuldades individuais passaram a ser interpretadas como problemas clínicos. Nesse contexto, é pertinente refletir sobre como, na contemporaneidade, o neoliberalismo reforça essa tendência, tanto por meio da responsabilização individual pelo desempenho quanto pelo uso de indicadores que definem sucesso e fracasso. Embora esta abordagem não seja a tônica do presente estudo, entende-se que este tema nos permite pensar um recorte dentro da tópica dos processos de medicalização, presentes no cenário contemporâneo.

A modernidade se constitui a partir de uma sucessão de mudanças, definidas pelo rompimento com a sociedade tradicional rumo à moderna, o que exige respostas rápidas dos indivíduos em várias esferas sociais. Na contemporaneidade, entretanto,

esses deslocamentos se intensificam diante dos imperativos produtivos e econômicos, pois, na lógica neoliberal, as mudanças não se restringem às mudanças políticas, mas também se refletem em questões subjetivas, nas quais as ideias de autonomia e disciplina se tornam internalizadas, abrangendo os modos de ser e de agir (Dardot, Laval, 2017).

Segundo Byung-Chul Han (2024), todo período histórico traz consigo padecimentos próprios de seu tempo. Nesse sentido, a modernidade apresenta, em suas mazelas, questões mentais que despontam neste século. Para o autor, no século XXI, a concepção de sociedade disciplinar foucaultiana não proporciona mais uma leitura fiel da realidade, outrossim, a ela soma-se a ideia de sociedade de desempenho, marcada pela produtividade. O poder ilimitado é uma característica desse modelo, em que não existem impossibilidades ou limites; ao contrário, os indivíduos buscam a gestão de si próprios, amparados por uma concepção de superação e motivação para atingir objetivos.

Dessa forma, Han (2017) explica que a sociedade disciplinar dá lugar à sociedade de desempenho, marcada por um novo modelo de performance e produtividade. Enquanto a primeira, segundo o autor, produz loucura e atos de delinquência, a sociedade do desempenho gera indivíduos deprimidos e com sensação de fracasso. Por meio de uma lógica social internalizada que busca alta produtividade, mesmo substituindo o sujeito da obediência, o sujeito do desempenho permanece obstinado em suas atribuições.

Para o autor supracitado, a sociedade do desempenho é mais eficaz porque traz aos indivíduos a “sensação de liberdade”, embora passem a explorar a si próprios, causando adoecimento mental. Essa nova organização social é guiada por um positivismo que torna tudo produtivo e consumível, também caracterizado pelo excesso. Por outro lado, os aspectos negativos, que poderiam gerar estranheza, estabelecer limites e favorecer relações de alteridade, provocam a perda da diferenciação, dando origem ao que Han (2017) denomina dialética da negatividade, na qual a própria imagem retorna para si como um espelho, reforçada pelo não reconhecimento do outro.

Birman (2016) afirma que a alteridade se estabelece por meio do reconhecimento das diferenças entre os indivíduos. Ainda segundo o autor, a noção estética e performática da subjetividade influencia a relação com o Outro, moldando também as interações sociais. A lógica neoliberal e suas estruturas extrapolam ao

campo econômico e se estendem em todas as áreas da existência humana (Dardot, Laval, 2017). A subjetividade, assim, passa a ser moldada pelos valores e estruturas sociais de cada época. Na atualidade, a noção de que cada indivíduo deve se tornar “empresário de si mesmo” reflete a pressão constante por desempenho, que já se manifesta na infância sob a forma de cobrança e expectativas precoces.

Para Byung-Chul Han (2017), a sociedade do desempenho produz novos quadros de sofrimento. Esses modos de vida também atravessam a experiência infantil. Neste sentido, pode-se agregar às nossas reflexões as afirmações de Freud (2020), em que se considera que a cultura estabelece seus imperativos de conformidade, reprimindo impulsos e desejos, gerando assim, mal-estar. Se, para Freud, essa tensão entre o sujeito e as imposições civilizatórias eram inevitáveis e, consequentemente intrínsecas à experiência humana, na contemporaneidade atravessada pela lógica neoliberal, essa tensão se intensifica sob a forma de excessiva exigência e exploração de si, em que a subjetividade é construída mediante a pressão por produtividade e eficiência, ampliando o sofrimento psíquico.

O crescente processo de medicalização da infância adentra o contexto escolar também como resposta às demandas de desempenho e normatização. Silva e Angelucci (2018) afirmam que a entrada da medicalização na escola é um sintoma e reflexo da sociedade neoliberal. Nessa perspectiva, o neoliberalismo também introduz-se no cotidiano escolar na exigência de desempenho, na pressão pela produtividade, nos adoecimentos dos profissionais e nas relações instituídas na escola.

Laval (2003) assinala que o neoliberalismo não apenas contribui para o declínio das estruturas sociais e de trabalho, mas do mesmo modo favorece o enfraquecimento das instituições, como a educação e o campo científico. Neste contexto, a escola, ao estar imersa no mundo neoliberal, não está isenta de seus impactos, sendo, inclusive, transformada à medida que as profundas mudanças sociais, econômicas e políticas avançam. Além disso, na perspectiva da lógica de mercado, o autor argumenta que o consumo se sobrepõe à aprendizagem:

[...] Quando algumas das principais evoluções dos últimos vinte anos são postas em relação, quer se trate da lógica gerencial, do consumerismo escolar ou das pedagogias inspiradas no individualismo, e ligadas às transformações econômicas e culturais que atingiram as sociedades de mercado, é possível ver por que e como a instituição escolar vem se amoldando cada vez mais ao conceito – do qual queremos mostrar a configuração geral – de escola neoliberal (Laval, 2003, p.23).

Nessa perspectiva, as instâncias educativas sofreram transformações significativas, impulsionadas pelas profundas mudanças no contexto social. Esses deslocamentos incluem alterações na estrutura familiar e no mercado de trabalho, além da crescente influência da mídia, que afeta profundamente as dimensões socializadoras das crianças. Esse cenário contemporâneo leva ao questionamento de ideias que, em tempos passados, eram consideradas estruturantes e essenciais, sendo transmitidas entre as gerações. Mas poderíamos nos perguntar, juntamente com Laval, que transformações vive a escola? O autor afirma que vivemos um processo de desescolarização, ou seja, uma

Pedagogização generalizada das relações sociais. Afinal, não entramos na tal “aprendizagem ao longo da vida”, expressão oficialmente aceita que aponta a dilatação da relação pedagógica? O desenvolvimento das tecnologias de informação e a individualização da relação com os saberes não são sinal de um declínio inevitável da forma escolar? O universo dos conhecimentos e o dos bens e serviços parecem se confundir, a ponto de cada vez mais pessoas não verem a razão de ser da autonomia dos campos do saber ou o significado intelectual e político da separação entre o mundo da escola e o das empresas (Laval, 2003, p. 22).

Laval (2003, p. 22), ao citar uma entrevista de Toni Negri com Gilles Deleuze, retoma a afirmação de que “tentam nos fazer acreditar que é uma reforma da escola, mas é na realidade uma liquidação”. A partir dessa perspectiva, Laval (2003) argumenta que transitamos da sociedade de “confinamento e recomeço” descrita por Michel Foucault – na qual os sujeitos estão inseridos em instituições como escola, família, indústria e hospital por um tempo determinado, mas de forma oscilante e fragmentada – para uma sociedade de controle de maior abrangência e continuidade. Trata-se de uma sociedade caracterizada pelo monitoramento constante, voltada a garantir a adaptação e a disponibilidade permanente dos indivíduos. Nesse contexto, a escola mantém-se presente tanto na vida individual quanto na coletiva, atravessando o tempo e as gerações e tornando-se, portanto, alvo de disputas de ideais em torno do que ela representa.

Corroborando a estas afirmações, Voltolini (2019, p. 380), no texto intitulado a “Insustentável Leveza da Escola”, reflete sobre as transformações da escola, a qual não está em questão sua exclusão, mas sim mutações advindas de sua época, tendo em vista:

(1) em seu vigor – apesar de muito criticada, não há ninguém que considere extingui-la ou substituí-la por outra mais eficiente –; (2) em sua extensão – nunca a escola, ou a ideia de escolar abrangeu tantas propostas como hoje: escola para crianças e jovens, para a terceira idade, para pais, para analistas etc. –; (3) em sua longevidade – nunca se prolongou tanto o tempo de vida passado na escola –; e (4) em sua utilidade – nunca a escola foi tão decisiva em termos do lugar que será reservado ao indivíduo na polis e no mercado de trabalho.

Para o referido autor, ao citar François Dubet (1998), a escola, enquanto instituição, encontra-se em declínio na contemporaneidade. O conceito de desinstitucionalização é utilizado para explicar as transformações sociais e simbólicas que passam a atravessar os espaços institucionais, incluindo a própria escola. Instituições tradicionais, como a escola, a igreja e a família, exerciam forte influência na constituição subjetiva e na vida coletiva dos indivíduos. Nesse prisma, a instituição cede espaço à lógica da organização, tornando-se mais fragilizada em sua função de transmissão do laço social e da cultura:

Mas como organização ela segue cada vez mais forte, reafirmando seu vigor. A questão que podemos colocar aqui [...] é sobre a dinâmica e as consequências desse declínio, pois sabemos, desde a psicanálise, que a institucionalidade é um elemento que joga um papel fundamental na organização civilizatória. Trata-se do papel de garantir a transmissão da Lei. É por isso que se diz, e não sem razão, que se vão as pessoas e ficam as instituições. O declínio da instituição não representaria, por acaso, um problema quanto à transmissão? (Voltolini, 2019, p. 381).

Apesar dos desafios, a solidez da escola na vida contemporânea é inegável, mesmo frente a controvérsias sociais e vertentes políticas, a manutenção e evolução da escola como ambiente para a educação consolida-se cada vez mais. Inexiste a sugestão de outro espaço público que substituiria sua função, abrangendo cada vez mais cedo a vida dos indivíduos, estendendo-se ao longo da vida, e também com propostas diferentes, como escola para pais, por exemplo. Contudo, a escola ocupa um lugar decisivo na sociedade moderna, na inserção social e preparação para o mercado de trabalho (Voltolini, 2019).

Apesar dos desafios e das controvérsias sociais e políticas que atravessam a contemporaneidade, a centralidade da escola permanece inegável. Sua manutenção e expansão como espaço destinado à educação consolidam-se cada vez mais, não havendo, até o momento, outro espaço público capaz de substituir plenamente sua função social. A escola passa a abranger os indivíduos cada vez mais cedo e a estender-se ao longo da vida, incorporando, inclusive, novas propostas e

modalidades, como programas voltados à orientação de pais. Nesse contexto, a escola ocupa um lugar decisivo na sociedade moderna, especialmente no que se refere à inserção social e à preparação para o mercado de trabalho (Voltolini, 2019).

Por essa via, Voltolini (2019) afirma que a escola, na atualidade, tende a se consolidar como uma organização, enfraquecendo-se enquanto instituição. Os impactos dessa mudança incidem diretamente sobre a transmissão e a organização do laço social, uma vez que a instituição possui maior peso e estabilidade. A escola, enquanto organização, torna-se mais frágil. Considerando que sua função é o estudar, ainda que com frequência se afirme que sua função é o aprender, é importante destacar que, na era moderna, a aprendizagem ocorre de diversas formas, inclusive em casa, pela internet. Essa passagem do “estudar” para o “aprender” é também um dos sinais do declínio da instituição e do fortalecimento da lógica organizacional. Para Voltolini (2019, p.381), “a institucionalidade é um elemento que desempenha um papel fundamental na organização civilizatória, pois garante a transmissão da Lei”.

Esse declínio e enfraquecimento institucional não são causados pelas críticas ou pela perda da notoriedade da escola, mas, à medida que o caráter institucional se perde, mais há a redução da busca pelo outro. Uma das nuances desse declínio se deve à escola assumir para si, no lugar da igreja, o grande capital cultural e se tornar responsável pelo deslocamento do estudar para o aprender (que é utilitarista) - e, nesse processo, “não faltam instrumentos diagnósticos de avaliação de crianças e de transtornos mentais” (Kupfer, 2009). Diante disso, “O elogio à escola” de Larrosa (2018) é a tentativa de um resgate institucional quando este afirma que a principal tarefa do professor é despertar o desejo do aluno à aprendizagem e ao estudar.

Neste mesmo sentido, Laval (2003) tece importantes considerações ao apontar a tendência do caráter mercadológico e individual que adentra as instituições escolares e o campo educacional, perdendo a característica da institucionalidade, que foi fundante para serem o que são hoje. Estes novos moldes de escola devem-se também a fatores como desinstitucionalização, desvalorização e desintegração (Laval, 2003).

Para o autor, no primeiro fator, a escola necessita estar em conformidade para corresponder às demandas socialmente impostas, tornando-se, de certa forma, utilitarista. Embora seja uma instituição estável, ela possui flexibilidade para decisões mais autônomas e, sendo gerida pela perspectiva de educação organizacional, passa gradativamente, ao longo do tempo, a alinhar a flexibilização para corresponder às

demandas. O segundo fator é a desvalorização: apesar do reconhecimento da importância da educação para o futuro, é inegável o declínio de sua função simbólica e formação cultural. Estes pressupostos consolidam-se cada vez mais em responder às exigências do mercado, substituindo a concepção de autonomia individual e coletiva por meio do conhecimento pelo foco no desempenho e na produtividade. Dessa forma, os valores educacionais passam a ser quantificados e mensurados em valores de mercado (Laval, 2003). Quanto ao terceiro fator, a desintegração, refere-se à lógica de consumo do ensino, como a escolha de alunos e famílias, o que pode fragilizar a instituição e reproduzir desigualdades de forma sutil, tendo em vista que nesse caso a escola busca corresponder apenas às necessidades individuais (Laval, 2003).

2.2 O encontro entre educação, saúde e medicalização na aprendizagem

Em continuidade à análise das construções históricas e sociais da infância e dos processos de medicalização, este capítulo busca traçar os contornos da intersecção crítica entre essas esferas, que se manifesta com intensidade no contexto escolar contemporâneo. No subcapítulo 2.2.1, “Processos de medicalização e patologização na educação”, busca-se compreender como as dificuldades escolares passam a ser reduzidas a patologias individuais, deslocando o foco das responsabilidades institucionais e pedagógicas, bem como analisar o modo como o diagnóstico atua na produção de subjetividades. Em seguida, o subcapítulo 2.2.2, “Do guarda-chuva ao espectro: considerações sobre a expansão diagnóstica na infância”, aborda o aumento dos diagnósticos na infância, com ênfase no Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Discute-se o crescimento dessas classificações diagnósticas, amplamente presentes na infância contemporânea, assim como os riscos de patologização de comportamentos infantis e o papel da escola nesse processo. Por fim, o subcapítulo 2.2.3, “Repetir, diagnosticar e medicalizar: problematizações sobre a aprendizagem na educação contemporânea”, busca compreender as dificuldades de aprendizagem em uma perspectiva mais ampla e macrossocial. Nesse contexto, analisa-se como tais dificuldades passam a ser frequentemente interpretadas pelos sistemas educativos como “fracasso escolar”, discutindo-se de que modo a medicalização pode

operar como uma solução rápida, que acaba por deslocar ou evitar questionamentos sobre as próprias práticas e estruturas do sistema educacional.

2.2.1 Processo de medicalização e patologização na educação

A medicalização das dificuldades de aprendizagem é um tema recorrente nos debates sobre educação e infância. Apesar de políticas públicas como a Resolução CNS nº 488/2015 e a Resolução CONANDA nº 177/2015, que define a medicalização excessiva como a "redução inadequada de questões de aprendizagem, comportamento e disciplina a patologias", a aplicação dessas diretrizes enfrenta obstáculos no cotidiano escolar. Esse distanciamento entre a formulação das políticas e as práticas institucionais persiste devido a fatores culturais e institucionais que dificultam a implementação efetiva das normas. A Resolução do CONANDA, inclusive, é clara em sua proposição:

Parágrafo único. Para os fins desta Resolução, define-se excessiva medicalização como a redução inadequada de questões de aprendizagem, comportamento e disciplina a patologias, em desconformidade com o direito da criança e do adolescente à saúde, ou que configure negligência, discriminação ou opressão. (CONANDA, 2015, [s. p.]).

Outra iniciativa é o Projeto de Lei nº 8324/2014, que propõe campanhas de conscientização pelo SUS contra o uso inadequado de psicofármacos em crianças e adolescentes. Aprovado na Comissão de Seguridade Social em 2021, o projeto aguarda conclusão na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, essas iniciativas legislativas não têm sido suficientes para conter a expansão da medicalização no campo educacional, cujo avanço pode ser favorecido pela pouca eficácia de algumas intervenções e pela ainda incipiente conscientização nas políticas públicas.

Esse fenômeno ganha força ao se consolidar como a principal estratégia de intervenção diante das dificuldades escolares. Ao reduzir a complexidade dos fenômenos educacionais a uma disfunção individual inata, essa abordagem desvia o foco das responsabilidades institucionais e pedagógicas. A patologização do não-aprender transfere o ônus do fracasso para o indivíduo, negligenciando o aprimoramento das práticas de ensino e da adequação curricular (Moysés, 2001).

A construção diagnóstica, nesse contexto, opera como produtora de subjetividade. Watzlawick (1994) aponta que a realidade instituída nas relações sociais pode se constituir por meio de uma lógica de causa e efeito. Para Christofari e Freitas (2023), o diagnóstico não revela algo sobre os sujeitos, mas estabelece-se como instrumento de produção da realidade, orientando nosso olhar e ação sobre ela (Bezerra *et al.*, 2014). Brzozowski e Caponi (2013) observam que o diagnóstico imputado à criança a partir do encaminhamento escolar altera suas formas de relação, impondo um entendimento sobre ela que antes não existia.

Integrados a classificações, estigmatizações e dispositivos de controle, os diagnósticos atuam na vida cotidiana, transformando a percepção que o indivíduo tem de si mesmo. Essa descrição diagnóstica influencia desde a leitura das próprias emoções até os aspectos relacionais, levando o sujeito a agir dentro do "esperado" e a incorporar o diagnóstico à sua identidade, especialmente na infância. Nesse prisma, manuais como o DSM 5 intensificam a inflação diagnóstica no contexto escolar, desvalidando a pluralidade dos modos de ser e de aprender (Collares, Moysés, 1994; Frances, 2016; Christofari, Baptista, Freitas, 2015; Whitaker, 2017). A construção diagnóstica, delimitada a partir de sintomas relatados pela família e pelas instituições (Moysés, Collares, 2017), faz com que, ao retornar à escola, a criança seja percebida e tratada de forma divergente, moldada pela estigmatização e pelos estereótipos associados ao diagnóstico (Brzozowski, Caponi, 2013).

Esses processos inserem-se em um contexto mais vasto que busca soluções céleres para os impasses educacionais, recorrendo à medicina do bem-estar. Tais soluções desviam a atenção das inquietações subjacentes às dificuldades de aprendizagem e comportamento. Ao centralizar essas dificuldades no indivíduo, o sistema de ensino exime-se da responsabilidade de solucionar os dilemas pedagógicos (Collares, Moysés, 1994). Vorcaro (1999) alerta que intervenções psicológicas e psicopedagógicas, tomadas como demandas individuais das funções cognitivas da criança, reproduzem ciclos de exclusão, tornando o sintoma cada vez mais nebuloso e dificultando a interpretação e a intervenção. Conforme Mannoni (1988), as manifestações sintomáticas não são individualizáveis, mas advêm do contexto e do discurso coletivo que se desenvolve em torno do sintoma. É nesse discurso social que os processos medicalizantes despontam como "força de lei" (Dunker, 2015, p. 20), impondo intervenções e encaminhamentos que enquadram o sofrimento escolar em sintomas.

Segundo Arantes (2017), a medicalização vai além da prescrição de medicamentos, abrangendo tecnologias e dispositivos que adentram a existência humana. O saber médico incorporou os processos de aprendizagem ao consolidar classificações diagnósticas que estabelecem fronteiras entre o normal e o patológico, atribuindo à medicina o estudo e a definição da normalidade (Moysés, 2001). Assim, a medicalização relaciona-se ao enfraquecimento das relações sociais e de alteridade na contemporaneidade, transformando em problemas individuais questões que deveriam ser tratadas coletivamente (Moysés, 2001). Dunker (2020) acrescenta que esse processo tem avançado no Brasil, especialmente na infância, como uma face da terceirização da educação, tornando-se uma alternativa para resolver questões pedagógicas. O professor, sem respaldo para contestar diagnósticos, vê seu fazer pedagógico substituído pela racionalidade médica, que atribui os problemas escolares ao mau comportamento dos alunos, a ser resolvido com remédios. Isso desvaloriza a multiplicidade de modos de ser e aprender na escola (Christofari, Freitas, 2023). Christofari e Freitas (2023, p. 17) abordam essa questão afirmando que:

A força da racionalidade médica na intervenção do fazer pedagógico coloca em funcionamento a compreensão de que os problemas escolares advêm do mau comportamento dos alunos e podem ser resolvidos com remédios. Professores e familiares acreditam que, ao serem medicados, vão se acalmar e ajustar seus comportamentos, tendo uma conduta adequada que favorece os processos de aprendizagem. O não reconhecimento da importância do trabalho do professor sustentado em uma base pedagógica e a não valorização da multiplicidade de modos de ser e aprender na escola como fonte de potencialização da aprendizagem, muitas vezes, são referidos nos discursos e nos encaminhamentos produzidos na escola.

Esse cenário é alimentado por uma lógica de mercado, na qual a indústria farmacêutica, ao adentrar a infância, garante um potencial cliente para tratamentos de suposta cronificação (Frances, 2016). Estudos mostram que o crescente consumo de psicotrópicos não produz a cura, mas torna cada vez mais numerosa a população dependente desse recurso, impedindo sua emancipação do circuito farmacológico (Whitaker, 2017). Whitaker alerta para a ininterrupção do tratamento medicamentoso de doenças mentais, cujos efeitos a longo prazo ainda são desconhecidos (Whitaker, 2017; Bezerra, 2011; Landman, 2024).

Embora drogas possam parecer eficazes a curto prazo, com relatos iniciais de melhora, não há evidências de melhora que permitam a interrupção do uso (Whitaker, 2017). Essa permanência reforça a ideia de cronificação e pode produzir

efeitos negativos, especialmente na infância, em que comportamentos próprios do desenvolvimento podem ser suprimidos, e o diagnóstico torna-se determinante para o futuro. Alunos com dificuldades escolares, vistos como fora das "normas", podem ter seu espaço potencial subtraído, transformando-se em pacientes crônicos (Whitaker, 2017; Libowitz; Nurmi, 2021). Nesse sentido, Brzozowski e Caponi (2013) afirmam que, embora os processos medicalizantes tragam aspectos negativos para a criança, mostram-se positivos como recurso útil para a sociedade e o meio em que ela está inserida.

Desse modo, ressalta-se a importância do debate e da compreensão dos diagnósticos mais frequentes na infância em interface com suas construções históricas, tema que será discutido no capítulo seguinte.

2.2.2 Do guarda-chuva ao espectro: considerações sobre a expansão diagnóstica na infância

Neste capítulo teceremos algumas considerações acerca do aumento cada vez maior de diagnósticos na infância, com maior destaque ao TDAH. Tal escolha se dá por ser o diagnóstico mais recorrente na infância, quando relacionado às questões escolares (Lima, 2005). Também busca-se refletir sobre o deslocamento da inflação diagnóstica para o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O TDAH, considerado o principal diagnóstico infantil, é permeado de controvérsias, principalmente por não haver exames de maior exatidão que o comprovem. Não existem exames que não sejam feitos somente por avaliação clínica e, além disso, o TDAH tem fronteiras diagnósticas limítrofes entre diferentes comportamentos de desatenção. Por fim, ainda se busca uma otimização do diagnóstico que compreenda quais sintomas realmente fazem parte do transtorno.

Na importante obra sobre o tema, *Somos Todos Desatentos* (2005), de Rossano Cabral Lima, o autor faz um importante apanhado da construção diagnóstica do TDAH, traçando um panorama histórico-social para a sua compreensão. Para o autor, essa questão é permeada de polêmicas oriundas da fragilidade diagnóstica do TDAH como uma enfermidade psiquiátrica e da maneira como a sociedade moderna se estruturou, negligenciando formas diversas de aprender. No início desse contexto, foi o pediatra inglês George Frederic Still que estabeleceu o diagnóstico em 1902, o qual, ao longo do tempo, sofreu diversos desdobramentos. Posteriormente, em 1962,

Still utilizou o termo “Disfunção Cerebral Mínima” (DCM) para descrever essa categoria, que incluía comportamentos como hiperatividade, agressividade, falhas no controle inibitório, desatenção e indisciplina (Lima, 2005). Ele considerava que o comportamento infantil poderia ser entendido como um “defeito no controle moral”, associado a uma herança genética, uma vez que as crianças pesquisadas tinham familiares com histórico de depressão e alcoolismo (Barkley, 1997; Diller, 1998; Hallowell e Ratey, 1999, *apud* Lima, 2005).

Paralelamente a essa construção histórica do diagnóstico, Patto (2022) postula que, na década de 60, a psicologia e a psiquiatria dedicavam-se a consolidar o conceito e o tratamento das dificuldades de aprendizagem. Nesse cenário, surge a psicopedagogia como uma área especializada voltada ao tratamento dessa nova concepção diagnóstica.

Outro marco importante na história desse diagnóstico é a sua inclusão no DSM 2, pela APA, em 1968, quando foi classificado como “reação hipercinética da infância”. Já no DSM 3, em 1980, devido a novas pesquisas e vivências clínicas, o diagnóstico passou a ser chamado de “Distúrbio de Déficit de Atenção” (DDA), podendo ou não incluir a hiperatividade como sintoma. No manual DSM 5, o TDAH é considerado um “transtorno do neurodesenvolvimento”, classificado por níveis de intensidade e pelo prejuízo na rotina devido a sintomas de desatenção e desorganização (como não conseguir focar em tarefas, perder objetos e não seguir instruções), com ou sem hiperatividade/impulsividade, estas últimas caracterizadas por inquietação, falta de controle inibitório e dificuldade em permanecer sentado, conforme a idade da criança (Lima 2005).

A suposta base neurológica do TDAH como uma desordem cerebral carece de validação consistente por neuroimagem e exames. Existem na literatura divergências sobre esse ponto de vista, percebidas através de inconsistências nos diagnósticos por imagens. Essas discordâncias passam a atribuir ao TDAH a definição de um transtorno construído pelas características da sociedade moderna, marcada por “excessos da informação, do consumo material desenfreado e sem sentido, da cultura somática, das identidades descartáveis, da perda da autoridade da família, da igreja e do Estado” (Caliman, 2010, p.48-49).

Já no início XX surgiram várias hipóteses para explicar o TDAH. A criança com sintomas associados ao TDAH foi apontada como indivíduo provido de falha moral, com deficiência mental leve. Ela também foi considerada portadora de

encefalite letárgica, de alguma disfuncionalidade no cérebro que a tornava hiperativa ou hipercinética. Além disso, foi identificada com problemas no controle inibitório, apresentando o déficit de atenção que a encaixaria como, então, portadora de déficit de atenção e hiperatividade (Lima, 2005).

Assim, desde a primeira metade do século XX, vem sendo construída uma tentativa de padronização para o diagnóstico do transtorno, a qual sofreu significativas mudanças na transição do DSM 4 ao 5. Ademais, há uma predominância na incidência dos critérios nestas edições do DSM. Estes resultados devem-se ao fato de que, conforme aponta Lima (2005), a compreensão contemporânea do transtorno, juntamente com a crescente propensão dos psiquiatras a fazer diagnósticos, facilitou seu reconhecimento em conjunto com problemas comportamentais relativamente menos graves, classificados sob a designação de diagnósticos rotulados como casos leves.

O TDAH é conhecido como um transtorno guarda-chuva, que, pela sua ampla apresentação, não pode ser visto com clareza, muito menos de forma unificada (Caliman, 2008). Ou seja, a expressão é utilizada para dizer que nesta categoria nosológica² abarcam-se inúmeras características, que por sua vez encobrem vários sintomas de outras patologias.

É válido ressaltar que foi apenas na década de 70 que o foco do diagnóstico se tornou a desatenção, deixando de ser a hiperatividade o principal sintoma. Assim, expandiram-se os critérios para a construção diagnóstica desse transtorno. Na década de 1990, surge uma nova explicação: problemas no controle inibitório levariam a criança a estar mais desatenta, fato que teria início muito cedo no desenvolvimento infantil. Pelo TDAH, muitos diagnósticos que não colocavam as pessoas como deficientes mentais, passaram a defini-las como inaptas ou incapazes de responder a demandas sociais, como se possuísem um defeito nas funções de adaptar-se ao ambiente e fossem incapazes de seguir suas vidas. Esse fato, que está diretamente ligado a uma explicação cerebral, corroborou para a fortificação da conexão entre o campo orgânico-biologicista e a capacidade atencional (Caliman, 2010). Ainda para Lima (2005), a justificativa de uma causa física para o transtorno representa uma ideia reducionista da atenção como função cerebral independente do ambiente, explicação

² Nosografia é um termo da área da saúde que significa a descrição e classificação sistemática das doenças.

que vem a corroborar a falta de implicação e o entendimento da sociedade moderna com o tempo de aprendizagem da criança (Lima, 2005).

Ao adentrar na discussão dos processos de medicalização na infância, observamos que, ao trabalharem esse tema, os autores estudados utilizam de um perceptível fio condutor. Nesse, são debatidas questões como a construção do diagnóstico e a entrada do tratamento farmacológico para o TDAH, atreladas ao consumo de metilfenidato. Para Lima (2005), com o crescimento exponencial desse diagnóstico, aumentou também o uso de medicamentos como primeira opção de tratamento.

Caliman (2010) destaca que o enlace entre infância e TDAH surge principalmente no ambiente escolar, devido às características do transtorno que se tornam mais visíveis nessa fase do desenvolvimento. Caliman (2010) afirma que algumas características dos transtornos infantis emergem no contexto escolar devido à visibilidade e às exigências trazidas pelo próprio ambiente educacional, bem como à faixa etária da criança, sendo esses traços típicos do desenvolvimento infantil.

Conforme a autora, há uma dualidade no transtorno entre as explicações originadas do cérebro e sua construção histórico-social. Os sintomas atribuídos ao transtorno, como a falta de atenção, dificuldade no controle de impulsos e a hiperatividade podem ser comorbidados à outras patologias. No entanto, para o diagnóstico do TDAH não é necessário que os três sintomas estejam presentes e, portanto, qualquer um deles poderia preencher critérios suficientes para o transtorno (Caliman, 2010). O transtorno oscila entre explicações neurobiológicas e construções sociais, servindo como mecanismo de controle: na infância, medicaliza-se condutas; já na adolescência, por exemplo, é a explicação para atos de delinquência (Caliman, 2010).

O aumento no número de diagnósticos, antes concentrados no TDAH e agora migrando para o TEA, reflete uma tendência social de medicalizar variações no comportamento infantil e nas trajetórias de desenvolvimento (Whitaker, 2017). No contexto brasileiro, os dados mais recentes do Censo Escolar evidenciam um crescimento significativo no número de crianças com diagnóstico de TEA na escola regular. Entre 2023 e 2024, houve um aumento de 44,4% nas matrículas desses alunos, passando de 636 mil para mais de 918 mil (Brasil, 2025). Neste recorte de tempo, observa-se uma expansão contínua e acelerada desse diagnóstico na escola, o que coloca em evidência não apenas avanços no seu acesso, mas também tensiona

as formas como a escola tem respondido às diferenças, frequentemente mobilizando discursos medicalizantes para dar conta dessas demandas.

Ao analisar historicamente essa inflação diagnóstica, percebemos que ela espelha uma sociedade sintomática, voltada à patologização e medicalização da infância, alinhadas a um modelo hegemônico que valoriza docilidade e obediência enquanto desvaloriza comportamentos considerados desviantes. Como aponta Barbosa (2000), a concepção de uma infância universalizada ignora contextos e realidades distintas.

Assim, hoje percebe-se o deslocamento da inflação diagnóstica do TDAH para o aumento da nosografia TEA, que reflete a tendência da patologização associada a problemas do desenvolvimento infantil relacionados a marcadores biológicos e orgânicos e que por sua vez enfatiza a presença do discurso médico. Houve uma ampliação da categoria diagnóstica no DSM 5, abrangendo uma gama de variedades de comportamentos, utilizando o termo espectro, originando a classificação TEA, ou seja, essa nomeação passou a englobar um grupo de características que não são uniformes, compondo um conjunto de sintomas que define um transtorno com diferentes níveis, conforme manifestações mais leves ou graves do mesmo transtorno.

O conceito TEA foi desenvolvido com determinada ampliação de critérios e, assim como o TDAH, que passou a ser um transtorno guarda-chuva, enquadra um maior número de sintomas e nuances. Tais designações exemplificam a perspectiva medicalizante e patologizante que adentram a educação e o campo do desenvolvimento infantil, de tais maneiras que, por vezes, desconsideram aspectos variáveis e subjetivos. Assim, a ampliação dos critérios diagnósticos de TDAH e TEA possui um ponto convergente: o uso de medicamentos como uma das principais alternativas de tratamento.

Acerca disso, a busca por diagnósticos que enquadrem a criança em uma categoria de transtornos mentais é crescente e faz com que um processo medicalizante para as condutas inadequadas seja iniciado. A medicalização na infância perpassa o universo escolar no momento em que a criança não se adequa aos demais ou não aprende no método e tempo esperado para sua idade: “os desvios da infância, dessa forma, são aqueles relacionados com a quebra de normas e de regras impostas socialmente, como, por exemplo, a falta de atenção e a agitação em sala de aula” (Brzozowski, Caponi, 2013, p. 211).

Esse modelo se reflete nas práticas escolares, que frequentemente classificam e rotulam crianças fora das expectativas normativas de comportamento e rendimento. Caliman (2008) destaca que a escola funciona como um dispositivo médico-pedagógico, medicalizando condutas divergentes por meio de pareceres, encaminhamentos e diagnósticos. Lima (2005) reforça esse papel, identificando a escola como espaço privilegiado para observação e categorização de comportamentos, contribuindo para a produção de subjetividades medicalizadas.

Brzowski e Caponi (2015) observam que o discurso médico ganha centralidade na definição de “normalidade”, deslocando o olhar pedagógico e silenciando a escuta das necessidades reais da infância. A infância medicalizada também está ligada à expansão dos saberes *psi*, que atuam como autoridades na educação, promovendo a internalização de normas e a regulação dos corpos por dispositivos clínico-terapêuticos. Caponi (2009) afirma que a psiquiatrização da infância segue uma lógica de gestão dos comportamentos, em que o desvio deve ser diagnosticado, tratado e corrigido.

Mannoni (1995) acrescenta que o discurso institucional pode *produzir* o sintoma, não apenas descrevê-lo. A rotulação escolar age como profecia autorrealizável, gerando fracasso a partir de expectativas e previsões patologizantes, que desconsideram as relações institucionais e os atravessamentos sociais que incidem sobre o sujeito. Neste sentido, ao excluir os aspectos subjetivos e contextuais, as classificações abarcam cada vez mais questões do desenvolvimento como patológicas, causando um número de diagnósticos infantis, apressados, aumentados e imprecisos (Caliman, 2008).

Na análise histórica e crítica do TDAH percebe-se que a construção diagnóstica do transtorno desvela dinâmicas sociais e institucionais. Desde os primeiros apontamentos descritos por Still até os manuais contemporâneos, a expansão dos critérios diagnósticos evidencia a tendência de patologização de comportamentos desviantes, muitas vezes desconsiderando fatores contextuais e subjetivos.

As reflexões aqui apresentadas apontam para a complexidade que envolve a relação entre infância, diagnóstico e medicalização. Se, por um lado, os avanços da ciência permitem maior compreensão sobre a infância, por outro, o uso acrítico e inflacionado de classificações como TDAH e TEA escamoteia as dimensões pedagógicas, sociais e subjetivas que constituem o processo de aprender e se

relacionar. É nessa direção que o próximo capítulo avançará, ao investigar as implicações desses diagnósticos nas trajetórias escolares e na constituição subjetiva das crianças.

2.2.3 Repetir, diagnosticar e medicalizar: problematizações sobre a aprendizagem na educação contemporânea

Para compreender a aprendizagem na educação contemporânea, é fundamental considerar a dimensão do fracasso escolar, que emerge da interação entre os desafios de aprendizagem e as limitações do sistema educativo, incluindo práticas pedagógicas, estruturas institucionais e o envolvimento de professores e familiares. O fracasso escolar não se restringe às dificuldades do aluno: ele emerge da interação entre os desafios de aprendizagem e as limitações do sistema educativo, incluindo práticas pedagógicas, estruturas institucionais e o envolvimento de professores e familiares.

O fracasso escolar é caracterizado pela não aprendizagem do aluno, sendo frequentemente tratado de forma individualizada, como se as dificuldades fossem exclusivamente dele, sem considerar o contexto escolar ou a responsabilidade dos outros atores envolvidos (Collares, Moysés, 1994). Consequentemente, a noção de fracasso escolar tem sido amplamente consolidada como uma das dimensões dos processos de medicalização, que se ampliam com considerável velocidade.

Comumente, o termo é utilizado para expressar o déficit de desempenho escolar das crianças no cenário educacional brasileiro (Moysés, Collares, 2015). Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, 2021), o fracasso escolar é caracterizado pela combinação de fatores como reprovação, disparidade idade-série e abandono do ambiente educacional. Ainda conforme o Unicef (2021), no ano de 2019, 2,1 milhões de alunos foram reprovados no Brasil e o número absoluto de abandono escolar chegou a 620 mil alunos, contribuindo para a distorção idade-série, que se encontrava superior a 6 milhões de alunos. Embora a pandemia de Covid-19 tenha agravado o quadro, o cenário do país já vinha se desenhando para esses resultados. Os estudantes mencionados são, em maior parte, alunos que vivenciam grande vulnerabilidade econômica e social, tais como negros, indígenas e residentes do norte e nordeste do país. As autoras supracitadas apontam dados expressivos: as crianças brasileiras na educação primária apresentam um dos

maiores índices de repetência, sendo três vezes mais elevada que a taxa apresentada em países da América Latina, ocorrência pela qual tem sido nomeada como "cultura da repetência" (Moysés, Collares, 2015).

É inegável, conforme Moysés e Collares (2015), a necessidade de discussão sobre as políticas públicas educacionais e como o sistema escolar vem centralizando no aluno a causa do não aprender. As autoras citam ainda que, nos anos subsequentes a 1990, no município de São Paulo, somente 10% dos alunos concluíram a oitava série do ensino fundamental no tempo de oito anos em 57 escolas analisadas. Esses dados fazem parte de uma pesquisa realizada pelas autoras, que também citam a visão dos profissionais envolvidos. Ao serem questionados, todos os professores participantes mencionaram questões biológicas como a causa dos problemas de aprendizagem. Os profissionais de saúde entrevistados também mencionaram fatores biológicos como possíveis causas para as dificuldades de aprendizagem dos alunos.

Diante desse cenário, torna-se imperativo compreender como a escola e os profissionais da educação e saúde têm interpretado tais dificuldades. A partir desses discursos, a centralidade perante o fracasso escolar gira em torno do aluno, tornando-o responsável pela origem e causa das dificuldades de aprendizagem e, conseqüentemente, os processos medicalizantes se tornam crescentes na educação. Nesse mesmo estudo, Collares e Moysés (1994) reforçam que, em maior proporção, o aluno é responsabilizado pela produção desse fracasso e, algumas vezes, as famílias são responsabilizadas juntamente. Contudo, raramente a escola e as políticas educacionais são apontadas como responsáveis. Igualmente, os processos de ensino e aprendizagem não são questionados mediante a não aprendizagem do aluno.

Patto (2022) sugere que a expressão fracasso escolar deve ser substituída por "fracasso da escola", a qual não consegue efetivar os processos de ensino-aprendizagem. Assim, os processos de medicalização transportam para o saber médico as origens e soluções dessas dificuldades, eximindo as instituições e o Estado da responsabilização (Moysés, Collares, 2015). Nessa abstenção do Estado em relação aos problemas da educação, as escolas são fortemente impactadas. O professor, por sua vez, vê-se desamparado em seus recursos, tendo em vista o despreparo para tais insurgências e a necessidade de dar conta das atividades curriculares. Seja pelo excesso de demanda de trabalho ou pela precariedade educacional, coloca-se esse profissional em risco de adoecimento mental. As salas

de aula na atualidade refletem a homogeneização dos modos de ser, tida como uma tendência de cunho estatal, individualizadora e supressora das subjetividades inerentes a cada um. Assim, percebe-se a replicação das relações de poder e normatizadoras do próprio Estado dentro da escola (Dunker, 2020).

Por mais que o professor, de forma isolada, se esforce para atingir essa meta, suas ações tendem ao fracasso, pois acabam sendo vencidas por problemas institucionais, como o tempo reduzido e o grande número de alunos sob sua responsabilidade. Em 1988, por exemplo, Mannoni propôs ao sistema educacional francês a preparação dos professores com as ferramentas e os recursos necessários para o pleno desenvolvimento de suas atividades profissionais. Ainda segundo a autora, as questões relacionadas à má adaptação escolar teriam seus impasses solucionados dentro do sistema educacional se fossem considerados de forma singular, mediante as necessidades de cada sujeito. Podemos encontrar em Mannoni (1988, p. 49) esta crítica, quando afirma que:

Em vez de revolucionar o ensino e sua estrutura, o Ocidente prefere, pelo contrário, remediar os efeitos das anomalias geradas por um ensino inadequado à nossa época. Remediar os efeitos significa, neste caso, encarregar a medicina de responder onde o ensino fracassou.

Nesse contexto, importa considerar a experiência das crianças em relação à sua percepção e singularidade. Assim, refletir sobre em qual contexto surge a demanda educativa e quais as possibilidades e recursos dispomos nos impasses escolares viabiliza novos caminhos nas práticas educacionais (Arantes, 2017). Essas críticas ao sistema educacional já eram debatidas por Mannoni que, em 1988, aponta a sobrecarga de trabalho e o excessivo número de alunos por turma como fatores que interferem diretamente no trabalho do professor. Conforme a autora, é preciso enfrentar os problemas no ensino, ao invés de escondê-los. Mannoni (1988, p. 112) afirma ainda que "o problema hoje levantado pelos efeitos nefastos de um ensino preocupado antes de mais nada com salvar as aparências é, em primeiro lugar, um problema político".

Para Larrosa (2018), o ofício do professor produz-se a partir do desejo de aprendizagem gerado no aluno. Nesse sentido, o conceito de transferência (Freud, 2010) aplica-se à relação professor-aluno, especialmente quando se transcende um ambiente escolar normatizador e uniformizador - capaz de produzir processos subjetivos marcados pela inibição. A relação de transferência visa despertar no aluno

o desejo de aprender e o vínculo com o ensinador, abrindo novos caminhos para o processo de ensino e aprendizagem.

Como sustenta Kupfer (2005), a aprendizagem pressupõe a relação com o professor e, fora dela, não há ensino. Seja pela presença física ou pelos escritos que orientam o aluno, o professor fornece a base para a produção de significados. Para a autora, o aluno nunca está sozinho nesse processo, pois está sempre em diálogo com as ideias do mestre: "aprender é aprender com alguém" (Kupfer, 2005, p. 84). Portanto, à luz da psicanálise, pode-se afirmar que a aprendizagem se dá na relação entre docente e discente, não apenas nos processos cognitivos, mas também na relação afetiva e transferenciada nesse encontro. Assim, o professor, ao abandonar a posição de controle estabelecida na relação de poder e autoridade sobre o aluno, propicia novas possibilidades pedagógicas, que facilitam ao estudante assimilar o conhecimento transmitido e permitem uma nova abertura de produção de sentidos e o despertar do seu próprio desejo de aprendizagem (Kupfer, 2005).

Dessa forma, a própria noção de transferência como propulsora do desejo pela aprendizagem segue em uma direção distinta aos enquadramentos rígidos e padronizantes do sujeito. Nesse prisma, Safatle, da Silva Júnior e Dunker (2018) apontam diversos estudos que demonstram que essa forma de conceber o diagnóstico, camuflada por uma aparente objetividade e neutralidade científica, oculta interesses específicos. Essa abordagem, marcada por ignorar fatores sociais e contextuais, beneficia as grandes indústrias farmacêuticas e centros de formação, instituindo a cultura da produtividade e eficácia a empresas e escolas, impulsionando uma padronização e aceitação do sofrimento, priorizando o desempenho em detrimento da saúde coletiva e individual. Consequentemente, ao ignorar as dimensões sociais e individuais da saúde, essa prática contribui para a medicalização excessiva da população, para a cronicidade das questões mentais e para a desresponsabilização e "barateamento" por parte do Estado em relação à saúde pública (Frances, 2016).

Nesse sentido, os manuais classificatórios como o DSM passam a estabelecer critérios de normalidade e desvio que ultrapassam o campo clínico, abrangendo também espaços educacionais (Frances, 2016). Para Dunker (2015), há uma valorização no exercício da produção diagnóstica dos modos de viver na atualidade, caracterizada pela crescente fratura nas lacunas das políticas públicas que se fundamentam nessas classificações. O autor também destaca que o campo da

educação é profundamente impactado pela lógica neoliberal, evidenciada pela crescente frequência de diagnósticos realizados de forma cada vez mais precoce. Ao simplificar e uniformizar as manifestações de dor, a cultura ocidental neutraliza os sintomas psicológicos. Consequentemente, estes perdem sua força de contestação social e sua potencialidade para estabelecer novos laços e novas formas de relação com o Outro, elementos cruciais para a apreensão integral do sofrimento humano. Em decorrência disso, são validadas estratégias que promovem a normatização e produção de exclusão dentro da própria psicopatologia (Safatle, Da Silva Júnior; Dunker, 2018). Nesse contexto, seguindo a perspectiva de Arendt (2000), pode-se constatar que a contemporaneidade tem gerado sofrimento sob a máscara de um suposto progresso.

Para encerrarmos este subcapítulo, recorreremos às palavras de Freitas e Baptista (2017, p. 4), a fim de ilustrar que a aprendizagem não se restringe a aspectos de adequação às normas, mas parte da criação de novos modos de ser e estar no mundo: "nascemos capazes de aprender e construir conhecimento. A possibilidade de aprender não é a mera capacidade de nos adaptarmos ao mundo, mas de inventá-lo continuamente, invenção como ato único que cada sujeito produz".

2.3 Processos de aprendizagem e a construção do laço social na escola

Dando continuidade à análise crítica da medicalização e de sua inserção na educação, este capítulo busca estabelecer um contraponto ao focalizar a dimensão inerentemente relacional, afetiva e contextual da aprendizagem, traçando outros contornos para a compreensão do aprender. A seção inicia-se com o subcapítulo 2.3.1, "Processos de aprendizagem", que explora diferentes matrizes teóricas que compreendem o aprender como um processo multidimensional (Gallo), articulado entre o sujeito, o Outro e o contexto, e impulsionado pelo desejo. Em seguida, o subcapítulo 2.3.2, "Atenção: dimensão fundamental", aborda a atenção não como um déficit a ser corrigido, mas em sua complexa dimensão subjetiva, pulsional e relacional (Freud, Vygotsky), confrontando a lógica contemporânea que a reduz a um recurso individual voltado à produtividade e ao desempenho.

O subcapítulo 2.3.3, "Escola: afeto, laço e socialização", busca compreender a escola como um dos principais espaços públicos para a construção de vínculos, afetos e experiências de socialização. Por fim, o subcapítulo 2.3.4, "Educação

Especial e Processos Inclusivos”, contextualiza a busca por um ambiente escolar acolhedor e de suporte, que garanta a participação efetiva de todos os alunos, reforçando a necessidade de resistir à lógica medicalizante que frequentemente transforma a diversidade dos modos de aprender em desvio.

2.3.1 Processos de aprendizagem

A compreensão dos processos de aprendizagem mobiliza diversas matrizes teóricas que buscam explicar como o ser humano se apropria do conhecimento. Jean Piaget situa a aprendizagem no desenvolvimento da cognição, resultante da interação entre o sujeito e o ambiente. Henri Wallon a concebe pela integração entre emoção, cognição e movimento, compreendendo o desenvolvimento da criança como dinâmico e indissociável das relações sociais. A abordagem teórica de Freire a entende como um processo dialógico e crítico, construído a partir da relação com o meio e pela vontade de transformação. Na perspectiva histórico-cultural de Lev Vygotsky (1995), a aprendizagem está diretamente relacionada ao meio social, no qual a linguagem e a relação entre os indivíduos têm papel central. Em comum, essas matrizes teóricas apontam para a aprendizagem como um processo que articula o sujeito, o Outro e o contexto, tríade que a medicalização, ao centrar no indivíduo as dificuldades escolares, pode vir a romper.

Silvio Gallo, em *As Múltiplas Dimensões do Aprender* (2000), considera a aprendizagem como um processo de muitas dimensões, envolvendo aspectos afetivos, sociais e éticos, não se restringindo às questões cognitivas e intelectuais. O autor acrescenta que a aprendizagem não é uma linha uniforme, mas riscos singulares compostos por afetos e tracejados por descobertas (Gallo, 2000).

Para Gallo (2012), o acompanhamento desses processos pelo mestre e pelo aluno proporciona seu reconhecimento, auxiliando nos modos de ser e aprender no espaço escolar. A aprendizagem, assim, constitui-se como processo também de relações, que exige presença e implicação de ambos os atores, marcando suas vidas (Gallo, 2012). O autor também problematiza se, na atualidade, o objetivo da escola é a transmissão de conhecimento ou a educação em sentido integral. Corroborando essa ideia, Manuel Jacinto Sarmiento (2011) refere que, embora a escola frequentemente se ocupe mais do aluno do que da criança, é necessário refletir sobre o cuidado em sua integralidade, para além do desempenho individual de

aprendizagem. Esta proposição também é discutida por Voltolini (2019), para quem a função da escola é o estudar, pois aprender se dá em vários contextos, enquanto no estudo se analisa um objeto de diferentes perspectivas. Nesse sentido, a necessidade da dupla professor-aluno é fundamental. Rechia e Larrosa (2019) afirmam que o principal ofício do professor é tornar os alunos em estudantes, ainda que os efeitos de sua ação no ambiente educacional nem sempre sejam mensuráveis. Essa distinção entre estudar e aprender é central para pensar a medicalização: quando a aprendizagem é reduzida ao desempenho e à produtividade, o estudar como ato de desejo e abertura ao conhecimento cede lugar a uma lógica de adequação e resultados, na qual as dificuldades da criança são lidas como falhas a serem corrigidas pela medicina.

De acordo com Lajonquiere (1997), o ato educativo busca despertar o desejo do aluno no processo de ensino, possibilitando-lhe atribuir significados em sua aprendizagem e reconhecendo as necessidades escolares que são singulares entre as crianças e os adolescentes. Porém, os aspectos voltados para a normatização no ambiente escolar podem ocultar o espaço de expressão, resultando no sintoma, via pela qual a criança necessita ser escutada para que se produzam novos significados, resultando em experiências significativas na aprendizagem. Dessa forma, a adequação à norma suprime as características subjetivas e impõe um ideal a ser atingido, não produzindo abertura para um discurso que produza novas significações perante o mal-estar vivenciado.

Silvio Gallo (2000) propõe que o desenvolvimento integral do aluno requer a articulação entre a transmissão didática do conteúdo e a constituição social, que ocorre no encontro com o outro e nos lugares sociais ocupados, de modo que o processo educativo ultrapasse a mera aquisição de conteúdos e possibilite a constituição do sujeito em sua dimensão crítica, relacional e participativa no contexto social (Gallo, 2000). Em uma passagem que sintetiza sua concepção, Gallo (2000, p. 2) afirma:

Não podemos, porém, perder de nosso horizonte que a utopia que nos guia é algo bem maior: a construção de uma concepção de saber que vislumbre a multiplicidade sem a fragmentação; um currículo e uma escola na qual as crianças possam aprender sobre o mundo em que vivem, um mundo múltiplo e cheio de surpresas, e possam dominar as diferentes ferramentas que permitam seu acesso aos saberes possibilitados por esse mundo, e possam aprender a relacionar-se com os outros e com o mundo em liberdade.

A aprendizagem, de forma ampla, requer a consideração de fatores afetivos e sociais, bem como abertura às vivências e aos contextos dos alunos. Nesse sentido, torna-se necessário produzir novos currículos que reduzam a fragmentação e superem barreiras por meio do diálogo e de práticas interdisciplinares, como defende Silvio Gallo (2000). Dessa forma, práticas pedagógicas orientadas pela diversidade e pela singularidade da criança preservam as formas pelas quais ela aprende e experiencia a educação, possibilitando o desprendimento de estruturas rígidas de conhecimento e a construção de práticas educativas integradas, ampliando as possibilidades de aprendizagem.

Nessa perspectiva, como sintetiza Silvio Gallo (2017), a aprendizagem constitui-se como construção singular e coletiva de saberes e experiências que se conectam entre si, abrangendo passado, presente e futuro. Nesse processo, torna-se necessário refletir sobre as relações interpessoais no ambiente escolar, que extrapolam a relação professor-aluno e incluem pares, funcionários e demais sujeitos da escola. Essas experiências compõem um espaço de trocas e de constituição subjetiva, no qual o aprendizado ocorre nas interações de um ambiente coletivo em que o estudante vivencia e reconhece, em si e nos outros, práticas pautadas no compromisso, no respeito e na autonomia, sendo essa dinâmica relacional a que efetivamente produz sua formação (Gallo, 2000).

Considerar a criança como sujeito ativo no aprendizado é reconhecer suas experiências, saberes e formas singulares de atribuir sentido ao mundo. Essa perspectiva relacional e afetiva se opõe às lógicas medicalizantes, que silenciam, padronizam e transformam em sintoma o que é expressão singular da criança.

2.3.2 Atenção: dimensão fundamental

Dalgalarrondo (2019, p. 82) define a atenção como "conjunto de processos psicológicos que torna o ser humano capaz de selecionar, filtrar e organizar as informações em unidades controláveis e significativas". Esse sistema de operações mentais é constituído por diferentes dimensões que se articulam entre si. Neste trabalho, detemo-nos especificamente em sua dimensão voltada à aprendizagem, na qual a atenção está geralmente ligada ao foco. A habilidade de atenção e foco permite direcionar e sustentar a concentração em um estímulo, estando também relacionada à subjetividade do indivíduo. Essa habilidade varia ao longo do tempo, sendo

influenciada por fatores externos, como o interesse pelo estímulo e as exigências da tarefa, e internos, como a motivação e o estado emocional. Para Fernández (2012), a aprendizagem é sustentada pela seleção de estímulos para os quais a atenção se orienta.

Em síntese, a atenção pode ser compreendida como a habilidade de cada indivíduo de direcionar e manter o foco em uma tarefa específica (Caliman, César, Kastrup, 2020). Há inúmeros desdobramentos em torno desse conceito, produzindo base para uma série de alternativas terapêuticas que procuram aprimorar a atenção ou a regular, que vão desde a gestão da atenção até concepções filosóficas baseadas na atenção, como elemento para meditações, por exemplo. Sob essa perspectiva, administrar a capacidade atencional torna-se uma ferramenta que se expande a diversos aspectos da vida, abrangendo também a constituição dos indivíduos (Caliman, 2012).

A compreensão da atenção ganha maior profundidade quando considerada sua dimensão subjetiva. Para Freud (1976), as nuances e dificuldades em torno da atenção apontam para questões subjetivas dos sujeitos, que emergem e se tornam urgentes naquele momento, sobrepondo-se aos mecanismos de "prestar atenção". O autor afirma que não há diminuição da atenção, mas sim um deslocamento do foco atencional:

Daí parece decorrer que o fator da atenção dos lapsos da fala, da leitura e da escrita deve ser determinado de maneira diferente daquela descrita por Wundt (ausência ou redução da atenção). Os exemplos que submetemos à análise realmente não nos autorizam a supor que tenha havido uma redução quantitativa da atenção; encontramos algo que talvez não seja exatamente a mesma coisa: uma perturbação da atenção por um pensamento que se impõe e demanda consideração. (Freud, 1976, p.88).

Neste sentido, a atenção produz uma expectativa que, conseqüentemente, encadeia envolvimento e dedicação, lançando luz sobre determinado objeto:

A *atenção* consiste, pois, em estabelecer o estado psíquico de expectativa, inclusive para aquelas percepções que não coincidem, em parte, com as catexias de desejo. [...] Acontece, simplesmente, que se tornou importante mandar catexias ao encontro de todas as percepções, uma vez entre elas podem estar as desejadas (Freud, 1976, s/p).

Embora Freud não negue a origem biológica da atenção, ele afirma que outros aspectos precisam ser considerados para sua compreensão, desde questões

subjetivas até mesmo relacionais. A atenção está diretamente ligada às necessidades e formas de satisfação dos sujeitos, podendo ser considerada também em sua dimensão pulsional. Essa perspectiva subjetiva encontra ressonância na abordagem histórico-cultural. Para Vygotsky (1995), a atenção está diretamente ligada à linguagem, que tem um papel central na organização dos processos atencionais, pois permite que a criança direcione e mantenha o foco de forma mais intencional. Por meio das palavras, ela passa a destacar o que é mais relevante no ambiente, reorganizando o que percebe e aumentando seu controle sobre as próprias ações. Além disso, a linguagem possibilita não apenas estruturar o que é visto, mas também orientar-se no tempo, tornando o direcionamento do foco mais flexível e consciente. Como afirma o autor: "a criança começa a perceber o mundo não somente através dos olhos, mas também através da fala" (Vygotsky, 1995, p. 32).

A dimensão relacional da atenção também tem sido evidenciada em pesquisas contemporâneas. Um estudo realizado por Caliman, César e Kastrup (2020) com usuários de um espaço de saúde mental infanto-juvenil apontou os benefícios da abertura de um espaço de leitura de obras literárias promovendo a atenção coletiva como forma de cuidado. A intervenção proporcionou um ambiente seguro e de acolhimento mútuo, que favoreceu a criação de laços e a atenção dos participantes, demonstrando que "o cuidado atencioso acolhe o pluralismo das formas de relação" (Caliman; César; Kastrup, 2020, p. 190).

No campo educacional, essa perspectiva relacional ganha contornos específicos. O estudo de Freitas e Baptista (2005) relaciona a atenção à educação, apontando a "desatenção" como ponto de cruzamento entre os desafios da aprendizagem e uma explicação simplista das dificuldades atencionais. Os autores referem que fatores contextuais e relacionais necessitam ser considerados para que se produzam novos discursos em torno da criança, buscando a "ressignificação da atenção" no ambiente escolar. Outro estudo importante sobre este tema é "Aprendizagem da atenção: uma abertura à invenção", de De-Nardin e Orglar Sordi (2008), que explanam que o ambiente e a relação entre aluno e professor, com a presença do diálogo e do afeto, promovem a atenção como resultado desses elementos e da própria aprendizagem.

A atenção é permeada por diversos aspectos, dentre eles a dispersão, compreendida como um elemento que faz com que a atenção seja constantemente mudada de foco, voltando-se a diversos objetos ou experiências. Já a distração é o

processo pelo qual a atenção se desvia: o pensamento do indivíduo é inundado por demandas advindas de si ou do meio, mudando o foco sem objetivo claro. A distração pode ser entendida como um movimento em que o foco atencional escapa do ponto central da atividade proposta, ampliando-se sem objetivo definido e resistindo às exigências da tarefa imediata. Nesse sentido, o sujeito distraído não é necessariamente desatento — pode estar profundamente concentrado, mas voltado para outro ponto (Caliman; César; Kastrup, 2020). Embora ambos os processos desviem o sujeito da atividade proposta, essa distinção é importante para distinguir a sutileza dos limites entre dificuldades e transtornos (Kastrup, 2004; Caliman, 2008).

Paralelamente a essas concepções relacionais, emerge na contemporaneidade uma compreensão da atenção como recurso individual e produtivo. Em seu estudo sobre a atenção no contexto empresarial, Caliman (2012) aborda o gerenciamento da atenção por expectativa de sucesso e desempenho. Para a autora, a atenção é compreendida como recurso individual, de grande valia ao homem moderno e bastante disputado. Assim, esse conceito tornou-se objeto de diferentes perspectivas de conhecimento e práticas que extrapolam as ciências da saúde, sendo uma condição que proporciona êxito no desempenho e corresponde às expectativas produtivas de mercado.

Essa compreensão tem implicações diretas sobre a subjetividade dos sujeitos. Ainda para a autora, o lugar central que a atenção passou a ocupar nos dias de hoje tornou-se de grande valor subjetivo e marcador de sucesso. Os entraves e dificuldades advindos do campo atencional ressoam como uma declaração de fracasso e fratura existencial:

O desatento se identifica com o sujeito não produtivo, incapaz de autogestão. O sujeito incapaz de chamar a atenção do outro é também um símbolo do fracasso na economia atual da atenção. Antes de ser um desatento, ele é um desatendido, mas ele assim o é por não ser capaz de ater-se suficientemente à tarefa de se fazer notar. A ele é dito que a culpa de seu insucesso é dele e somente dele, de sua falta de persistência e competência. (Caliman, 2012, p. 07).

Embora os avanços tecnológicos e farmacológicos em torno da atenção sejam crescentes e estejam acompanhados de grande expectativa, eles convergem em pontos críticos que impõem limitações, como riscos físicos e mentais, e apontam para desfechos e princípios éticos ainda não conhecidos (Caliman, 2012). A autora alerta

para os "efeitos totalizadores" desses processos que, embora baseados em preceitos importantes, sobrepõem-se aos mecanismos atencionais quando visam corresponder às expectativas de produtividade e desempenho irrestritas. Essa lógica produtivista também atravessa o ambiente escolar, onde a atenção é reconhecida como elemento básico e primordial nos processos de aprendizagem (Caliman, César, Kastrup, 2020).

Para Kastrup (2004), as características da vida moderna contribuem para o surgimento de queixas em torno das dificuldades de atenção. Campos (2013) aponta que o advento das tecnologias e a exposição a um grande volume de informações modificam inúmeros aspectos da vida humana, como a subjetividade, as relações, o trabalho e a atenção, a qual passa a se dividir entre inúmeras tarefas. Para o autor, ao se transformarem, na modernidade, aspectos como linguagem, comunicação e tempo-espço, altera-se também a capacidade atencional. Diante dessa fugacidade das experiências, "a atenção não se volta para dentro, refugiando-se no mundo interno, na medida em que a subjetividade não encontra mais espaço para se expressar em palavras" (Campos, 2013, p. 71).

No ambiente escolar, as dificuldades de atenção estão entre as queixas mais frequentes. É importante ressaltar, contudo, que essa dificuldade não se restringe a um simples desinteresse, trata-se de uma complexa interação de fatores subjetivos e ambientais que podem dificultar para o aluno focar e sustentar o esforço mental necessário para a aquisição de novos conhecimentos.

Conforme Kastrup (2004), a falta de atenção pode ser associada a problemas comportamentais e à dificuldade de sustentação de atividades de longa duração, especialmente quando associada à hiperatividade. No ambiente educacional, as dificuldades em estar atento às aulas e aos conteúdos escolares são muitas vezes associadas ao Transtorno de Déficit de Atenção (TDA), caracterizado pela dificuldade de manter o foco e o interesse por períodos prolongados, pela execução insatisfatória de atividades e pela quebra de normas. Assim, a manutenção do foco atencional reflete-se diretamente na experiência de aprendizagem da criança.

Kastrup (2004) aponta que as dificuldades de atenção surgem sob a forma de queixas da atenção em diferentes contextos, como na vida social, laboral, em ambientes de saúde e especialmente no ambiente escolar. Para a autora, a falta de atenção, muitas vezes interpretada como problema de concentração, não ocorre por acaso no contexto atual. Vivemos em um cenário que favorece a fragmentação e a constante mudança do foco atencional, seja pelo grande volume de estímulos da vida

moderna, pelas tecnologias, pelo ritmo acelerado do cotidiano ou pela busca incessante por novos conteúdos. A rapidez na circulação de dados e a expansão contínua desses fluxos, associadas a modos de vida que também produzem subjetividades cada vez menos voltadas a um único objeto por longos períodos, contribuem para a fragmentação da atenção. A autora alerta para a expansão dessa concepção, considerando que a atenção vai além do ato de estar atento, ou concentrado em si mesmo, mas também se configura como ato de criação (Kastrup, 2004). Essas questões adentram várias esferas da vida, mergulhando também na saúde e na educação, o que culmina com frequência em diagnósticos como TDAH, caracterizados pelo desempenho reduzido na entrega das atividades ou na aprendizagem esperada, sendo comum a explicação: "Considera-se que a criança não aprende porque não presta atenção" (Kastrup, 2004, p. 8).

A reflexão sobre a atenção no ambiente escolar leva inevitavelmente à discussão sobre o TDAH, condição amplamente relacionada às dificuldades de manter o foco e uma das principais referências para compreender os desafios enfrentados por muitos alunos. Caliman (2008) alerta para a importância da distinção entre as características dos sintomas do TDAH e o desejo de melhora da capacidade atencional. Tal questão, com vistas à otimização da atenção para o desempenho, envolve aspectos sociais e econômicos que adentram o mercado e a educação. Embora validado, o TDAH se expande através da discussão sobre a capacidade atencional, tornando ainda mais sensíveis os limites entre o transtorno e a busca pela otimização com vistas ao desempenho.

Essas características atencionais são especialmente demandadas no ambiente escolar e os recursos de tratamento para o transtorno corroboram a busca pela otimização, performance e desempenho acadêmico. Nesta perspectiva, as abordagens terapêuticas para este fim necessitam ser ponderadas para que se faça uma avaliação crítica e contextual dessas demandas (Caliman, 2008).

Dessa forma, compreender o conceito de atenção como fenômeno complexo, perpassado por dimensões subjetivas, relacionais e contextuais, auxilia na ampliação do olhar sobre os processos de aprendizagem. A partir das afirmações de Freud, é possível compreender que a atenção não é estável, mas sim caracterizada por deslocamentos e investimentos psíquicos, evidenciando seu caráter dinâmico. Caliman (2012) aponta ainda que a atenção está implicada nas relações e na subjetividade dos sujeitos, tratando-a pela perspectiva do cuidado como forma de

potência. A atenção como movimento inventivo, capaz de se reinventar mediante os afetos que emergem, compõe outra experiência de aprendizagem.

2.3.3 Escola: afeto, laço e socialização

A infância é um chão que pisamos a vida inteira
Lia Luft

Na atualidade, observa-se uma redução progressiva dos espaços sociais de convivência infantil, o que traz impactos significativos a esse grupo geracional. O modo como a sociedade passou a olhar para os lugares frequentados por crianças modificou-se, sobretudo pelo aumento das preocupações com a segurança e a exposição aos perigos urbanos, limitando as oportunidades de circulação em ambientes externos e alterando formas de brincar e o convívio com seus pares e entre gerações (Rabello de Castro, 2025; Trevisan *et al.*, 2022; Bento, Dias, 2017).

É nesse contexto de progressivas mudanças da infância que a escola emerge como um dos poucos espaços públicos de encontro ainda disponíveis. Após a família, a escola é apontada como espaço socializador, de construção de vínculos e de experiências, configurando-se como instância pública de socialização que acompanhará os sujeitos ao longo da vida (Sarmiento, 2004; Sarmiento, 2024). Dessa forma, a instituição escolar passa a ter um papel central na formação social e subjetiva dos indivíduos, especialmente em um tempo em que as oportunidades de convivência fora dela se tornam cada vez mais escassas. Essas ideias corroboram com as colocações de Castro:

Para a criança, participar na escola é visto como a aquisição de competências individuais, respondendo à exigência de formação. No entanto, contemporaneamente, o desenvolvimento das competências individuais não se direciona mais em função de uma esfera pública normativa reguladora dos processos de subjetivação que faz convergir individualização e socialização. Hoje a formação escolar está modelada pela concepção de fazer valer o empenho pessoal no presente como um trunfo ou uma garantia para o futuro (por exemplo, por meio da obtenção de um emprego). Desta forma, quanto mais a escola reforça o discurso social da preparação para o amanhã, mais ele vai ser compreendido e apropriado pelas crianças e jovens na perspectiva de um ganho ulterior para aqueles que se dedicarem (Castro, 2013, p.123)

No entanto, a socialização que ocorre na escola não pode ser compreendida apenas como convivência entre pares. Conforme afirmam Kupfer e Voltolini (2023, p.

3), "a escola não é apenas um lugar – físico – onde ocorre o processo inclusivo; ela é, sobretudo, um lugar – simbólico –, dada a institucionalidade que atravessa as relações que se passam em seu interior". Quando uma criança encontra outra no espaço escolar, essa interação não possui o mesmo estatuto que teria em outros contextos sociais. O que diferencia a instituição são os significados e sentidos que ela assume na vida social, sendo constituída pelo conjunto de discursos que a atravessam e a moldam. A socialização escolar configura-se, assim, como processo simbolicamente mediado pelas expectativas, discursos e significações institucionais (Kupfer, Voltolini, 2023).

Voltolini (2021) aprofunda essa compreensão ao afirmar que a socialização no ambiente escolar se entrelaça entre os atores envolvidos, guiada pelo fio da institucionalidade. É precisamente neste ponto que está sua importância: ao adentrar em um espaço regido pelas mesmas regras e objetivos, as crianças reconhecem-se, identificam-se e produzem o encontro. O autor afirma ainda que, "nem só de relação professor-aluno é feita a escola" (2021, p. 155), pois há um campo de relações entre pares que possui estatuto próprio e efeitos formativos específicos.

O laço produzido no encontro gera bem-estar e desperta o interesse pelo outro. Essas marcas relacionais, para Voltolini (2021, p. 156), propiciam não apenas a socialização, mas o reconhecimento de si e do outro:

Isso se deve ao registro que a criança tem de seu próprio estatuto, ela não se vê apenas como um ser entre outros, mas como um ser inscrito numa filiação. Se a outra criança a fascina é porque reflete a fascinação que tem de si mesma: a outra criança seria, então, não apenas um par, mas um semelhante.

Há, portanto, coisas que somente "uma criança pode fazer por outra" (Kupfer, Voltolini, 2023, p. 15), e a socialização é uma delas. O outro, enquanto alguém próximo, desperta um interesse próprio justamente por possibilitar à criança sustentar questionamentos sobre sua própria existência. Trata-se de um movimento que já vem sendo elaborado e que, ao entrar em relação e contato com esse outro, encontra um espaço privilegiado para se desenvolver e ganhar forma. Sarmiento oferece uma análise precisa dessa tensão:

No entanto, em nenhuma das circunstâncias o desempenho do ofício de aluno como ofício de criança esgota todas as dimensões, potencialidades e capacidades da "criança que vive em cada aluno". A escola, fiel à sua cultura,

filtra no seu programa de socialização para o individualismo aquilo que do indivíduo é convergente com a aquisição dos valores e saberes escolares legítimos. Mas deixa de fora muito do que verdadeiramente integra o universo simbólico dos seus alunos: os jogos, os rituais, a própria linguagem gerada nas relações de pares e configurantes das culturas infantis e juvenis (Sarmiento, 2011, p. 593).

Essa tensão entre criança e aluno está atravessada por uma lógica mais ampla: o adultocentrismo. Para Sarmiento, o adultocentrismo posiciona o adulto como referência, dimensionando os espaços infantis a partir de sua perspectiva. Os padrões adultos adentram a socialização infantil, o comportamento, a aprendizagem — podendo muitas vezes suprimir as experiências infantis e a autonomia das crianças (Sarmiento, Cerisara, 2004).

Kohan (2003) aprofunda essa crítica ao afirmar que, na busca pela emancipação da infância, pode-se obter o contrário: a captura da infância no próprio discurso adulto, moldando-a às expectativas que ditam valores e padrões, impedindo a infância se manifestar em sua singularidade. Negar a experiência, para o autor, produz consequentemente a negação da infância. Na sociedade moderna, aumenta "a ausência de espaço para a experiência" (Kohan, 2003, p. 240) — diagnóstico que Bauman (2009) corrobora ao afirmar que os espaços públicos de convivência estão reduzidos, desdobrando-se em lacunas na educação como tarefa complexa.

Para Kohan (2003, p. 239), a infância precisa ser compreendida para além de uma fase biológica do desenvolvimento e sim, sobretudo, como uma condição existencial: "a infância é a condição de ser afetado que nos acompanha a vida toda. O dito e o não-dito, a falta de palavra, a ausência de voz, nos afetos. É aquela singularidade silenciada que não pode ser assimilada pelo sistema." Para o autor, ser afetado implica estar aberto ao encontro com o Outro, com a experiência, com o inesperado e com a aprendizagem. Na singularidade da infância, a abertura se opõe a práticas sociais que tendem a ser normatizadoras, pois podem suprimir experiências, escapando também à linguagem (nas formas de discursos racionais) adaptativa e conformativa ao mundo adulto. Essas experiências, contudo, podem ser representadas de outras formas, pelo silêncio, pelas emoções, pelo encontro com o outro.

O autor supracitado propõe uma infância vista como dimensão que permanece ao longo da existência e não como algo que se perde com o crescimento. Nesse sentido, as experiências infantis tornam-se fios que compõem a tessitura da

vida. A infância precisa permanecer aberta ao novo, permitindo-se ser afetada pelas experiências que moldam sua subjetividade; não pode se fechar a elas, pois ainda não está completamente formada. A infância que se manifesta pela curiosidade, sensível e singular, resiste à racionalidade do mundo adulto, que visa utilitarismos, desempenho e produtividade (Sarmiento, 2011). É nessa resistência que reside sua potência.

É nesse contexto que a escola pode ser compreendida como espaço potencial, conforme a perspectiva de Winnicott (1975). Para o autor, o espaço potencial é a área intermediária entre o indivíduo e o ambiente onde ocorre a experiência criativa e o brincar, fundamentais para a constituição subjetiva e para a capacidade de se relacionar com o mundo. A escola pode ser considerada um espaço potencial para o desenvolvimento humano, contribuindo para o repertório de habilidades sociais e preparando a criança para a vida em sociedade (Winnicott, 1975). Quando o ambiente escolar oferece segurança e acolhimento, ele favorece que a criança se arrisque no encontro com o outro, experimente, crie, aprenda.

Sob essa perspectiva, compreende-se que o espaço escolar representa uma possibilidade de inserção social para todas as crianças. Tal assertiva, central na educação especial sob a ótica inclusiva, demanda uma reflexão acerca do lugar efetivamente oferecido às crianças. Se, como apontado, a escola configura-se como espaço de afeto, vínculo e experiência de socialização, cabe a questão: esse espaço se apresenta de maneira equitativa para todas as crianças? Voltolini (2021, p. 11) convoca-nos a essa reflexão ao problematizar uma expressão frequentemente utilizada no contexto escolar para se referir aos alunos inseridos na perspectiva inclusiva: “elas estão aqui só pra socializar?”. Para o autor, aprender e socializar são processos indissociáveis, sendo a socialização muito mais do que um ganho secundário:

O termo socializar aparece aqui definido em oposição ao de pedagógico: socializar significa circular entre os outros, e pedagógico é colocado em referência a aprender. O próprio fato de que aprender é algo profundamente atravessado pelo social – é em si mesmo uma forma poderosa de socializar – é negado com a consequência de que o próprio socializar vira um subproduto da escola (Voltolini, 2021, p.100).

Essa concepção de infância como condição para ser afetado e da escola como espaço potencial para esse afeto nos permitem refletir criticamente sobre as

práticas medicalizantes e a patologização das dificuldades de aprendizagem. Essa tríade configura-se como um dispositivo de controle que, ao transformar modos de ser e aprender em manifestações (sintomas) que exigem tratamento e correção, silencia o potencial criativo e a abertura ao inesperado nas formas de existir. O mundo adulto, por meio da medicina, da pedagogia, da psicologia e de áreas afins, submete a existência infantil à lógica da normatização e do desempenho (Christofari, Freitas, Baptista, 2015).

2.3.4 Educação Especial e Processos Inclusivos

Como mencionado na introdução, esta pesquisa não tem como objetivo central a educação especial na perspectiva inclusiva. No entanto, considera-se necessária a abordagem desse tema para situar a amplitude e a complexidade do espaço escolar, que, para além da função de ensinar, busca acolher e oferecer suporte a todas as crianças em sua diversidade. Assim, compreende-se que o processo inclusivo faz parte desse movimento mais amplo da escola em direção à garantia de acesso, permanência e participação de todos os alunos. Ressalta-se que a pesquisa não utilizará a inserção da criança no processo inclusivo como critério, estando aberta a qualquer criança-aluno que atenda aos requisitos definidos pelo contexto do estudo.

O sistema educacional brasileiro tem sofrido inúmeras transformações na última década, principalmente no tocante à educação especial e aos processos inclusivos (Baptista, 2019). No entanto, apesar das políticas públicas preverem normativas que viabilizam a práxis educacional, ainda persistem inúmeros desafios que permanecem por superar, sendo um deles, senão o principal, a efetiva inclusão dos alunos. Para Freitas e Jacob (2019), estar matriculado e frequentar o ambiente escolar não significa, necessariamente, ter uma vivência inclusiva de fato.

Dentro das políticas de inclusão, a legislação brasileira, por meio da Constituição Federal 1988 (Art. 205), estabelece o direito à educação como um direito de todos os cidadãos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996, Art. 58-60) compreende a Educação Especial em sua transversalidade, amparada pelos dispositivos que visam à acessibilidade na rede de educação regular, baseados no princípio do direito à educação formal. Os artigos 27 e 28 da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) preconizam a formação continuada para os profissionais

que atuam nos processos inclusivos. A Educação Especial na perspectiva inclusiva está fundamentada na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva - PNEEPEI (Brasília, MEC/SEESP, 2008), que visa assegurar o acesso efetivo da educação para todos, estabelecendo apoio em tempo integral e profissionais especializados para atender a demanda educacional e transpor quaisquer barreiras ou entraves para a efetivação da aprendizagem.

Em 2025, entrou em vigor um novo marco legal que reafirma as diretrizes voltadas ao público da educação especial no país. A normativa atualiza os mecanismos para garantir que crianças e adolescentes com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades tenham acesso a percursos escolares compartilhados com seus pares, por meio de estratégias que envolvem suportes pedagógicos específicos e eliminação de barreiras:

§ 3º A garantia do sistema educacional inclusivo ocorre por meio da organização do sistema educacional geral, de forma a assegurar que os estudantes que são público da educação especial tenham o direito a ser incluídos em classes e escolas comuns, com o apoio necessário à sua participação, permanência e aprendizagem. (Brasil, 2025)

A proposta incorpora princípios como a valorização das diferenças e a recusa a práticas discriminatórias no ambiente educacional, além de prever que os recursos de apoio sejam definidos a partir das necessidades observadas no contexto escolar, sem depender da apresentação de diagnósticos ou laudos médicos (Brasil, 2025). A construção desta política pública orienta-se pelo compromisso de assegurar trajetórias escolares compartilhadas, por meio da supressão de obstáculos que dificultam o percurso educativo, da valorização incondicional das diferenças e da busca por tratamento justo que considere as singularidades de cada estudante, estejam elas relacionadas a aspectos sociais, físicos, intelectuais ou culturais (Brasil, 2025).

Como dispositivos pedagógicos de inclusão existem as salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) dentro das escolas. Este ambiente visa oferecer suporte pedagógico e recursos que auxiliem a aprendizagem dos estudantes, promovendo a inclusão no ensino regular. Outro agente que atua nos processos inclusivos são os profissionais de apoio, ou monitores, que realizam um trabalho voltado para o acompanhamento de alunos com necessidades específicas no espaço escolar, subsidiados pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI, 2015).

Neste sentido, pode-se afirmar que a escola é um espaço composto por múltiplos atores, que abrangem a coletividade, mas que também precisa assegurar a singularidade. Nesta rede de relações, tanto alunos quanto profissionais, estão implicados no mesmo objetivo, buscando a autonomia e o desenvolvimento de alunos regulares e/ou inseridos na Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Dessa forma, garantir a educação inclusiva pressupõe a criação de espaços que proporcionem aos sujeitos envolvidos vivências, convívio e experiências nas relações com o outro, superando a mera formalidade dos procedimentos (Rigo, 2019).

A discussão sobre inclusão, ainda que breve, interessa a esta pesquisa na medida em que revela as tensões entre o ideal de acolhimento à diversidade e as práticas concretas que, muitas vezes, acabam por reproduzir lógicas normatizadoras. É nesse interstício que a medicalização encontra terreno fértil: quando a diversidade dos modos de aprender é lida como desvio a ser corrigido e não como expressão legítima da singularidade infantil. Assim, as políticas de inclusão, por mais avançadas que sejam do ponto de vista legal, podem ser apropriadas pela lógica médica quando não são acompanhadas de uma reflexão crítica acerca dos processos de medicalização que permeiam o cotidiano escolar.

2.4 Novos caminhos: da crítica às possibilidades

Após as análises percorridas até aqui, este capítulo propõe um novo pensamento ético e metodológico. Esta seção finaliza o arcabouço teórico, delineando os contornos que pavimentam o caminho para a investigação empírica, como um esboço inicial em que ideias são rabiscadas e começam a ganhar cor e forma.

O subcapítulo 2.4.1, “Trilhas para a singularidade: a escuta da criança e sua participação nas pesquisas”, explora a necessidade de romper com a perspectiva adultocêntrica, que historicamente silenciou a infância, e fundamenta a criança como sujeito ativo e produtor de conhecimento, cuja escuta é essencial para a compreensão dos processos medicalizantes. Em seguida, o subcapítulo 2.4.2, “Medicalização na infância: que caminhos apontam as pesquisas da CAPES?”, apresenta um mapeamento da produção científica nacional recente, situando a presente pesquisa no contexto acadêmico e destacando a lacuna de estudos que incluem a escuta direta da criança, reforçando a relevância do foco metodológico desta dissertação.

Concluída a discussão teórica, o próximo passo é apresentar o desenho metodológico, no qual se delineiam os traços que orientaram, na prática, a construção dessa escuta. Dessa forma, o Capítulo 3, “Metodologia”, será introduzido para descrever o delineamento da pesquisa qualitativa, o contexto, os participantes e as técnicas de coleta e análise de dados que nortearam o encontro com as crianças e demais sujeitos envolvidos.

2.4.1 Trilhas para a singularidade: a escuta da criança e sua participação nas pesquisas

O tema da infância tem sido objeto de estudo diversas abordagens teóricas na atualidade, principalmente nas ciências sociais, que contribuem para a compreensão das transformações históricas da infância e sua participação ativa nos estudos que as envolvem (Corsaro, 2011). Assim, investigar a infância, em suas estruturas singulares e vivenciadas de maneiras diversas, exige a consideração dos seus contextos. Essa abordagem permite traçar os caminhos que levam ao entendimento sobre o que significa ser criança em realidades distintas, como, por exemplo, a infância vivida em uma aldeia indígena em contraste com a de uma grande metrópole (Cohn, 2010). A partir dessa premissa, a criança deve ser vista como sujeito social, cuja experiência precisa ser compreendida através de seu próprio olhar e percepção, que são singulares e não podem ser concebidos como universais (Cohn, 2005).

Embora esteja em desenvolvimento, em razão de sua condição infantil, ao incluir a criança na pesquisa não se pressupõe que seu conhecimento seja inferior, mas sim diferente em relação ao adulto. Dessa forma, ao ser considerada como sujeito ativo na pesquisa, ela pode atribuir significados com base em suas vivências e ser reconhecida como um sujeito social pleno, capaz de consolidar percepções e construir sentidos a partir de suas experiências (Cohn, 2005).

Segundo Lúcia Rabello de Castro (2013), o estudo sobre a infância aprofunda a compreensão de suas estruturas e favorece o entendimento da subjetividade infantil, resgatando aspectos fundamentais das raízes subjetivas que constituem a condição humana. Para a autora, é por meio da infância que se descobre a potência da capacidade de invenção, frequentemente perdida quando a vida adulta é alcançada.

Nesse contexto, os estudos sobre a infância demandam uma abordagem ampliada e crítica, como afirma Castro (2003, p.23):

O estudo da infância não se reduz a se verificar como as crianças são, sentem e agem (no caso do projeto de uma psicologia positiva), mas como esse ser, sentir e agir se condiciona social e historicamente, ou seja, o que determina – em termos de valores e forças – que essas produções subjetivas emergem no bojo do projeto de uma psicologia crítica.

Além dos paradigmas sociais, a etimologia da palavra *infância* remete a um conjunto de simbologias e significados, vinculando-se ao desenvolvimento da capacidade de articular a fala. A palavra infância é originária do latim pelo termo *infantia*, que deriva de *infans/infantis*, significando *aquele que não fala* com o prefixo *in-* exprime negação e, *fans* significando fala. Para elucidar, buscamos Sarmiento (2005), que evidencia o prefixo *in-*, denota uma ideia negativa e contínua no presente da infância, não apenas remete à incapacidade de fala, mas também à negação social, tal como o termo *inimputáveis* remete à forma jurídica e aos direitos de cidadãos, como o voto, por exemplo. Assim, seu discurso se desarticula em relação ao meio social, produzindo exclusão do pertencimento por meio da fala, haja vista sua condição infantil; a *Infância* é, portanto, a idade do não-falante (Sarmiento, 2005, s/p.).

Assim, escutar a criança corrobora com a premissa de Winnicott na obra *A criança e seu mundo* (1984), que ressalta a importância de compreender a história do sujeito, considerando aspectos estruturantes, como o ambiente, as suas relações primordiais e os principais cuidadores. O autor afirma tratar-se de uma “história total do relacionamento individual da criança com seu ambiente específico” (1984, p. 9). Esse processo permite uma compreensão aprofundada dos pontos importantes na trajetória da criança, algo que é amplamente fortalecido e viabilizado pela escuta atenta dela.

Os desafios da escuta infantil em pesquisas na educação são multifacetados e demandam atenção às nuances que surgem ao pesquisar a infância. A questão central, como apontam Santos, Anjos e Farias (2017), é: as crianças são sujeitos epistêmicos ou meros informantes? Essa indagação atravessa as pesquisas que envolvem a participação infantil, enfatizando a necessidade de reconhecê-las como produtoras de cultura, pesquisa e conhecimento. Os autores também alertam que, com frequência, a participação infantil nas pesquisas é reduzida à função de fornecedora de dados e informações.

Sarmiento (2015) destaca o impacto da produção discursiva adulta sobre a infância, evidenciando como ela pode dificultar a compreensão dessa etapa do desenvolvimento. Essa construção impõe valores e marcadores como, por exemplo, saúde e doença, visto que molda a percepção social da infância. Vygotsky (1995) corrobora com essa perspectiva, ao enfatizar que o desenvolvimento humano é socialmente construído por meio do ambiente e das interações. Assim, pode-se afirmar que o desenvolvimento psíquico mais elaborado e satisfatório surge a partir dessas interações.

Assim, a concepção adulta de infância, frequentemente universalizante, prejudica a compreensão das diversas infâncias, que são marcadas por culturas, temporalidades e contextos específicos. Essa visão hegemônica, ao desconsiderar a diversidade infantil, que pouco é perpassada pelo pensamento crítico e ético, limita a implementação de ações eficazes para a promoção de saúde, a garantia de direitos e a proteção das crianças (Sarmiento, 2015).

Ao se direcionar o olhar para a infância, percebe-se as conquistas já alcançadas no que tange aos seus direitos, mas também se reconhece que, para compreendê-las de forma mais aprofundada, é essencial considerar a possibilidade de ouvir a própria criança (Ferreira, 2014). Portanto, incluí-las nas pesquisas é, também, reconhecê-las como sujeitos de direitos. Partimos, então, dessa concepção: a criança precisa ser ouvida, uma vez que entendemos que é pela sua manifestação que ela dará significação às suas experiências, bem como contará sua visão sobre seu próprio tratamento. Nesse viés, Port (2010, p. 42) contribui ao afirmar:

A fala promove uma certa captura do que é captado pelos processos perceptivos, conferindo-lhes a realidade, ou seja, possibilitando que não sejam invasivos, da ordem do real e que possam ser lembrados, sendo assim a fala fundamental, dos traços que servirão de referência para a subjetivação.

Assim, a escuta nesse processo possui o potencial de corrigir equívocos na construção diagnóstica que foram elaborados de forma precipitada e inadequada. Nesse sentido, a psicanálise, fundamentada em sua ética, busca se posicionar contra os silenciamentos, promovendo o endereçamento da palavra da criança ao pesquisador, rompendo com o apagamento de sua voz gerado pela via química produzida pelos processos medicalizantes (Carneiro, Reys, 2024).

Nesta perspectiva, torna-se imprescindível romper com a rigidez dos protocolos positivistas da ciência moderna que historicamente silenciaram e marginalizaram diversas vozes e perspectivas. Esse modelo científico, ao promover um colonialismo epistêmico, estabeleceu uma hierarquia de saberes, privilegiando e excluindo outras formas de conhecimento. Por esse motivo, torna-se urgente a descolonização da ciência, mediante a construção de novos caminhos epistêmicos e metodológicos que abarquem a totalidade das manifestações culturais. Essa "desobediência epistêmica" revela-se fundamental para desafiar a ordem estabelecida e promover a valorização de distintas formas de saber e de produção do conhecimento (Santos, Santiago, 2016).

Ademais, Sarmiento (2015) salienta a necessidade de que a produção científica rompa com paradigmas tradicionais, como a ideia de universalidade da infância, que pressupõe um desenvolvimento infantil uniforme para todas as crianças, independentemente do contexto, frequentemente tomando como referência modelos europeus e norte-americanos. O autor ressalta que a infância não pode ser concebida como uma fase de total autonomia, mas também não deve ser reduzida a uma mera etapa preparatória para a vida adulta. Nesse sentido, torna-se essencial adotar uma abordagem crítica e multidisciplinar nos estudos sobre a criança (Sarmiento, 2015).

Ao promover os estudos das infâncias e incluí-las nas pesquisas, rompe-se com as convenções oriundas do mundo adulto, nas quais as crianças assumem um papel coadjuvante. O afastamento da perspectiva adultocêntrica ocorre a partir do reconhecimento da infância também como objeto de estudo e produção de conhecimento (Sarmiento, 2015).

Como sugere Sarmiento (2015, p. 36), é urgente, portanto, que as pesquisas sobre a infância superem paradigmas tradicionais e adotem uma abordagem mais crítica e multidisciplinar. Para isso, é essencial desenvolver metodologias específicas para as pesquisas "junto das e com as crianças". Em suma, que permitam a interação delas, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e suas perspectivas respeitadas. Dessa forma, faz-se necessário lançar o olhar aos processos subjetivos da criança que, segundo Cervo (2017), é um ator social com voz ativa capaz de compreender e expor suas próprias vivências. Nesse contexto, procurou-se considerar a experiência das crianças em relação às suas percepções, assim como suas maneiras de ser e estar no mundo.

Por isso, torna-se fundamental a escuta das crianças e dos educadores, a fim de se compreender essas relações, considerando que a estrutura oferecida aos profissionais da educação é essencial para a efetivação dos processos inclusivos. Para Freitas e Baptista (2017), um ambiente favorável e mediado pelo professor pode beneficiar a aprendizagem do aluno em sua capacidade atencional. Diante do exposto, é fundamental considerar a subjetividade da criança, evitando o risco de uniformizá-la com base em padrões de comportamento estabelecidos pelo mundo adulto e pelos modelos biomédicos, com grandes chances de adentrar nos processos medicalizantes, também caracterizados pela pouca voz dos sujeitos nesse processo (Lima, 2022).

Ora, as infâncias são diversas e atravessadas por marcadores sociais e necessitam de uma visão dentro de seus contextos (Sarmiento, 2004). Escutar e acolher o que a criança tem a dizer contribui para que ela possa se constituir como um sujeito ativo nos estudos que a envolvem, promovendo interdependência e reconhecimento cultural, também produtoras de pesquisa (Werle, Bellochio, 2017).

2.4.2 Medicalização na infância: que caminhos apontam as pesquisas da CAPES?

Com o objetivo de articular nossa discussão, realizou-se um mapeamento de estudos similares para expandir nosso referencial teórico. Dada a relevância do tema para a infância contemporânea, optou-se por uma revisão de literatura. A busca, focada nas palavras-chave do tema, concentrou-se nas teses e dissertações defendidas entre 2019 e 2025, disponíveis no Portal do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES.

A revisão de literatura nos auxilia a situar e pensar a pesquisa, tendo em vista o eixo principal deste trabalho, que se ancora na escuta da criança nos processos de medicalização na aprendizagem. A revisão de literatura narrativa, apresentada neste subcapítulo como desenho metodológico, proporciona maior abrangência de análise e um viés crítico, facilitando a compreensão de um determinado tema, teoria ou contexto (Rother, 2007).

Sendo assim, considera-se relevante buscar no repositório da CAPES, no catálogo de dissertações e teses brasileiras, quais pesquisas têm se debruçado, nos últimos anos, sobre essas temáticas. Para isso, foi utilizado como descritores de busca as próprias palavras-chave deste estudo. Importante mencionar que a inserção

de descritores com os termos “escuta” ou “participação” não apresentou resultados; com isso, chegou-se a seguinte composição:

Infância AND Medicalização AND Escola AND Diagnóstico AND Patologização AND escuta: Nenhum registro encontrado.

Infância AND Medicalização AND Escola AND Diagnóstico AND Patologização AND participação: Nenhum registro encontrado.

Dessa forma, considerou-se pertinente reduzir os descritores para “Infância, medicalização, escola, diagnóstico e patologização”, aos quais obteve-se 7 estudos, sendo que dois não permitem nenhum tipo de divulgação. Abaixo, a síntese dos estudos encontrados:

Quadro 1 – Pesquisa realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, com os descritores

Estudo	Autor/Ano	Método/Participantes
Medicalização Na Infância: Um Carimbo Que Implica Na Subjetividade Da Criança	Lima (2022)	Educadores e profissionais da saúde
Medicalização e Patologização Da/Na Primeira Infância: Conversas Sobre Práticas Pedagógicas Não Medicalizantes	Oliveira (2022)	Professores (grupos focais) + observação em escola
Crianças Com Transtorno De Déficit De Atenção e Hiperatividade (TDAH): Os Sentidos Produzidos Sobre A Infância Na Perspectiva De Familiares e Profissionais Da Educação	Batista (2019)	Familiares e educadores
Representações Sociais Dos Professores Sobre O Fenômeno Da Medicalização Nas Escolas	Resende (2021)	Professores

O Trato Com A Queixa Escolar Na Educação Infantil Em Um Sistema Municipal De Ensino: Uma Análise Histórico Cultural	Tomas (2022)	Profissionais + documentos
---	--------------	----------------------------

Fonte: Criado pelos autores.

Em breve análise dos estudos encontrados, todos apresentam um olhar crítico sobre a patologização da infância no contexto educacional. Embora nenhum deles se debruce sobre a escuta da criança, realizam análises de documentações importantes, trazendo a participação de profissionais e familiares a fim de se compreender os processos e caminhos do atendimento em saúde da criança, sob diferentes perspectivas. O estudo de Lima (2022) discute como o processo de medicalização pode estigmatizar e rotular as crianças, afetando diretamente sua subjetividade e constituição de identidade. Oliveira (2022) aborda a patologização de comportamentos infantis comuns, analisando os processos de patologização e medicalização no contexto escolar e de que forma se entrelaçam às práticas pedagógicas. Batista (2019) realiza uma análise das interpretações de familiares e educadores sobre o TDAH, bem como de suas implicações no contexto escolar da criança. Rezende (2021) investiga a percepção dos professores sobre os discursos medicalizantes em sala de aula. Tomas (2022) analisa a construção das queixas escolares que culminam na medicalização, propondo uma abordagem cultural e social.

É possível perceber temas que se entrelaçam nesses estudos, como a crítica aos processos de medicalização frente aos comportamentos infantis, em especial no contexto escolar. A maior parte dos estudos aponta com frequência para o TDAH como exemplificação diagnóstica nesse processo, destacando também o papel da escola e dos professores. Os textos sugerem ainda alternativas pedagógicas por meio de práticas educacionais que apoiem a diversidade e sejam mais inclusivas.

Enquanto desenho metodológico, os estudos se concentram, em maior número, na análise crítica dos fenômenos medicalizantes. Dentre os pontos convergentes, pode-se citar o olhar crítico à medicalização e à patologização da infância, os questionamentos em relação ao diagnóstico médico e psicológico excessivo, o reducionismo terapêutico e a desconsideração do contexto social. As pesquisas analisam, em grande número, a demanda escolar em torno dos

diagnósticos e os adultos frente a esses enquadres. Os participantes das pesquisas concentraram-se, em maior número, entre educadores e familiares. Os estudos selecionados sugerem alternativas não medicalizantes, compostas pela consideração da singularidade infantil, indicando apoio psicossocial, adaptações curriculares e escuta ativa da criança.

Quanto à escuta da criança, a análise dos estudos permite identificar avanços importantes na problematização da medicalização da infância, especialmente ao dar visibilidade às práticas escolares, aos discursos docentes e às implicações dos diagnósticos na trajetória das crianças. De modo geral, as pesquisas priorizam a escuta de professores, familiares, profissionais da saúde e documentos institucionais. Nesse movimento, a criança aparece, ainda que de forma indireta, por meio das interpretações e observações dos adultos que com ela convivem. Ao mesmo tempo, observa-se que ainda há um campo em expansão no que se refere à escuta direta da criança. Em alguns estudos, como o de Oliveira (2022), identificam-se aproximações com o cotidiano infantil por meio da observação, indicando um movimento de maior sensibilidade às experiências das crianças. No entanto, de forma geral, suas vozes aparecem mediadas, o que sinaliza uma oportunidade de aprofundamento metodológico nas pesquisas futuras.

Assim, as pesquisas analisadas anteriormente convergem na crítica ao excesso de diagnósticos, ao possível reducionismo terapêutico, às práticas pedagógicas e à desconsideração do meio social, além de defenderem políticas educacionais e apoio psicossocial que evitem a medicalização. Constata-se, portanto, a necessidade de novos estudos que, para além das análises críticas já realizadas, incluam efetivamente a escuta e a participação da própria criança, reconhecendo-a como sujeito ativo no processo de pesquisa e destacando a contextualidade da medicalização a partir de sua voz. Faz-se necessário compreender como ela mesma produz sentidos para sua experiência de aprendizagem e escolarização.

3 METODOLOGIA

Este capítulo tem como objetivo descrever detalhadamente os procedimentos metodológicos que orientaram a realização desta pesquisa. O estudo parte de um contexto específico: a investigação das vivências e significados construídos por crianças que, em sua singularidade, enfrentam desafios no processo de escolarização

e são acompanhadas por um Serviço de Atendimento Especializado. Adota-se uma perspectiva teórica de base psicanalítica, que valoriza a escuta e a narrativa dos sujeitos participantes como caminhos para a compreensão de suas experiências subjetivas.

A pesquisa foi desenvolvida com seis crianças do ensino fundamental, atendidas por um Serviço de Atendimento Especializado à infância na região metropolitana de Porto Alegre. O trabalho alinha-se ao entendimento de que a pesquisa com crianças, enquanto sujeitos ativos e capazes de transformar a realidade, possibilita uma relação dialógica e de mútua troca no processo de pesquisa científica (Werle, Bellochio, 2017).

Severino (2017) afirma que a ciência se consolida a partir da atuação do pesquisador que investiga os fenômenos com uma estrutura e preceitos técnicos, mantendo o rigor científico do método e alicerce epistemológico. O papel do pesquisador, portanto, é de escuta desse processo, a partir da narrativa da criança, buscando compreender os sentidos que ela produz sobre suas experiências e possibilitando que ela se aproprie de sua própria história. Embora o pesquisador assuma um papel ativo na pesquisa psicanalítica, é o sujeito participante, com suas singularidades e experiências, que ocupa o lugar central nesse processo, dispondo de um espaço de escuta e reflexão.

A pesquisa psicanalítica, aqui proposta, busca valorizar essa relação dialógica entre pesquisador e sujeito, na qual ambos são atores ativos na construção do conhecimento. A partir disso, torna-se essencial escutá-la e compreendê-la a partir de suas perspectivas, tendo em vista que não há possibilidade de constituição metodológica que seja desvinculada do contexto e das situações em que os indivíduos estão inseridos (Morin, Ciurana, Motta, 2003).

Cabe ressaltar que a criança, a quem este projeto se propõe a escutar, pode não estar caracterizada a partir dos modelos tradicionais da deficiência, nem ser considerada público-alvo das políticas de educação inclusiva. Trata-se, antes, de alunos que, em razão da sua singularidade, expressam questões que os excluem da efetiva vivência escolar. Isso implica que muitas crianças, em razão de seu ritmo próprio de aprender, acabam não acompanhando a constância da maioria e permanecem à margem da aprendizagem e interação no ambiente escolar.

A seguir, são apresentados o delineamento da pesquisa, o contexto, os participantes, as técnicas e os instrumentos de produção de dados, e as subseções

“Momento Lúdico: Brincar e imaginar”, “Questionário de entrevistas” e “Imagens que contam histórias: foto-elicitación”. Por fim, são apresentadas as considerações éticas que nortearam o trabalho e os procedimentos adotados para a análise das informações obtidas.

3.1 Delineamento

O delineamento desta pesquisa configura-se como um estudo qualitativo de caráter exploratório, que adota a estratégia de estudo de casos múltiplos com recorte transversal. Para Stake (2011), a pesquisa qualitativa permite o enfoque e a interpretação do investigador acerca dos fenômenos em estudo, que se concretizam por meio da escuta e da análise das experiências narradas pelos sujeitos participantes. Complementarmente, foi realizada uma análise documental de encaminhamentos, laudos, pareceres e relatórios sobre a criança, com vistas a contextualizar sua trajetória de saúde e educacional.

A escuta das crianças, orientada pelos referenciais da pesquisa, demandou a consideração dos discursos que as envolvem: familiar, escolar e clínico. Esse olhar abrangente foi fundamental para auxiliar na compreensão de sua posição subjetiva. Dessa forma, para apreender os efeitos dos processos de medicalização e patologização, vinculados às dificuldades de aprendizagem na subjetividade infantil, realizamos a escuta e o acolhimento das diversas formas de manifestação (expressão) das crianças.

O método qualitativo de caráter exploratório permite ao pesquisador formular pressupostos e indagações pertinentes ao objeto de estudo, enquanto o recorte transversal possibilita sua análise em um determinado período de tempo (Yin, 2001). O trabalho de campo desta pesquisa foi realizado entre julho e dezembro de 2025, período em que ocorreu a produção de dados. A opção pelo estudo de casos múltiplos confere ao pesquisador maior expressividade e uma visão global do objeto de análise, contribuindo para a robustez da pesquisa (Yin, 2001).

Nesta etapa, o delineamento revela-se fundamental para a estruturação e condução da pesquisa, uma vez que articula a pergunta inicial de pesquisa às possibilidades de resposta, culminando na conclusão. É nesse planejamento que se consolida a validade do estudo, oferecendo sustentação para sua aplicação em

diversos contextos. Embora estruturado, o delineamento manteve-se flexível, permitindo revisões e ajustes à medida que o estudo avançava (Yin, 2001).

3.2 Contexto do Estudo

A pesquisa foi realizada em um pequeno município da região metropolitana de Porto Alegre, pertencente à região do Vale dos Sinos. A fim de situar a perspectiva social e cultural dos participantes, ressalto que o município em questão tem aproximadamente 20 mil habitantes, com forte influência da origem germânica e tem como base econômica a indústria calçadista. A articulação de serviços e espaços que as crianças frequentam com seus familiares é mencionada por elas na fase de produção de dados da pesquisa. Portanto, torna-se válido ressaltar que o município conta com os serviços da rede intersetorial, tais como Unidade Básica de Saúde (UBS), Estratégias de Saúde da Família (ESF), Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), Conselho Tutelar (CT) e Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS).

Os participantes da pesquisa são crianças matriculadas na rede municipal de ensino e frequentam um Serviço multiprofissional de Atendimento Especializado em Aprendizagem, que é um espaço de atendimento multidisciplinar de apoio à aprendizagem. O público do serviço é composto por alunos encaminhados pelas escolas públicas municipais, visando atender crianças com dificuldades específicas de aprendizagem e com entraves que possam emergir em seu processo educativo, como questões psicossociais. O serviço atende atualmente em torno de 120 crianças. Além do encaminhamento das crianças para a pesquisa, a coleta de dados e entrevistas com familiares ocorrerão no espaço do serviço onde o núcleo está sediado, enquanto os professores serão entrevistados nas respectivas escolas. O serviço conta com uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais da pedagogia, psicologia, psicomotricidade, psicopedagogia, entre outros, e é administrado pela Secretaria de Educação municipal local, atendendo à prerrogativa das legislações federais, como o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determinam como prioridade absoluta o atendimento a crianças e adolescentes.

3.3 Participantes do estudo

Como participantes deste estudo, foram selecionadas seis crianças, juntamente com seus respectivos familiares ou responsáveis, que frequentam o serviço municipal de auxílio a crianças com demandas escolares e psicossociais. A seleção foi conduzida com base nos critérios de inclusão estabelecidos e em colaboração com o serviço responsável: crianças com idade entre 6 e 12 anos, que apresentam queixas do sistema escolar relacionadas ao comportamento e/ou a dificuldades de aprendizagem e que estejam vivenciando ou tenham vivenciado processos de investigação diagnóstica vinculados a esse contexto.

Inicialmente foram pré-selecionadas dez crianças, as quais foram avaliadas quanto às possibilidades logísticas de deslocamento à sede do serviço e de acordo com a manifestação de interesse em participar do estudo. Após essa etapa de pré-seleção, permaneceram seis crianças, cujos perfis constam no Quadro 4, na seção de resultados. Para preservar suas identidades, optou-se por utilizar nomes fictícios baseados em personagens do filme *Divertida Mente 2*, que aborda as emoções que atravessam intensamente a personagem *Riley*. As escolhas dos nomes dos personagens serão explicadas na apresentação dos resultados.

Dessa forma, serão apresentadas as histórias das crianças participantes, nomeadas como Riley, Bing Bong, Jangles, Frank, Clow e Dave. O Quadro 4, localizado na seção de Resultados, descreve o perfil de cada criança, base fundamental para compreender suas singularidades no contexto investigado.

3.4 Técnicas e instrumentos para coleta de dados

A pesquisa foi conduzida a partir da seleção dos participantes, com a realização de três encontros com as crianças, um encontro com os familiares ou responsáveis e outro com os profissionais da educação. Cada encontro teve a duração aproximada de uma hora. A coleta de dados com as crianças foi desenvolvida gradualmente ao longo dos encontros, não se restringindo apenas à entrevista semiestruturada. Foram criados momentos lúdicos compostos por contação de histórias, desenhos, diálogos livres e brincadeiras. Ao explorar linguagens como o movimento, a brincadeira, o desenho, a fala e a escrita, buscamos criar um ambiente

que favoreça a expressão e estimule as crianças participantes do estudo a se sentirem à vontade.

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as crianças, voltadas às suas experiências e percepções. Adicionalmente, ocorreram encontros com os responsáveis, que neste estudo foram representados pelas mães, para a realização de uma entrevista semiestruturada, visando auxiliar na compreensão do contexto das crianças participantes. Da mesma forma, os professores também foram escutados, seguindo a técnica de entrevista semiestruturada, como forma de ampliar a compreensão do ambiente escolar.

Com o intuito de auxiliar nesse processo, em cada encontro com crianças, responsáveis-familiares e professores, foram realizadas anotações em um caderno de diário de campo. Este instrumento foi utilizado como recurso para registro dos procedimentos e das observações. A utilização do diário de campo possibilita ao pesquisador maior envolvimento e compreensão do campo de estudo, facilitando sua imersão na produção do conhecimento. Esse tipo de escrita possibilita não apenas o registro descritivo, mas também apontamentos sobre as percepções do pesquisador, os caminhos percorridos pela pesquisa, seus avanços e quais questões que demandam maior atenção. Assim, este recurso pode ser considerado um instrumento que facilita a mediação e produz intervenção, pois possibilita a leitura das situações no decorrer da pesquisa e, ao mesmo tempo, produz a própria pesquisa (Kroef *et al.*, 2020).

Ademais, foi realizada a gravação de áudio dos encontros, como meio de acessar os conteúdos trazidos pelos sujeitos de forma mais fidedigna e para preservar uma relação de alteridade da pesquisadora durante a interação com esse material. Por fim, foi conduzida a análise documental e a gravação de áudio das entrevistas, que foram posteriormente transcritas. A combinação desses recursos mostrou-se de suma importância para o avanço do estudo. Para Severino (2017), documentos e gravações constituem uma espécie de matéria-prima que será trabalhada pelo pesquisador no desenvolvimento da análise da pesquisa.

3.4.1 Momento lúdico: Brincar e imaginar

Para proporcionar às crianças uma forma mais livre e espontânea de expressar suas percepções e sentimentos, buscamos criar momentos de brincadeira

livre, utilizando-se de recursos como brinquedos, desenhos e jogos. O brincar, neste estudo, foi entendido como um mediador no processo de escuta, fundamental para que as crianças pudessem expressar suas vivências e atribuir significados às suas trajetórias, conforme a premissa psicanalítica que o valoriza como via de acesso à subjetividade infantil.

No decorrer dos encontros, foram disponibilizados brinquedos como a família lúdica terapêutica³ e bonecos dos personagens dos filmes *DivertidaMente*⁴ e *Lego City*⁵, além de brinquedos variados, inclusive aqueles que remetem a temas de saúde e escola. Encontravam-se disponíveis também brinquedos artesanais, para que a criança tivesse a liberdade de criar e inventar suas próprias brincadeiras. Diversos jogos foram disponibilizados, com a livre escolha de utilização pelas crianças. Entre eles, incluíram-se jogos que estimulavam a produção de narrativas, como um quiz com temática escolar e jogos de tabuleiro focados em situações de vida e aprendizagem. Além disso, um jogo da memória com temática de emoções também foi empregado.

Como parte da produção de dados da pesquisa, foi proposta às crianças a realização de um desenho a partir do enunciado “Eu na minha escola”. Para isso, havia disponíveis materiais como folhas e lápis de cor. A atividade foi apresentada como um convite para que cada criança representasse, da maneira que desejasse, a si mesma no espaço escolar. A escolha pelo desenho como recurso metodológico fundamenta-se na compreensão de que essa linguagem possibilita às crianças expressarem percepções, experiências e significações relacionadas ao contexto escolar, muitas vezes difíceis de serem verbalizadas apenas por meio da fala.

Após a realização dos desenhos, as crianças foram convidadas a comentar suas produções, explicando os elementos representados e as situações retratadas. Esses comentários foram considerados parte do material empírico da pesquisa, sendo analisados em articulação com os próprios desenhos e com as falas produzidas ao longo dos encontros. Dessa forma, os desenhos não foram interpretados de maneira

³ Família Lúdica Terapêutica é um conjunto de bonecos de pano flexíveis que representam diferentes membros de uma família (avós, pais, filhos, bebê e até mesmo animais de estimação), utilizado como recurso terapêutico em contextos clínicos e educacionais.

⁴ *Divertida Mente (Inside Out)* é um filme de animação, na seção de Resultados relatamos o motivo da escolha de objetos e outros elementos alusivos ao filme para compor este estudo.

⁵ Lego City é uma linha de conjuntos de blocos de montar que simula uma cidade, com prédios, pessoas, ruas, escola, supermercado, posto policial e hospital.

isolada, mas compreendidos como produções simbólicas inseridas no contexto das narrativas das crianças sobre suas experiências escolares.

Como opção, foram incluídos livros infantis que foram integrados aos materiais destinados à contação de histórias. Segundo Gutfreind (2020), a literatura infantil auxilia a criança a compreender suas questões e possibilita a narrativa sobre elas, produzindo diferentes sentidos para sua própria história de vida. Essa variedade de materiais visou criar um ambiente lúdico e seguro, estimulando-as a explorar o tema da pesquisa de forma autônoma e criativa. Todos os recursos, embora criativos e lúdicos, buscavam remeter ao objeto de estudo investigado.

Segundo Macedo (2005), o ato de brincar é uma atividade de grande envolvimento e significado para a criança, pois a insere em um universo onde o físico e o imaginário se entrelaçam. Ao interagir com objetos e dar forma a suas fantasias, a criança encontra um espaço para expressar suas emoções e construir conhecimento. Essa atividade, além de prazerosa em si mesma, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil, proporcionando oportunidades de expressão sobre o mundo ao seu redor. Ao brincar, a criança explora diferentes papéis, experimenta novas sensações e descobre as relações entre os objetos e as pessoas, construindo assim sua própria compreensão da realidade. Apesar de sua ludicidade, leveza e fantasia, o brincar traz um pressuposto de seriedade e carrega uma profundidade significativa, pois, por meio da brincadeira, a criança expressa seu mundo, percepções, sentimentos e, em suma, sua subjetividade. Nesse espaço e tempo compartilhado, ela cria o próprio universo, sendo protagonista do seu mundo e, de forma simbólica, produz sentidos para suas fantasias e criações. Com seu protagonismo, ela acaba tornando-se responsável pela fantasia e criação daquele momento. Portanto, o brincar é um jogo de ideias, sentimentos e emoções que, muitas vezes, não é percebido de forma clara pelos envolvidos (Macedo, 2005).

O ato de brincar possibilita à criança expressar e experienciar sua realidade de forma segura, num ambiente que lhe traz confiabilidade, sendo, portanto, uma forma de comunicação de seus afetos e conflitos. Winnicott (1975) aponta o brincar como uma potente ferramenta terapêutica e muito eficaz durante o processo de psicoterapia infantil, pois, segundo o autor, essa atividade permite à criança expressar seu mundo interno e elaborar conflitos emocionais. Para o autor, o não brincar da criança constitui um importante sinal de alerta, demandando intervenções apropriadas antes que qualquer ação terapêutica seja iniciada.

Assim, selecionando partes e situações do seu mundo real, na brincadeira ela expõe ao pesquisador objetos e situações que representam seus desejos, medos e fantasias mais particulares. No brincar, ela transforma a realidade externa em um palco para seus sonhos, seleciona objetos e situações do mundo real e os utiliza para representar seus desejos, medos e fantasias mais íntimos. Contudo, sem se desconectar da realidade, a criança cria um espaço mental onde o onírico e o real se misturam, permitindo-a experimentar e dar forma aos seus sentimentos mais profundos. O ato de brincar é, portanto, considerado um ato de criação e de expressão da subjetividade infantil (Winnicott, 1975).

Por meio do brincar e da experiência da encenação, a criança utiliza as narrativas inerentes a essa ação, o que lhe possibilita expressar-se pela encenação. A encenação, enquanto experiência lúdica, permite à criança a utilização das propriedades linguísticas inerentes a essa ação, o que a torna um meio de expressão. Nesse contexto, o brincar pode ser considerado como uma operação de escrita, pois por meio dele é possível ter uma leitura e compreensão da potência simbólica da criança; ainda que alguns traços não sejam claros. Assim, o brincar legitima também o lugar e a posição da criança em relação à sua própria subjetividade (Vorcaro, Veras, 2008). Dessa forma, na pesquisa, outro fator importante nesse momento é a observação das suas reações, de sua linguagem corporal e das interações que ela realiza durante a brincadeira.

3.4.2 Questionário e entrevistas - levantamento de dados sociodemográficos e narrativos

O Questionário de Informações de Perfil Social e Demográfico (Apêndice 3) foi utilizado como um instrumento estruturado para levantar dados sobre a família e seu contexto, possibilitando a descrição das características familiares dos participantes. Assim como em todas as etapas da pesquisa, a identidade dos respondentes (familiares ou responsáveis) foi preservada por meio da utilização de nomes fictícios. Conforme Severino (2017), a aplicação de questionários direciona perguntas e respostas para categorias de análise, o que consolida sua importância no levantamento inicial e sistemático de dados. Esse instrumento, por sua natureza mais fechada, foi complementado pelas entrevistas, que visavam aprofundar e ampliar as possibilidades de respostas.

As entrevistas semiestruturadas (Apêndices 6, 7, 8) constituíram uma etapa de escuta dos participantes, crianças, familiares e profissionais, com o objetivo de compreender como vivenciaram o percurso de aprendizagem e os caminhos percorridos pela criança. Esse instrumento pressupõe uma escuta atenciosa pelo pesquisador e possibilita adentrar em assuntos que podem não emergir de forma espontânea no diálogo livre (Severino, 2017).

Os roteiros de entrevista foram elaborados a partir dos temas da pesquisa, com o objetivo de obter informações detalhadas e aprofundamento na temática. Conforme Severino (2017), questionários são recursos importantes e de grande utilidade para as ciências sociais, pois dão direcionamento e possibilitam um levantamento de dados mais categorizado e robusto. Portanto, a entrevista é composta de perguntas direcionadoras do questionário, bem como o diálogo e a livre narrativa dos participantes.

3.4.3 Imagens que contam histórias: recurso metodológico de foto-elicitación

Compondo o Momento Lúdico, utilizamos como ferramenta para a produção discursiva o recurso da foto-elicitación, com imagens relacionadas a momentos escolares, familiares e de saúde. Este método consiste na utilização de fotografias ou imagens como disparadores de novas narrativas, possibilitando construções singulares e, dessa forma, proporcionando “a produção de pensamento, de diálogo e, com efeito, o convite à narração e à criação” (Marcello, Soares, 2021, s/p.).

Considera-se que a inserção da imagem na relação entre o pesquisador e as crianças configura-se como um “terceiro elemento” que produz novas construções. Esse recurso estimula a fala e a evocação de memórias na criança, além de promover a leitura da realidade e do mundo (Marcello, Soares, 2021). Neste momento, após a exibição de cada imagem, a criança era convidada a responder à pergunta: “O que está acontecendo aqui?”. As imagens utilizadas constam no Apêndice 9.

3.4.4 Quadro de síntese dos procedimentos de coleta de dados

Quadro 2 – Síntese dos procedimentos da coleta de dados

TAREFA METODOLÓGICA	PARTICIPANTES	INSTRUMENTOS DE PESQUISA E FONTE DE DADOS
Entrevista	Família; Profissionais; Criança.	Questionários e escuta
Caderno de Diário de Campo	Pesquisador	Utilizado como recurso de anotações e registros dos procedimentos, após todas as etapas.
Gravação de áudio	Criança; Profissionais; Família.	Gravador
Análise Documental	Documentos que a família obteve de profissionais de saúde, professores e coordenadores escolares.	Pareceres escolares, encaminhamentos, laudos médicos, entre outros documentos emitidos sobre a criança.
Momento Lúdico	Criança	Brincadeiras; Hora do Conto; Desenho livre.
Questionário Sociodemográfico	Família	Lista de perguntas sobre o contexto familiar.

Fonte: Criado pelos autores

3.4.5 Sequência de procedimentos de pesquisa

Quadro 3 – Sequência de procedimentos de pesquisa

AÇÃO	PARTICIPANTES	PROCEDIMENTO
1º Aproximação e escolha dos participantes.	Profissionais do Local de pesquisa e pesquisadora	Seleção de participantes e contato com os responsáveis pela criança expondo a proposta da pesquisa.
2º Entrevista	Familiares	TCLE; Questionário sociodemográfico; Entrevista semiestruturada.

3º Análise Documental	Pesquisadora	Análise de laudos, pareceres e documentos pertinentes ao processo da criança.
4º Entrevista	Profissionais (Professores e profissionais que atendem a criança no serviço)	TCLE; Entrevista semiestruturada; Conversa.
5º Momento de conhecer a criança	Criança	Termo de assentimento; Momento Lúdico; Apresentação da pesquisa.
6º Entrevista	Criança	Questionário, Ent. semiestruturada; Momento lúdico.
7º Fechamento	Criança	Momento Lúdico; Finalização da pesquisa com a criança.

Fonte: Criado pelos autores

3.5 Questões éticas

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Para sua condução, foi imprescindível a consulta da Resolução CNS/MS nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que preconiza diretrizes para a realização de pesquisa com seres humanos. Conforme esta resolução, tornou-se necessária a leitura e a utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para ser assinado pelos participantes adultos, que também receberam uma das vias. Para as crianças foi utilizado o TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido), um documento para obtenção do assentimento de participantes menores de 18 anos, conforme previsto nas normativas e resoluções da Ética em Pesquisa no Brasil. A presente pesquisa teve parecer favorável em 16 de julho de 2025 com o Parecer número 7.709.447 e CAAE número 88386325.1.0000.5347.

O processo ético desenvolveu-se primeiramente com o contato com o serviço para verificar a existência de público que atendesse aos critérios da pesquisa, além de serem explicados os objetivos, a temática e a metodologia. Nessa primeira interlocução, a recepção foi positiva, o que resultou no envio do pedido de autorização

e do termo de anuência para a Secretaria de Educação do município. Após a aprovação do CEP UFRGS, foram contatadas a Secretaria de Educação e a instituição em que a pesquisa seria realizada para dar início ao trabalho. Após a seleção dos participantes, entrou-se em contato com as famílias e responsáveis, aos quais se explanou brevemente a pesquisa e solicitou-se a confirmação do interesse em participar. Posteriormente, foi marcada a primeira entrevista com os familiares, a fim de se detalhar melhor os procedimentos, realizar a leitura conjunta do TCLE e obter suas assinaturas.

Como possíveis riscos desta pesquisa, destaca-se o aspecto emocional, uma vez que o processo de escuta poderia suscitar reflexões ou abrir questões que despertem emoções intensas ou desconfortos. Além disso, existia o risco de desconforto social, visto que o compartilhamento de informações em um ambiente diferenciado poderia gerar sensação de exposição ou desconforto nos participantes. Para a prevenção desses riscos e desconfortos, adotou-se uma escuta sensível e atenta às singularidades de cada participante. Dessa forma, foi realizada uma escuta acolhedora, reconhecendo os relatos de forma empática, evitando qualquer tipo de julgamento e respeitando os limites emocionais de cada um. Além disso, foram previstas alternativas para atenuar eventuais incômodos ao longo da pesquisa, como a possibilidade de pausas, a oferta de encaminhamento para acompanhamento psicológico, quando necessário, e o contato com redes de apoio. Dessa forma, buscou-se garantir um ambiente ético, cuidadoso e acolhedor durante todo o processo investigativo. Tais estratégias integram o compromisso com a proteção integral dos sujeitos da pesquisa, conforme preconizado pelas diretrizes éticas aplicáveis à pesquisa com seres humanos.

Por outro lado, os benefícios incluem a valorização da subjetividade, com a criação de um espaço seguro e acolhedor para que as crianças expressem seus sentimentos e suas percepções. O destaque à fala da criança permite que a pesquisa contribua tanto para práticas educativas quanto para a vida de outras crianças. A garantia de confidencialidade é outro ponto positivo, assegurando sigilo e privacidade aos participantes e proporcionando um ambiente de confiança.

A função deste documento é complementar o TCLE, com o objetivo de assegurar que os participantes compreendam as informações de maneira clara e acessível. A referida resolução estabelece os documentos necessários para pesquisas com seres humanos, entre os quais se incluem o TCLE e o TALE, que

devem ser apresentados “de forma escrita, contendo todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento acerca da pesquisa da qual se propõe participar” (Capítulo II, item II.23). Nesse sentido, o TCLE e o TALE devem explicitar os detalhes da pesquisa, como o tema e os procedimentos, direitos, riscos e benefícios, os quais se encontram anexados ao final deste trabalho.

No tangente à pesquisa com crianças, elas poderiam aceitar ou não participar do estudo por meio do TALE, conforme preconiza a Resolução 510/2016 sobre a Ética em Pesquisa, baseada na legislação anteriormente citada. Nesse sentido, sua assinatura no TALE não necessitava ser por escrito, no caso de crianças não alfabetizadas. Para essa assinatura, foram disponibilizadas outras formas de comunicação, como desenhos, o uso de uma linguagem acessível e de recursos visuais adequados à idade.

Dessa maneira, a comunicação adequada com a criança que participa do estudo é de fundamental importância para garantir os preceitos éticos em pesquisa com seres humanos. Assim, por meio do TALE, de forma clara e respeitando o desejo da criança, ela poderá ter conhecimento da proposta da pesquisa, garantindo que ela compreenda claramente qual é a sua participação e quais são as suas implicações, além de se estabelecer um diálogo aberto para que se sinta segura e respeitada durante sua participação no estudo (Coutinho, 2016).

Este estudo, portanto, fundamenta-se na premissa da lei sobre os Direitos da Criança, conforme estabelecido pela Convenção da ONU (1989, p. 3), que enfatiza o princípio do “Superior Interesse da Criança”, o qual prioriza o desenvolvimento pleno e a integralidade do cuidado e da proteção infantil. Assim, fundamentados nos direitos da criança, é essencial fornecer informações claras e adequadas, assegurando que elas compreendam e possam decidir sobre a participação, garantindo sua proteção integral durante todas as etapas do estudo (Coutinho, 2016).

Como parte de nosso compromisso ético, prevê-se, após a conclusão da pesquisa, a realização de um encontro de devolutiva com a criança e o seu responsável. Nesse momento, serão apresentadas algumas das reflexões produzidas pelo estudo, problematizando os temas investigados e explicitando de que modo as informações por eles compartilhadas foram utilizadas. O referido encontro está previsto para ocorrer após a defesa final do mestrado.

3.6 Organização e estratégia para análise de dados

A análise de dados compreende uma etapa fundamental do delineamento metodológico da pesquisa, a partir da decodificação dos dados obtidos por meio de entrevistas, gravações e análise de documentos. Nessa etapa, torna-se possível categorizar os dados e realizar cruzamentos para a análise de pontos em comum, bem como identificar temas que emergem da pesquisa (Severino, 2017).

Para Yin (2005), nos estudos de caso, é necessário organizar o material para que ocorra a codificação, ou seja, transformar os dados brutos da pesquisa em material de análise, processo realizado por meio da codificação e da construção de categorias analíticas. Nesse sentido, o desenho metodológico das pesquisas qualitativas, estruturado na linguagem, exige uma revisão cuidadosa dos materiais e das falas dos participantes, uma vez que “o desafio para o(a) pesquisador(a) repousa na obtenção de interpretações plausíveis no universo de narrações” (Souza, Santos, 2020, p. 1397).

A organização do material empírico compreendeu os registros no diário de campo, transcrições de áudio, entrevistas, questionários, bem como demais anotações e registros produzidos ao longo da pesquisa. Esses procedimentos possibilitaram o reconhecimento de assuntos emergentes trazidos pelas crianças, os quais passaram a se configurar como temas centrais de análise. O material foi separado por pastas, e todas as falas das crianças foram impressas, permitindo uma leitura minuciosa, com destaque para conteúdos considerados importantes e passíveis de interpretação e análise.

Inicialmente, realizou-se a transcrição integral das falas. Em seguida, organizou-se os materiais, imprimindo as transcrições e separando-as em pastas individuais de cada participante, juntamente com seus respectivos materiais e registros. As fontes de dados incluíram entrevistas com familiares, professores e profissionais de saúde, além de registros de campo e observações escolares. Os nomes dos participantes foram anonimizados por meio do uso de pseudônimos.

Os dados como transcrições, registros e documentos foram lidos e relidos atentamente, com o objetivo de familiarização com o material. Na primeira leitura, buscou-se uma compreensão geral das falas; na segunda, realizou-se grifos dos trechos mais relevantes; e, na terceira leitura, inseriu-se anotações e códigos provisórios, destacando temas que poderiam ser analisados posteriormente. Após

duas leituras de familiarização, foram feitas anotações nas partes consideradas mais significativas, criando unidades de significado. A esses trechos foram atribuídas categorias iniciais, que funcionaram como identificadores provisórios, mantidos de forma aberta, flexível e exploratória, sem a busca imediata por categorias fechadas.

Nesse momento, priorizou-se descrever o que estava sendo dito e como estava sendo dito, evitando interpretações equivocadas. Trata-se, portanto, de uma etapa descritiva e exploratória, cujo foco foi capturar a essência do discurso dos participantes. Priorizou-se o uso das próprias palavras das crianças, incluindo expressões inventadas, para preservar sua linguagem e voz. A partir disso, realizou-se uma breve síntese do conteúdo de cada trecho, como, por exemplo, “dificuldade escolar”, “queixa de comportamento” ou “sentimento de exclusão”.

Além das transcrições, foram relidos os diários de campo, considerando observações, posturas e organização das brincadeiras. Os desenhos produzidos pelas crianças também foram organizados e todos os arquivos da pesquisa foram sistematizados em um serviço de computação em nuvem, em pastas protegidas por senhas. As falas selecionadas para compor a pesquisa foram inicialmente destacadas em amarelo; em uma segunda leitura, aquelas consideradas mais fortes foram marcadas em vermelho, com vistas a posterior inferência em categorias analíticas.

Após as leituras das transcrições, buscou-se compreender o que estava sendo falado pelas crianças e de que forma essas falas se apresentavam, realizando um resumo sintético das ideias centrais. Em um momento posterior, os temas foram agrupados e refinados em categorias temáticas centrais. Para a análise, consideraram-se três eixos possíveis: identificar semelhanças nas falas das crianças e o que se repetia em suas vivências; analisar situações únicas que exemplificam determinadas questões dentro de um enfoque temático; e analisar aspectos que, por ocorrerem com alguns participantes, mereceram destaque e atenção.

Na análise dos dados, buscou-se adotar uma perspectiva que englobasse a experiência integral da criança em relação à tríade: dificuldades de aprendizagem, patologização e processo de medicalização, com foco em compreender as trajetórias individuais de cada participante. Para isso, os dados foram analisados considerando aspectos como a percepção das crianças sobre o diagnóstico e o tratamento, as mudanças percebidas, a aprendizagem e seus entornos, a subjetividade nesse contexto, a rede de apoio e o papel do contexto familiar e escolar.

Essa abordagem permitiu construir uma compreensão mais profunda e abrangente da experiência das crianças no processo de aprendizagem. Assim, adotou-se uma abordagem qualitativa, centrada na experiência subjetiva das crianças, com atenção especial aos percursos individuais, às percepções sobre si mesmas e ao papel e a atuação da rede de cuidados.

4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS PARTICIPANTES

Este capítulo apresenta os dados empíricos da pesquisa e sua respectiva análise. Inicialmente, no subcapítulo 4.1, “Percursos da aprendizagem: trilhas singulares das crianças participantes”, são apresentados os participantes da pesquisa, acompanhados de uma breve contextualização individualizada de seus percursos de vida, a partir do recorte da aprendizagem e da saúde. Em seguida, no subcapítulo 4.2, “Apresentação dos resultados e análise dos dados: vozes, trajetórias e significados”, são apresentados de forma mais detalhada os resultados da pesquisa, seguidos das análises.

4.1 Percursos da aprendizagem: trilhas singulares das crianças participantes

No decorrer do período em que a presente pesquisa foi desenvolvida, um notável fenômeno cultural e midiático se manifestou com o lançamento do filme *Divertida Mente 2* (no original, em inglês: *Inside Out 2*), uma produção da Pixar Animation Studios em colaboração com a Walt Disney Pictures. Esta sequência, lançada em 2024, seguiu-se ao sucesso da primeira versão, que havia chegado aos cinemas em 2015. O impacto de *Divertida Mente 2* foi imediato e massivo, alcançando um sucesso de bilheteria e conquistando amplamente o público de todas as idades, consolidando a franquia como um verdadeiro ícone da cultura *pop* contemporânea.

O filme, mais do que um mero entretenimento, tornou-se um marco simbólico, especialmente no contexto da infância e da adolescência. Sua relevância se estendeu para o mercado de consumo, resultando na produção e comercialização de uma vasta gama de brinquedos, *action figures* e diversos objetos temáticos que são ativamente utilizados e incorporados pelas crianças em suas brincadeiras cotidianas, perpetuando o universo e os personagens da narrativa.

A trama central de *Divertida Mente 2* continua a explorar a rica e complexa abordagem das emoções que atravessam intensamente a personagem principal, Riley. O enredo faz uma menção profunda e acessível aos sentimentos, à construção da subjetividade e, especificamente, aos desafios emocionais e sociais inerentes à transição da infância para a adolescência. A narrativa é construída em torno de uma metáfora engenhosa: uma “sala de comando” localizada no cérebro de Riley, onde as emoções primárias (Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojo, presentes desde o primeiro filme) precisam lidar com a chegada de novas e mais complexas emoções, como a Ansiedade, a Inveja, o Tédio e a Vergonha, que representam as turbulências típicas desta nova fase da vida.

É neste cenário de intensa e por vezes caótica convivência emocional que as cenas se desenvolvem, mostrando como a complexidade e, muitas vezes, o conflito entre essas emoções se manifestam no comportamento e nas decisões de Riley, colocando a personagem diante de novas situações, dilemas morais e desafios de autodescoberta. A representação visual e narrativa dessas interações emocionais oferece um material valioso para a reflexão sobre o desenvolvimento psíquico e a regulação emocional, temas de grande interesse para a pesquisa.

Nos encontros com a pesquisadora, as crianças participantes da pesquisa frequentemente associavam os temas de saúde mental e emoções ao filme, percebendo-o como uma linguagem familiar. Essa referência cinematográfica tornou-se um elemento recorrente, permeando diversos diálogos e atividades lúdicas. Elas compreendiam sua presença nos encontros como parte de uma pesquisa e, ao serem abordados temas relacionados à saúde mental e às emoções, recorriam frequentemente ao filme *Divertida Mente*, por se tratar de uma linguagem familiar. Essa referência tornou-se um fio condutor que atravessou diálogos e brincadeiras, sustentando as trocas estabelecidas ao longo dos encontros. A partir dessa produção audiovisual, as crianças identificavam na personagem comportamentos e sentimentos que percebiam em si mesmas, como os desafios que elas enfrentavam em cada mudança de contexto ou fase da vida.

Ao optar pelo uso de pseudônimos para nomear as crianças participantes, decidiu-se acompanhar a brincadeira por elas proposta, utilizando os nomes dos personagens do filme. Serão apresentadas as histórias de crianças participantes, no contexto da medicalização da infância, que serão chamadas de Riley, Bing Bong, Jangles, Frank e Dave. Na sequência, apresenta-se um quadro descritivo, bem como

a trajetória individual de cada criança, considerando esse material como um recurso auxiliar para a compreensão dos caminhos percorridos pelas crianças participantes no contexto investigado.

Em sequência, cinco crianças participantes mencionadas no estudo serão apresentadas com um apanhado dos seus históricos relacionados à problemática que nos orienta. Cada criança será apresentada seguindo a organização textual com os seguintes itens: a) apresentação resumida da situação familiar; b) marcos da trajetória nos campos da educação e da saúde.

Quadro 4 – Descrição dos participantes

Nome (Idade/Série)	Núcleo Familiar	Principal Queixa/Motivo Disparador para Saúde	Diagnóstico	Medicação Atual	Alfabetização (Leitura/Escreita)
Dave (8 anos/ 3º Ano EF)	Pai, mãe e irmão (6 anos)	Preocupações maternas (atraso na fala); queixas escolares (interação/comportame nto: isolamento, agitação).	TEA Nível 1 e TDAH	Atentah (cloridrato de metilfenidat o)	Alfabetizado sem queixas. Dificuldades exclusivamente comportamentai s/relacionais.
Bing Bong (10 anos/ 5º Ano EF)	Mãe, avó, tio (7 anos - TEA nível 3)	Percepção materna de sinais de diferença no desenvolvimento (complicações no parto) e atraso da fala.	TEA e Dificuldades de Aprendizagem	Risperidon a, Depakene (valproato de sódio) e Aripiprazol	Alfabetizado com habilidades avançadas. Lê, escreve bem e produz textos autorais.
Frank (9 anos/ 4º Ano EF)	Mãe, irmãs (6a e 2a), padrasto	Dificuldades de aprendizagem significativas (leitura e escrita); queixas escolares persistentes; Concentração.	1. Epilepsia focal (confirmado); 2. TDAH (hipótese em investigação).	Trileptal (oxcarbaze pina) - para epilepsia. Sem psicofárma cos.	Não alfabetizado de forma autônoma. Defasagem grave e persistente. Depende de ajuda.
Jangles (11 anos/ 5º Ano EF)	Mãe e irmão (5 anos)	Dificuldades escolares agravadas na pandemia (1º ano): falta de interesse, desatenção e não acompanhamento das atividades.	TDAH	Ritalina (10mg - cloridrato de metilfenidat o) e Nortriptilina	Alfabetização incompleta e com defasagem. Histórico de reprovação. Lê e escreve "mais ou menos".

Riley (9 anos/ 4º Ano EF)	Mãe e padrasto	Histórico de dificuldades de atenção, desatenção e impulsividade observadas pela escola desde os 6 anos.	TDAH e sintomas de TDO	Ritalina (10mg - cloridrato de metilfenidat o)	Alfabetizada, mas com fluência de leitura comprometida. Domina fundamentos, mas a leitura não é totalmente fluente.
Clow (10 anos/ 4º Ano EF)	Mãe e irmão	Dificuldades de aprendizagem significativas (leitura e escrita); queixas escolares persistentes; Concentração.	Investigação diagnóstica relacionada a dificuldades de aprendizagem.	Nenhum psicofármaco relatado.	Alfabetizado sem queixas. Engajado e com interesse por português.

Fonte 3: Criado pelos autores

4.1.1 Dave

Dave é uma criança de 8 anos que cursa, no momento da pesquisa, o 3º ano do Ensino Fundamental. Reside com a mãe (39 anos, coordenadora pedagógica, com ensino superior completo e pós-graduação), o pai (45 anos, industrial, com ensino superior completo) e o irmão (6 anos, que estuda na mesma escola).

Após contato prévio, a mãe compareceu ao serviço, demonstrando interesse e disponibilidade para a participação do filho. Durante a entrevista, apesar de demonstrar semblante sério, emocionou-se ao relatar preocupações com a socialização de Dave, mencionando que frequentemente o encontra sozinho na escola no pátio da escola. Questionada sobre as atividades extracurriculares de Dave, ela respondeu que já houve tentativas, mas sem sucesso.

No primeiro encontro, Dave chegou alegre e curioso. Após a leitura, a assinatura do TALE e a explicação da pesquisa, demonstrou entusiasmo. Mostrou-se desinibido e participativo, relatando sua rotina. Ao falar da escola, a criança contou a sensação de solidão que a acompanha no espaço educacional. Dave sugeriu que sua preferência por realizar tarefas rapidamente pode atrapalhar a convivência e gerar impaciência dos colegas. Os encontros foram organizados em blocos, pois Dave referia cansaço diante de assuntos e perguntas prolongadas, preferindo intercalar com momentos de desenho e brincadeira.

No momento lúdico, escolheu um jogo de tabuleiro sobre trânsito, demonstrando competitividade e comemorando sua vitória. Produziu desenhos sobre a vida familiar e escolar e, ao manipular brinquedos, convidava constantemente a pesquisadora para participar, explorando o ambiente com curiosidade e criatividade. Demonstrou interesse por matemática e habilidades de construção com Lego.

Dave estabeleceu bom vínculo afetivo com a pesquisadora. Seus jogos e brincadeiras envolveram a criação de cenários complexos e a elaboração de regras próprias. O brincar configurou-se como um recurso de expressão emocional, oscilando entre o desejo de proximidade e a manifestação de irritabilidade. Dave recorrentemente expressou grande desejo de socialização com os colegas.

4.1.1.1 Trajetória em Educação e Saúde

Desde bebê, Dave foi acompanhado por um pediatra, com desenvolvimento considerado adequado, embora houvesse a percepção materna de atraso na fala. Aos dois anos, uma fonoaudióloga particular sugeriu diagnóstico de autismo, o que não foi seguido pela família naquele momento. Posteriormente, uma nova avaliação identificou “língua presa”, resultando em intervenção cirúrgica e tratamento fonoaudiológico.

Na Educação Infantil (Jardim A, aos 4 anos), começaram as queixas escolares, focadas em interação e comportamento, sem prejuízos à aprendizagem. Em um espaço clínico infantil, recebeu o diagnóstico de TDAH e iniciou medicação (fluoxetina e risperidona). Posteriormente, a psiquiatra revisou o caso e acrescentou o diagnóstico de autismo (nível 1), passando a ser reconhecido como aluno do processo inclusivo.

A trajetória envolveu ajustes medicamentosos devido a efeitos colaterais (perda de apetite, irritabilidade) e, em 2024, a substituição pelo medicamento Atentah, indicado por uma nova neurologista. No contexto escolar, as queixas concentram-se persistentemente em comportamento e interação social, mais do que em aprendizagem. A criança relatou desconforto por ser frequentemente identificada pelo diagnóstico.

Em alguns anos, contou com monitor de apoio; em outros, não. A família relatou que os registros escolares enfatizavam agitação, isolamento e dificuldade de permanecer sentado, enquanto a mãe percebia a instituição com pouco preparo para

lidar com necessidades específicas. A ausência do monitor/profissional de apoio escolar em certos períodos foi apontada como agravante, evidenciando contradições entre o discurso e a prática inclusiva.

O caso configura-se em um circuito clínico-escolar em que família, escola e serviços de saúde reforçam queixas compreendidas prioritariamente por categorias médicas. Observa-se uma trajetória marcada por uma medicalização progressiva, na qual o discurso clínico organiza a leitura escolar do comportamento, ainda que o interesse pelo aprender e a capacidade imaginativa permaneçam preservados.

4.1.2 Bing Bong

Bing Bong tem 10 anos e está cursando o 5º ano do Ensino Fundamental. Reside com a mãe (30 anos, professora auxiliar, com ensino superior em andamento em Pedagogia), a avó (com nível superior em Pedagogia e atua como profissional de apoio à inclusão) e o tio (7 anos, adotado pela família, diagnosticado com autismo nível 3 não verbal, que estuda na mesma escola). O pai (industrial) tem pouco contato com a criança.

Após contato prévio, a mãe compareceu ao serviço, demonstrando interesse e colaboração, dizendo que a participação na pesquisa seria importante na trajetória escolar do filho. No primeiro encontro, Bing Bong chegou alegre e curioso, assinou o TALE com entusiasmo e mostrou-se animado, prestativo e afetivo, estabelecendo bom vínculo com a pesquisadora. Comunicou-se com propriedade sobre seus pensamentos e rotina, mantendo-se engajado e demonstrando curiosidade.

Bing Bong trouxe seus próprios livros e seu microscópio para os encontros, compartilhando com orgulho suas criações, como o mundo imaginário “Bing Bongnópolis”. Sua principal forma de expressão é o brincar, utilizando Lego, jogos digitais (Roblox, Minecraft) e narrativas inventadas para construir cenários complexos com regras próprias, revelando potencial simbólico e elaboração emocional.

Manteve interações afetivas, incluindo abraços apertados na chegada e saída. Os colegas participam de suas brincadeiras e demonstrações científicas com o microscópio, embora haja tensão em alguns momentos quando ele sente que parte de seu mundo imaginativo permanece incompreendido pelos colegas.

4.1.2.1 Trajetória em Educação e Saúde

A mãe relatou que percebeu sinais de diferença no desenvolvimento, associados a complicações no parto (falta de oxigênio) e atrasos nas respostas no primeiro ano de vida. Por volta de 1 ano e meio, um neurologista identificou atraso na fala e solicitou exames (o eletroencefalograma apontou alteração sugestiva de possível epilepsia), mas as investigações foram suspensas pela família.

Aos quatro anos, iniciou atendimento psiquiátrico e, aos cinco, recebeu o diagnóstico de autismo após avaliação. Foi iniciada medicação (risperidona e depakene) para dificuldades de sono e agitação, o que, segundo a família, estabilizou a rotina e melhorou o desempenho escolar.

Bing Bong manteve acompanhamento psiquiátrico contínuo, com ajustes medicamentosos. Apresentou visões e alucinações auditivas, levando à introdução de aripiprazol e à hipótese de esquizofrenia por um profissional, posteriormente interpretada como reações paranoides associadas à medicação. A nova medicação estabilizou o quadro.

A criança ingressou na Educação Infantil aos 1 ano e 3 meses sem que a escola relatasse alguma diferença ou atraso. Ele também frequentou instituições onde a mãe ou avó trabalhavam, se sentindo acolhido. Atualmente, no ensino fundamental, está em uma escola sem vínculo familiar direto, mas a descreve como uma ótima escola. Seu engajamento depende do estado emocional e interesse, com maior envolvimento em matemática e ciências e dificuldades em português e geografia. Assim, sua aprendizagem é mais produtiva quando vinculada a interesses pessoais (ciência) e contextos práticos (brincar, jogos digitais).

Bing Bong compreende seu diagnóstico, mas não o vivencia como limitador cognitivo. A narrativa evidencia um percurso de medicalização progressiva, no qual o campo da saúde assume papel significativo no comportamento, enquanto a escola aparece como lugar de acolhimento, porém dependente dos direcionamentos clínicos para a condução pedagógica.

4.1.3 Frank

Frank tem 9 anos e está cursando o 4º ano do Ensino Fundamental. Reside com a mãe (30 anos, estudante de Pedagogia e estagiária), o padrasto (44 anos,

trabalha na construção civil) e duas irmãs (6 e 2 anos). Mantém bom vínculo afetivo com o pai biológico (eletricista), com quem realiza visitas regulares.

Após o primeiro contato, a mãe de Frank compareceu ao serviço para compreender os detalhes da pesquisa, demonstrando interesse e disponibilidade da família para a participação do filho no estudo. Durante a entrevista, mostrou-se participativa e interessada, afirmando que a pesquisa poderia ser importante para a trajetória escolar de Frank.

No primeiro encontro, Frank chegou um pouco tímido, porém curioso, e assinou o TALE demonstrando aceitação e interesse. No decorrer dos encontros, mostrou-se participativo, relatando sua rotina escolar e contexto familiar.

Frank demonstrou curiosidade pelos jogos e brinquedos disponibilizados. Trouxe uma peteca de pena de galinha, feita por ele mesmo, para brincar com a pesquisadora e interessou-se por fazer construções com as peças do Lego. Em suas falas, mencionou com frequência questões financeiras, se referindo a objetos de colegas e deduzindo que seriam “ricos”.

Em seus relatos, mencionou assuntos de autoestima e fez comparações. A relação com o pai biológico é positiva, enquanto com o padrasto percebe-se certa barreira afetiva. A mãe configura-se como principal mediadora de sua escolarização.

4.1.3.1 Trajetória em Educação e Saúde

Frank possui diagnóstico confirmado de epilepsia focal e faz uso de medicação (Trileptal), sem alterações significativas em sua vivência escolar. A mãe relata que aguarda há dois anos consulta com neurologista na rede pública e, devido à demora, buscou atendimento particular.

No decorrer da pesquisa, ocorreu a consulta em que o neurologista solicitou exame WISC⁶, já realizado anteriormente em função de queixas escolares, e levantou a hipótese diagnóstica de TDAH, ainda em investigação. No momento, Frank não faz uso de psicofármacos além da medicação para epilepsia.

⁶ WISC (Escala Wechsler de Inteligência para Crianças) é um instrumento padronizado de avaliação cognitiva para crianças de 6 a 16 anos, que mensura domínios como compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de processamento, resultando em um QI Total.

Segundo a genitora, ele apresenta dificuldades de aprendizagem desde o 1º ano. Aos nove anos, ainda não lê nem escreve de forma autônoma, esquecendo rapidamente o conteúdo. Já frequentou três escolas diferentes no município, com adaptação difícil em novos contextos. Na escola atual ele conta com o apoio de professora auxiliar, de forma não contínua, com quem mantém vínculo positivo de afeto e confiança. Segundo os relatos da mãe, o dia que a professora auxiliar vai na sala é aguardado com expectativa por ele.

A queixa escolar apareceu como eixo de mediação, mobilizando encaminhamentos médicos, neurológicos e de saúde mental. Frank recebe acompanhamento psicológico e psicopedagógico e relatou sentir-se triste com comentários sobre as suas dificuldades, mas afirmou que a possível condição de TDAH não influencia sua vida.

Frank disse gostar de estudar e da escola, embora reconheça dificuldade em pedir ajuda quando não consegue realizar as tarefas. Em relação à rede intersetorial de cuidados, mantém acompanhamento psicológico no CREAS e segue com neurologista particular em andamento.

A mãe é a principal mediadora no processo de escolarização e aprendizagem, ainda que o pai também ofereça apoio. Apesar dos desafios, Frank demonstrou gosto pelo aprendizado, principalmente quando recebe orientação clara, e mantém boa convivência com professores e colegas, embora se entristeça diante de conflitos ou disputas. Frank expressou gostar do recreio, de interações lúdicas e de jogos, além de valorizar a ajuda recebida nas atividades escolares.

4.1.4 Jangles

Jangles tem 11 anos e cursa o 5º ano do Ensino Fundamental. Reside com a mãe (37 anos, pedagoga pós-graduada) e o irmão mais novo (5 anos), que estuda na mesma escola. A relação entre os irmãos é próxima e afetiva, ainda que apresente conflitos cotidianos. O contato com o pai é praticamente inexistente desde a separação do casal, quando Jangles tinha 7 anos, embora anteriormente mantivessem bom vínculo. Em contrapartida, o vínculo com os avós paternos e maternos é positivo e frequente, mantido por vídeo chamadas regulares e visitas. Jangles também passa parte do contraturno na casa da avó materna, onde se sente

acolhido e confortável. A mãe demonstra grande preocupação com a escolarização e a socialização do filho.

A mãe apresentou disponibilidade e interesse para a participação de Jangles na pesquisa. Durante a entrevista, Jangles afirmou não querer falar sobre o pai, tendo sua vontade respeitada. Demonstrou diferentes formas de expressão, com destaque para o diálogo. Identificou e expressou emoções e sentimentos com clareza, embora costume tentar resolver situações sozinho antes de recorrer aos adultos. Revelou também consciência social, realizando críticas a desigualdades, inclusive raciais. Ele valorizou gestos simples e demonstrou satisfação ao conseguir realizar tarefas que antes considerava difíceis, especialmente escolares.

Foi possível observar que a criança utiliza a fantasia em brincadeiras e jogos como recurso de comunicação e elaboração de vivências difíceis, como acidentes e medos, transformando-os em narrativas. Demonstra preferência por atividades práticas e criativas, como preparar receitas, desenhar, montar cenários e brincar com elementos da natureza.

Jangles relatou que possui limitações e dificuldades na aprendizagem, o que o faz sentir-se diferente dos colegas, ainda que se perceba capaz de estabelecer relações sociais. Na escola, disse que por vezes permanece solitário no recreio, buscando atividades criativas. Outro aspecto que se destacou na interação com Jangles foi a sensibilidade e empatia pelo outro, utilizando a imaginação e a criatividade lúdica como estratégia para lidar com sentimentos de solidão e frustração. A criança também demonstrou a tendência de “se fechar” ao perceber-se diante de situações de desaprovação por parte de adultos, especialmente pela mãe e pela professora.

4.1.4.1 Trajetória em Educação e Saúde

Segundo a mãe, durante o percurso na Educação Infantil, não havia queixas significativas sobre o desenvolvimento de Jangles. As dificuldades surgiram no 1º ano do Ensino Fundamental, coincidindo com o período pandêmico, o nascimento do irmão e a separação dos pais. Ao traçar uma linha do tempo, observa-se a convergência de acontecimentos relevantes em sua rotina: isolamento social, perda do contato frequente com o pai e a mudança de endereço da sua escola. A escola

mudou para local mais amplo, mas, embora a mudança estrutural fosse positiva, a mãe de Jangles relata que houve dificuldades de adaptação ao novo espaço.

Jangles foi encaminhado ao neurologista, que inicialmente descartou alterações em exames de sono e atribuiu as dificuldades ao contexto pandêmico. Em consulta com o profissional, Jangles demonstrou intenso interesse pelos brinquedos, mantendo-se concentrado e pouco responsivo aos chamamentos dos adultos, o que gerou suspeita inicial de autismo, posteriormente descartada.

No decorrer das investigações que explicassem as dificuldades de aprendizagem de Jangles, o neurologista sugeriu o diagnóstico de TDAH. Assim, iniciou-se o uso de risperidona por dois meses, que foi suspenso em razão de ganho de peso e inchaço repentino da criança. Em uma nova avaliação, Jangles passou a fazer uso de Ritalina (10 mg) e, mais tarde, Nortriptilina, com o objetivo de auxiliar no controle da frustração, conforme relato da genitora.

A trajetória escolar de Jangles foi marcada por dificuldades significativas na alfabetização, especialmente em leitura e escrita cursiva, culminando em reprovação no 3º ano. O engajamento nas atividades melhorou visivelmente quando houve o estabelecimento de vínculos afetivos com os seus professores e ele demonstrou preferência por atividades artísticas e criativas, como desenho e arte, apresentando maior dificuldade em exercícios repetitivos e mecânicos.

A mãe relatou que as queixas escolares motivaram a busca por um segundo neurologista, que, ao analisar cadernos e documentos escolares, confirmou o diagnóstico de TDAH e manteve a medicação. Jangles reconheceu que o medicamento o auxilia em seu foco, mas afirmou que sua atenção varia conforme o interesse pela atividade. Jangles segue com o acompanhamento psicológico e psicopedagógico.

A história de Jangles evidencia como um conjunto de eventos críticos, como a pandemia, as mudanças familiares e a transição escolar, convergiu para a medicalização das dificuldades de aprendizagem. O diagnóstico e o uso de medicação passaram a organizar parte significativa das respostas institucionais às suas necessidades, deslocando o foco de uma compreensão psicossocial e pedagógica do contexto para uma leitura predominantemente biologicista e individualizada, ainda que permaneçam evidentes seus recursos criativos, sua sensibilidade relacional e seu potencial simbólico no modo como Jangles elabora suas experiências.

4.1.5 Riley

Riley é uma menina de 9 anos que está cursando o 4º ano do Ensino Fundamental. Ela reside com a mãe (28 anos) e o padrasto (29 anos). O pai biológico não possui convivência frequente, mas é mencionado com tranquilidade. Em seus cuidados, a criança possui uma rede de apoio dos avós maternos, que moram no mesmo pátio, e de um casal de tios, configurando-se um ambiente familiar afetivo.

A mãe mostrou-se presente e comprometida com a participação na pesquisa. Riley expressou sua aceitação no TALE por meio de desenho, inserindo diversos símbolos que, segundo ela, representavam sua alegria em participar. Apresentou dificuldade em aceitar o encerramento da etapa de produção de dados, relatando se sentir bem com a pesquisa.

No decorrer dos encontros Riley demonstrou espontaneidade, afeto e criatividade. A criança conversava bastante e participava ativamente das atividades. Riley revelou medo de permanecer sozinha, dormindo com a mãe e o padrasto, trazendo este assunto para a pesquisa.

Durante a convivência, Riley demonstrou que é detalhista e busca “perfeição” em suas produções, especialmente em desenhos ricos em detalhes. Engaja-se em atividades lúdicas e imaginativas, como desenhar, recortar, fazer dobraduras e construir com Lego, criando casas, cidades e narrativas elaboradas. Demonstra interesse por objetos colecionáveis, expressando cuidado e organização nas brincadeiras. Prefere atividades que envolvem movimento e imaginação, nas quais se envolve intensamente. Riley reage rapidamente à frustração, porém consegue administrar a situação quando recebe orientações e limites, reconhecendo e solicitando ajuda quando necessário. Ela relata que o diagnóstico de TDAH atravessa sua vida e seu processo de aprendizagem, contudo demonstra uma posição de aparente indiferença em relação a ele, quando questionada, afirma que isso não lhe afeta significativamente.

4.1.5.1 Trajetória em Educação e Saúde

Riley apresenta histórico de dificuldades de atenção desde os 6 anos, o que motivou encaminhamentos para avaliação especializada. Ela foi diagnosticada com TDAH e sintomas de transtorno oppositor aos 7 anos, realizando acompanhamento

com neuropediatra. Atualmente faz uso de Ritalina (10 mg) há quase dois anos, principalmente antes do horário de ir para a escola e em tarefas que exigem maior foco. Ela relata que tem, por um período de tempo, melhora na atenção e concentração.

Apesar de alfabetizada, sua leitura ainda não é totalmente fluente. Quando apoiada pela professora, descrita como paciente e atenta, apresenta avanços significativos, sobretudo na concentração e na escrita em sala. Gosta de ir à escola e é participativa, embora manifeste resistência diante de atividades que considera menos atrativas. A professora relatou que Riley acompanha o ritmo de ensino-aprendizagem da turma, compreende os conteúdos e apresenta uma evolução satisfatória em sua aprendizagem, sendo a única dificuldade relacionada a um ritmo mais lento. A professora também apontou em Riley criatividade e inteligência, especialmente em atividades práticas e lúdicas, e que seu desempenho melhora consideravelmente quando recebe apoio direto e contínuo da professora.

Riley participa de diversas atividades extracurriculares, como idas ao Centro de Tradições Gaúchas - CTG⁷, dança e escotismo, que favorecem a socialização. A rede de apoio, familiar e comunitária, configura-se como elemento relevante para seu desenvolvimento integral, articulando cuidado, rotina e pertencimento social.

A história de Riley exemplifica um percurso em que o diagnóstico de TDAH e o uso de medicação são incorporados como recursos auxiliares para a atenção, sem se constituírem como eixo central de sua identidade.

4.1.6 Clow

Clow tem 10 anos e está cursando o 4º ano do Ensino Fundamental. Atualmente encontra-se em sua segunda escola, após ter frequentado outra instituição anteriormente. Reside com a mãe e o irmão, realizando visitas espaçadas ao pai, com quem mantém boa relação, ainda que mais distante. Em casa demonstra vínculo familiar positivo e grande apego aos animais de estimação, descrevendo com riqueza de detalhes a sua rotina de cuidados diários. As suas atividades escolares

⁷ Centro de Tradições Gaúchas (CTG) é uma entidade cultural dedicada à preservação e divulgação das tradições, danças e costumes do estado Rio Grande do Sul/Brasil, promovendo atividades como danças artísticas e eventos comunitários.

são organizadas pela mãe. É também ela quem regula o tempo de tela de jogos e uso de internet, relatando que há tensionamentos neste quesito.

Após o primeiro contato, a mãe demonstrou interesse e disponibilidade para a participação do filho. A postura familiar revelou-se colaborativa e aberta ao processo investigativo.

No primeiro encontro, Clow mostrou-se bastante retraído, referindo cansaço, aspecto que se modificou nos encontros subsequentes, nos quais se mostrou mais animado e participativo. Clow comunicou-se bem, demonstrou criatividade e curiosidade nas atividades propostas.

Clow relatou que tem interesse e curiosidade sobre animais, principalmente gatos, e em seus desenhos os animais de estimação estavam juntos. No desenho, revelou cuidado com detalhes como cores, expressões e arquitetura dos espaços representados. Engajou-se com maior facilidade em propostas que envolvem movimento, exploração ou construção, preferindo atividades práticas e visuais, como Lego, quebra-cabeças e jogos de memória.

4.1.6.1 Trajetória em Educação e Saúde

Clow relatou gostar da escola e do processo de aprendizagem, demonstrando entusiasmo especial por ciências, português, matemática, inglês, artes e educação física. Conforme seu relato, seu engajamento aumenta em atividades práticas e visuais, nas quais evidencia concentração e interesse contínuo. O ambiente escolar é descrito por ele como “legal” e acolhedor. Na escola, mantém boa relação com colegas e professores, possuindo um amigo próximo com quem compartilha brincadeiras no campo de futebol, o que indica vínculos sociais positivos e estáveis.

O caso de Clow destaca-se pela ausência de diagnósticos clínicos formais, estando em investigação, sendo a principal questão de investigação centrada nas dificuldades de aprendizagem. Seu percurso de educação e saúde foi descrito pela mãe, e pelos documentos emitidos, predominantemente a partir do contexto escolar e de seus interesses pessoais, evidenciando boa socialização e interesse nas atividades. O ambiente escolar é percebido por ele como um espaço prazeroso e de descobertas, seus interesses por animais e natureza funcionam como motores de aprendizagem e expressão criativa.

4.2 Apresentação dos resultados e análise dos dados: vozes, trajetórias e significados

Este capítulo se constitui da essência interpretativa desta investigação, no qual os dados produzidos no contexto da pesquisa são submetidos a uma análise sistemática, à luz do referencial teórico que orienta este estudo. Buscamos compreender os sentidos atribuídos pelas crianças, e seus entornos, às vivências de dificuldades escolares, bem como de que modo se articulam com os processos de patologização e medicalização presentes em seus percursos de vida.

4.2.1 Traçando o percurso analítico

As análises apresentadas foram construídas no estudo do material empírico, composto por falas recorrentes consideradas preponderantes por estarem relacionadas às experiências e percursos das crianças participantes na relação com a aprendizagem e o acompanhamento em saúde mental. Realizamos recortes específicos dos materiais encontrados, privilegiando situações singulares nas narrativas escutadas e gravadas que se mostraram significativas na investigação. A apresentação dos recortes foi feita por meio de trechos de diálogos entre os participantes e a pesquisadora, bem como termos específicos empregados pelos próprios participantes, que serviram de exemplos para embasar as análises.

As Unidades de Análise foram enumeradas, totalizando 37 Unidades de Análise. Um dos critérios utilizados está ligado aos aspectos comuns nas produções das diferentes crianças integrantes do estudo; As produções pontuais foram aquelas consideradas emblemáticas e que permitiram a compreensão de relações da criança ao lidar com as suas particularidades no contexto escolar no processo de inclusão e suas vicissitudes. Entendemos que realizar análises de questões em comum entre os participantes e recortes pontuais permitiu contemplar singularidades, preservando a complexidade das experiências vividas e evitando generalizações reducionistas.

Para a organização desta discussão, a análise foi estruturada em cinco eixos temáticos principais, que ajudam na compreensão do objeto de estudo. Primeiramente, nos debruçamos sobre a categoria “Desejo de Aprender”, que busca analisar o desejo de aprender como dimensão subjetiva, evidenciada nas falas, interesses e experiências das crianças, compreendendo a aprendizagem não apenas

como desempenho escolar, mas como um movimento sustentado no vínculo, nos sentidos atribuídos ao saber e nas possibilidades de expressão oferecidas pelo ambiente. Em segunda análise, está a categoria “*Ajudação: Aprender em Relação e Processos Inclusivos*”. Este capítulo propõe uma reflexão sobre dispositivos clínico-pedagógicos e os processos de aprendizagem de crianças que são alvo da perspectiva da educação especial e, ao mesmo tempo, não conseguem acompanhar o ritmo de aprendizagem da turma. Após esta análise, vamos adentrar na categoria “*Infância, Socialização e Laço Social: O Aprender no Encontro*”, fazendo uma reflexão em como as dificuldades de aprendizagem se entrelaçam nas dinâmicas das relações sociais pelo vínculo com seus pares e o mundo adulto. Em seguida, a categoria “*A (Des)atenção para Além do Déficit: Significados e Contextos*”, seção na qual se buscará compreender a construção diagnóstica que emergiu nos casos analisados, em que as dificuldades atencionais culminaram no diagnóstico de TDAH, seção pela qual se busca a compreensão sintomática da ideia de desatenção como um sintoma exclusivamente orgânico, buscando um olhar mais amplo. Por último, a categoria “*A Participação Infantil na Pesquisa: Escuta e Lugar*”, que possibilita refletir sobre o método de escuta como instrumento ético e epistemológico, que pode desvelar competências e a voz infantil, levando em consideração a criança como sujeito produtor de pesquisa.

Este capítulo não se limita à apresentação de resultados, mas propõe um convite ao leitor para escutar a criança em interlocução com a pesquisadora, percorrendo um caminho interpretativo que ultrapassa os ruídos diagnósticos. A escuta da criança em sua singularidade, valorizando a narração de sua própria história e de seu percurso no contexto da aprendizagem, consolidou-se como elemento norteador e eixo metodológico central desta pesquisa. Além disso, são apresentadas as Unidades de Análises de diálogos entre a pesquisadora e as crianças participantes, dos quais se destacaram expressões significativas que materializam as análises, ilustradas por excertos de falas utilizados como exemplos ao longo do capítulo.

4.3 Desejo de aprender

Há muita sabedoria pedagógica nos ditos populares. Como naquele que diz: “É fácil levar a égua até o meio do ribeirão. O difícil é convencer ela a beber a água...”. De fato: se a égua não estiver com sede, ela não beberá água por mais que o seu dono a surre... Mas, se estiver com sede, ela, por vontade própria, tomará a iniciativa de ir até o ribeirão. Aplicado à educação: “É fácil

obrigar o aluno a ir à escola. O difícil é convencê-lo a aprender aquilo que ele não quer aprender... (Rubem Alves, em O Desejo de Ensinar e Arte de Aprender, 2012)

Na perspectiva psicanalítica, o conceito de desejo não se resume à vontade ou ao querer algo, mas está atrelado à constituição psíquica e à subjetividade humana. Parte de algumas premissas fundamentais, como a ideia de que o desejo vem do Outro, indicando que a criança se constitui como sujeito desejante desde as relações primordiais do início da vida, passando por momentos de dependência inicial e de diferenciação em relação ao outro, até chegar ao processo de individualização. A individualização é um processo extenso, construído desde a infância até a vida adulta, no qual o sujeito se estabelece como um ser íntegro. Essa ideia de integralidade, contudo, é simultaneamente atravessada pela incompletude, resultando numa espécie de "dobra discursiva": há uma prontidão, mas que coexiste com uma falta de prontidão.

Constituímo-nos como sujeitos faltantes, já constituídos e, ao mesmo tempo, em permanente processo de constituição, movimento que gera a vida, as buscas, as vontades e as não vontades, entre outras expressões que marcam a individualidade e que, contudo, também se articulam ao social e à cultura desde a origem. Mencionamos acima que o desejo vem do Outro e, ainda, podemos considerar que o desejo se dirige ao Outro, estabelecendo laços sociais nos quais encontramos diferentes formas de amarração, ou seja, de enlaçamento. Nesse sentido, o desejo move os sujeitos na busca por vínculos com o mundo, com o saber e com as relações simbólicas.

O desejo se situa na ordem pulsional, sendo essencial à constituição psíquica. O termo desejo se expandiu muito e diversas leituras são possíveis fora do campo psicanalítico. Aqui interessa-nos o desejo que move e rege nossas pulsões (Ramos, Falcade, Albino, 2020) e mais especificamente a pulsão epistemofílica, na qual a criança, ao ter curiosidade sobre como as crianças nascem e sobre suas origens de filiação, funda o desejo de conhecer. Conforme Freud (2016), a pulsão de saber (ou pulsão epistemofílica) emerge das investigações sexuais infantis, deslocando-se posteriormente para outros campos do conhecimento. Esse movimento funda o desejo de conhecer como uma busca que jamais se completa, mantendo o sujeito em permanente interrogação. A partir disso, o desejo de conhecer ganha variados e múltiplos desdobramentos na vida de uma pessoa e da sociedade.

Cabe, com isso, refletir sobre como a relação subjetiva com o conhecimento e com a escola se torna um fator determinante para os percursos de aprendizagem. O escritor Rubem Alves, ao recorrer à sabedoria dos ditos populares, oferece uma metáfora para refletir sobre essa questão, como percebemos na epígrafe desta seção: assim como não se pode forçar a égua a beber água se ela não estiver com sede, também não é possível impor o aprendizado quando o desejo não está presente. A presença do aluno em sala de aula não garante, por si só, o envolvimento subjetivo da criança com o saber, tampouco a construção de sentidos em relação ao que lhe é proposto a aprender.

Aplicada ao campo educacional, essa metáfora evidencia a distinção entre o frequentar a escola e desejar aprender. Neste sentido, o aprendizado não se sustenta apenas pela obrigatoriedade e exigência externa como a imposição curricular, mas depende de condições que mobilizem o interesse, o vínculo e a curiosidade da criança. Trata-se de um processo que busca despertar o desejo pelo saber, tornando o aprender uma iniciativa própria. Nesta categoria de análise, propomo-nos a investigar o desejo de aprender como elemento central para uma leitura das experiências das crianças no contexto escolar, compreendendo o desejo pelo saber como um fenômeno relacional e contextualizado. Ao ser entrevistado, Lajonquiere dá pistas sobre como esse desejo pode ser despertado:

Na escola, a criança deve – em certo sentido e como dizemos em português – ter oportunidade de dizer a que veio à vida. Ou seja, ela deve poder dar provas a si mesma da sua dignidade humana, de seu investimento nesse trabalho de conquista de um lugar na história em curso. Para se aceder ao saber, os saberes, ou ao conhecimento – como se diz em português – requer-se de algo mais que o ensino dos conhecimentos. O saber por si só não “cola”, isto é, não adianta colocar um professor que vai repetir como se fosse um papagaio. [...] O saber em si não cola, o que “dá liga” é o desejo que não é outro que seu avesso. Os adultos, os professores, são – como dizia – embaixadores desse outro mundo habitado por grandes espíritos. É em nome deles que ensinamos às crianças. Mais ainda, é em nome da dívida que temos com eles que nos endereçamos às crianças. Na educação trata-se, assim, de darmos testemunho do desejo que nos habita, de nossa sujeição à história (Rodrigues, Reis, 2018).

Para Cavalheiro e De Araújo (2018), é notória a diminuição do desejo de aprender na atualidade, mesmo quando há possibilidades de acesso e condições favoráveis à sua efetivação. Essa falta de desejo é vista como uma dificuldade frequentemente interpretada como problema individual ou familiar. No entanto, aprender é um processo complexo, que não pode ser mensurado apenas pelos

resultados. Faz-se importante considerar os diferentes fatores envolvidos e compreender a aprendizagem como um processo que faz sentido para o sujeito. Ainda para os autores, necessita-se pensar a educação de forma mais aberta e criativa, a partir de experiências que envolvam o estudante e favoreçam sua participação ativa, possibilitando que ele construa seu próprio caminho no aprender. Assim, o conhecimento deixa de ser apenas repetição e passa a ter mais sentido, a partir da valorização das formas singulares de aprendizagem, em que o estudante possa se expressar, criar e se envolver de maneira mais viva com o que aprende. Esse desejo é nascido e despertado no encontro com o outro, pois “todo desejo é produção de realidade” (Cavalheiro; De Araújo, 2018, p. 203). Para Lajonquiere (1999), a inserção da criança no campo da linguagem e do discurso é condição para sua constituição como sujeito desejante.

No decorrer da pesquisa, emergiram no diálogo com as crianças participantes as dificuldades de aprendizagem, de concentração e a procura de distrações ligadas à falta de desejo de realizar as atividades educacionais componentes do currículo. Dessa forma, considera-se relevante abordar essas questões, buscando compreender como esse processo de desejo se constitui, a fim de entender os impasses para além de uma leitura que reduz a aprendizagem à atenção ou à capacidade cognitiva isolada, mas, por meio da perspectiva psicanalítica, esmiuçar esses processos. O despertar deste desejo é um desafio ainda maior para a escola, tendo em vista a oferta massiva de entretenimento vivenciada nos dias de hoje, que gera atividades prazerosas, como abordam Lima e Roavi (2022). Mostra-se importante dizer, também, que um ponto convergente entre a psicanálise e a pedagogia é a compreensão de que a aprendizagem está intrinsecamente ligada à subjetividade, às experiências e ao desejo de conhecer (Corrêa, Coutinho, 2024).

O desejo de saber adquire espaço e materialidade nos diálogos individuais entre a pesquisadora e os participantes. Vejamos no enunciado a seguir o relato de Clow, falando sobre as dificuldades de aprender ligadas ao desejo:

Unidade de Análise 1:

Pesquisadora: Sobre aprender na escola, o que você acha mais difícil?

Clow: Na hora de aprender, quando a gente não tá com vontade de estudar, isso é o mais difícil.

O tema reaparece nas atividades seguintes. Quando Clow observa a Figura 19, reproduz a mesma impressão ao ver a imagem da criança de cabeça baixa e séria:

Unidade de Análise 2:

Pesquisadora: O que você vê aqui nesta figura?

Clow: Tem um guri que não está querendo estudar.

Quando Clow responde na Unidade de Análise 1, que a aprendizagem é mais difícil *na hora de aprender, quando tu não está com vontade de estudar* e identifica na figura uma criança que está sem o desejo de estudar, ele está apontando para algo essencial: a dimensão psíquica do desejo ou da falta dele na aprendizagem. A resposta não é apenas um comentário comportamental; ela revela como o envolvimento com o saber está ligado a algo que pulsa internamente, que não se reduz apenas à vontade consciente, mas a uma implicação subjetiva com o conhecimento.

Neste sentido, o desejo de aprender não é simplesmente vontade de assimilar conteúdos, mas uma disposição subjetiva que emerge a partir de encontros significativos com o mundo, com outras pessoas e com aquilo que nos causa interesse e curiosidade. Logo, o ato de aprender está intrinsecamente ligado ao desejo. A fala de Clow, portanto, pode ser lida como um sinal subjetivo de dificuldade de engajamento e não apenas como uma queixa de falta de vontade, no sentido comum do termo. Em linhas gerais, isso se conecta ao fato de que o desejo de aprender ainda não foi convocado ou reconhecido no contexto em que a aprendizagem lhe é proposta.

Nessa perspectiva, as dificuldades de aprendizagem podem ser pensadas a partir do desejo, que remete à falta e, justamente por isso, convoca ao conhecer. A fala da criança participante demonstra o desejo de saber intrínseco à implicação na aprendizagem. O desejo também atravessa a esfera social; por isso, a escola pode ser pensada nesse dinamismo, articulando de forma incessante o plano subjetivo e o coletivo (Lima, Roavi, 2022).

O diálogo a seguir revela a oscilação motivacional da criança frente à escola, evidenciando como o interesse pelo aprender se articula a experiências significativas e afetivas, ao mesmo tempo em que expõe a dificuldade de nomear aquilo que produz desmotivação:

Unidade de Análise 3:

Pesquisadora: Como você se sente na escola?

Bing Bong: Meio motivado e meio não. Mais ou menos.

Pesquisadora: Mais ou menos?

Bing Bong: Aham.

Pesquisadora: Me explica melhor, o que te deixa mais motivado?

Bing Bong: Tipo, quando tem passeio, a gente vai a algum lugar, tipo ir no zoológico. Fazer passeios ou ir a uma floresta acampar e fazer piquenique.

Pesquisadora: E o que não te deixa motivado na escola?

Bing Bong: Eu não sei.

Pesquisadora: Não sabe? Você acha fácil ou difícil aprender as coisas da escola?

Bing Bong: Quando é ciência ou matemática eu acho fácil, e artes também.

Para fins de análise, é pertinente compreender a motivação a partir de seu sentido etimológico⁸, entendida como o ato ou efeito de despertar interesse por algo que faça sentido e produza prazer ao sujeito. No diálogo, Bing Bong oferece pistas de seus campos de interesse ao mencionar afinidade com ciências, matemática e artes, áreas do conhecimento que sinalizam modos particulares de relação com o saber. Esses apontamentos revelam pontos de conexão entre o conteúdo escolar e seu desejo de aprender, aspecto central para a compreensão dos processos de aprendizagem.

Ainda no diálogo com Bing Bong, o qual nos permite observar que o prazer de estar na escola não se restringe às atividades pedagógicas formais, mas se manifesta em experiências cotidianas que envolvem convivência, brincadeira e alimentação, revelando dimensões do desejo que atravessam o espaço escolar:

Unidade de Análise 4:

Pesquisadora: O que você mais gosta de fazer quando está na escola?

Bing Bong: Eu gosto de jogar no ônibus com meus amigos novos. Eu gosto de pintar, porque eu, às vezes, pinto no recreio. Gosto também de comer. Comer

⁸ A compreensão etimológica do termo foi construída a partir da consulta ao dicionário da língua portuguesa: <https://dicionario.priberam.org/>.

várias coisas. Acho que é uma comida bem legal. Muito saborosa. A sopa de bolacha nem se fala.

Pesquisadora: É a tua preferida?

Bing Bong: A sopa de bolacha nem se fala.

Pesquisadora: Tem torta de bolacha na tua escola?

Bing Bong: É creme com bolacha. E mais um que eu gosto, que é pão e chocolate.

Na fala de Bing Bong, o gostar da escola aparece associado aos momentos de jogos com os colegas, à pintura e, de forma bastante enfatizada, aos momentos de refeições. A alimentação surge como elemento de destaque, não apenas como satisfação de uma necessidade biológica, mas como experiência marcada por prazer, memória e vínculo. Comer algo que foi organizado por alguém implica a presença de um Outro que prepara, oferece e cuida, o que insere o alimento no campo simbólico do vínculo e do reconhecimento. Também neste momento, ele e os colegas estão reunidos na mesa do refeitório, espaço que favorece a convivência e diálogos. Nessa perspectiva, o desejo se manifesta em práticas aparentemente simples, como brincar e comer, indicando que o laço com a escola também se constrói por meio de experiências sensoriais e afetivas. Assim, o espaço escolar se apresenta não apenas como lugar de transmissão de conteúdo, mas como ambiente em que a criança encontra possibilidades de satisfação, pertencimento e relação com o outro, dimensões que sustentam sua implicação com o aprender.

O diálogo a seguir evidencia a relação da criança com aquilo que lhe provoca resistência no contexto escolar, permitindo observar como a dificuldade de aprendizagem se articula a afetos intensos e modos singulares de responder às exigências do saber.

Unidade de Análise 5:

Pesquisadora: O que você menos gosta de fazer quando está na escola ?

Bing Bong: Ah, eu menos gosto quando tem não prova, quer dizer, não prova, tipo, tema, esse tema que eu não gosto, tipo, português, geografia.

Pesquisadora: Quando é difícil aprender algo na escola, o que você faz?

Bing Bong: Eu choro...

Pesquisadora: Como você lida com essas dificuldades?

[...]

Bing Bong: Eu sempre digo para minha mãe: A tristeza faz parte da vida. Haverão alguns momentos difíceis.

Em outro trecho mais a frente, a criança retoma a temática da prova:

Pesquisadora: O que você vê nesta figura?

Bing Bong: Eu acho que deve ter prova ou alguém morreu.

Nessa Unidade de Análise, a fala de Bing Bong evidencia que a dificuldade escolar não se apresenta de forma generalizada, mas localizada em determinados conteúdos, como português e geografia, indicando que o impasse não é propriamente com o aprender em si, mas com modos específicos de relação com o saber.

A formulação “eu acho” indica que a criança está elaborando uma hipótese interpretativa, mobilizando referências de sua própria experiência para dar sentido ao que observa na figura. A inferência entre prova e morte sugere que ambos ocupam um lugar simbólico semelhante de cobrança e avaliação, produzindo tensão e antecipação de fracasso. Ao aproximar a tristeza da prova e da morte, pode-se compreender que essa associação remete a situações de perda. A avaliação, nesse sentido, opera como um corte, uma cisão, colocando em jogo oposições como sucesso e fracasso, vida e morte, aprender e não aprender, conseguir e não conseguir, que também podem ser lidas como pequenas perdas que marcam a experiência cotidiana.

Dessa forma, o choro emerge como resposta emocional diante da dificuldade, que pode ser geradora de angústia, revelando que o processo de aprendizagem é atravessado por afetos. Nessa perspectiva, o sofrimento não necessariamente aponta para um déficit, mas pode ser compreendido como expressão do encontro entre o desejo de saber e a experiência da frustração, indicando a necessidade de mediações pedagógicas e relacionais que sustentem a criança diante do não saber. Cavalheiro e De Araújo (2018) destacam a necessidade de ampliar a reflexão para as diversas dinâmicas que atravessam os processos de aprendizagem, concebendo-a “não como um produto, mas como um processo, abrindo a possibilidade de perceber como e por que ela acontece na composição subjetiva do aprendiz” (2018, p. 198).

O diálogo a seguir possibilita compreender como a criança interpreta o ato de estudar a partir de identificações coletivas e representações sociais, revelando não apenas sua relação com a tarefa escolar, mas também os sentidos atribuídos no campo educacional. O diálogo se dá com Jangles quando ele vê a figura de um menino estudando em casa:

Unidade de Análise 6:

Pesquisadora: O que está acontecendo nesta imagem?

Jangles: O menino está fazendo o tema de casa. O menino não gosta.

Pesquisadora: O menino não gosta de fazer o tema ?

Jangles: Dá pra ver nos olhos dele. Ele é um dos nossos. Quem gosta de tema de casa e quem gosta de aula? Ou seja, as pessoas nerds.

Pesquisadora: Como assim as pessoas nerds? Pode me explicar melhor?

Jangles: Toda faculdade tem aquele garoto nerdzinho, que mesmo num filme, que mesmo assim numa sessão de filme, ele fica lá na mesa dele lendo. Essas pessoas nerds.

Na leitura de Jangles, o desagrado pelo tema de casa é reconhecido por traços expressivos, como na fala: “dá pra ver nos olhos dele”, indicando uma identificação imediata com a imagem e a construção de um “nós” que compartilha o não gostar da tarefa escolar. Ao afirmar que gostar de aula seria próprio de “pessoas nerds”, a criança mobiliza categorias sociais e estereótipos que posicionam o desejo de estudar como algo externo ao grupo do qual sente pertencer. Esse movimento revela que o vínculo com o saber não se constitui apenas na dimensão individual, mas também na esfera simbólica e coletiva, atravessada por discursos culturais que associam o interesse pelo estudo a um público específico. Assim, o não gostar do tema pode ser lido menos como recusa ao aprender e mais como efeito de identificações e pertencimentos que modulam a forma como o desejo de saber é reconhecido socialmente.

O excerto a seguir permite analisar como a criança atribui sentidos a uma cena a partir de marcadores sociais, evidenciando que a leitura da imagem ultrapassa a tarefa escolar e se desloca para construções simbólicas de pertencimento:

Unidade de Análise 7:

Pesquisadora: O que está acontecendo nesta cena?

Jangles: Esse aí é um garoto loiro fazendo tema de casa. Os loirinhos sempre tentam se destacar fazendo como gente rica. Como se os fios de cabelo fossem feitos de ouro. Falando: “Ah, não toca no meu cabelo que ele tá bonitão, ele é caro sabe?”.

Na fala de Jangles, o foco deixa de ser o ato de estudar e se concentra na questão estética do colega, especialmente na cor do cabelo, associada a ideias de riqueza e distinção social. O “loirinho” é descrito como alguém que tenta se destacar e se colocar em posição superior, revelando que a interpretação da criança é atravessada por discursos culturais que relacionam estética e valor. Essa leitura indica que o ambiente escolar não é percebido apenas como espaço de aprendizagem, mas também como campo de comparações sociais. Assim, a tarefa de casa torna-se pano de fundo para a projeção de significados ligados à imagem, ao reconhecimento e ao lugar que o sujeito ocupa ou imagina ocupar no grupo, mostrando que o olhar da criança se orienta também pelas marcas sociais.

O diálogo a seguir possibilita observar como o gostar ou não das atividades escolares se vincula diretamente à experiência de compreensão, evidenciando a relação entre entendimento, interesse e implicação subjetiva no aprender.

Unidade de Análise 8:

Pesquisadora: Você gosta de fazer as atividades da escola?

Jangles: Quando tem coisa que eu não gosto, aí não.

Pesquisadora: Que tipo de coisa que tu não gosta?

Jangles: Tema que eu não entendo.

Na fala de Jangles, a recusa não aparece dirigida à escola de modo geral, mas especificamente às tarefas que não são compreendidas. O “não gostar” surge, portanto, como efeito da ausência de sentido e não como desinteresse absoluto pelo aprender. Essa associação revela que o vínculo com o saber depende da possibilidade de entendimento e mediação, indicando que a dificuldade se situa menos na vontade e mais na experiência de não conseguir acessar o conteúdo. Assim, o desejo de aprender mostra-se condicionado à produção de sentido: quando há compreensão, há abertura; quando o saber se apresenta difícil, emerge a recusa.

Essa Unidade de Análise aponta, portanto, para a importância das mediações pedagógicas e do endereçamento singular como sustentação do laço entre a criança e o conhecimento.

O fragmento de diálogo a seguir permite analisar como a percepção da aula é atravessada pela relação estabelecida com o professor, evidenciando que o interesse pelo conteúdo não se dissocia do vínculo afetivo e relacional no contexto escolar.

Unidade de Análise 9:

Pesquisadora: Você considera as aulas chatas?

Jangles: Depende de que professora é. Se for uma professora que eu gosto. Se é uma professora que eu já não gosto tanto. Então, já complica um pouco minha vida.

Na fala de Jangles, o caráter “chato” ou não da aula não está diretamente ligado ao conteúdo da disciplina em si, mas à figura da professora, indicando que o laço com o saber é mediado pela relação com quem o transmite. O aprender aparece, portanto, como experiência relacional, em que empatia, identificação e afetividade influenciam o modo como o conteúdo é aprendido. A expressão “complica minha vida” demonstra que a dificuldade não se restringe ao campo cognitivo, mas envolve dimensões emocionais e simbólicas que interferem na disponibilidade para aprender. O excerto evidencia que o desejo de saber se sustenta na presença de um Outro que desperte interesse e reconhecimento, reforçando a importância do vínculo pedagógico como um elemento essencial nos processos de aprendizagem (Lajonquiere, 1999).

A fala da criança vai ao encontro das afirmações de Almeida (2019), que explanam que o ato de aprender se constitui a partir dos vínculos estabelecidos com o outro, de modo que aquele que aprende é continuamente moldado pelas interações que vivencia ao longo de sua experiência relacional com diferentes sujeitos.

O diálogo da Unidade de Análise a seguir possibilita refletir a recusa explícita às tarefas escolares, evidenciando como o desagrado em relação ao estudar pode expressar não apenas resistência ao conteúdo, mas um impasse na relação subjetiva com o saber.

Unidade de Análise 10:

Pesquisadora: O que te irrita lá na escola?

Jangles: Tema.

Pesquisadora: Você não gosta de fazer tema?

Jangles: É tema de casa, ou essas tarefas de textos, essas coisas em casa, sabe?

Pesquisadora: Mas na escola, você gosta de fazer as tarefas?

Jangles: Não.

Pesquisadora: Não?

Jangles: Não gosto de temas.

Pesquisadora: Você gosta de estudar?

Jangles: Não.

Na fala de Jangles, o “tema” aparece reiteradamente como fonte de irritação, ocupando um lugar simbólico de obrigação e cobrança que ultrapassa o espaço da escola e se estende ao ambiente doméstico. A negativa sucessiva encontrada nas expressões: “não gosto”, “não”, “não gosto de estudar”, indica uma posição de afastamento que pode ser compreendida como forma de defesa diante de uma experiência que não produz sentido ou prazer. O estudo é associado a tarefas repetitivas e exigências externas, sem que apareça um vínculo de interesse ou identificação por parte da criança. Esse movimento indica que a relação com o saber encontra-se fragilizada, sugerindo a ausência de mediações que favoreçam o endereçamento subjetivo e a construção de significado. Assim, a recusa não se limita ao fazer da tarefa, mas aponta para um distanciamento mais amplo do processo de aprender, no qual o desejo de saber não encontra sustentação simbólica ou relacional.

O excerto a seguir permite analisar os elementos que produzem sensação de bem-estar no ambiente escolar, evidenciando como determinadas experiências sensoriais e a ausência de cobranças influenciam o estado emocional da criança frente ao ambiente de aprendizagem:

Unidade de Análise 11:

Pesquisadora: O que te deixa calmo na escola?

Jangles: O que me deixa calmo é quando não tem tema e tem uma musiquinha.

Na narrativa de Jangles, a calma é associada a dois aspectos centrais: a inexistência do “tema” e a presença de música. O tema, anteriormente nomeado como fonte de irritação, reaparece aqui como elemento cuja retirada gera alívio, indicando que a exigência escolar é vivenciada como tensão. Em contrapartida, a música surge como recurso regulador, capaz de produzir tranquilidade e organizar a experiência subjetiva. Esse contraste evidencia que o vínculo com a escola não se estrutura apenas por conteúdos pedagógicos, mas também por estímulos afetivos que modulam o desejo e a disponibilidade para aprender. A cena aponta para a importância de considerar as emoções e os dispositivos de acolhimento no espaço escolar, revelando que a aprendizagem se sustenta também nas condições subjetivas que tornam esse encontro possível.

O diálogo a seguir possibilita aprofundar a temática de sofrimento associado à escola, evidenciando como a experiência escolar pode ser vivida como tensão, ao mesmo tempo em que o aprender continua sendo reconhecido como mais viável nesse espaço:

Unidade de Análise 12:

Pesquisadora: O que te deixa triste?

Jangles: Segunda-feira.

Pesquisadora: Segunda-feira, por quê?

Jangles: Porque eu tenho aula. Tenho aula.

Pesquisadora: Você gosta de ir pra escola?

Jangles: Não.

Pesquisadora: Não?

Jangles: Não. Eu sofro.

Pesquisadora: Sofre? Por que você sofre?

Jangles: Porque é pra ficar trancado numa sala com um monte de criança.

Pesquisadora: O que você acha das aulas?

Jangles: É, eu não gosto muito da aula.

Pesquisadora: Você acha mais fácil aprender na escola ou aprender em casa?

Jangles: As coisas na escola.

No relato de Jangles, a segunda-feira aparece como significante de tristeza por marcar o retorno às aulas, revelando uma associação direta entre escola e sofrimento. A expressão “ficar trancado numa sala com um monte de criança” indica a vivência do espaço escolar como lugar de restrição, mais ligada ao mal-estar relacional e ambiental do que propriamente ao conteúdo pedagógico.

Assim como Jangles, todas as crianças participantes da pesquisa relataram que aprendem e realizam melhor as tarefas no próprio ambiente escolar, quando questionadas se preferiam fazê-las em casa ou na escola. Ao afirmar que é mais fácil aprender “as coisas na escola”, as reconhecem como um lugar onde o aprendizado se efetiva. Essa fala ilustra que a recusa não se dirige inteiramente ao saber, mas às condições em que ele é oferecido, sugerindo que as dificuldades estão mais relacionadas a experiências subjetivas do que à impossibilidade de aprender.

A preferência de muitas crianças por estudar na escola, ao invés de realizar as tarefas em casa, pode ser lida não apenas pela estrutura pedagógica oferecida, mas sobretudo pelas relações e insígnias simbólicas que o espaço escolar representa. A escola organiza o tempo, o conteúdo e a rotina de forma coletiva, oferecendo referências claras de começo, meio e fim das atividades, o que produz maior sustentação para o processo de aprendizagem. Diferentemente do ambiente doméstico, frequentemente associado ao descanso, ao lazer ou às relações familiares, a escola se apresenta como um lugar socialmente reconhecido para o saber, conferindo legitimidade e sentido à atividade de estudar.

Do ponto de vista relacional, a presença de professores e colegas também desempenha papel central para as crianças participantes. O aprender na escola ocorre em meio a trocas, identificações e comparações, elementos que mobilizam o desejo e favorecem o engajamento. A criança aprende com e para o outro, buscando reconhecimento, pertencimento e validação social. No decorrer da pesquisa, as crianças mencionaram com frequência encontrar mais facilidade nas tarefas realizadas com os colegas, aprendendo também com eles. Em casa, essa dimensão coletiva tende a se reduzir, podendo transformar o estudo em atividade solitária ou associada a cobranças familiares, o que nem sempre desperta e sustenta o seu interesse. Além disso, a escola oferece mediações pedagógicas especializadas, explicações, exemplos, estratégias didáticas, que facilitam a compreensão e diminuem a sensação de fracasso. Muitas crianças percebem que, na escola, há alguém cujo papel é justamente traduzir o saber, enquanto em casa essa função pode

não estar disponível ou pode se misturar a relações afetivas que dificultam a separação entre ajuda e cobrança.

Assim, a preferência pela escola mostra a importância das relações sociais, da organização do espaço e da presença de um professor que ensina, reconhece e sustenta o sujeito em sua posição de aprendiz. A partir do pensamento de Vygotsky (1995), podemos pensar que o aprender na escola ganha centralidade por se dar na relação com o Outro e na mediação simbólica do ensino, indicando que o acesso ao saber se sustenta na interação social, dimensão que também convoca o desejo e o engajamento do sujeito.

Na Unidade de Análise a seguir, a fala de Bing Bong evidencia a tensão entre o desejo de brincar e as demandas escolares, permitindo analisar como a ansiedade emerge como efeito do conflito entre o tempo subjetivo da criança e as exigências institucionais.

Unidade de Análise 13:

Pesquisadora: Você já se sentiu ansioso na escola?

Bing Bong: Sim.

Pesquisadora: O que te deixa ansioso na escola?

Bing Bong: Tipo, eu tenho que fazer o tema, mas eu quero ir brincar. Fico ansioso. Fico muito ansioso.

Pesquisadora: E aprender na escola, você gosta?

Bing Bong: Eu amo.

Neste diálogo, destacamos a expressão “mas eu quero ir brincar”, na qual aparece o desejo por um recurso próprio da infância. Nesse momento, o brincar pode representar uma forma de dar vazão ao desejo de conhecer, tanto a si mesmo quanto ao outro, considerando a sua própria subjetividade. Sigmund Freud (2021) menciona que o brincar constitui a origem da capacidade do ser humano de imaginar, fantasiar e criar. Destaca ainda que uma das particularidades do brincar reside no fato da criança utilizar objetos para produzir suas fantasias e imaginações. Bing Bong afirma que gosta de aprender e dá pistas de por onde está realizando suas produções imaginativas, as quais, por sua vez, possibilitam a produção de pensamentos, como capacidade para pensar, presente no desejo de conhecer e na atividade imaginária.

Um dos pontos que podem nos auxiliar a pensar essa questão é o brincar como forma de simbolismo e como estruturante na subjetividade e no desenvolvimento. Percebe-se na atualidade e ao longo da história a redução das brincadeiras coletivas, que se tornam cada vez mais individualizadas (Ariès, 1981). A escola não escapa dessas mudanças; o brincar livremente acaba sendo substituído por atividades mais direcionadas (Corrêa, Coutinho, 2024). A exemplo disso, a saída da criança da Educação Infantil para o Ensino Fundamental pode ser marcada por um grande degrau na escolarização. Essa nova fase perde os contornos da educação infantil e o brincar também se reduz de forma abrupta. Ademais, para Corrêa e Coutinho (2024), os anos finais da Educação Infantil já vêm propiciando uma maior aproximação com a alfabetização, o que pode ocupar ainda mais o espaço/tempo para as atividades livres que possibilitam o brincar. Ao entrar no Ensino Fundamental, trata-se da introdução de um novo arranjo escolar, etapa que se constitui de forma diferente para a aprendizagem, produzindo novas demandas e exigências para a criança, que nem sempre tem condições de corresponder. Devido a sua pouca maturidade e à subjetividade, entre outras questões, essa nova etapa pode produzir sofrimento, bem como impasses no desenvolvimento de suas habilidades escolares, tornando-se uma experiência complexa para as crianças e professores (Corrêa, Coutinho, 2024). Fernandez (2001) aponta para a necessidade do brincar compartilhado no espaço escolar, promovendo a invenção e o brincar em relação. Para Corrêa e Coutinho (2024), o processo subjetivo que dará bases para a aprendizagem necessita da simbolização advinda do brincar, que para muitas crianças ainda está em andamento. Dessa forma, ela não se encontra completamente preparada para as exigências e para o rendimento escolar.

Almeida (2019) afirma que alunos que enfrentam obstáculos no processo de escolarização nos primeiros anos do Ensino Fundamental têm sido expostos a modos de ensinar que não consideram, nem respondem adequadamente, às suas demandas emocionais, afetivas e de interação com o Outro. Para Narodowski (1993), a infância passou a ser concebida por bases educacionais que a enquadram em modelos pedagógicos rígidos, estabelecendo classificações que delimitam o que é considerado esperado, padronizando os percursos de crescimento e igualando tanto os impasses quanto as respostas propostas para enfrentá-los.

No material empírico desta pesquisa, observou-se que todas as crianças associaram dificuldades em realizar tarefas à ausência de desejo para fazê-las. Por

exemplo, Jangles relatou que gosta mais das aulas quando a relação com a professora é significativa para ele, evidenciando que a afetividade e o vínculo impulsionam o engajamento escolar. Bing Bong manifestou facilidade de aprendizagem em áreas de seu interesse, especialmente ciências, sugerindo que o interesse intenso por um conteúdo pode estar ligado à curiosidade e ao momento em que esse saber se torna significativo.

O desejo também é social e nele se encontra a formação dos sujeitos, que emerge sempre na relação com o Outro e com o mundo compartilhado. É nesse campo intersubjetivo que os sujeitos se colocam, construindo um lugar para si nos espaços que habitam, como a família e a escola, e se inserem no laço social. É nesse laço que também a educação escolar exerce papel fundamental, pois o desejo passa a sustentar a experiência escolar, favorecendo a produção de sentidos, o envolvimento com o saber e as experiências coletivas. Neste sentido, o desejo dá base para relações no laço social, podendo ser compreendido como um elemento que produz o engajamento do aluno com o aprender, fazendo-o experienciar no ambiente com o Outro desafios e relações de alteridade, que articulem múltiplas possibilidades de vivências. Também se estende na relação aluno-professor, que, quando atravessada pelo afeto, alicerça as bases para a vida em sociedade (Lima, Roavi, 2022).

Para Lima e Roavi (2022), a falta de desejo em aprender e o desejo de ensinar estão ligados, e são causados pelas estruturas políticas e sociais de uma época, atravessados pela superficialidade atual das relações, que geram vínculos mais frágeis. Neste sentido, sendo esta falta de desejo uma característica sintomática dentro de um contexto datado, para que se rompa com estas configurações e se sustente o desejo de aprender, faz-se necessário o fortalecimento das relações afetivas. A proliferação de diagnósticos relacionados às questões de aprendizagem e comportamento evidencia essas fragilidades. Ainda que tais manifestações se inscrevam na subjetividade, torna-se necessário questionar o aumento no número de classificações diagnósticas, na medida em que se busca medicalizar problemas sociais (Lima, Roavi, 2022).

Por essa via, interrogamo-nos: o diagnóstico tampona o desejo ou a falta? Nas narrativas das crianças, percebemos que elas também se interrogam e, em suas singularidades, perguntamo-nos como resgatar ou construir esse desejo. Na narrativa de Bing Bong, ele reflete sobre a sua relação com o processo de aprender:

Unidade de Análise 14:

Pesquisadora: O que você acha do seu jeito de aprender?

Bing Bong: O meu jeito de aprender é fantástico!

Pesquisadora: Tem alguma coisa que os professores e sua família não sabem sobre seu jeito de aprender que gostaria que soubessem?

Bing Bong: As pessoas sabem o que há no meu coração, mas não no meu cérebro.

[...]

Bing Bong: Eu tenho ideias maravilhantes.

A criança estava explicando que fala sobre seus sentimentos, mas que gostaria também de conseguir expressar como desenvolve seu raciocínio, que não encontra limitações; por isso, ela busca formas de expressar. Essa fala expressa também que a criança encontra espaço para falar do que sente, mas tem o desejo de falar como constrói seu processo de aprendizagem, que pode ser apenas diferente dos demais. Embora os diagnósticos ajudem a explicar os comportamentos infantis, eles não são suficientes para abranger a singularidade da criança. No caso de Bing Bong, ele não demonstra apresentar sofrimento pela sua forma de aprender, mas sim pela maneira que os adultos lidam com ela.

Bing Bong é uma criança muito criativa, escreve livros com folhas de ofício, carrega consigo um microscópio de brinquedo e vai juntando inúmeros objetos da natureza, como folhas ou insetos mortos para analisar. Conta histórias com riqueza de detalhes, imaginação e fantasia. A criação de livros e narrativas aparece como uma importante forma de expressão. Na Unidade de Análise 14, sobre as ideias consideradas “maravilhantes”, é possível perceber o desejo de compartilhar suas ideias e percepções, relatando ficar chateado quando não é escutado pelos colegas ou quando suas produções imaginativas não encontram espaço de acolhimento.

Bing Bong relata ter criado um mundo da sua imaginação, Bingbongnópolis. Lá existem três países: um todo de chocolate, um feito com tudo que existe na cidade de Paris, capital da França, e outro feito com todos os seus objetos pessoais. Como comenta Byung-Chul Han (2024, p. 79), ao se referir aos estudos de Walter Benjamin: “Para Benjamin, as crianças são os últimos habitantes do mundo encantado. Para

elas, nada existe pura e simplesmente aí. Tudo é eloquente e repleto de sentido. Brincando, elas entram em contato com as coisas transformando-se nelas”.

Na fala de Bing Bong, como mencionado anteriormente, ele parece estar em uma busca de formas de se expressar. Dessa forma, na percepção da criança, parece haver uma cisão entre o reconhecimento dos sentimentos e da afetividade e a falta de compreensão do seu processo de aprendizagem e pensamento, evidenciando que o mundo adulto em torno dele, família e escola, tem um reconhecimento parcial das suas questões, mas parte da sua singularidade não é compreendida. Esse descompasso, muitas vezes, encontra práticas medicalizantes, nas quais a diversidade dos modos de aprender não é concebida como característica singular, mas como algo passível de diagnósticos ou correções.

A criança demonstra clareza sobre sua forma de aprender, que diz ser muito prazerosa, concebendo a aprendizagem também como uma forma de brincadeira. As falas dele reforçam as premissas da escuta da criança como sujeito epistêmico, que sabe dizer de si mesmo e desloca a ideia do diagnóstico para a singularidade, também atravessada pelo laço pedagógico e institucional. A criança relata que os adultos consideram seu jeito de aprender fantástico, mas que a família e professores compreendem suas colocações apenas parcialmente. Desse modo, observam-se barreiras presentes na atual pedagogia e nas formas de ensino que podem dificultar o acolhimento dos modos de aprender.

Essa fala dialoga com as reflexões de Mariano Narodowski (1993), ao apontar que a pedagogia moderna se consolidou historicamente vinculada à infância e às questões dela decorrentes. Assim, na contemporaneidade, pensar a infância implica também considerar os padrões pedagógicos e a constituição do sujeito escolar. Nesse sentido, a busca por uma forma própria de aprender e compreender evidencia aspectos subjetivos que escapam à padronização, apontando para a necessidade de se reconhecer a singularidade da criança.

Desse modo, o desejo de aprender não se configura como um elemento natural, mas como algo que se constitui na relação com o outro, na linguagem e nas experiências que atravessam o processo educativo. Trata-se de um desejo que se inscreve na falta e se sustenta no laço com o saber, enquanto, no campo pedagógico, convoca práticas que reconheçam o estudante como sujeito de desejo (Lajonquiere, 1997). Assim, essa discussão permanece em aberto, indicando a necessidade de retomá-la ao longo desta escrita.

4.4 Ajudação: aprender em relação e processos inclusivos

O título “Ajudação: aprender em relação e processos inclusivos” emerge a partir da expressão criada por Jangles, descrita na Unidade de Análise 15, ao se referir às professoras de apoio como “professoras de ajudação”. Essa nomeação revela uma compreensão singular da criança sobre o lugar desses profissionais, deslocando a noção técnica de apoio pedagógico para uma dimensão relacional e afetiva. Nesse sentido, a *ajudação*, ou seja, a ação de ajudar (verbo que possui sinônimos como assistir, apoiar, facilitar), não se configura apenas como suporte instrumental, mas como um gesto de apoio e de cuidado que pode ser considerado como uma mediação que auxilia a tradução do conteúdo escolar para um modo de compreensão acessível à criança.

O profissional de apoio atua no espaço escolar como um facilitador que viabiliza o saber, trabalhando ativamente nas lacunas de diálogo, pedagógicas e relacionais, propiciando melhora significativa nos processos educacionais. O professor de apoio intervém de forma ativa nas dificuldades de comunicação e interação, o que resulta em uma melhoria expressiva nas relações (Mousinho *et al.*, 2010). Dessa forma, a *ajudação* é uma ponte que produz sentidos na aprendizagem, seja proporcionando a relação com o Outro pela comunicação, seja facilitando a aprendizagem.

Dentro desse pressuposto, destacamos algumas falas em torno desta categoria temática que nos auxiliam a compreender e aprofundar as reflexões dessas questões. Este termo emerge na brincadeira de *Minecraft*, em que Jangles demonstra interesse por uma picareta e atribui diversas funções a ela, o que culmina no seguinte diálogo:

Unidade de Análise 15:

Pesquisadora: Digamos que isso aqui fosse uma varinha mágica. Que essa picareta virasse uma varinha mágica e pudesse mudar algo na tua vida, o que você gostaria de mudar ? O que você mudaria para ser mais feliz?

Jangles: O que eu mudaria? Minha classe. Queria poder ser rico.

Pesquisadora: A tua classe social? Você queria ser rico?

Jangles: Sim

Pesquisadora: E o que você faria com o dinheiro? O que gostaria de fazer?

Jangles: Aí eu poderia fazer umas coisas.

Pesquisadora: Que tipo de coisas?

Jangles: Aí eu poderia fazer coisas que eu só penso. Tipo assim, morar numa casa que não seja alugada.

Pesquisadora: E na escola o que mudaria?

Jangles: Só algumas coisinhas.

Pesquisadora: Que tipo de coisinhas?

Jangles: Tipo assim... Eu mudaria, eu botaria mais umas *professoras de ajudação* das crianças.

Pesquisadora: Mais professoras para ajudar as crianças?

Jangles: Sim. Aí na aula e depois a aula daria pra poder ter mais *professoras de ajudação* das crianças.

Pesquisadora: É bom quando tem professora de *ajudação* das crianças?

Jangles: É, sim. Uma professora que cuida de uma criança na aula. Sabe por quê? Porque ano passado tinha uma professora que permitia até que a gente pulasse na cama elástica. Mas agora não tem mais a professora para cuidar da gente, a gente não pode mais pular.

Nesse contexto, a *ajudação* pode ser entendida como uma prática que evidencia a necessidade de um olhar ampliado sobre os processos inclusivos, capaz de reconhecer que a inclusão não se esgota na presença ou ausência de diagnósticos, mas se constrói cotidianamente nas relações, nos gestos de cuidado e na possibilidade de endereçamento ao sujeito. Além disso, ao recordar a professora auxiliando na cama elástica, foi possível perceber a presença de uma memória afetiva, vínculo e desejo de continuidade.

A expressão *ajudação*, criada pela criança, pode ser trabalhada em um jogo conceitual de palavras, para expandir a ideia, sem perder a delicadeza da fala infantil. *Ajudação*, como: Ajuda em Ação; Ajuda mais Ação; Ajuda em Relação; Ajuda que se constrói no encontro. Mais do que um cargo ou uma função, a *ajudação* aparece como sustentação simbólica do processo de aprendizagem, marcada pelo encontro, tradução e pela presença.

Ao criar essa palavra, a criança expande a figura do professor de apoio para um gesto de ajuda em ato, que nos remete a sustentação simbólica, mostrando que

o apoio só se torna efetivo quando acontece nas relações, nos encontros e na singularidade. A sugestão de Jangles em relação à contratação de professoras também revela sua percepção dos entraves institucionais presentes na escola, ao expressar, de forma quase mágica, uma associação entre a obtenção de dinheiro e a possibilidade de contratação de docentes, evidenciando os limites e dificuldades dessas políticas institucionais.

Numa definição conceitual, no interior desta pesquisa, a *ajudação* é compreendida como uma forma de mediação relacional que sustenta o acesso da criança ao saber escolar, não pela via da correção, da adaptação ou do controle, mas pela presença, pela disponibilidade e pelo endereçamento subjetivo.

Enquanto a Unidade de Análise 15 evidencia a percepção da criança sobre aspectos institucionais da escola, especialmente no que se refere à presença das “*profes de ajudação*”, a Unidade de Análise 16 desloca o olhar para a experiência concreta da mediação pedagógica no processo de aprendizagem:

Unidade de Análise 16:

Pesquisadora: O que você acha que te ajuda a aprender ?

Frank: As aulas.

Pesquisadora: As aulas? E o que te ajuda mais, quando você está com dificuldades?

Frank: Uma professora auxiliar e uma titular.

Pesquisadora: Você acha que ter duas professoras ajuda na sua aprendizagem?

Frank: Sim.

Pesquisadora: Entendi. Como é o nome da professora auxiliar?

Frank: Amy⁹ Ela ajuda o Bing Bong também pela manhã. Ela ajuda na minha mesa a entender as tarefas, me explica o que a professora passa no quadro, eu entendo.

Pesquisadora: E qual o nome da titular?

Frank: A professora titular é Amy, que dá aula e passa as coisas no quadro.

Pesquisadora: É Amy as duas?

Frank: Sim, as três. A faxineira também se chama Amy. Que é legal também.

⁹ Nome fictício.

Com Frank, no momento em que afirma “*quando ela me explica o que a professora passa no quadro, eu entendo*”, podemos compreender que não se trata propriamente de déficit cognitivo, mas uma necessidade de um modo acessível de comunicação e explicação do conteúdo. Essa fala sugere que suas dificuldades podem ser atenuadas quando há esse auxílio, assim como as crianças apontaram que precisam de alguém que traduza, sustente e faça um elo entre o saber e seu modo de compreender. Essa fala confronta a lógica medicalizante, pois mostra que a aprendizagem também está no modo como o saber se articula e circula entre os sujeitos, no jeito como o ensino é apresentado e organizado, apontando que outras possibilidades e formas são possíveis, que não existe uma única via de aprendizagem. Podemos considerar que a *ajudação* aparece, assim, como um operador clínico-pedagógico que permite à criança se inscrever no laço com o saber. Portanto, a aprendizagem se torna possível quando há alguém que sustenta o laço com o saber, oferecendo explicações que considerem o tempo, a linguagem e a singularidade da criança.

Na Unidade de Análise 17, o foco desloca-se para o vínculo afetivo estabelecido com as professoras, aspecto que também se mostra central na experiência escolar da criança. É pertinente ressaltar que, durante a pesquisa, as crianças não tinham contato entre si; ainda assim, conteúdos semelhantes emergiram em suas falas na abordagem de determinados temas. Ao realizar o desenho “Eu na minha escola”, Bing Bong escolheu representar suas professoras, a titular e a de apoio, o que permite analisar como o vínculo afetivo e a mediação pedagógica se articulam na sustentação do aprender.

Unidade de Análise 17:

Bing Bong: Entendi. Então, eu vou fazer a minha professora. A minha professora, que me ajuda a fazer a maioria dos temas.

Pesquisadora: Ela é a professora que te acompanha?

Bing Bong: Aham. E ela é legal.

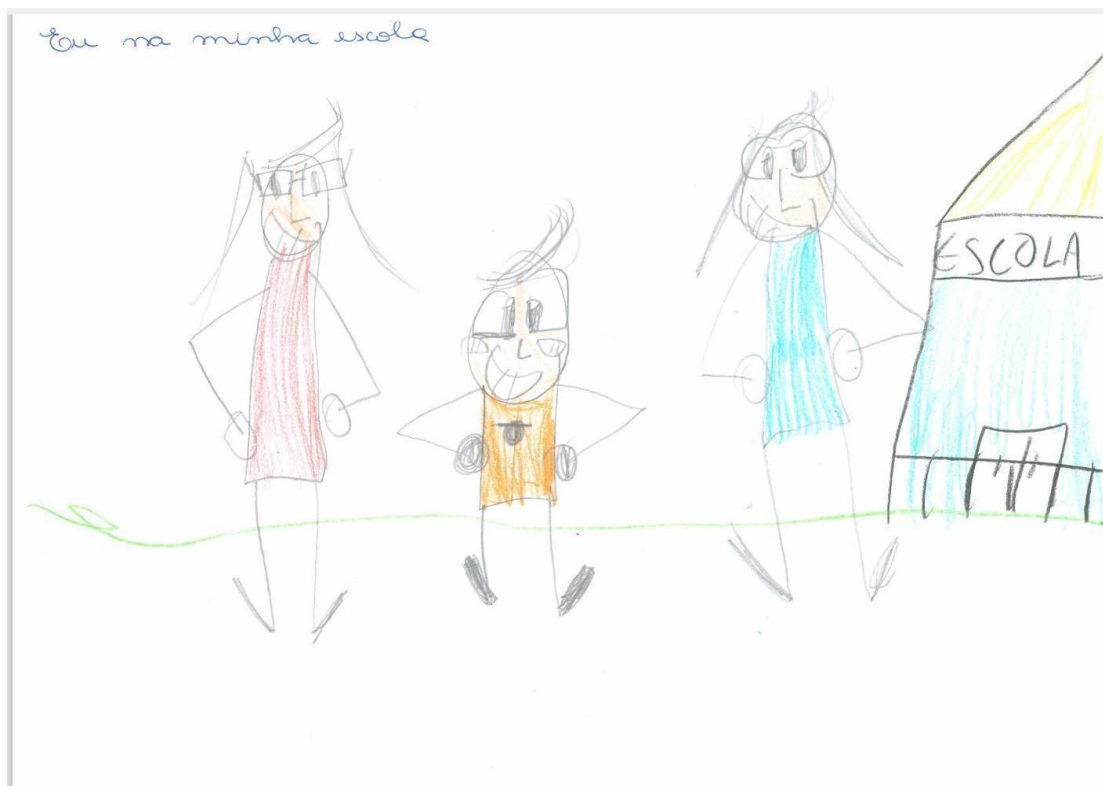
Pesquisadora: Como é a tua relação com a tua professora?

Bing Bong: Bem legal. Essa professora é calminha. E a outra que me ajuda é a Amy. As duas fazem uma ótima dupla.

Pesquisadora: E você se dá bem com as duas?

Bing Bong: Sim. Sabia que eu tenho novos amigos? Fiz amigos novos.

Desenho 1 – Bing Bong, 07/08/2025



Ao escolher desenhar sua professora, Bing Bong destaca uma figura significativa em sua trajetória de aprendizagem. A professora é nomeada como alguém que “ajuda a fazer os temas”, revelando a importância da mediação e do acompanhamento no acesso ao saber. A descrição de que ela é “legal” e “calminha” indica que o vínculo afetivo e a postura relacional da docente produzem efeitos de segurança e acolhimento, favorecendo o engajamento da criança. A menção à “dupla” de professoras e à conquista de novos amigos amplia essa análise para o campo do laço social, mostrando que o aprender se sustenta em redes de relação e reconhecimento. O desenho, nesse contexto, pode ser lido como expressão de identificação e gratidão, evidenciando que o processo educativo se constitui não apenas por conteúdos, mas pelo encontro com outros que acompanham, traduzem e legitimam o sujeito em sua posição de aprendiz.

Vygotsky (1995) afirma que o desenvolvimento das capacidades mentais mais complexas da criança, como pensar, planejar, lembrar, prestar atenção de forma intencional e aprender conceitos, não acontece de maneira isolada ou apenas

biológica. Essas habilidades se constroem principalmente nas relações sociais e no contato com elementos da cultura. Ou seja, a criança não desenvolve sozinha suas funções psicológicas superiores; elas dependem das interações com adultos e outras pessoas mais experientes, especialmente nas situações de ensino. Quando um adulto explica, orienta, demonstra ou conversa, ele não está apenas transmitindo conteúdo, mas participando ativamente da formação do modo de pensar da criança. Assim, Vygotsky (1995) enfatiza ainda que aprender e se desenvolver é um processo relacional e cultural, sendo que a cooperação com seus pares e o ensino recebido funcionam como vias de acesso que possibilitam à criança alcançar formas mais elaboradas de compreender o mundo.

Outro ponto crítico a ser observado se encontra entre a inclusão e o não pertencimento. Jangles e Frank não são formalmente contemplados pelas políticas de Educação Especial, mas se beneficiam significativamente da intervenção dos profissionais presentes em sala destinados geralmente aos alunos incluídos nesta política. Esse dado evidencia um ponto crítico dos processos inclusivos contemporâneos, produzindo um paradoxo: são crianças que não se enquadram nos critérios para inclusão nas políticas públicas de Educação Especial, mas tampouco acompanham o ritmo de aprendizagem da turma e, por isso, acabam ocupando um lugar intermediário, marcado por ambiguidades e fragilidades institucionais. Portanto, fica num entre-lugar: nem incluída oficialmente, nem plenamente alcançada no planejamento pedagógico regular. Embora possa frequentar o Serviços de Atendimento para Dificuldades de Aprendizagem e a Sala de Atendimento Educacional Especializado, percebemos que o acompanhamento dentro da sala de aula é essencial para a efetivação da aprendizagem.

A partir da fala da criança, podemos conceituar o termo *ajudação*, utilizado por Jangles para nomear as professoras de apoio, não como uma expressão infantil ou um erro linguístico, mas um significante produtor de sentido, que condensa a forma como a criança vivencia os processos de apoio escolar. Assim, a *ajudação* opera como um dispositivo de sustentação do laço com o saber, possibilitando que a criança se reconheça como capaz de aprender quando há alguém que traduza o conteúdo para o seu modo de compreender. Nesse sentido, a noção de *ajudação*, tal como emerge da fala de Jangles, aproxima-se diretamente das bases da educação inclusiva, a partir do momento que a escola reconhece e ampara o aluno pelo laço institucional (Voltolini, 2021).

Por sua vez, a fala de Frank “*quando ela me explica o que a professora passa no quadro, eu entendo*”, explicita que a dificuldade não reside na incapacidade de aprender, mas na ausência de mediações adequadas. A aprendizagem se torna possível quando há alguém que auxilie o processo de aprender, oferecendo explicações que considerem o tempo, a linguagem e a singularidade da criança. A *ajudação* opera, assim, como um dispositivo de inclusão, pois permite que a criança se reconheça como capaz de aprender quando o saber lhe é endereçado de maneira singular.

Nesse contexto, a *ajudação* não se orienta pela correção de um suposto déficit, mas pela sustentação de uma relação de alteridade e apoio. Assim, configura-se como um contraponto aos processos de medicalização e às formas normativas de gestão da infância.

4.5 A (des)atenção para além do déficit: significados e contextos

Nesta categoria, pretende-se articular a atenção como sintoma de caráter contextual, passível de ser trabalhado, percorrendo ideias em torno da capacidade atencional e do chamado déficit. A atenção, ou a falta dela, é frequentemente sintetizada como um componente direto da aprendizagem (Kastrup, 2004).

Em alguns pontos de reflexão desta análise serão trazidas algumas falas importantes das mães das crianças participantes. Embora esta pesquisa se debruce na escuta da criança, compreendeu-se que as narrativas das mães ajudam a compreender como as questões atreladas à atenção ganham força nos processos clínicos e pedagógicos, inclusive gerando demandas por profissionais de saúde.

Para Campos (2008), a atenção do aluno muitas vezes não corresponde ao que o educador considera relevante ou espera que desperte seu interesse. Nessa direção, o diálogo a seguir ilustra esse deslocamento. As falas das crianças indicam que a atenção não se configura como uma função ausente, mas como uma capacidade seletiva, orientada pelo desejo, pelo afeto e pelo vínculo estabelecido nas situações de interação:

Unidade de Análise 18:

Pesquisadora: Você se acha distraído?

Jangles: Sim. Sim. Me dá um remédio para atenção. Eu presto atenção numa mosca. Depois falam: “Tem que prestar mais atenção!”

Pesquisadora: Mas você presta atenção em tudo, e até na mosca?

Jangles: Eu presto atenção no que me dá vontade. No que me dá vontade com o remédio. Me faz prestar atenção. Tô lá, naquela aula chata. E eu vejo uma mosca voando.

Pesquisadora: Aí você acha a mosca interessante e te chama a atenção ?

Jangles: Sim, né? Não tem nada pra fazer na escola. Se é pra prestar atenção em alguma coisa, eu vou prestar atenção que é legal, né?

Neste recorte enunciativo, a atenção aparece articulada ao desejo e ao modo como a criança se relaciona com a atividade proposta. Nessa perspectiva, a atenção não pode ser compreendida apenas como uma função cognitiva isolada, mas como um fenômeno relacional, atravessado pelo sentido que a experiência adquire para o sujeito, pelo interesse, pelo vínculo estabelecido e por aquilo que captura o olhar da criança. Essa premissa de que a atenção é orientada pelo desejo encontra respaldo mesmo em estudos das ciências cognitivas, os quais indicam que o metilfenidato e medicamentos semelhantes aumentam a atenção na tarefa e diminuem a sensação de esforço e custo, o que pode levar a uma maior disposição para começar ou manter uma atividade, sem que isso implique, necessariamente, o surgimento do desejo de estudar a partir de um interesse próprio (Westbrook *et al.*, 2020). Esses achados reforçam a distinção entre motivação e desempenho, evidenciando as diferenças entre produzir engajamento por meio de um aumento da capacidade de dedicação e sustentar o interesse genuíno pelo aprender.

Nesta Unidade de Análise, percebemos que com o uso da medicação houve um maior período de concentração; no entanto, isso não implicou, necessariamente, um envolvimento com a tarefa pedagógica. Jangles reconhece ter mais foco com o remédio, consoante às afirmações de Landman (2025), que aponta que o metilfenidato, em um primeiro momento, pode até auxiliar na concentração em atividades consideradas entediantes, mas alerta que o uso descontextualizado pode encobrir necessidades futuras. Este recorte enunciativo ilustra que, mesmo medicalizado, o sujeito permanece orientado por seu interesse, evidenciado pelos deslocamentos do foco atencional, que revelam não a ausência de atenção, mas uma

atenção direcionada àquilo que lhe oferece algum tipo de captura subjetiva diante de um contexto pouco significativo.

Essa perspectiva aparece também nos relatos familiares. Na afirmação da mãe de Jangles: “o que chama a atenção dele pode fazer meses, anos, ele vai lembrar”. Essa fala reforça a hipótese de que há investimento atencional, memorização e compreensão, desde que o conteúdo em questão esteja articulado a algo que faça sentido para a criança. De acordo com Campos (2008, p. 67), “a capacidade de permanecer atento, de focar a atenção, varia de acordo com os estímulos externos, os fatores subjetivos, os estados afetivos, os graus de motivação e as demandas de respostas”.

A narrativa da mãe de Jangles, ao destacar a memória duradoura do filho para um objeto que lhe chamou a atenção, encontra ressonância na afirmação de Campos (2008) sobre a atenção ser modulada por fatores subjetivos e afetivos, e essa mesma lógica se revela na fala do menino no exemplo a seguir, que contrasta o tédio ao olhar para uma árvore. Com o efeito da medicação, ele tem ajuda para sustentar a atenção na tarefa escolar, ainda que isso possa não fazer sentido para ele:

Unidade de Análise 19:

Jangles: Ano passado, as profes não gostavam muito dessa minha concentração.

Pesquisadora: Por quê?

Jangles: Eu olhava pela janela e ficava olhando pra árvore.

Pesquisadora: Você ficava muito concentrado na árvore? E quando estava com remédio ano passado?

Jangles: Era com remédio. Aham.

Pesquisadora: E o que as professoras falavam?

Jangles: As próprias reclamavam... Ela fechava a cortina. Aham.

Pesquisadora: E quando tu não toma o remédio, como é na escola?

Jangles: Ah, eu fico mais normal.

Pesquisadora: Fica mais normal? E como fica a concentração?

Jangles: Fica mais ou menos.

Pesquisadora: Mas tu acha que é melhor com ou sem o remédio na escola?

Jangles: Com o remédio. Porque ele me dá mais concentração, preste mais atenção na escola.

Em diferentes relatos, a chamada “desatenção” aparece associada a comportamentos como fixar o olhar pela janela, observar árvores, acompanhar o vôo da mosca, enfim, geralmente direcionar o interesse por estímulos externos à sala de aula. Sob uma leitura psicanalítica, estes gestos podem ser compreendidos como um deslocamento da atenção, orientado para elementos que, naquele instante, oferecem algum tipo de apoio ou organização interna ao sujeito. Freud (1978), ao discutir a formação dos sintomas, aponta que estes não surgem de forma arbitrária, mas como respostas do psiquismo diante de situações que produzem angústia e conflito. Nesse sentido, a desatenção pode ser compreendida como uma formação sintomática, isto é, uma solução possível encontrada pelo sujeito para lidar com impasses internos e relacionais. Trata-se de uma manifestação que carrega sentido e que precisa ser escutada, não apenas corrigida.

A experiência relatada por Jangles ilustra de maneira clara essa dinâmica. O comportamento de olhar pela janela, frequentemente interpretado como dispersão, pode ser lido sob a ótica freudiana como um sintoma, uma ação voltada para questões subjetivas. Ele não deixa de prestar atenção, mas direciona sua atenção a outro objeto, muitas vezes em conteúdos que não encontram espaço de elaboração e simbolização no ambiente imediato. Consoante as afirmações de Campos (2013, p.66), “a direção da atenção pode ser vetorizada para o mundo interno de maneira reflexiva pelo sujeito, em virtude de um conflito, de um trauma ou de um sintoma que acarrete sofrimento psíquico, de sorte que, de maneira inversa, restará ao sujeito uma desatenção para com mundo externo”. Assim, o comportamento interpretado como desatenção pode ser lido como um sinal de sofrimento psíquico, no qual a criança busca, ainda que de forma silenciosa, organizar seu mundo interno.

Conforme evidenciado no relato de Jangles, percebe-se que o olhar direcionado para fora da sala ocorre em um contexto marcado por intensas transformações familiares que exigiram da criança rearranjos afetivos importantes. Além disso, os relatos que situam o surgimento das queixas de atenção em momentos de reorganização familiar, como, no caso de Jangles, a separação dos pais, o nascimento do irmão, a pandemia, o isolamento social no ano de sua alfabetização e a entrada para o ensino fundamental, o fizeram vivenciar alterações na rotina. Essas questões reforçam a compreensão de que o sintoma se articula à história do sujeito e às suas relações. Torna-se pertinente ressaltar que, segundo dados da Rede CPE

(2023), a pandemia de Covid-19 e as medidas de isolamento social trouxeram muitos entraves e dificuldades no processo de aprendizagem dos alunos (Kupfer *et al.*, 2025; Rede Cpe, 2023).

Outro ponto de destaque refere-se à atribuição diagnóstica do TDAH à falta de atenção. Os relatos de Jangles nos permitem elucidar como ele percebe essa relação:

Unidade de Análise 20:

Pesquisadora: Alguém fala alguma coisa pra ti, sobre você tomar remédio antes de ir para a escola?

Jangles: Não... A A. disse que eu tinha TDAH.

Pesquisadora: Quem é a A. ?

Jangles: Uma profe.

Pesquisadora: Como você se sente sobre ter que tomar remédios?

Jangles: Me sinto estranho.

Assim como Jangles, Frank compartilha suas vivências acerca do diagnóstico, cuja narrativa nos permite ampliar a compreensão sobre o fenômeno:

Unidade de Análise 21:

Pesquisadora: Frank, e se você pudesse mudar algo na tua vida pra te ser mais feliz, o que você mudaria?

Frank: Eu não ter TDAH.

Pesquisadora: O que você acha que o TDAH muda na tua vida?

Frank: De ter mais atenção e aprender normal

Pesquisadora: O que ter TDAH também impacta em outras coisas pra ti?

Frank: Porque quando eu tô indo pra fazer alguma coisa, eu esqueço, do nada. E aí, por isso, eu não gostaria de ter.

Pesquisadora: E uso de medicamento? Você não queria tomar medicamento?

Frank: Não. Não.

Pesquisadora: O que tu sente quando toma o medicamento?

Frank: Nada.

Pesquisadora: E tu acha que o medicamento muda alguma coisa?

Frank: Acho que muda, hein, meu amigo tomou.

Pesquisadora: Na figura 6, o que está acontecendo?

Frank: Estão rindo, né? Na seis.

Pesquisadora: Eles estão prestando atenção na aula?

Frank: Aham.

Pesquisadora: De que matéria é essa aula?

Frank: Eles estão muito atentos. Não sei.

A narrativa de Frank indica que o diagnóstico e o uso da medicação não atua apenas sobre a atenção, mas também sobre a experiência subjetiva da criança consigo mesma e com o outro. A expressão “aprender normal” pode ser compreendida pela atribuição diagnóstica. A fala da criança se religa aos processos medicalizantes e questões institucionais de ordem mais amplas, conforme as afirmações de Vorcaro:

Assim, ao mal-estar provocado pela criança, que não pode ser reconhecido pelo saber pediátrico, pedagógico ou parental, a clínica psiquiátrica diagnóstica. O diagnóstico psiquiátrico visa responder a “isso” que não é reconhecível pelo ideal parental e social, e indicar terapêuticas que sustentem a promessa de re conduzir a criança à “normalidade” ou que, adaptando-a, possam aliviar o mal-estar que a infância produz ao projeto social e assim sustentá-lo. (Vorcaro, 2011, p. 221).

Quando Frank diz que não gostaria de ter TDAH e compara sua trajetória com a do colega, essa fala ilustra diretamente o que Guarido e Voltolini (2009) apontam sobre a ampla midiaticização e o deslocamento direto da dificuldade de aprendizagem para uma doença considerada como causa. Ao que parece, o campo da educação também deposita suas esperanças no diagnóstico que explique o não aprender da criança e direcione para um método de ensino mais eficaz (Collares, Moysés, 1994; Guarido, Voltolini, 2009). Contudo, os profissionais da educação passam a lidar com esses impasses na medida em que o diagnóstico não lhes traz um roteiro didático nem aponta para as soluções pedagógicas que muitas vezes imaginavam encontrar para orientar o ensino ou garantir a aprendizagem; o seu fazer é atravessado por essas expectativas, sem garantias de eficácia, podendo abrir espaços para decepções (Guarido, Voltolini, 2009).

No tangente a medicação, normalização e estranhamento de si, torna-se um eixo central desta subcategoria a relação ambivalente das crianças com o uso de medicação:

Não há atenção que não seja conjunta, que não esteja ligada ao outro e ao contexto no qual se realiza. Se falamos, é para alguém, é com um outro que nossa atenção e ação são realizadas. Agir, escutar e ver se enlaçam com ser escutado, ser visto e desejado. (Carneiro, 2025, p.9).

As falas das crianças evidenciam que a atenção varia conforme a relação estabelecida com o professor e com o contexto. Esses dados apontam para o caráter profundamente relacional do processo de aprendizagem e para a influência direta do vínculo pedagógico na capacidade de engajamento da criança. Nesse sentido, a atenção se configura como um efeito da relação e não apenas como uma condição prévia.

Nesse contexto, a experiência da criança com a medicação não pode ser compreendida apenas como efeito farmacológico, mas pode estar associada às expectativas sociais e educacionais que moldam a atenção como instrumento de conformidade. O relato da mãe de Dave evidencia a valorização seletiva de habilidades escolares:

Unidade de Análise 22:

Mãe de Dave: Ele é ótimo em matemática. Ótimo. Maravilhoso em matemática. Ele adora números desde pequeno. Em língua portuguesa, ele não gosta. E ele não tem atenção.

De maneira semelhante, Dave expressa sua percepção de si mesmo e, embora reconheça sua agitação, esta se manifesta prioritariamente na escola e não fora dela. Dave pega o boneco da personagem Ansiedade (*Divertida Mente*) e sacode rapidamente. Começa a relatar que é “agitado” e entramos neste tema:

Unidade de Análise 23:

Pesquisadora: E o que a tua família diz de tu ser agitado?

Dave: Eu acho que eu sou agitado só na escola.

Pesquisadora: Ah, só na escola. Tem alguém que te ajuda? Alguma coisa que tu faz que te ajuda nessa agitação?

Dave: Não.

Pesquisadora: Não?

Dave: Mas tem um remedinho.

Pesquisadora: Um remedinho para agitação? E você toma?

Dave: Sim.

Pesquisadora: Todo dia?

Dave: Sim

Pesquisadora: E ele resolve a agitação?

Dave: Ele me ajuda um pouquinho a me acalmar.

Pesquisadora: Mas é só um pouquinho? Sim.

Dave: Às vezes eu me esqueço de tomar.

A medicação, que ele chama de “um remedinho”, atua apenas como auxílio temporário para se acalmar, mostrando que os efeitos do tratamento são parciais e dependem do contexto escolar. Para Collares e Moysés (1994), a medicação é compreendida como sendo a solução rápida, como se a intervenção medicamentosa fosse capaz de eliminar o mal-estar de forma simples e sem necessidade de enfrentamento ou implicação dos diversos contextos no entorno da criança. Esses dados reforçam que o desejo de aprender não é um atributo interno ou estático, mas um efeito relacional produzido no encontro entre o sujeito, o saber e as interações com outros sujeitos, algo que não pode ser plenamente explicado por um modelo de déficit ou de atenção isolada, mas que exige uma compreensão da singularidade e do contexto relacional em que a criança se encontra. Nessa direção, os relatos familiares oferecem elementos importantes para compreender como esses processos se constituem no cotidiano. É o que também se observa no excerto a seguir, em que a mãe de Riley conta como tudo começou:

Unidade de Análise 24:

Pesquisadora: Quando que ela começou a ir no neurologista? Como foi o início dessas questões?

Mãe de Riley: O tratamento com o neuro foi quando a escola começou a ter muita queixa dela. Ela não prestava atenção nas aulas, ela só queria ficar brincando. E ela já estava com 6 anos, quase 7. Mas tinha essa coisa infantil, mas também que ela tinha que se envolver, saber a hora de parar... Mas ela queria só brincar. Só brincar.

A Unidade de Análise 25 de Riley nos ajuda a compreender esse contexto:

Unidade de Análise 25:

Pesquisadora: Por que você acha que disseram que tem TDAH?

Riley: Eu perguntei: Mãe, eu sou especial? E ela falou que não é especial. Que eu tenho só TDAH. E não vai mudar nada na tua vida. Tu vai continuar sendo essa pessoa linda e maravilhosa que você é.

Esse trecho mostra como a criança negocia o significado do diagnóstico em sua construção identitária e como a resposta da mãe, ao afirmar sua identidade para além do transtorno, pode funcionar como um anteparo protetivo não reduzindo sua subjetividade a um déficit. Riley prossegue trazendo suas reflexões, como podemos ver abaixo.

Unidade de Análise 26:

Pesquisadora: E na escola, o que te deixa confiante?

Riley: Quando me concentro na prova.

Pesquisadora: Quando tu te concentra na prova? E o que te ajuda a concentrar?

Riley: Pra prova. Foco.

Pesquisadora: E o que mais?

Riley: E meu lápis de tabuada.

Pesquisadora: Você se considera distraída?

Riley: Não.

Pesquisadora: Lá na escola tu acha que tu te distrai na aula às vezes?

Riley: Mínima coisa.

A fala de Riley “quando me concentro na prova” indica que a atenção se configura também como um fenômeno motivacional e relacional, sensível ao contexto e ao significado emocional da atividade. Campos (2008) aponta que estímulos externos também auxiliam na capacidade atencional, dentre eles aspectos afetivos e motivacionais.

A análise aqui apresentada encontra ressonância na perspectiva winnicottiana. Winnicott (1990) aborda o sujeito-em-relação, cuja capacidade de

brincar e aprender depende da qualidade do ambiente suficientemente bom que o sustenta. Nos relatos das crianças participantes da pesquisa, observa-se que a atenção se organiza de maneira seletiva e relacional. As crianças participantes afirmam que conseguem prestar atenção "no que é legal", ou quando há identificação com o professor ou interesse pela atividade. Tal dado empírico dialoga diretamente com a perspectiva winnicottiana de que o engajamento da criança no mundo depende da experiência de sentido e de continuidade de ser. Quando o ambiente falha em oferecer condições de acolhimento, previsibilidade e interesse compartilhado, a criança pode retirar seu investimento do campo escolar.

Winnicott (1975) destaca que a criança se recolhe em si mesma para manter a continuidade de sua existência e aqui encontramos a raiz de numerosos fenômenos de desatenção. O caso de Jangles evidencia essa dinâmica de forma exemplar. O comportamento de olhar pela janela, frequentemente interpretado como dispersão, pode ser compreendido, à luz de Winnicott, como uma resposta a falhas ambientais. O olhar voltado para fora da sala de aula não indica ausência de atenção, mas uma tentativa de encontrar um espaço psíquico onde seja possível sustentar a própria experiência.

É nesse ponto que a contribuição de Kupfer se torna central. Para Kupfer (2000), o fracasso escolar frequentemente é tratado como um problema da criança, quando, na realidade, envolve a relação da criança com o saber, com o professor e com a instituição escolar. A atenção, nesse contexto, não é apenas uma função mental, mas um efeito da relação da criança com o desejo de aprender e com o lugar que lhe é oferecido na escola. Assim, medicalizar a atenção significa, muitas vezes, interromper a possibilidade de escuta, transformando uma mensagem subjetiva em um problema a ser corrigido.

Winnicott (1975) aponta que quando o ambiente não sustenta o gesto espontâneo da criança, ela pode reagir por meio de retraimentos, inquietações ou deslocamentos da atenção. Assim, a desatenção pode ser compreendida como um sinal de que o espaço escolar deixou de funcionar como um ambiente facilitador, tornando-se um espaço que exige adaptação. Para Fernandez (2012), o brincar também influencia a capacidade atencional na medida em que ela é alimentada na relação, no simbolismo e na arte.

Chaves e Caliman (2017) afirmam que as questões escolares que adentram os espaços de saúde mental infantil apontam para uma intersecção entre saúde,

escola e família. A fragmentação do cuidado e o isolamento são evidências disso. Quando a medicação é concebida como único e principal tratamento, a tendência ao isolamento do cuidado se expande, tendo em vista que também inibe a teia de relações que precisaria se consolidar ali. Dessa forma, os autores apontam para a criação de novos caminhos possíveis para a educação e saúde, que se guiem pelo cuidado e pela rede de relações.

Embora a Reforma Psiquiátrica tenha trazido novas formas de cuidado em saúde mental e evoluído de forma bastante positiva, o manejo e a regulação das medicações psicotrópicas ainda são uma questão sensível no cenário brasileiro. Para Gonçalves, Caliman e César (2021), as experiências subjetivas do uso de psicofármacos, na maioria das vezes, não são validadas como um saber pertinente ao processo terapêutico, situação que se agrava ainda mais quando os usuários são crianças. Nesse sentido, o cuidado em saúde mental com a criança pode ter uma linha tênue na contemporaneidade, seja pelas estratégias de proteção modernas, seja pela visão da criança enquanto dependente do adulto, seja pelas barreiras diagnósticas. Ainda que se amplie o acesso ao cuidado, encontramos muitas barreiras no tangente à participação das crianças no próprio tratamento.

Pontos como o grande volume de prescrições de psicofármacos e a escassez de políticas públicas que fomentem alternativas terapêuticas são um ponto delicado dentro desse contexto. Ademais, a perspectiva da criança no processo de tratamento em saúde mental tende a ficar subjacente, sendo frequente que a criança não seja informada sobre as razões do uso de medicamentos (Gonçalves, Caliman e César, 2021).

Em determinados pontos, alguns participantes expressaram questões emocionais e sentimentais que atravessavam os conteúdos pedagógicos, exigindo atenção. Ao conversarmos sobre as dificuldades escolares, as crianças apontaram elementos importantes que influenciam diretamente sua rotina escolar e processo de aprendizagem. Assim como Frank ao ser questionado:

Unidade de Análise 27:

Pesquisadora: O que você acha que atrapalha sua concentração?

Frank: Eu não consigo pensar quando estou triste.

Frank refere-se ao fato de que não consegue aprender quando está se

sentindo triste. Quando questionado sobre o que ocasiona a tristeza, ele aponta dificuldades nas relações escolares, conflitos, entre outros aspectos. Contudo, se diz muito confiante quando tem ajuda de alguém para as tarefas escolares. Para Fernández (2012), quando a tristeza passa a ser interpretada exclusivamente por um viés patologizante, deixa-se de nomeá-la e de buscar o Outro como interlocutor na produção de sentidos. Nesse movimento, perde-se também a possibilidade de experimentar a alegria, intrinsecamente ligada à tristeza, quando esta não encontra espaço para ser vivida. Em contrapartida, ao se envolver na brincadeira, a criança direciona sua atenção ao próprio desejo; o jogo constitui, então, um campo em que pensamento, expectativa e desejo se articulam, favorecendo a atenção e a expressão subjetiva (Fernández, 2012). Ao conversarmos sobre as dificuldades escolares, as crianças participantes apontaram elementos importantes que influenciam diretamente sua rotina escolar e seu processo de aprendizagem. Dentre estes elementos, estão sentimentos e emoções descritas por elas como questões que se atravessam e, por vezes, atrapalham, como na narrativa de Riley a seguir:

Riley: A ansiedade é o que mais domina o meu corpo. Tenho medo de não conseguir fazer a tarefa. Tenho medo de tirar nota baixa. E é um medo muito, muito grande.

O relato de Riley explicita a centralidade que a ansiedade ocupa em sua experiência escolar, sendo nomeada como algo que “domina” seu corpo, o que indica não apenas um estado pontual, mas uma vivência que atravessa sua relação com o aprender. O medo de não conseguir realizar a tarefa e de obter uma nota baixa evidencia a forte incidência de uma lógica de desempenho, na qual o erro passa a ser vivido como ameaça e não como parte do processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, observa-se que a antecipação do fracasso organiza a relação de Riley com a escola, produzindo um movimento de inibição diante das demandas escolares.

A partir dessa narrativa, torna-se possível aproximar a experiência da criança das formulações de Campos (2008), segundo as quais a desatenção pode também ser compreendida como um modo de evitar a possibilidade de não corresponder às expectativas: ao recusar se envolver com a tarefa, sente-se protegido do risco de fracassar. Assim, enquanto a hiperatividade se apresenta como uma tentativa de se haver com tudo, mantendo a ilusão de controle e potência diante do que ameaça

escapar, a ansiedade que se manifesta no corpo da criança pode ser lida como a expressão de um mal-estar mais amplo, que emerge na relação entre sujeito, escola e exigências sociais.

As análises aqui apresentadas reforçam a importância de abordagens que considerem a criança em sua totalidade, articulando aprendizagem, afetividade e acolhimento. As narrativas das crianças apontam que a atenção não é um atributo homogêneo e deficitário, mas um fenômeno profundamente modulado pela motivação, pelo significado percebido e pela qualidade das relações, de modo que situações percebidas como mais relevantes podem aumentar substancialmente o foco e o engajamento. Esse entendimento contribui para deslocar a leitura da atenção de uma perspectiva reducionista para uma que considera fatores motivacionais e relacionais como centrais no desempenho escolar.

Os dados empíricos da pesquisa indicam que as crianças não demonstraram dispersão durante os encontros e atividades propostas. Este achado está em consonância com a perspectiva de Campos (2013), que argumenta que crianças diagnosticadas com déficit de atenção conseguem sustentar um alto nível de concentração por períodos prolongados quando engajadas em atividades de seu interesse. Isso inclui interações com dispositivos digitais ou videogames que exigem planejamento e raciocínio elaborado. Tais observações contrastam com a queixa inicial frequentemente associada ao TDAH, a qual se baseia na suposta falta de atenção. A esse respeito, Caliman (2008) destaca a tênue linha que separa a busca pela otimização da atenção e o transtorno.

As narrativas das crianças mostraram que a desatenção pode ser, paradoxalmente, uma forma de atenção: dar atenção ao que faz sentido, ao que acolhe, ao que permite sustentar a continuidade de ser em meio às tempestades da vida. Escutá-las, portanto, é o primeiro e mais fundamental gesto para que possamos, de fato, promover aprendizagens que façam sentido.

4.6 Infância, brincadeira e laço social: o aprender no encontro

*Confirma-se mais uma vez que uma criança pode fazer muito por outra.
(Kupfer et al., 2025, s/p.).*

Esta seção analisa as concepções e as vivências das crianças no ambiente escolar, tendo como eixo central o valor relacional na experiência escolar, articulando os dados empíricos obtidos nas entrevistas e observações de campo com referenciais da psicanálise e da sociologia da infância. As narrativas das crianças ao longo da pesquisa indicaram que a escola se configura primordialmente como um espaço de encontro, de socialização e de brincadeira, dimensões que se revelam constitutivas para sua subjetividade e para a própria motivação em aprender.

Ao longo da pesquisa, as crianças referiram-se à escola com frequência como um espaço importante de encontro com seus pares e de construção de laços sociais. Quando questionadas sobre os momentos mais importantes na escola, relataram que estar com seus amigos, no recreio ou na merenda, constituem experiências de grande significado. Todas as crianças participantes mencionaram criar expectativas em relação aos passeios escolares, referindo-os como alguns dos melhores acontecimentos do ano em suas rotinas. Este destaque recorrente a tais atividades desloca o foco do olhar do rendimento escolar para o campo das relações, indicando que o valor atribuído à escola está ancorado na possibilidade de convivência e partilha.

Essa convivência, que é marcada pela aprendizagem, necessita também ser considerada na constituição da subjetividade infantil e os efeitos das relações ali estabelecidas. Corriqueiramente escuta-se que crianças inseridas em processos inclusivos frequentam a escola para socialização, como se essa dimensão se resumisse a estar entre pares (Voltolini, 2021). Contudo, o ambiente escolar propicia a socialização para todas as crianças, sendo profundamente importante para a subjetividade e o laço social (Kupfer, Voltolini, 2023). O material empírico desta pesquisa aponta que a socialização não se configura como um aspecto secundário da vida escolar, mas como um elemento estruturante. As crianças também mencionaram que, em determinados momentos, conseguem auxiliar-se mutuamente nas tarefas escolares, indicando que suas relações com os colegas podem favorecer também os processos formais de aprendizagem.

Um dos pontos que emergiu com frequência nos relatos das crianças é a centralidade do brincar no ambiente escolar. Segundo as crianças, a hora do recreio é aguardada com expectativa especialmente por representar a possibilidade de brincar livremente com os amigos. Quando questionadas sobre o brincar fora da escola, os relatos foram de brincadeiras mais individuais (geralmente em jogos e telas)

ou em casa com irmãos, que em alguns momentos culminam em brigas devido às diferenças de idade e disputas por brinquedos. A Unidade de Análise a seguir ilustra como uma criança enuncia essa experiência:

Unidade de Análise 28:

Pesquisadora: O que te deixa animado quando você está na escola?

Clow: O recreio.

[...]

Pesquisadora: Há algo que você gostaria de mudar na sua escola?

Clow: Aumentar o tempo do recreio, para ter mais tempo com meus amigos.

A fala de Clow, também expressada pelas demais crianças participantes, vai ao encontro dos achados de Rabello de Castro (2025) acerca da participação infantil no contexto escolar. A produção da autora, ao longo da última década, aponta que o momento do recreio aparece de forma recorrente nas manifestações das crianças (Rabello de Castro *et al.*, 2025).

No desenho produzido por Clow, também se evidenciam elementos relacionados ao desejo de brincar e às suas relações com os colegas:

Desenho 2 – Clow, 05/08/2025



Faz-se pertinente, neste contexto, uma defesa do brincar, tal como proposta pela psicanálise, frequentemente desvalorizado no cenário contemporâneo marcado por uma lógica produtivista. Impõe-se, então, a pergunta: quais são, na atualidade, os espaços reservados às crianças para brincar?

Nesta perspectiva, podemos afirmar que o ambiente escolar também proporciona e constitui uma forma de expressão e partilha, favorecendo o fortalecimento do senso de coletividade. Ainda que a instituição escolar estimule trajetórias individuais voltadas à aquisição de conhecimento, conquistas e desempenho, os espaços comuns como o recreio proporcionam momentos de cooperação e trocas. Nesse espaço, o olhar infantil é reinventado, produzindo novos modos de ser e estar no ambiente escolar (Rabello de Castro, 2018).

No desenho de Jangles, percebemos com maior clareza a importância do laço com os colegas e a escola como espaço de socialização, na atividade “Eu na minha escola”, a criança desenha a si e aos colegas, em uma cena que parece ser o momento do recreio:

Desenho 3 – Jangles, 04/08/2025



Para Meira (2004), o momento do recreio é aquele em que a criança pode brincar livremente, expressando sua subjetividade com maior liberdade. Embora muitas atividades escolares envolvam recursos lúdicos, elas costumam ser direcionadas pelo saber pedagógico e com objetivos de aprendizagem. O brincar livre configura-se, portanto, como um momento em que a criança estabelece vínculos com seus pares e vivencia a socialização para além das finalidades instrucionais. Sobre a importância de estar junto aos pares, Frank trouxe a seguinte reflexão ao ver a imagem (Apêndice 9) de uma criança com semblante sério:

Unidade de Análise 29:

Frank: Ela está triste.

Pesquisadora: Porque ela está triste?

Frank: Porque ela está... Está fora da conversa.

A percepção de Frank evidencia que a exclusão do laço com os pares é interpretada como sofrimento, ainda que projetada em uma imagem. Já no decorrer do diálogo com Dave, durante uma brincadeira surge o tema sobre tristeza, e a pesquisadora lhe questiona:

Unidade de Análise 30:

Pesquisadora: O que algum amigo da escola faz que te deixa triste?

Dave: Quando ele não quer brincar comigo.

Do ponto de vista psicanalítico, o brincar pode ser compreendido como uma forma de linguagem da criança, especialmente quando outros modos de simbolização ainda se encontram em construção. Klein (1997) destaca que a brincadeira funciona como um equivalente da associação livre, permitindo que conteúdos psíquicos sejam expressos de forma simbólica. Assim, ao brincar de escola, de ônibus escolar ou ao atribuir sentidos afetivos aos personagens das imagens, as crianças não apenas brincam, mas narram, à sua maneira, suas experiências, desejos e conflitos. A fala de Dave na Unidade de Análise 31 aprofunda essa questão, ao revelar os efeitos do diagnóstico sobre a participação no brincar compartilhado. A criança refere que se sente de fora das brincadeiras, que muitas vezes tinha dificuldade de participar e que escutava:

Unidade de Análise 31:

Dave: “não dá bola, ele é autista”.

[...]

Pesquisadora: O que você gostaria que os professores soubessem de como você se sente?

Dave: Que eu não gosto de ser chamado de autista.

Pesquisadora: E o que você queria que os colegas soubessem de como você se sente?

Dave: A mesma coisa.

Dave referiu inúmeras vezes, durante a pesquisa, que desejava brincar com os colegas, e sentia-se sozinho no ambiente escolar, associando essas dificuldades ao diagnóstico de autismo. Em certo momento, relatou que uma de suas maiores dificuldades na escola ocorre quando não pode brincar com eles, seja por não ser inserido ou por ser desconsiderado. Ele relatou episódios de quando, por não saber como era a brincadeira e por não receber as instruções necessárias, acabava atrapalhando os colegas, escutando com frequência a frase acima, que lhe traz sofrimento e simboliza a sua sensação de estigma e exclusão.

A fala de Dave é consoante com as proposições do psiquiatra e professor britânico Sami Timimi (2026), que em recente entrevista ressaltou que quando um diagnóstico é atribuído a uma criança, isso pode repercutir na maneira como ela constrói a própria imagem, pois modifica também o modo como familiares, professores e colegas passam a percebê-la e a se relacionar com ela.

A vivência relatada por Dave evidencia não apenas sofrimento individual, mas também processos de exclusão que incidem diretamente sobre o sentimento de pertencimento da criança no ambiente escolar. Segundo Kupfer *et al.* (2022), a psicanálise nos mostra que, além dos benefícios dos vínculos entre crianças, que proporcionam laços, trocas, apoio e segurança emocional, a presença do Outro mostra-se essencial para a constituição subjetiva delas. A presença do Outro funciona como um espelho que, a partir do contato com seus pares, atua como referência de identificação e contribui para a formação da sua subjetividade e identidade.

Freud desloca a atividade de brincar do campo da ludicidade para entendê-la como um importante trabalho psíquico, reconhecendo nela uma atividade investida de afeto e elaboração simbólica. Para o autor:

A atividade que mais agrada e a mais intensa das crianças é o brincar. Seria injusto então pensar que a criança não leva a sério esse mundo; ao contrário, ela leva muito a sério suas brincadeiras, mobilizando para isso grande quantidade de afeto. O oposto da brincadeira não é a seriedade, mas a realidade. (Freud, 2020, p.54).

Para Trevisan (*et al.*, 2022), as crianças constituem um grupo social que, ao mesmo tempo em que modificam os ambientes que ocupam, são também moldadas por eles, tanto em experiências pessoais quanto nas vivências em grupo. Durante os diálogos nas brincadeiras sobre a escola, Frank introduz o tema do brincar associado ao recreio, ao estar junto com os amigos, expressado pela seguinte fala:

Unidade de Análise 32:

Pesquisadora: Se você pudesse mudar algo na sua escola, o que seria? O que você mudaria na sua escola?

Frank: Raquete. No dia das crianças, todo mundo receber raquete e pingue-pongue. Mesmo para todo mundo, raquete, bolinha, duas para todo mundo e no dia das crianças todo mundo receber duas raquetes, uma bolinha e uma bola de futebol de presente. Para brincar no recreio, aí não precisa esperar. Para todas as crianças, e um doce.

A fala da criança expressa o desejo de possuir objetos em comum ao gosto das crianças, em que todos teriam acesso. O interesse por brinquedos, filmes ou desenhos, em evidência na cultura infantil, que fazem parte do imaginário infantil, também produz significações e pode ser considerado uma forma de pertencimento (Sarmiento, 2003). Neste imaginário infantil está a forma da criança de se relacionar com o universo ao seu redor e para a teoria freudiana nele se encontra a sobreposição da satisfação desejante em face às exigências da realidade (Sarmiento, 2003). Estes objetos passam a operar como linguagem comum entre as crianças, produzindo pertencimento a grupos e facilitando as trocas simbólicas. Ao serem compartilhados, tais interesses deixam de ser meramente individuais e passam a funcionar como

dispositivos que estimulam o laço social, permitindo que as crianças se reconheçam umas nas outras.

As crianças participantes da pesquisa demonstraram, ao longo dos encontros, bastante interesse em atividades lúdicas, produzindo cenas de brincadeiras criativas e compartilhadas, de diversos temas, que remetiam também a questões relacionadas à escola e contrastavam com as queixas iniciais ligadas ao comportamento e às dificuldades de aprendizagem. As cenas observadas evidenciam que o brincar não se restringe a uma atividade recreativa, mas se configura como um modo de pensamento e de produção de sentido.

No brinquedo Lego, Frank insistia que a porta da escola precisava de uma maçaneta. Enquanto, em outro momento, Clow afirmava que a escola parecia um posto policial por ter cores azuis e brancas. Essas falas evidenciam não apenas criatividade, mas também capacidade de observação e a forma como interpretam o mundo, revelando saberes e percepções sobre os espaços que frequentam.

Em outro momento, Frank brincava de passear na cidade e ir ao McDonald's, depois à confeitaria. Ao ser perguntado se iria à escola, respondeu que não. Frank relatou que nunca foi ao McDonald's, apontando tratar-se de um espaço distante de sua cidade. Essas intervenções demonstram que a brincadeira proporciona às crianças pensar modos de ser e estar no mundo, interrogando espaços institucionais e realizando leituras próprias da realidade que as cerca. Dessa forma, as brincadeiras não se limitavam à reprodução da realidade, mas produziam deslocamentos simbólicos e representavam desejos, permitindo que a lanchonete e a escola fossem ressignificadas nas cenas (Sarmiento, 2003).

As crianças trouxeram, ainda, seus próprios brinquedos e organizaram as brincadeiras de forma autônoma, demonstrando engajamento de maneira divertida e compartilhada com a pesquisadora. Riley trouxe sua coleção de figurinhas, enquanto Frank levou uma peteca, confeccionada por ele mesmo, feita com as penas de sua galinha de estimação, dizendo que ela é da raça Isa Brown e que possui muito apego por ela. Frank relatava que seu animal de estimação é muito importante, demonstrando grande valor atribuído à ave. A maioria das crianças participantes também relatou forte apego aos animais de estimação, indicando que o afeto por eles constitui um fator de apoio afetivo.

O fato de Riley, Bing Bong e Frank trazerem objetos para brincar evidencia a importância dos objetos e dos vínculos afetivos para as crianças. Esses elementos

não se restringem apenas à brincadeira, mas configuram-se como amparos simbólicos investidos de afetividade e significado. No caso de Frank, o destaque dado à galinha, com a nomeação da raça e a ênfase no apego ao animal, aponta para um vínculo singular marcado por cuidado, valor emocional e proximidade.

Em diferentes momentos, durante o recurso da foto-elicitación (Apêndice 9), as crianças afirmavam que os personagens estavam tristes diante dos livros porque não queriam estudar, mas brincar com os colegas. Esse elemento repetiu-se ao longo das entrevistas: as atividades mais citadas como prazerosas na escola estavam relacionadas ao brincar e à convivência entre os pares.

Em certo momento, na interação e brincadeira com Dave, a terapeuta controla o boneco, personificando a voz do personagem, Dave diz que não gostaria que ela fizesse aquela voz e brincasse daquela forma, ficando muito irritado e jogando os brinquedos no chão. Dave ficou muito chateado dizendo à terapeuta que não era mais para o boneco falar e demorou a voltar à brincadeira. Essa atitude pareceu a tentativa da criança de reproduzir suas vivências com colegas nas brincadeiras escolares. Klein (1997) afirma que pelo brincar a criança pode projetar na cena alegrias ou conflitos, transitando rapidamente de um para o outro. A agressividade expressa por Dave pode ser compreendida como uma forma de expressão e a forma que a criança encontrou para dar sentido à própria realidade, que, naquele momento, estava relacionada às brincadeiras com os colegas.

Esses recortes nos permitem compreender o brincar como espaço de expressão subjetiva e convivência. Conforme Winnicott (1975), é no brincar que a criança pode existir de forma criativa, colocando algo de si mesma no mundo. O brincar não é apenas uma atividade, mas um espaço potencial situado entre a realidade interna e a externa, no qual o sujeito pode experimentar, criar e simbolizar suas vivências. Nesse sentido, quando Riley, Bing Bong e Frank perguntam se podem brincar do que quiserem, não se referem apenas à atividade lúdica em si, mas à possibilidade de ocupar um espaço onde sua iniciativa e singularidade são reconhecidas.

As cenas lúdicas observadas no espaço da pesquisa revelaram criatividade e imaginação, especialmente em atividades com o Lego e outros brinquedos, com os quais criavam histórias e cenas. Essas competências exigem planejamento, supõem combinações com o outro e demandam negociação de regras. Esses fatores tornam-se um ponto analítico relevante, pois são elementos que muitas vezes não aparecem

no desempenho escolar formal, que emergem com força na brincadeira e na relação com o outro.

Diante do exposto, evidencia-se que o brincar e o laço social ocupam um importante lugar na experiência escolar, como condições fundamentais para a constituição subjetiva e para o próprio processo de aprendizagem. A escola, enquanto espaço simbólico de encontro, possibilita que as crianças construam sentidos, estabeleçam vínculos e elaborem suas experiências por meio do brincar.

4.7 A participação infantil na pesquisa: escuta e lugar

Esta seção pretende compreender a participação das crianças na pesquisa, não apenas como um recurso metodológico, mas como um paradigma ético e epistemológico fundamental. A partir dos procedimentos e recursos adotados na etapa de produção de dados, buscou-se preservar um espaço em que as crianças pudessem expressar-se de diversas formas, como escolhessem, e assim reconhecê-las como sujeitos ativos.

Esta perspectiva é consonante às afirmações de Sarmiento (2005), para quem a participação das crianças constitui um espaço de reconhecimento, no qual elas podem se expressar, construir sentidos e ocupar um lugar de palavra. Para o autor, a infância, enquanto categoria social, pode ser compreendida a partir da própria perspectiva da criança, capaz de interpretar a realidade e transmitir conhecimento entre seus pares e em relação ao mundo.

A metodologia de escuta, viabilizada pelo diálogo e pela brincadeira, possibilitou que as manifestações das crianças emergissem mais livremente, buscando ser um espaço sem pressões ou expectativas por parte do adulto pesquisador. Dessa forma, o brincar revelou-se, neste estudo, um recurso importante para a expressão subjetiva delas, favorecendo a produção discursiva e a atribuição de novos sentidos frente às vicissitudes do crescer e do aprender. Ao se apropriarem de suas próprias narrativas, nas quais puderam afirmar suas singularidades, seus modos de aprender e de brincar, há uma ampliação na pesquisa do entendimento sobre a criança e sua história, assim confrontando leituras reducionistas e medicalizantes da infância.

Em diversos momentos, as crianças assumiram o protagonismo nas atividades, escolhendo com o que iriam brincar e introduzindo temas de seu interesse.

Um aspecto que se destacou foi como se engajaram em participar da pesquisa. Elas demonstraram entusiasmo, desde os desenhos que representavam as suas assinaturas de concordância no TALE, feitos com riqueza de detalhes, até a sugestão de assuntos, o que acontecia sempre, e os pedidos à pesquisadora que conferisse se suas vozes haviam sido gravadas com nitidez no dispositivo eletrônico, para posteriormente serem transcritas. Um detalhe que se torna pertinente mencionar é o grande volume de material empírico produzido no decorrer da pesquisa, o que aponta, mais uma vez, para a participação ativa delas. Em muitos relatos, elas diziam se sentir alegres e que participar da pesquisa era algo muito especial, pedindo para a pesquisadora tirar fotos delas e gravar vídeos (material que ficou nos arquivos da pesquisa). A participação na pesquisa foi tema de muitas histórias e desenhos feitos por elas.

A fala de Riley ilustra um pouco essa dinâmica:

Unidade de Análise 33:

Riley: Você é nova aqui?

Pesquisadora: Sim, eu vim só fazer essa pesquisa. Não vou continuar aqui.

Riley: Você está sendo paga para isso ou não?

Pesquisadora: Não...

Riley: Então, onde é que você tirou essa ideia da pesquisa?

Pesquisadora: Eu trabalho e também estudo em outro lugar, que faz essas pesquisas. Esses trabalhos...

Riley: Aí, eles mandaram você para cá?

Pesquisadora: Aham. Você já tinha participado de alguma vez?

Riley: É a primeira vez. E a minha mãe também, é a primeira vez.

No caso de Riley, o entusiasmo dela, trazendo elementos e materiais, demonstrou o engajamento e o desejo de participar do estudo. Dessa forma, tudo que elas diriam ali era importante. Quando foi lido TALE, elas prestaram atenção, assinaram e fizeram desenhos no documento para expressar sua concordância. Ao final da leitura do TALE, Riley, por exemplo, exclamou: mil vezes sim! A animação de Riley e dos outros participantes em fazer parte do estudo revela que, para eles, a experiência não se limitava em responder à pesquisa, mas participar ativamente da construção de saberes sobre a aprendizagem e a vida escolar.

A cena exposta revela que Riley se reconhece enquanto produtora de conhecimento e protagonista na pesquisa. A criança questiona a origem da pesquisa, buscando compreender as condições do estudo, como vínculo institucional e pagamento, demonstrando não ocupar um lugar passivo na construção da pesquisa. No diário de campo também há anotações do quanto as crianças prestaram atenção à leitura do TALE e perguntaram muitas coisas sobre os materiais e os procedimentos do estudo. Essas interrogações apontam para uma postura investigativa da criança, na qual ela não apenas participa, mas também analisa e atribui significado ao projeto que está inserida. Essa atitude pode ser compreendida a partir as proposições de Sarmiento (2015), que situa a criança como sujeito social ativo:

A promoção do estudo das crianças a partir das suas próprias práticas, culturas e ações, resgata-as do olhar pousado nos eixos, frequentemente maiusculizados, onde elas são colocadas como referentes secundários, a partir do papel que lhes é outorgado pelos atores adultos encarregues de, junto delas, promover a Educação, ou o Desenvolvimento, ou a Inserção Social, etc. O corte com as visões adultocêntricas da infância é o correlato deste processo de assumir determinadamente as crianças e a infância como objeto de conhecimento. Objeto que é também sujeito, daí que os estudos da criança tenham promovido – e este é outro dos seus contributos – um importante desenvolvimento no apuramento das metodologias de pesquisa junto das e com as crianças (Sarmiento, 2015. p.35/36).

No segundo encontro, Bing Bong trouxe um microscópio, afirmando que quer ser um cientista no futuro e que participar da pesquisa representava algo muito importante para ele. A ação de trazer o brinquedo e fazer menção à ciência demonstra também o engajamento da criança, o que revela sua posição de centralidade na construção do estudo. Em alguns momentos, quando estava na sala de espera ou nos corredores do Serviço, aguardando a pesquisadora, Bing Bong mostrava seu microscópio às outras crianças que circulavam no espaço, explicando com alegria que estava participando de um estudo científico, por isso a necessidade do microscópio.

Além de Bing Bong e Riley, as demais crianças demonstraram participação ativa na pesquisa, apropriando-se com autonomia e protagonismo em todas as atividades. Este movimento desloca a posição da criança como sujeito passivo na ciência, colocando-a como participante ativa, produtora e interlocutora da própria pesquisa, o que reforça a necessidade de metodologias que sustentem o espaço de escuta e participação efetiva das crianças (Sarmiento, 2015).

Outro aspecto relevante nesta análise refere-se à afirmação de Riley de que é “a primeira vez” que participa de uma pesquisa, mencionado também a sua mãe.

Riley situa a pesquisa ligada a uma rede relacional mais ampla, evidenciando que sua participação não é isolada, mas vinculada a um contexto familiar e social. Riley, assim como as outras crianças e suas mães na assinatura do TCLE, falaram com frequência:

Unidade de Análise 34:

Riley: Minha mãe me disse que era para eu falar tudo para você.

Clow: Conta tudo para ela, não precisa ficar com medo.

Mãe Dave: Vou falar para ele falar tudo que tiver vontade, não precisa guardar nada.

Estas falas reforçam a ideia de que as crianças, assim como suas respectivas famílias, estão implicadas na pesquisa como sujeitos situados, que articulam suas experiências singulares com os vínculos que as constituem. Assim, estes episódios analisados explicitam que a participação infantil, quando sustentada por uma escuta que acolhe suas iniciativas, permite o surgimento da criança como interlocutora legítima. Nessa perspectiva, a criança deixa de ser um mero informante e passa a fazer parte da pesquisa, situando-se em um espaço de encontro, no qual também pergunta, interpreta e produz conhecimento (Sarmiento, 2015).

No segundo encontro, a fala de Riley demonstra algumas mudanças:

Unidade de Análise 35:

Pesquisadora: Como foi sua semana?

Riley: Nem te conto, você não vai acreditar!

Pesquisadora: O que houve?

Riley: Nesta semana, eu copiei todo o conteúdo e fiz todas as tarefas durante a aula!

Pesquisadora: Que legal, Riley! E como foi isso? Me conta melhor.

Riley: Eu pensei assim, eu vou fazer! Eu estava determinada.

Podemos considerar que este fato não é secundário: ele aponta para os efeitos subjetivos da escuta. Quando a criança encontra um espaço em que sua palavra é acolhida, produz-se um reconhecimento simbólico que pode favorecer sua implicação e sua expressão. Sarmiento e Oliveira (2020) propõem reflexões sobre a escuta como elemento capaz de produzir transformações nos processos educativos,

ao problematizar: “De que forma a escuta se materializa em ação educativa?” (p. 1.126). Essa dimensão é aprofundada pelo diálogo, que é um ato de reconhecimento ao Outro. Quando a criança é escutada têm-se a possibilidade de elaborar sentidos sobre sua própria experiência, o que pode incidir diretamente sobre a sua relação com o aprender. A fala de Riley, marcada pela determinação, indica que o engajamento não emerge apenas de exigências externas, mas pode ser produzido a partir de um movimento interno que encontra sustentação no laço com o outro e no reconhecimento de si mesma.

Dessa forma, entendemos que o espaço de escuta possibilita à criança formular questões e discursos, por meio dos quais, na narrativa de si mesma, possa encontrar contornos e explicações para suas angústias e questões. Como afirma Kohan (2003, p. 223), “aprender é abrir os sentidos ao que carece de ser pensado”, produzindo assim efeitos práticos nas formas de expressão da criança e em seus processos de aprendizagem.

No terceiro encontro, Riley, orgulhosa, demonstrou entusiasmo ao mostrar à pesquisadora seus cadernos e materiais escolares, evidenciando que havia conseguido copiar e realizar as tarefas de casa nos últimos dias. Sua participação ativa não se limitou à presença, mas se manifestou como uma conquista real no ambiente escolar. Isso aponta para uma conexão entre a pesquisa, a subjetividade de Riley e o reconhecimento de suas capacidades. Bing Bong, por sua vez, trazia seus livros para terminar de escrever e grampear, além de levar materiais escolares para mostrar à pesquisadora.

Frank, no último dia da pesquisa, trouxe uma peteca de penas que ele próprio havia confeccionado, compartilhando com a pesquisadora o processo de construção do brinquedo e convidando-a para brincar. A iniciativa das crianças em trazer brinquedos e compartilhar materiais de estudos remete ao desejo de serem consideradas, mediante sua perspectiva infantil, no meio social. Esse movimento foi também marcado pelo questionamento de Frank:

Unidade de Análise 36:

Frank: Quando vai ter de novo?

Neste sentido, a abertura de um espaço de fala na pesquisa torna-se um operador conceitual capaz de produzir novas narrativas e perspectivas sobre o

mundo. As narrativas infantis produzidas durante os encontros desvelam singularidades, sentimentos e percepções sobre suas trajetórias entre família, saúde e educação. Dessa forma, a criança pode pensar, elaborar, desenvolver opiniões e sentidos para seus processos de aprendizagem e também para os atravessamentos institucionais que afetam suas trajetórias. Conforme Kohan (2003), podemos afirmar que a criança não apenas comunica, mas produz pensamento e sentido. Ao narrar, ela elabora e transforma suas vivências em conteúdos simbólicos, o que contribui para a continuidade de seus processos de aprendizagem e desenvolvimento.

A compreensão da infância proposta por Kohan desloca-se da ideia de tempo cronológico, se aproximando de “uma possibilidade afirmativa do pensar, como uma metáfora da gênese de um novo pensar” (Kohan, 2003, p.18). A partir dessa afirmação, podemos compreender que a participação das crianças nas pesquisas lhes confere reconhecimento como sujeitos de experiência e de produção de pensamento, relação pela qual se torna subjetivante.

As reações das crianças decorrentes da finalização da pesquisa também podem ser lidas à luz da psicanálise, na medida em que o estabelecimento de vínculos torna significativa a experiência de separação, tendo em vista que os laços sociais ali constituídos incidem diretamente sobre a subjetividade. Nessa perspectiva, a pesquisa não se configura apenas como dispositivo de coleta de dados, mas como experiência de encontro com o Outro e com a abertura de novas possibilidades a partir disso (Sarmiento, 2015). Em todos os encontros, a pesquisadora os preparava para o próximo, informando detalhes como datas, horários, atividades propostas, para que eles pudessem se organizar e solicitar algum material que gostariam de brincar. No penúltimo encontro, foram avisados que na próxima semana o processo finalizaria. Quando chegou o dia, as crianças manifestaram o desejo de continuar. Riley expressou com muita emoção:

Unidade de Análise 37:

Riley: Fiquei triste porque eu gostei muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito.

Riley não reagiu bem à finalização da pesquisa, disse se sentir bem falando sobre seu processo de aprendizagem, no último dia debruçou sua cabeça sobre os braços, escondendo-se da pesquisadora, dizendo que estava difícil para ela aceitar a

finalização. A reação de Riley mediante a finalização revela que a pesquisa se tornou um espaço de vínculo, demonstrando que o processo foi terapêutico também, transpondo a lógica de coleta e produção de dados, vindo a se tornar um espaço de escuta e expressão subjetiva. As outras crianças também indagaram quando a pesquisa retornaria e se poderiam ainda ter acesso às vezes, para visitar.

Bing Bong e Clow disseram que gostariam de dar continuidade, que consideraram importante terem participado. As crianças referiram também que a partir da participação na pesquisa se deram conta de algumas questões e conseguiram falar melhor nos outros atendimentos e na escola sobre aspectos que lhes incomodavam ou traziam angústias. A psicopedagoga do Serviço apontou diferenças nas atividades de Clow, relatando que ele passou a ser propositivo e expor melhor suas ideias e vontades nos atendimentos. O pedido de continuidade por parte das crianças pode ser interpretado como um desejo de prosseguir produzindo narrativas e elaborações subjetivas, não apenas pela presença da pesquisadora e pelas atividades propostas, mas por um processo que teve um investimento pessoal e um olhar cuidadoso para elas.

A defesa da criança como sujeito de direitos com ação, vez e voz parte do reconhecimento de que as crianças são atores sociais com agência sobre o mundo em que vivem, com direito a expressarem as suas vozes e ações e a se representarem como sujeitos de conhecimento nos seus próprios termos [...] (Sarmiento, Tomás, 2020, p.23).

Lima (2022) aponta que uma das características da instauração dos processos medicalizantes é o fato de estes se basearem na fala dos adultos, enquanto a criança geralmente ocupa um lugar de silenciamento. Assim, a pesquisa, ao constituir-se também como um espaço de escuta, possibilita à infância produzir desdobramentos discursivos e simbólicos. Ao falar dos seus modos de aprender, dificuldades, invenções e saídas para o mal estar, as crianças abrem possibilidades para o novo, repensando seus modos de ser e estar na escola. Esse exercício de pensamento favorece, no tempo da criança, a construção narrativa da experiência e a compreensão dela no seu próprio mundo.

Essa perspectiva tensiona posicionamentos adultocêntricos, bastante evidentes nos processos medicalizantes, ao reconhecer e validar a perspectiva infantil nos processos que lhes dizem respeito, sejam elas clínicas ou pedagógicas. Reforça-se, assim, a dimensão epistemológica da infância, que não apenas descreve

experiências, mas sustenta um discurso próprio sobre elas, permanecendo aberta à invenção e à produção de sentidos (Sarmiento, 2015). Nesse contexto, a escuta deixa de ser apenas um recurso metodológico e passa a operar como uma dimensão ética e clínica, favorecendo a subjetividade e novas formas de relação com o saber.

5 PALAVRAS E RABISCOS FINAIS

O trabalho de campo desta pesquisa ocorreu entre julho e dezembro de 2025, no contexto do curso de mestrado (2023–2026), envolvendo seis crianças de 6 a 12 anos com queixas escolares em um Serviço de Atendimento Especializado para dificuldades de aprendizagem e questões psicossociais na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Assim como se inscreve um traço em uma folha em branco, as crianças deixaram rastros de suas experiências, desenhando com palavras, gestos e brincadeiras os significados de aprender, de se relacionar e de existir no espaço escolar. É válido ressaltar que inicialmente não estava prevista a participação de crianças inseridas nas políticas de educação especial na perspectiva inclusiva; entretanto, a inclusão de duas crianças com diagnóstico de TEA, anteriores ao processo de escolarização, mostrou-se relevante para o estudo, ampliando o escopo analítico da pesquisa e enriquecendo as formas de participação delas.

O estudo concentrou-se nos processos de medicalização e patologização relacionados às dificuldades de aprendizagem e aos comportamentos considerados inadequados no contexto escolar, incluindo diagnósticos e uso de psicofármacos. O diagnóstico de TDAH, com ou sem hiperatividade, mostrou-se presente nos casos associados às dificuldades de aprendizagem ou agitação.

O percurso metodológico adotou a escuta pela perspectiva psicanalítica, com construção de estudos de caso, a partir de encontros lúdicos, entrevistas e observações. Os seis casos permitiram compreender como cada criança percebe e produz sentidos sobre a medicalização e patologização, construídos na relação, nos gestos, nas entrelinhas e no brincar.

A participação das crianças ocorreu por meio da fala, de desenhos, narrativas, brincadeiras, fotos e vídeos, possibilitando compreender como elas vivenciam e produzem sentidos acerca dos processos de aprendizagem e dos efeitos da medicalização em seus percursos escolares. As crianças trouxeram muitos relatos de experiências ligadas a relações interpessoais, socialização, lazer e convivência

escolar, destacando o vínculo com professores e profissionais de apoio, bem como o desejo de aprender. Observou-se, nas narrativas das crianças, que os sentidos por elas atribuídos transcendem a dimensão estritamente clínica, influenciando a percepção de si enquanto alunos e as relações estabelecidas com professores e colegas. Os momentos de escuta favoreceram a ampliação da compreensão desses efeitos, revelando elementos frequentemente invisibilizados nos discursos adultos.

As crianças estabeleceram vínculo com a pesquisadora; entretanto, suas manifestações extrapolavam essa relação direta, configurando sua posição como um “lugar terceiro” próprio da pesquisa, para o qual direcionavam suas falas e experiências. Elas desejavam ser vistas e escutadas, inicialmente demonstrando entusiasmo com o processo investigativo, mas evidenciando que sua comunicação transcendia à figura da pesquisadora. Em muitos momentos contavam experiências difíceis, que soavam como uma espécie de delação, por encontrarem um espaço seguro que poderiam dizer o que lhes incomodava. As falas das crianças não se centraram no diagnóstico; suas expressões concentraram-se, sobretudo, em compartilhar vivências, percepções e significados a partir de sua própria perspectiva. Cabe destacar, como mencionado anteriormente, o expressivo volume de material empírico gerado no decorrer da pesquisa, o que evidencia, mais uma vez, a participação ativa das crianças. O referido material constitui um acervo importante, com potencial para subsidiar estudos e análises futuras e foi juntamente arquivado.

A pesquisa evidenciou que as crianças produzem sentidos próprios acerca das dificuldades de aprendizagem e dos processos de medicalização e de patologização que permeiam sua experiência escolar. Embora, em alguns momentos, tenham surgido referências a diagnósticos, capacidade atencional e uso de medicação, suas narrativas indicam que tais experiências são compreendidas principalmente a partir das relações estabelecidas na escola, do interesse pelas atividades e das possibilidades de participação no cotidiano escolar.

As falas, brincadeiras e produções das crianças evidenciam que o processo de aprender está profundamente relacionado ao vínculo, à mediação pedagógica e ao sentimento de pertencimento, reforçando a importância de reconhecer as crianças como interlocutoras ativas na reflexão sobre as dificuldades escolares e as estratégias construídas para seu enfrentamento. Assim, podemos compreender que a escola se configura como um espaço relacional, onde, entre brincadeiras e interações, as crianças vão rabiscando os primeiros traços de pertencimento social.

A pesquisa evidenciou a visão singular, contextualizada e dinâmica de cada criança, mostrando que aprender envolve relações e vínculos. Os subcapítulos de análise apontaram para isso: “Desejo de Aprender” retratou o quanto o desejo de estar na escola é fundamental para os processos de aprendizagem. A “Ajudação: aprender em relação e processos inclusivos” nos mostrou que, muitas vezes, a criança precisa de apoio para dar sustentação aos seus processos de aprendizagem. Em “A (des)atenção para além do déficit: significados e contextos”, a atenção foi problematizada como fenômeno atravessado por interesse, vínculo e condições pedagógicas, e não apenas como uma capacidade isolada dos indivíduos. A seção “Infância, brincadeira e laço social: o aprender no encontro” indicou que a aprendizagem se constrói nas relações, vínculos e mediações pedagógicas. Por último, o subcapítulo “A participação infantil na pesquisa: escuta e lugar” evidenciou o envolvimento ativo das crianças. O material produzido mostrou-se polissêmico, abordando sentimentos, experiências e múltiplas temáticas.

A participação das crianças configurou-se como um princípio ético e epistemológico, mostrando-as como interlocutoras ativas, capazes de interpretar e produzir sentidos sobre suas experiências. Sugere-se aprofundar a análise do brincar como dispositivo metodológico e realizar estudos longitudinais sobre trajetórias de medicalização e subjetividade.

Ao final, cada história compartilhada pelas crianças se inscreve como um traço único em nossa compreensão do aprender: Dave rabisca amizades; Bing Bong inventa mundos; Frank constrói brinquedos; Jangles inventa palavras; Riley ama os detalhes; Clow observa a natureza com paciência. Cada traço evidencia a capacidade das crianças de criar, imaginar, desejar e se vincular. Elas nos convocam a sustentar espaços onde cada criança possa existir plenamente, para além de qualquer rótulo, continuando a rabiscar juntos outros mundos possíveis.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Lucila Silva de. **Interações**: crianças, brincadeiras brasileiras e escola. São Paulo: Blucher, 2º ed. 2019.

ALMEIDA, Tiago. **O governo da infância**: para uma ontologia histórica do desenvolvimento infantil e a delimitação de modos de ser criança. *Childhood & Philosophy*, 2023. DOI: 10.12957/childphilo.2023.76362. Acesso em: 13 set. 2024.

ARANTES, Esther Maria de Magalhães. **Aprendizagem da atenção**: uma abertura à invenção. *Psicologia Escolar e Educacional*, Campinas, v. 13, n. 1, p. 123-130, jan./jun. 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-85572009000100011>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/dsmLXJB4wrhzK5C6gDZ6Ycj/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 15 fev. 2026.

ARANTES, Ricardo Lugon. **A constituição da demanda para a neurologia nas vozes das ensinantes**. 2017. 128 f. Dissertação Mestrado em Educação — Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, 2017.

ARENDT, Hannah *et al.* **A crise na educação. Entre o passado e o futuro**, v. 5, p. 221-247, 2000.

ARIÈS, Philippe. **História social da criança e da família**. Rio de Janeiro: LTC, 1981.

BAPTISTA, C. R. **Política pública, Educação Especial e escolarização no Brasil**. *Educação e Pesquisa*, v. 45, p. e217423, 7 nov. 2019. Acesso em: 15 mai. 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022019000100407&script=sci_arttext&tlng=pt.

BARBOSA, M. C. S. **Por Amor & Por Força**: Rotinas na Educação Infantil. Campinas, São Paulo, 2000. Tese (Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas à Educação). Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. (versão digital)

BATISTA, Karina de Andrade. **Crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)**: os sentidos produzidos sobre a infância na perspectiva de familiares e profissionais da educação. 2019. 164 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019.

BENTO, Gabriela; DIAS, Gisela. **The importance of outdoor play for young children's healthy development**. *Porto Biomedical Journal*, v. 2, n. 5, p. 157–160, 2017.

BESSET, Vera Lopes. **TDA/H**: transtorno, sintoma ou angústia? In: CARNEIRO, Cristiana; PONNOU, Sébastien (orgs.). *Escutar crianças e adolescentes hiperativos [recurso eletrônico]: aposta da psicanálise*. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2024. p. 12- 14. 1 recurso eletrônico (259 p.); digital.

BEZERRA JR; ZORZANELLI, Rafaela; COSTA, Jurandir Freire. **A criação de**

diagnósticos na psiquiatria contemporânea. Editora Garamond, 2014.

BEZERRA, Benilton. **Café Filosófico: A história da psicopatologia no Brasil.** Produção: Instituto CPFL, 2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rXJtS0A1WQ>. Acesso em: 13 ago. 2024.

BIRMAN, Joel. **Dor e sofrimento num mundo sem mediação.** In: Estados Gerais Da Psicanálise. II Encontro Mundial, Rio de Janeiro, 2003.

BIRMAN, Joel. **Inconsciente e desejo na escrita do infantil:** uma leitura de Alice no país das maravilhas" e de A travessia do espelho, de Lewis Carroll. Tempo psicanalítico, v. 48, n. 2, p. 47-67, 2016. Acesso em: 05 fev. 2024. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-48382016000200004

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Comissão aprova campanha sobre uso de remédios psiquiátricos por crianças.** Agência Câmara de Notícias, Brasília, DF, 16 ago. 2021. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/794843-comissao-aprova-campanha-sobre-uso-de-remedios>. Acesso em: 15 fev. 2026.

BRASIL. **Estudo aponta crescimento no consumo de metilfenidato.** 2013. Acesso em: 26 jan. 2024. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=2673362&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitl=estudo-aponta-crescimento-no-consumo-de-metilfenidato&inheritRedirect=true.

BRASIL. IBGE: Instituto Brasileiro de Pesquisas (2024, January 26). **De 2019 para 2022, trabalho infantil aumentou no país.** Agência De Notícias Do IBGE. GOV.BR. Acesso em: Fev./2026, Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38700-de-2019-para-2022-trabalho-infantil-aumentou-no-pais>

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Crescem matrículas de alunos com transtorno do espectro autista.** Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/censo-escolar/crescem-matriculas-de-alunos-com-transtorno-do-espectro-autista>. Acesso em: 1 mar. 2026

BRASIL. Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990. **Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.** Acesso em :01 mar. 2024. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L8069.htm

BRZOZOWSKI, Fabíola Stolf; CAPONI, Sandra. **Medicalização dos desvios de comportamento na infância:** aspectos positivos e negativos. Psicologia: ciência e profissão, v. 33, n. 1, p. 208-221, 2013. Acesso em: 01 mar. 2024. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pcp/v33n1/v33n1a16.pdf>

BRZOZOWSKI, Fabíola Stolf; CAPONI, Sandra. **Medicamentos estimulantes:** uso e

explicação em casos de crianças desatentas e hiperativas. *Cadernos Brasileiros de Saúde Mental*, v. 15, pág. 1-23, 2015.

CALIMAN, Luciana Vieira. **Notas sobre a história oficial do transtorno do déficit de atenção/hiperatividade TDAH**. *Psicologia: Ciência e Profissão*, [S.L.], v. 30, n. 1, p. 46-61, 2010. FapUNIFESP (SciELO). Acesso em: 15 maio 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932010000100005&script=sci_arttext&tlng=pt.

CALIMAN, Luciana Vieira. **O TDAH: entre as funções, disfunções e otimização da atenção**. *Psicologia em estudo*, v. 13, n. 3, p. 559-566, 2008. Acesso em: 25 jan. 2024. Disponível em: <http://www.redalyc.org/html/2871/287122110017/>

CALIMAN, Luciana Vieira; CÉSAR, Janaína Mariano; KASTRUP, Virgínia. **Práticas de cuidado e cultivo da atenção com crianças**. *Educação, Arte Inclusão*, Florianópolis, v. 16, n. 1, p. 166-186, jan./jun. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.5965/198431781642020166>. Disponível em: <https://periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/17887/12080>. Acesso em: 15 fev. 2026.

CALIMAN, Luciana Vieira; PASSOS, Eduardo; MACHADO, Adriana Marcondes. **A medicação nas práticas de saúde pública: estratégias para a construção de um plano comum**. *Movimentos micropolíticos em saúde, formação e reabilitação*, 2016. Acesso em: 10 ago. 2018. Disponível em: <https://bdpi.usp.br/item/002787353>

CALIMAN, Luciana. **Os regimes da atenção na subjetividade contemporânea**. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, Rio de Janeiro, v. 64, n. 1, p. 2-17, 2012

CAMPOS, Sérgio de. **A psicanálise do hiperativo e desatento: uma leitura lacaniana**. In: SANTIAGO, Ana Lydia; AZEVEDO, Márcia (org.). *A psicanálise do hiperativo e desatento*. São Paulo: Scriptum, 2013.

CANGUILHEM, Georges. **O normal e o patológico**. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 2017.

CARNEIRO, Cristiana. **Entre o remédio e o corpo inquieto: de qual infantil falamos?** *Política & Sociedade*, Florianópolis, v. 20, n. 47, p. 313-335, 2021. DOI: 10.5007/2175-7984.2021.e75312.

CARNEIRO, Cristiana; NETTO DOS REYS, Bruno. **O prêt-à-porter do diagnóstico e seu avesso: qual lugar para Rubens?** In: CARNEIRO, Cristiana; PONNOU, Sébastien (Org.). *Escutar crianças e adolescentes hiperativos: aposta da psicanálise [recurso eletrônico]*. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2024. p. [41-71].

CÁSSIA MARTINS, Rita de; CAMARGO GARANHANI, Marynelma. **A organização do espaço na educação infantil: o que contam as crianças?** *Revista Diálogo Educacional*, v. 11, n. 32, 2011. Acesso em: 12/03/2019. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/4621>

CASTRO, Lúcia Rabello de. **A infância e seus destinos no contemporâneo**. In:

Pensar a infância: fundamentos teóricos e epistemológicos. Rio de Janeiro: Editora Contra Capa, 2003.

CAVALHEIRO, P., & DE ARAUJO, R. (2018). **Um desejo de aprender**: maquinações de uma educação contemporânea. Revista Thema, 15(1), 197–212. <https://doi.org/10.15536/thema.15.2018.197-212.774>

CERVO, Michele da Rocha. **O lugar que as crianças ocupam nas pesquisas**: uma revisão sistemática. Voos Revista Polidisciplinar, v. 7, n. 1, p. 12-21, 2017. Acesso em: 16 mai. 2024. Disponível em: <http://www.revistavoos.com.br/seer/index.php/voos/article/viewArticle/321>.

CHAVES, Alan Mendes; CALIMAN, Luciana Vieira. **Entre Saúde Mental e a Escola**: a Gestão Autônoma da Medicação. Polis e Psique, Porto Alegre, v. 8, n. 3, p. 136-160, set./dez. 2018. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/PolisePsique/article/view/75328/pdf>. Acesso em: 15 fev. 2026.

CHRISTOFARI, Ana Carolina; FREITAS, Claudia Rodrigues de; BAPTISTA, Claudio Roberto. **Medicalização dos Modos de Ser e de Aprender**. Educação & Realidade, [S.L.], v. 40, n. 4, p. 1079-1102, 25 ago. 2015. FapUNIFESP (SciELO). Acesso em: 14 mai. 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2175-62362015005042057&script=sci_arttext.

COHN, Clarice. **Antropologia da criança**: crianças, cultura e sociedade. São Paulo: Editora Contexto, 2005.

COHN, Clarice. **Na íntegra**: Clarice Cohn e Mary Del Priori – Infância. 2010. Acesso em: 21 out. 2024. Disponível em: https://cultura.uol.com.br/videos/51581_na-integra-clarice-cohn-e-mary-del-priori-infancia.html.

COLLARES, Cecília Azevedo Lima; MOYSÉS, Maria Aparecida Affonso. **A transformação do espaço pedagógico em espaço clínico**: a patologização da educação. Série ideias, v. 23, p.25-31, 1994. Acesso em: 15 mai. 2024. Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_23_p025-031_c.pdf.

CONRAD, Peter. **The medicalization of society**: On the transformation of human conditions into treatable disorders. Johns Hopkins University Press, 2007.

CONRAD, Peter. **A descoberta da hipercinesia**: notas sobre a medicalização do comportamento desviante. Problemas Sociais, v. 23, n. 1, p. 12-21, 1975. Acesso em: 15 jan. 2024. Disponível em: <https://academic.oup.com/socpro/article-abstract/23/1/12/1609152>

CORSARO, William A. **Sociologia da Infância-2**. Penso Editora, 2011.

COUTINHO, Luciana Gageiro; CARNEIRO, Cristiana. **Infância, adolescência e mal-estar na escolarização**: interlocuções entre a psicanálise e a educação. Psicologia Clínica, v. 28, n. 2, p. 109-129, 2016. Acesso em 10 jan. 2024. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

56652016000200007

CPE, Equipe. Conecta: **O impacto da pandemia de covid-19 na educação: panorama e desafios no cenário brasileiro.** 2023. Disponível em: <<https://cienciaparaeducacao.org/2023/09/29/o-impacto-da-pandemia-de-covid-19-na-educacao-panorama-e-desafios-no-cenario-brasileiro/>>. Acesso em: 15 fev. 2026.

DALGALARRONDO, Paulo. **Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.** Artmed, 2019.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo.** Boitempo editorial, 2017.

DE CASTRO, Lucia Rabello. **“Precisamos falar do recreio!”** – A construção do comum pelas crianças na escola. *Childhood & Philosophy*, v. 14, n. 29, 2018.

DE FREITAS, Lessandro. **Educação pós-pandemia:** os impactos da Covid-19 sobre o processo de ensino-aprendizagem. *Epistemologia e Práxis Educativa - EPEduc*, v. 6, n. 2, p. 1-16, 2023.

DE-NARDIN, Maria Helena; SORDI, Regina. **Aprendizagem da atenção:** uma abertura à invenção. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 13, n. 1, p. 97–106, 2009.

DUNKER, Christian Ingo Lenz. **Mal-estar, sofrimento e sintoma.** *Tempo Social: Revista de Sociologia da USP*, v. 23, n. 1, p. 116, 2015.

DUNKER, Christian. **Paixão da ignorância:** a escuta entre a psicanálise e educação. São Paulo: Editora Contracorrente, 2020.

FERNÁNDEZ, Alicia. **A atenção aprisionada:** psicopedagogia da capacidade atencional. Artmed Editora, 2012.

FERNÁNDEZ, Alicia. **O saber em jogo:** a psicopedagogia propiciando autorias de pensamento. Trad. Neusa Kern Hickel. Porto Alegre: Artmed, 2001.

FERREIRA, Ligia Julianelli et al. **O conceito de grande Outro em Lacan:** a alteridade fundamental do simbólico. 2022.

FERREIRA, Marluci Guthiá et al. **A cultura lúdica das crianças contemporâneas na 'sociedade multitela':** o que revelam as 'vozes' de meninos e meninas de uma instituição de educação infantil. 2014. Acesso em 01 mar.2024. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/12949161>

FRANCES, Allen. **A fabricação do DSM:** Uma autópsia científica do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. São Paulo: Editora XYZ, 2016.

FREITAS, Cláudia Rodrigues de; BAPTISTA, Claudio Roberto. **A atenção, a infância e os contextos educacionais.** *Psicologia & Sociedade*, [S.L.], v. 29, 2017. FapUNIFESP (SciELO). Acesso em: 20 maio. 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010271822017000100205&script=sci_arttext&

[tlng=pt.](#)

FREITAS, S. N.; JACOB, H. L. **Inclusão educacional de crianças com deficiências:** notas do chão da escola. Educação e Pesquisa, v. 45, 2019. DOI: 10.1590/S1678-4634201945186303. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201945186303>. Acesso em: 02 dez. 2024.

FREUD, Sigmund. (1980). **A dinâmica da transferência** (J. O. A. Abreu, Trad.). Em J. Salomão (Org.), Edição standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XII, pp. 131-143). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1912).

FREUD, Sigmund. **As pulsões e seus destinos**—Edição bilíngue. Autêntica, 2016.

FREUD, Sigmund. **Cultura, sociedade, religião:** o mal-estar na cultura e outros escritos. Autêntica Editora, 2020.

FREUD, Sigmund. **Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud.** Imago editora, 2021.

FREUD, Sigmund. **Para uma psicologia científica.** Rio de Janeiro. Imago Editora, 2017. (Edição Standart, Obras Completas v.VI).

FREUD, Sigmund. **Sobre a psicopatologia na vida cotidiana.** Rio de Janeiro. Imago Editora, 1976. (Edição Standart, Obras Completas v.VI).

GALLO, Sílvio. **Transversalidade e educação:** pensando uma educação não-disciplinar. O sentido da escola, v. 2, p. 17-41, 2000.

GALLO, Sílvio et al. **As múltiplas dimensões do aprender.** In: Congresso de Educação Básica: aprendizagem e currículo. Florianópolis: UFSC, 2012.

GONÇALVES, Luana Gaigher; CALIMAN, Luciana Vieira; CÉSAR, Janaína Mariano. **Participação Infantil no Cuidado em Saúde Mental:** Um Grupo GAM no CAPSi. Psicologia Ciência e Profissão, v. 41, n. e223921, 2021.

GUARIDO, Renata. **A medicalização do sofrimento psíquico: considerações sobre o discurso psiquiátrico e seus efeitos na Educação.** Educação e pesquisa, v. 33, p. 151-161, 2007.

GUARIDO, Renata. **O sujeito refém do orgânico.** Anais do 7o Colóquio do LEPSI IP/FE-USP, 2008. II Acesso em 10 mar.2024. Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC000000003200800010000&script=sci_arttext&tlng=pt

GUTFREIND, Celso. **O terapeuta e o lobo:** a utilização do conto na clínica e na escola. Artmed Editora, 2020.

HAN, B. **Sociedade do cansaço.** 2a. edição. Petrópolis-RJ, Editora Vozes, 2017.

HAN, B. **A Crise da Narração.** 2a. edição. Petrópolis-RJ, Editora Vozes, 2024.

KLEIN, Melanie. **A psicanálise de crianças**. Rio de Janeiro: Imago, 1997.

KAMERS, Michele. **Psicopatologia dos transtornos de Comportamento**. In: KAMERS, M.; MARIOTTO, R. M. M.; VOLTOLINI, R (Org.). Por uma (Nova) Psicopatologia da Infância e da Adolescência. São Paulo: Editora Escuta, 2015. p.267-288.

KOHAN, Walter Omar. **Infância: entre educação e filosofia**. 2003.

KROEF, Renata Fischer da Silveira; GAVILLON, Póti Quartiero; RAMM, Laís Vargas. **Diário de campo e a relação do(a) pesquisador(a) com o campo-tema na pesquisa-intervenção**. Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p. 525-542, 2020. DOI: 10.12957/epp.2020.52579. Disponível em: <https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/52579>. Acesso em: 12 nov. 2024.

KUPFER, Maria Cristina. **Freud e a educação: o mestre do impossível**. São Paulo: Scipione, 2005.

KUPFER, Maria Cristina M.; VOLTOLINI, Rinaldo; PINTO, Fernanda S. C. Noya. **O que uma criança pode fazer por outra?** Sobre grupos terapêuticos de crianças. In: KUPFER, Maria Cristina M.; PINTO, Fernanda S. C. Noya (org.). Lugar de vida, vinte anos depois: exercícios de educação terapêutica. São Paulo: Escuta: Fapesp, 2010. p. 97-111. ISBN 978-8571373020

KUPFER, Maria Cristina Machado *et al.* **O que uma criança faz pela outra em tempos pós-pandêmicos**: resultados de uma pesquisa. Psicologia USP, v. 36, 2025.

KUPFER, Maria Cristina; VOLTOLINI, Rinaldo. **O que uma criança pode fazer por outra quando a heterogeneidade não tem lugar**: sobre o efeito de Columbine nas escolas. Educação Temática Digital, Campinas, v. 25, 2023.

LACAN, Jacques. **O Seminário, livro 23: O Sinthoma (1975-1976)**. Tradução de Antonio Quinet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

LAJONQUIÈRE, Leandro de. **Infância e ilusão (psico)pedagógica**: escritos de psicanálise e educação. São Paulo: Vozes, 1999.

LAJONQUIÈRE, Leandro de. **Psicopedagogia, psicanálise e educação**: uma aula introdutória. Psicopedagogia em Revista, 1997.

LANDMAN, Karina. **Ouvir as crianças em vez das sereias do cientificismo**. In: CARNEIRO, Cristiana; PONNOU, Sébastien (orgs.). Escutar crianças e adolescentes hiperativos [recurso eletrônico]: aposta da psicanálise. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2024. p. 118-135. 1 recurso eletrônico (259 p.); digital.

LARROSA, Jorge. **O ofício de professor**: condição e paixão docente. Tradução de João Wanderley Geraldi. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

LIBOWITZ, M. R.; NURMI, E. L. **The burden of antipsychotic-induced weight gain**

and metabolic syndrome in children. *Frontiers in Psychiatry*, [s.l.], v. 12, p. 275, 2021.

LIMA, Alcimar Alves de Souza; ROVAL, Esméria. **Escola, espaço de subjetivação: de Freud a Morin.** São Paulo: Editora Blucher, abril de 2022. e-Book. ISBN 9786555061017.

LIMA, Eliane Gonçalves de. **Medicalização na infância: um carimbo que implica na subjetividade da criança.** 2022. 95 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Inhumas, Inhumas, 2022.

LIMA, Rossano Cabral. **Medicalização e farmacologização: constâncias, deslocamentos e efeitos sobre a vida: diagnósticos e psicofármacos na infância e adolescência: usos e abusos.** In: CECCIM, Ricardo Burg et al (org.). *Fármacos, remédios, medicamentos: o que a Educação tem com isso?: fármacos, remédios, medicdebates continuados, diálogos interdisciplinares.* Poa: Rede Unida, 2022. p. 48-61.

LIMA, Rossano Cabral. **Somos todos desatentos: o tda/h e a construção de bioidentidades.** Rio de Janeiro: Dumara, 2005.

MACEDO, Lino de. **Ensaio construtivistas.** São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.

MANNONI, M. **Educação Impossível.** Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988.

MARCELLO, Fabiana de Amorim; SOARES, Gisele Rodrigues. **Sobre o uso de imagens na pesquisa com crianças: foto-elicitación e outras metodologias no panorama investigativo brasileiro.** *Práxis Educativa*, Ponta Grossa, v. 16, e2118030, p. 1-18, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.16.18030.063>. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/18030>. Acesso em: 16 fev. 2026.

MAZON, Márcia da Silva; BIANCHI, Eugênia. **Viver e conviver com a infância sem tratá-la como um problema.** *Revista Cult*, São Paulo, 5 jan. 2026. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/viver-e-conviver-com-infancia-sem-trata-la-como-um-problema/>. Acesso em: 2 mar. 2026.

MEIRA, Ana Marta. **A cultura do brincar: infância contemporânea, o brincar e a cultura no espaço e na cidade.** Porto Alegre: UFRGS, 2004.

MORIN, Edgar; CIURANA, Emilio-Roger; MOTTA, Raúl Domingo. **Educar na era planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem no erro e na incerteza humana.** Paris: Editions Balland, 2003.

MOSCHEN, Simone Zanon; VASQUES, Carla K.; FRÖHLICH, Cláudia Bechara. **Psicanálise, educação especial e formação de professores: construções em rasuras.** In: VASQUES, Carla K.; MOSCHEN, Simone Zanon (orgs.). *Psicanálise, educação especial e formação de professores: construções em rasuras.* São Paulo: Vozes, 2017. p. 11-28.

MOURA, Ana Karina Barbosa; GALLUCCI, Bruna D'Arezzo Pessente; RIBAS, Maria Fernanda Assis; CAMPOS, Érico Bruno Viana. **Medicalização da infância e psicanálise: o caso TDAH**. Semina: Ciências Sociais e Humanas, [S. l.], v. 41, n. 1, p. 5–18, 2020. DOI: 10.5433/1679-0383.2020v41n1p5. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc/article/view/38050>. Acesso em: 11 set. 2025.

MOYSES, Maria Aparecida Affonso. **A institucionalização invisível: crianças que não aprendem na escola**. Mercado de Letras, 2001.

MOYSÉS, Maria Aparecida Affonso; COLLARES, Cecília Azevedo Lima. **Vidas de crianças e adolescentes comprometidas pelos processos de patologização**. Revista Cult, São Paulo, jan. 2026. Disponível em: Acessar artigo. Acesso em: 2 mar. 2026.

MOYSÉS, Maria Aparecida; COLLARES, Cecília Azevedo Lima. **Produção do fracasso escolar e medicalização da infância e da escola**. In: VASQUES, Carla K. e MOSCHEN, SIMONE ZANON (ORG.). Psicanálise, educação especial e formação de professores: construções em rasuras. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017. p. 43-64. Acesso em 04 nov. 2024. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/173125/001061567.pdf?sequence=1#page=43>

MOYSÉS, Maria Aparecida; COLLARES, Cecília. **Produção do fracasso escolar e medicalização da infância e da escola**. Psicanálise, educação especial e formação de professores: construções em rasuras, p. 61-103, 2015.

NARODOWSKI, Mariano. **Infância e poder: a conformação da pedagogia moderna**. 1993. Tese de Doutorado. [sn].

OLIVEIRA, Adriana Cristina Gomes. **Medicalização e patologização da/na primeira infância: conversas sobre práticas pedagógicas não medicalizantes**. 2022. 121 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Convenção sobre os direitos da criança**. 1989. Disponível em: <https://www.ohchr.org/pt/professionalinterest/pages/crc.aspx>. Acesso em: 10 jun. 2024.

ORTEGA, F; BARROS, D; CALIMAN, L; ITABORAHY, C; JUNQUEIRA, L; FERREIRA, C. **A ritalina no Brasil: produções, discursos e práticas**. Interface (Botucatu). 2010; 14(34):499-510.

PATTO, Maria Helena Souza. **A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia**. Organizado por Maria Helena Souza Patto. São Paulo: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 2022. Acesso em: 3 jul. 2024. Disponível em: [file:///C:/Users/Elis/Downloads/Ebook_A_Produção do Fracasso Escolar MHSPatt_agenciaaquia_OK.pdf](file:///C:/Users/Elis/Downloads/Ebook_A_Produção_do_Fracasso_Escolar_MHSPatt_agenciaaquia_OK.pdf).

PONNOU, Sébastien. **Impasses das abordagens biomédicas, necessidade da**

psicanálise: o caso do TDA/H. In: CARNEIRO, Cristiana; PONNOU, Sébastien (orgs.). Escutar crianças e adolescentes hiperativos [recurso eletrônico]: aposta da psicanálise. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2024. p. 15-49. 1 recurso eletrônico (259 p.); digital.

PRIBERAM. **Dicionário Priberam de Português.** Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/>. Acesso em: 03 dez. 2024.

RABELLO DE CASTRO, Lucia, et al. **A infância e os processos de reprodução social no capitalismo global:** Em defesa do recreio escolar. 2025. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/scielopreprints.11908>>.

RAMOS, Rita de Cássia; FALCADE, Paulo Rodrigo Unzer; ALBINO, Araceli. **O enigma do desejo:** uma interface entre psicanálise e literatura. Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social, Uberaba, v. 9, n. 2, p. 463-471, abr./jun. 2021. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/4979/497969633011/html/>. Acesso em: 15 fev. 2026.

RECHIA, Karen Christine; LARROSA, Jorge. (Profissão) Ofício de Professor. **Sobre Tudo**, v. 10, n. 1, p. 23-23, 2019.

RESENDE, Rafaella Oliveira. **Representações sociais dos professores sobre o fenômeno da medicalização nas escolas.** 2021. 170 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Jataí, Jataí, 2021.

RIGO, Neusete Machado. **Inclusão escolar:** um olhar sobre as formas de conviver com o outro. ETD Educação Temática Digital, v. 21, n. 2, p. 495-512, 2019.

RODRIGUES, R., & REIS, M. (2018). **A ilusão (psico)pedagógica e o empobrecimento das experiências educativas (entrevista a Leandro de Lajonquière).** Estilos Da Clínica, 23(2), 430–450. <https://doi.org/10.11606/issn.1981-1624.v23i2p430-450>

SAFATLE, Vladimir; DA SILVA JÚNIOR, Nelson; DUNKER, Christian. **Patologias do social:** arqueologias do sofrimento psíquico. Autêntica, 2018.

SANTOS, Boaventura de Sousa; SANTIAGO, Maria Paula. **Desobediência epistêmica.** In: O direito à diferença: crítica da globalização e da modernidade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2016. p. 737-751.

SANTOS, Solange Estanislau dos; DOS ANJOS, Cleriston Izidro dos; FARIA, Ana Lúcia Goulart de. **A criança das pesquisas, a criança nas pesquisas... A criança faz pesquisa?** Práxis Educacional, v. 13, n. 25, p. 158, abr. 2017. DOI: 10.22481/praxis.v13i25.958. Licença: CC BY-SA 4.0.

SARMENTO, Manuel Jacinto. **A reinvenção do ofício de criança e de aluno.** Atos de pesquisa em educação, v. 6, n. 3, p. 581-602, 2011. Acesso em: 15 jan. 2024. Disponível em: <http://gorila.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/2819>

SARMENTO, Manuel Jacinto. **As culturas da infância nas encruzilhadas da 2a**

modernidade. Crianças e miúdos: perspectivas sócio-pedagógicas da infância e educação. Porto: Asa, p. 9-34, 2004. Acesso em: 15 mai. 2024. Disponível em: <http://sqmd.nute.ufsc.br/content/especializacao-cultura-digital/educacao-infantil/medias/files/culturas.pdf>.

SARMENTO, Manuel Jacinto. **Gerações e alteridade:** interrogações a partir da sociologia da infância. In: Dossiê: Sociologia da infância: pesquisas com crianças. Educação e Sociedade, Campinas, v. 26, n. 91, p. 361-380, ago. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302005000200003>. Acesso em: 3 dez. 2024.

SARMENTO, Manuel Jacinto. **Infância, exclusão social e educação como utopia realizável.** Educação & Sociedade, v. 23, n. 78, p. 265-283, 2002. Acesso em: jan/2024. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302002000200015&script=sci_abstract&tlng=pt

SARMENTO, Manuel Jacinto. **Radicalização da infância na segunda modernidade:** Para uma Sociologia da Infância. Configurações, n. 4, p. 23–39, 2008. Disponível em: <https://journals.openedition.org/configuracoes/543>. Acesso em: 21 out. 2024.

SARMENTO, Manuel Jacinto. **Uma agenda crítica para os estudos da criança.** Currículo sem Fronteiras, v. 15, n. 1, p. 31-49, jan./abr. 2015. ISSN 1645-1384 (online). Disponível em: <www.curriculosemfronteiras.org>. Acesso em: 17 jun. 2024.

SARMENTO, Manuel Jacinto; CERISARA, Ana Beatriz. **Crianças e miúdos:** perspectivas sociopedagógicas da infância e educação. 2004.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** Cortez editora, 2017.

SILVA, K. C. D. S.; ANGELUCCI, C. B. (2018). **A lógica medicalizante nas políticas públicas de educação.** Revista Educação Especial, 31(62), 683. <https://doi.org/10.5902/1984686x29132>

SOUSA, José Roberto de; SANTOS, Simone Cabral Marinho dos. **Análise de conteúdo em pesquisa qualitativa.** Research, Society and Development, Vargem Grande Paulista, v. 9, n. 6, p. e104963288, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/RPDE/article/view/31559/22049>. Acesso em: 15 fev. 2026.

STAKE, R. E. **Pesquisa Qualitativa:** estudando como as coisas funcionam. Porto Alegre: Artmed, 2011.

TIMIMI, Sami. **“Parece-me que houve um estreitamento do que consideramos uma trajetória de desenvolvimento infantil ‘normal’.** Isso ocorre ao mesmo tempo que se estreitam as formas aceitáveis de atuação dos pais”. [Entrevista concedida a] Sandra Caponi e Diogo Boccardi. Revista Cult, São Paulo, 5 jan. 2026. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/parece-me-que-houve-um-estreitamento-do-que-consideramos-uma-trajetoria-de-desenvolvimento-infantil-normal-isso-ocorre-ao-mesmo-tempo-que-se-estreitam-as-formas-aceitaveis/>. Acesso em: 15 fev. 2026.

TOASSI, Ramona Fernanda Ceriotti (Org.). **Interprofissionalidade e formação na**

saúde: onde estamos? 1. ed. Porto Alegre: Rede UNIDA, 2017. p. : il. (Série Vivência em Educação na Saúde).

TOMÁS, Débora Nogueira. **O trato com a queixa escolar na educação infantil em um sistema municipal de ensino:** uma análise histórico-cultural. 2022. Tese (Doutorado em Educação Escolar) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Araraquara, 2022. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/d73332cb-cda1-45f1-8093-ce805ea232d3/content>. Acesso em: 15 fev. 2026.

TREVISAN, Gabriela. **Infância, espaço público e participação:** a abordagem do território de aprendizagem. 2022.

UNICEF et al. **Enfrentamento da cultura do fracasso escolar:** Reprovação, abandono e distorção idade-série. Brasília (DF): Escritório da Representação do UNICEF no Brasil, 2021.

VOLTOLINI, R. (2019). **A insustentável leveza da escola.** Estilos Da Clínica, 24(3), 380–383. <https://doi.org/10.11606/issn.1981-1624.v24i3p380-383>

VOLTOLINI, Rinaldo. **Crianças fora-de-série:** psicanálise e educação inclusiva. 2021. Tese (Livre-Docência) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

VORCARO, A. **O efeito bumerangue da classificação psicopatológica da infância.** In: JERUSALINSKY, A.; FENDRIK, S. (org.). O Livro Negro da psicopatologia contemporânea. São Paulo: Via Lettera, 2011. p. 219-230.

VORCARO, Angela. **Da holófrase e seus destinos.** Crianças na psicanálise: clínica, instituição, laço social, p. 19-58, 1999.

VORCARO, Angela; VERAS, Viviane. **O brincar como operação de escrita.** Estudos Semióticos, São Paulo, v. 13, n. 24, p. 24-39, 2008. DOI: 10.11606/issn.1981-1624.v13i24p24-39.

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. **A formação social da mente:** o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Tradução de Maria Teresa de Souza. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

WATZLAWICK, P. (1994). **Profecias que se autocumprem.** In P. Watzlawick (Org.), A realidade inventada (pp. 97–116). Campinas: Editorial Psy II.

WERLE, Kelly; BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro. **Protagonismo Infantil, desafios éticos e metodológicos na pesquisa com crianças.** Cadernos de Pesquisa, v. 23, p. 227-242, 2017. Acesso em 31 jan. 2024. Disponível em: <file:///D:/Users/Usuario/Downloads/6216-19056-1-PB.pdf>

WESTBROOK, A. et al. **Dopamine promotes cognitive effort by biasing the benefits versus costs of cognitive work.** Science (New York, N.Y.), v. 367, n. 6484, p. 1362–1366, 2020. Acesso em 15/01/2026. Disponível em:

<https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaz5891>

WHITAKER, Robert. **Anatomia de uma epidemia**: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o aumento assombroso da doença mental. Tradução de Sérgio de Souza. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2017.

WINNICOTT, D. W. (1975). **O brincar e a realidade**. Trad. José Octavio de Aguiar Abreu e Vanede Nobre. Rio de Janeiro: Imago.

WINNICOTT, D. W. (1990). **Natureza humana**. Trad. David Litman Bogomoletz. Rio de Janeiro: Imago.

WINNICOTT, Donald W (1983). **O cuidado materno e a formação do eu**. São Paulo: Martins Fontes.

WINNICOTT, Donald. (1975) **O uso do objeto e a função do objeto no desenvolvimento emocional**. Tradução de Maria Lucia Palladino. São Paulo: Martins Fontes, 1975.

WINNICOTT, Donald. **A criança e o seu mundo**. Tradução de Maria Lucia Palladino. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. (Original publicado em 1971).

YIN, ROBERT K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Robert K. Yin. Trad. Daniel, 2001.

ZORZANELLI, Rafaela Teixeira; ORTEGA, Francisco; BEZERRA JÚNIOR, Benilton. **Um panorama sobre as variações em torno do conceito de medicalização entre 1950-2010**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, p. 1859-1868, 2014. Acesso em: 29 jan. 2024. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-81232014000601859&lng=pt&nrm=isso.

APÊNDICES

APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE (Familiares e/ou Responsáveis)

Olá, gostaria de convidar você e seu filho para participar desta pesquisa. Vou ler este documento que se refere-se a pesquisa “A escuta da criança nos processos de Medicalização na Aprendizagem”, realizada pela pesquisadora Elisangela Reinheimer de Bittencourt, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEDU UFRGS) com orientação do Professor Doutor Elisandro Rodrigues. Este projeto de pesquisa almeja a escuta da criança nos processos medicalizantes associados a problemas escolares em uma cidade situada na região metropolitana de Porto Alegre/RS.

Como possíveis riscos desta pesquisa, destaca-se o aspecto emocional, uma vez que o processo de escuta pode suscitar reflexões ou abrir questões que despertem emoções intensas ou desconfortos. Além disso, há o risco de desconforto social, visto que o compartilhamento de informações em um ambiente diferente pode gerar sensação de exposição ou desconforto nos participantes. Como prevenção dos riscos e possíveis desconfortos durante a participação da pesquisa, adotaremos uma escuta sensível e atenta às singularidades de cada participantes. Dessa forma, pretendemos realizar uma escuta acolhedora, reconhecendo os relatos de forma empática, evitando qualquer tipo de julgamentos e respeitando os limites emocionais de cada participante. Além disso, é importante prever alternativas para atenuar eventuais incômodos ao longo da pesquisa, como a possibilidade de pausas, a oferta de acompanhamento psicológico, quando necessário, e o encaminhamento a redes de apoio. Dessa forma, busca-se garantir um ambiente ético, cuidadoso e acolhedor durante todo o processo investigativo, tais estratégias integram o compromisso com a proteção integral dos sujeitos da pesquisa, conforme preconizado pelas diretrizes éticas aplicáveis à pesquisa com seres humanos.

Por outro lado, os benefícios incluem a valorização da subjetividade, com a criação de um espaço seguro e acolhedor para que as crianças expressem seus sentimentos e percepções. O destaque à fala da criança permite que a pesquisa contribua tanto para práticas educativas quanto para a vida de outras crianças. A

garantia de confidencialidade é outro ponto positivo, assegurando sigilo e privacidade aos participantes e proporcionando um ambiente de confiança.

A pesquisa também prevê suporte emocional, disponibilizado por uma equipe multidisciplinar para atender a possíveis intercorrências emocionais. O direito à interrupção será respeitado integralmente, permitindo que a criança possa encerrar sua participação a qualquer momento, caso não se sinta confortável. Outro benefício é o uso de uma linguagem acessível e facilitadora, adaptada para que as crianças compreendam melhor seus próprios sentimentos e as interações no contexto da pesquisa. Além disso, os resultados serão compartilhados de maneira transparente, priorizando respeito, ética e sigilo. Por fim, não haverá custos ou pagamentos aos participantes. Para minimizar transtornos logísticos, os horários serão flexíveis, de modo a não interferir nas atividades escolares das crianças ou laborais dos adultos participantes da pesquisa.

A pesquisa será realizada na sede do Núcleo de Atendimento Especializado em Aprendizagem (NAE), situado na rua Emílio Jost, 387, Centro de Nova Hartz. Com os familiares e/ou responsáveis será aplicado um questionário sociodemográfico e entrevista em 1 encontro, com duração de 1 hora.

Os encontros com as crianças terão duração de 1 hora. Estão previstos 3 encontros com a criança, que terão: apresentação da pesquisa, Termo de Assentimento; hora lúdica; questionário semiestruturado; diálogos e momento de finalização da pesquisa com a criança.

Como participantes deste estudo, pretendemos selecionar um grupo de quatro crianças, com seus respectivos familiares e/ou responsáveis, que tenham problemas escolares como questões de aprendizagem e/ou queixas de comportamento escolar considerado inadequado. Essa seleção será feita em conjunto com a equipe do Núcleo de Atendimento Especializado em Aprendizagem (NAE) e se dará a partir destes critérios de inclusão:

- Possuam algum tipo de diagnóstico; ou estão em investigação;
- Tenham idade entre 6 e 12 anos;
- Apresentem queixas escolares quanto ao comportamento e/ou dificuldades de aprendizagem;

A partir disso, será feito um quadro descrevendo os participantes do estudo com as informações pertinentes, como por exemplo, idade, composição familiar, dificuldades escolares, encaminhamentos, laudos, pareceres, tipo de medicação,

dosagem e tempo de uso, característica sociodemográfica familiar e série escolar. A partir da seleção de participantes, a pesquisa será desenvolvida em três encontros com as crianças e um com pais e profissionais da educação.

Pretendemos realizar com as crianças momentos lúdicos e compostos por contação de histórias, desenhos, diálogos livres e brincadeiras, bem como entrevistas sobre suas experiências e percepções. A coleta de dados com a criança será desenvolvida gradualmente ao longo dos encontros, não se restringindo apenas à entrevista semiestruturada. Além disso, são planejadas entrevistas com os responsáveis pelas crianças e seus educadores.

Para auxiliar nesse processo, temos a intenção de preencher o caderno de diário de campo, que será utilizado como recurso de anotações e registros dos procedimentos, gravação de áudio e análise documental, incluindo pareceres escolares, encaminhamentos, laudos médicos, entre outros. Com a criança também será reservado o encontro para a hora lúdica, composta por brincadeira, diálogos, hora do conto, desenhos livres, entre outros. Com as famílias pretende-se aplicar o questionário sociodemográfico, para apresentar o contexto e os participantes, e ficha de entrevista.

Para garantir que as crianças tenham voz ativa na pesquisa, é fundamental proporcionar recursos expressivos adequados ao seu universo cultural. Ao explorar linguagens como o movimento, a brincadeira, o desenho, a fala e a escrita, buscamos criar um ambiente onde as crianças se sintam à vontade para expressar suas percepções e vivências. A criança também terá um termo de assentimento, explicitando se concorda ou não em participar da pesquisa. Ela poderá interromper sua participação em qualquer momento. Caso isso ocorra, será realizado o devido encaminhamento psicológico com equipe multidisciplinar. Havendo algum dano decorrente da pesquisa, o participante terá direito a assistência e a buscar indenização pelo dano decorrente da participação na pesquisa conforme legislações brasileiras e, de acordo com, Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016.

De acordo com esse processo, assumo com você os seguintes compromissos:

1. Você está ciente dos objetivos e procedimentos da pesquisa e pode manifestar seu interesse em participar de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida.

2. Sua identidade, assim como as identidades de todos(as) os(as) participantes serão mantidas em sigilo. Nenhuma pessoa será identificada, sendo preservado o anonimato em quaisquer momentos de divulgação desta pesquisa.

3. As informações reunidas serão usadas unicamente para fins de pesquisa e de trabalhos científicos que dela poderão se desdobrar. As entrevistas estarão sob guarda dos pesquisadores por um período de 5 anos; após esse tempo, serão destruídas, conforme o preconizado pela Resolução 466/12.

4. Os resultados lhe serão apresentados, pois esse retorno permitirá que você tome ciência das informações produzidas durante a pesquisa, assim como assegurará que tais informações não serão utilizadas em prejuízo ou para a estigmatização de nenhum(a) dos(as) envolvidos(as).

5. Caso você possua interesse em desistir de colaborar com a pesquisa, isso poderá ser feito em qualquer fase, sem penalização alguma.

6. Você pode solicitar informações a qualquer momento sobre os procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa, com Elisangela Reinheimer de Bittencourt, no endereço: Rua Euclides João Alff de Campos, 316, Vila Nova, Nova Hartz/RS, CEP 93890-000, pelo e-mail e.reinheimer16@gmail.com ou telefone: (51) 997661615 e com o Professor Orientador da Pesquisa Elisandro Rodrigues, no endereço Avenida Francisco Trein, 326, Bairro Cristo Redentor/Porto Alegre, CEP 90420-150 ou por e-mail relisandro@ghc.com.br ou telefone: (51) 3357-2806.

7. Também que, se houver dúvidas quanto a questões éticas, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que está localizado na Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Telefone/WhatsApp do CEP/UFRGS (51) 3308- 3787. E-mail: etica@propesq.ufrgs.br. Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h.

8. Você não terá nenhum tipo de despesa como participante do estudo, bem como não há remuneração para a participação.

9. Ao final da análise será encaminhado via e-mail às transcrições das entrevistas assim como o texto final para análise, revisão e concordância com as informações.

10. Você receberá duas vias deste Termo para assinaturas onde ambas as vias deverão ser assinadas assim como todas as páginas rubricadas. Uma delas ficará sob seu poder, e a outra será entregue ao pesquisador.

Essa é uma pesquisa acadêmica sem finalidade comercial ou publicitária. Na publicação dos resultados dessa pesquisa, garantimos o sigilo das suas informações e dos seus dados pessoais conforme legislações vigentes da CONEP, como a Resolução 466/2012 e Resolução 510/2016 e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13709/2018).

Solicitamos, dessa forma, o consentimento para autorização de gravação e/ou divulgação da imagem e/ou voz, do familiar e/ou responsável, bem como da criança participante do estudo.

- () Autorizo a gravação e/ou divulgação da minha imagem e/ou voz e da criança.
- () Não autorizo a gravação e/ou divulgação da minha imagem e/ou voz e da criança.
- () Autorizo a gravação mas não a divulgação de minha imagem e/ou voz e da criança.

Eu, _____, recebi as informações sobre os objetivos e a importância desta pesquisa de forma clara e concordo em participar do estudo voluntariamente, tendo a liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar da pesquisa, sem que isto traga prejuízo para a minha vida pessoal e nem para minha atuação profissional. Declaro que recebi uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando outra via com o pesquisador.

Nova Hartz, _____ de _____, de 202__.

Assinatura do pesquisador responsável
Elisandro Rodrigues

Assinatura da pesquisadora assistente
Elisangela Reinheimer de Bittencourt

Assinatura do(a) participante de pesquisa

APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE (Profissionais)

Olá, gostaria de convidar você para participar desta pesquisa, que se refere ao processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança que você acompanha. Vou ler este documento que se refere-se a pesquisa “A escuta da criança nos processos de Medicalização na Aprendizagem”, realizada pela pesquisadora Elisangela Reinheimer de Bittencourt, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEDU UFRGS) com orientação do Professor Doutor Elisandro Rodrigues. Este projeto de pesquisa almeja a escuta da criança nos processos medicalizantes associados a problemas escolares em uma cidade situada na região metropolitana de Porto Alegre/RS.

Como possíveis riscos desta pesquisa, destaca-se o aspecto emocional, uma vez que o processo de escuta pode suscitar reflexões ou abrir questões que despertem emoções intensas ou desconfortos. Além disso, há o risco de desconforto social, visto que o compartilhamento de informações em um ambiente diferente pode gerar sensação de exposição ou desconforto nos participantes. Como prevenção dos riscos e possíveis desconfortos durante a participação da pesquisa, adotaremos uma escuta sensível e atenta às singularidades de cada participantes. Dessa forma, pretendemos realizar uma escuta acolhedora, reconhecendo os relatos de forma empática, evitando qualquer tipo de julgamentos e respeitando os limites emocionais de cada participante. Além disso, é importante prever alternativas para atenuar eventuais incômodos ao longo da pesquisa, como a possibilidade de pausas, a oferta de acompanhamento psicológico, quando necessário, e o encaminhamento a redes de apoio. Dessa forma, busca-se garantir um ambiente ético, cuidadoso e acolhedor durante todo o processo investigativo, tais estratégias integram o compromisso com a proteção integral dos sujeitos da pesquisa, conforme preconizado pelas diretrizes éticas aplicáveis à pesquisa com seres humanos.

Por outro lado, os benefícios incluem a valorização da subjetividade, com a criação de um espaço seguro e acolhedor para que as crianças expressem seus sentimentos e percepções. O destaque à fala da criança permite que a pesquisa contribua tanto para práticas educativas quanto para a vida de outras crianças. A garantia de confidencialidade é outro ponto positivo, assegurando sigilo e privacidade aos participantes e proporcionando um ambiente de confiança.

A pesquisa também prevê suporte emocional, disponibilizado por uma equipe multidisciplinar para atender a possíveis intercorrências emocionais. O direito à interrupção será respeitado integralmente, permitindo que a criança possa encerrar sua participação a qualquer momento, caso não se sinta confortável. Outro benefício é o uso de uma linguagem acessível e facilitadora, adaptada para que as crianças compreendam melhor seus próprios sentimentos e as interações no contexto da pesquisa. Além disso, os resultados serão compartilhados de maneira transparente, priorizando respeito, ética e sigilo. Por fim, não haverá custos ou pagamentos aos participantes. Para minimizar transtornos logísticos, os horários serão flexíveis, de modo a não interferir nas atividades escolares das crianças ou laborais dos adultos participantes da pesquisa.

A pesquisa será realizada na sede do Núcleo de Atendimento Especializado em Aprendizagem (NAE), situado na rua Emílio Jost, 387, Centro de Nova Hartz. Os encontros com os profissionais terão duração de 1 hora. Estão previstos 1 encontro que será aplicado entrevista semiestruturada e diálogo.

Como participantes deste estudo, pretendemos selecionar um grupo de quatro crianças, com seus respectivos familiares e/ou responsáveis e profissionais. O principal critério de participação será dificuldades escolares como questões de aprendizagem e/ou queixas de comportamento escolar considerado inadequado. Essa seleção será feita em conjunto com a equipe do Núcleo de Atendimento Especializado em Aprendizagem (NAE) e se dará a partir destes critérios de inclusão:

- Possuam algum tipo de diagnóstico ou estão em investigação;
- Tenham idade entre 6 e 12 anos;
- Apresentem queixas escolares quanto ao comportamento e/ou dificuldades de aprendizagem;

A partir disso, será feito um quadro descrevendo os participantes do estudo com as informações pertinentes, como por exemplo, idade, composição familiar, dificuldades escolares, encaminhamentos, laudos, pareceres, tipo de medicação, dosagem e tempo de uso, característica sociodemográfica familiar e série escolar. A partir da seleção de participantes, a pesquisa será desenvolvida em três encontros com as crianças e um com pais e profissionais da educação.

Pretendemos realizar com as crianças momentos lúdicos e compostos por contação de histórias, desenhos, diálogos livres e brincadeiras, bem como entrevistas sobre suas experiências e percepções. A coleta de dados com a criança será

desenvolvida gradualmente ao longo dos encontros, não se restringindo apenas à entrevista semiestruturada. Além disso, são planejadas entrevistas com os responsáveis pelas crianças e seus educadores.

Para auxiliar nesse processo, temos a intenção de preencher o caderno de diário de campo, que será utilizado como recurso de anotações e registros dos procedimentos, gravação de áudio e análise documental, incluindo pareceres escolares, encaminhamentos, laudos médicos, entre outros. Com a criança também será reservado o encontro para a hora lúdica, composta por brincadeira, diálogos, hora do conto, desenhos livres, entre outros. Com as famílias pretende-se aplicar o questionário sociodemográfico, para apresentar o contexto e os participantes, e ficha de entrevista.

Para garantir que as crianças tenham voz ativa na pesquisa, é fundamental proporcionar recursos expressivos adequados ao seu universo cultural. Ao explorar linguagens como o movimento, a brincadeira, o desenho, a fala e a escrita, buscamos criar um ambiente onde as crianças se sintam à vontade para expressar suas percepções e vivências. A criança também terá um termo de assentimento, explicitando se concorda ou não em participar da pesquisa. Ela poderá interromper sua participação em qualquer momento. Caso isso ocorra, será realizado o devido encaminhamento psicológico com equipe multidisciplinar. Havendo algum dano decorrente da pesquisa, o participante terá direito a assistência e a buscar indenização pelo dano decorrente da participação na pesquisa conforme legislações brasileiras e, de acordo com, Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016.

De acordo com esse processo, assumo com você os seguintes compromissos:

1. Você está ciente dos objetivos e procedimentos da pesquisa e pode manifestar seu interesse em participar de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida.

2. Sua identidade, assim como as identidades de todos(as) os(as) participantes serão mantidas em sigilo. Nenhuma pessoa será identificada, sendo preservado o anonimato em quaisquer momentos de divulgação desta pesquisa.

3. As informações reunidas serão usadas unicamente para fins de pesquisa e de trabalhos científicos que dela poderão se desdobrar. As entrevistas estarão sob guarda dos pesquisadores por um período de 5 anos; após esse tempo, serão destruídas, conforme o preconizado pela Resolução 466/12.

4. Os resultados lhe serão apresentados, pois esse retorno permitirá que você tome ciência das informações produzidas durante a pesquisa, assim como assegurará que tais informações não serão utilizadas em prejuízo ou para a estigmatização de nenhum(a) dos(as) envolvidos(as).

5. Caso você possua interesse em desistir de colaborar com a pesquisa, isso poderá ser feito em qualquer fase, sem penalização alguma.

6. Você pode solicitar informações a qualquer momento sobre os procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa, com Elisangela Reinheimer de Bittencourt, no endereço: Rua Euclides João Alff de Campos, 316, Vila Nova, Nova Hartz/RS, CEP 93890-000, pelo e-mail e.reinheimer16@gmail.com ou telefone: (51) 997661615 e com o Professor Orientador da Pesquisa Elisandro Rodrigues, no endereço Avenida Francisco Trein, 326, Bairro Cristo Redentor/Porto Alegre, CEP 90420-150 ou por e-mail relisandro@ghc.com.br ou telefone: (51) 3357-2806.

7. Também que, se houver dúvidas quanto a questões éticas, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que está localizado na Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Telefone/WhatsApp do CEP/UFRGS (51) 3308- 3787. E-mail: etica@propesq.ufrgs.br. Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h.

8. Você não terá nenhum tipo de despesa como participante do estudo, bem como não há remuneração para a participação.

9. Ao final da análise será encaminhado via e-mail às transcrições das entrevistas assim como o texto final para análise, revisão e concordância com as informações.

10. Você receberá duas vias deste Termo para assinaturas onde ambas as vias deverão ser assinadas assim como todas as páginas rubricadas. Uma delas ficará sob seu poder, e a outra será entregue ao pesquisador.

Essa é uma pesquisa acadêmica sem finalidade comercial ou publicitária. Na publicação dos resultados dessa pesquisa, garantimos o sigilo das suas informações e dos seus dados pessoais conforme legislações vigentes da CONEP, como a Resolução 466/2012 e Resolução 510/2016 e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13709/2018).

Solicitamos, dessa forma, o consentimento para autorização de gravação e/ou divulgação da imagem e/ou voz.

() Autorizo a gravação e/ou divulgação da minha imagem e/ou voz.

() Não autorizo a gravação e/ou divulgação da minha imagem e/ou voz.

() Autorizo a gravação mas não a divulgação de minha imagem e/ou voz.

Eu, _____,
recebi as informações sobre os objetivos e a importância desta pesquisa de forma clara e concordo em participar do estudo voluntariamente, tendo a liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar da pesquisa, sem que isto traga prejuízo para a minha vida pessoal e nem para minha atuação profissional. Declaro que recebi uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando outra via com o pesquisador.

Nova Hartz, _____ de _____, de 202__.

Assinatura do pesquisador responsável
Elisandro Rodrigues

Assinatura da pesquisadora assistente
Elisangela Reinheimer de Bittencourt

Assinatura do(a) participante de pesquisa

APÊNDICE 3 TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE (Crianças Maiores 9-12 Anos)

Título da Pesquisa: “A escuta da criança nos processos de Medicalização na Aprendizagem”.

Pesquisador responsável: Elisandro Rodrigues.

Pesquisadora assistente: Elisangela Reinheimer de Bittencourt
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Olá, meu nome é Elisangela, e estou realizando uma pesquisa e gostaria de convidar você para participar dela. Vou te explicar tudo e você poderá me dizer se quer participar.

Sua participação é muito importante, mas pode mexer com suas emoções e estaremos atentos a isso, de forma que lhe forneceremos o suporte necessário caso não se sinta bem. Essa pesquisa também vai ajudar na compreensão do seu processo escolar e de saúde e também irá auxiliar outras crianças no futuro. Como prevenção dos riscos e possíveis desconfortos durante a participação da pesquisa, adotaremos uma escuta sensível e atenta às singularidades de cada participantes.

A pesquisa será realizada na sede do Núcleo de Atendimento Especializado em Aprendizagem (NAE), situado na rua Emílio Jost, 387, Centro de Nova Hartz. Teremos 3 encontros em dias diferentes, cada um durante 1 hora, que terão: apresentação da pesquisa, Termo de Assentimento; hora lúdica; questionário semiestruturado; diálogos e momento de finalização da pesquisa com a criança.

Você poderá parar de participar quando quiser, se recusar ou suspender esse termo de assentimento a qualquer momento. E todas as tuas informações, como a tua identificação, ficarão em segredo. Você pode me perguntar qualquer coisa, sempre que tiver dúvidas. Se houver dúvidas quanto a questões éticas, você pode me dizer, ou seus familiares, e poderemos entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que está localizado na Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Telefone/WhatsApp do CEP/UFRGS (51) 3308- 3787. E-mail: etica@propesq.ufrgs.br. Pra falar comigo pode ser no Whatsapp (51)997661615, no e-mail e.reinheimer16@gmail.com, e me encontrar no endereço Rua Irmão Hartz, 185, sala 04, em Nova Hartz.

Você concorda em participar?

Assinatura ou Desenho do Participante:

Nova Hartz, _____ de _____, de 202__.

Assinatura do pesquisador responsável

Elisandro Rodrigues

Assinatura da pesquisadora assistente

Elisangela Reinheimer de Bittencourt

APÊNDICE 4 TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE
(Crianças Menores 6-9 Anos)

Título da Pesquisa: “A escuta da criança nos processos de Medicalização na Aprendizagem”.

Pesquisador responsável: Elisandro Rodrigues.

Pesquisadora assistente: Elisangela Reinheimer de Bittencourt
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Olá, meu nome é Elisangela, e estou realizando uma pesquisa e gostaria de convidar você para participar dela. Vou te explicar tudo e você poderá me dizer se quer participar.

Esta pesquisa busca escutar as crianças que têm dificuldades na escola, que estão indo ao médico por causa disso, fazendo exames e tomando remédios, com o objetivo de compreender e ajudar as crianças com dificuldades.

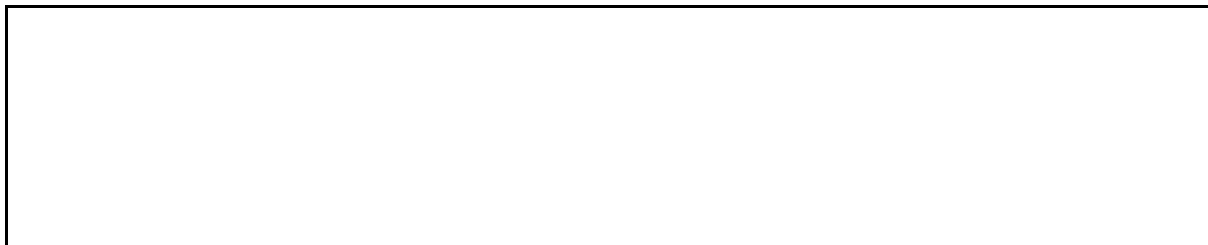
A pesquisa será realizada na sede do Núcleo de Atendimento Especializado em Aprendizagem (NAE), situado na rua Emílio Jost, 387, Centro de Nova Hartz. Teremos 3 encontros em dias diferentes, cada um durante 1 hora, que terão: apresentação da pesquisa, Termo de Assentimento; hora lúdica; questionário semiestruturado; diálogos e momento de finalização da pesquisa com a criança.

Sua participação é muito importante, mas pode mexer com suas emoções e estaremos atentos a isso, de forma que lhe forneceremos o suporte necessário caso não se sinta bem. Essa pesquisa também vai ajudar na compreensão do seu processo escolar e de saúde e também irá auxiliar outras crianças no futuro.

Você poderá parar de participar quando quiser, se recusar ou suspender esse termo de assentimento a qualquer momento. E todas as tuas informações, como a tua identificação, ficarão em segredo. Você pode me perguntar qualquer coisa, sempre que tiver dúvidas. Se houver dúvidas quanto a questões éticas, você pode me dizer, ou seus familiares, e poderemos entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que está localizado na Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Telefone/WhatsApp do CEP/UFRGS (51) 3308- 3787. E-mail: etica@propesq.ufrgs.br. Pra falar comigo pode ser no Whatsapp (51)997661615, no e-mail e.reinheimer16@gmail.com, e me encontrar no endereço Rua Irmão Hartz, 185, sala 04, em Nova Hartz.

Você concorda em participar?

Assinatura ou Desenho do Participante:



Nova Hartz, _____ de _____, de 202__.

Assinatura do pesquisador responsável

Elisandro Rodrigues

Assinatura da pesquisadora assistente

Elisangela Reinheimer de Bittencourt

APÊNDICE 5 - FICHA QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICOS E CONTEXTO DA FAMÍLIA

Informações da Criança:

- Nome fictício / Código participante:
- Data de nascimento:
- Idade:
- Série/ano escolar:
- Escola:

Composição Familiar:

- Número de pessoas que residem no mesmo domicílio:
- Relação de cada pessoa com a criança:
 - Nome fictício / Código participante:
 - Idade:
 - Grau de parentesco com a criança:

Educação e Trabalho dos Responsáveis:

- Qual o nível de escolaridade dos responsáveis?
 - () Ensino Fundamental Incompleto
 - () Ensino Fundamental Completo
 - () Ensino Médio Incompleto
 - () Ensino Médio Completo
 - () Ensino Superior Incompleto
 - () Ensino Superior Completo
 - () Pós-Graduação
- Os responsáveis estão inseridos no mercado de trabalho atualmente?
 - () Sim, ambos
 - () Sim, apenas um responsável
 - () Não
- Qual a profissão de cada responsável?
- Renda mensal aproximada da família:
 - () Até 1 salário mínimo
 - () 1 a 3 salários mínimos
 - () 3 a 5 salários mínimos
 - () Acima de 5 salários mínimos

Outras Informações:

- A família recebe algum tipo de benefício social?
() Sim () Não
- Se sim, qual?
- A criança já foi atendida por algum serviço de saúde mental?
() Sim () Não
- Se sim, qual serviço? (ex.: psicólogo, psiquiatra, CAPS, etc.)
- A criança participa de atividades extracurriculares? (ex.: esportes, música, etc.)
() Sim () Não
- Se sim, quais?

APÊNDICE 6: ENTREVISTA FAMILIAR

Diagnóstico:

- Como foi o processo de atendimento em saúde e educação para a criança?
- Foi dado algum diagnóstico para a criança?
- Se sim, qual a opinião da família sobre esse diagnóstico?
- Como foi construído esse diagnóstico?

Saúde e Medicamentos:

- A criança faz uso de medicação? () Sim () Não
- Se sim, qual(is) tipos de medicação(ões)? Qual tipo e dosagem?
- Há quanto tempo faz uso da medicação?
- Que profissional indicou a medicação? (Ex.: médico, psiquiatra, neurologista, outro):
- Qual o motivo para a prescrição dessa medicação?
- O que se esperava com o uso da medicação?
- O que percebem de diferente quando está ou não medicada?
- O que mudou desde o início da medicação?

Família e Escola:

- Como a família considera sua comunicação e sua relação com a escola da criança?
- Qual a opinião da família sobre o processo de aprendizagem da criança?
- Como é a sua relação com o(a) professor(a) da criança?
- Como a família percebe a relação da criança com a escola?
- Como a família percebe a relação da criança com o(a) professor(a)?

APÊNDICE 7: ENTREVISTA DA CRIANÇA

Criança e Família:

- O que sua família diz sobre seu jeito de aprender?
- Quem na sua casa te ajuda nas coisas da escola?
- Você tem alguma dificuldade em fazer as tarefas da escola em casa?
- Você e sua família conversam sobre isso?
- O que você e sua família fazem quando você está com dificuldade nas coisas da escola?
- Você acha que sua família entende quando você explica o que está sentindo?
- O que você gosta que sua família faz para te ajudar a aprender?
- Sua família conversa com você sobre suas tarefas ou dificuldades na escola?
- O que você gostaria que sua família soubesse sobre como você se sente?
- Como você se sente quando te ajudam em casa com as coisas da escola?

Criança e Escola:

- Como você se sente na sua escola?
- Você acha fácil ou difícil aprender as coisas na escola? Por quê?
- Como é a sua relação com o(a) professor(a)?
- Como é a sua relação com os colegas na escola?
- O que você mais gosta de fazer quando está na escola?
- O que você menos gosta de fazer quando está na escola?
- Quando é difícil aprender algo na escola, o que você faz?
- Você acha que seu jeito de aprender é diferente dos seus colegas? Por quê?
- Você acha que os professores ou colegas tratam você de forma diferente por causa disso?
- Quem te ajuda quando você está com dificuldades na escola?
- Você acha que os professores entendem quando você explica o que está sentindo?
- Como você se sente quando consegue fazer algo que achava difícil?
- Como você se sente quando não consegue fazer alguma tarefa da escola?
- Se você pudesse mudar algo na escola, o que seria?
- O que você gostaria que os professores soubessem sobre como você se sente?

- Como você se sente quando te ajudam na escola a aprender e fazer as coisas?

Criança e diagnóstico:

- O que lhe disseram sobre o que está acontecendo?
- Alguém lhe disse que você tinha alguma coisa?
- Como é para você quando alguém diz que você tem "dificuldades de aprendizagem"?
- Como é para você terem dito isso?
- Você concorda com isso?
- O que você gostaria que os profissionais de saúde soubessem sobre como você se sente?

Crianças e Medicamentos:

- Você toma alguma medicação/remédio todo dia?
- Você sabe por que precisa tomar esse remédio?
- Como você se sente sobre ter que tomar esse remédio?
- O que você sente quando toma o remédio?
- E se você não toma o remédio, como se sente?
- O que o médico contou para você sobre o remédio?
- E sua família, o que eles explicaram sobre por que você toma esse remédio?
- Como é na escola quando você toma o remédio?
- E como é quando você não toma o remédio na escola?
- O que as outras pessoas (amigos, colegas, professores) falam para você sobre tomar o remédio?

Encerramento:

- Você tem alguma dúvida ou algo que gostaria de me perguntar?
- Você gostaria de dizer mais alguma coisa que acha importante?

APÊNDICE 8: ENTREVISTA ESCOLAR

Informações Gerais

- Cargo/Função:
- Tempo de atuação na educação:
- Formação

Identificação de Dificuldades de Aprendizagem

- Quais as dificuldades você identificou na criança no espaço escolar?
- Essas dificuldades foram identificadas logo no início do processo de aprendizagem?

Diagnóstico e Patologização

- Você considera que as dificuldades de aprendizagem dela são tratadas com foco excessivo na patologização (diagnósticos médicos ou psicológicos)?
- Qual a sua percepção e opinião sobre o diagnóstico atribuído a criança?
- Você acredita que os alunos que recebem diagnósticos médicos e psicológicos têm o acompanhamento adequado educacional e de saúde?
- Qual sua percepção depois desse diagnóstico e/ou identificação de questões de saúde na criança?
- Se ela passou a tomar medicação, quais as diferenças que você percebeu na aprendizagem e nas relações dela?
- Você percebe algum tipo de sofrimento na criança?

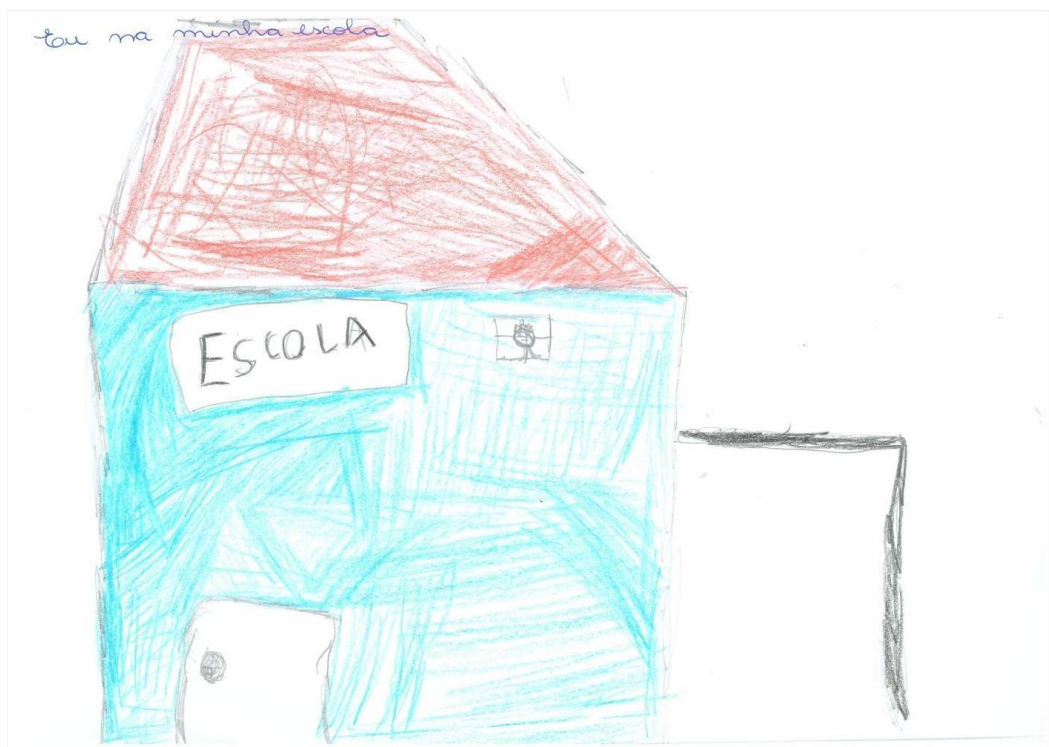
Apoio pedagógico

- Como é o trabalho pedagógico para os alunos com dificuldades de aprendizagem?
- Você sente que os professores têm suporte institucional suficiente para lidar com as dificuldades de aprendizagem e outros desafios que emergem no ambiente educacional?
- Como você percebe a adaptação da criança na escola?
- Como você percebe a participação da família no processo pedagógico?
- Como você percebe a relação da criança com os colegas?

APÊNDICE 9: FIGURAS DE FOTO ELICITAÇÃO





APÊNDICE 10: EU NA MINHA ESCOLA

Frank, 07/08-2025



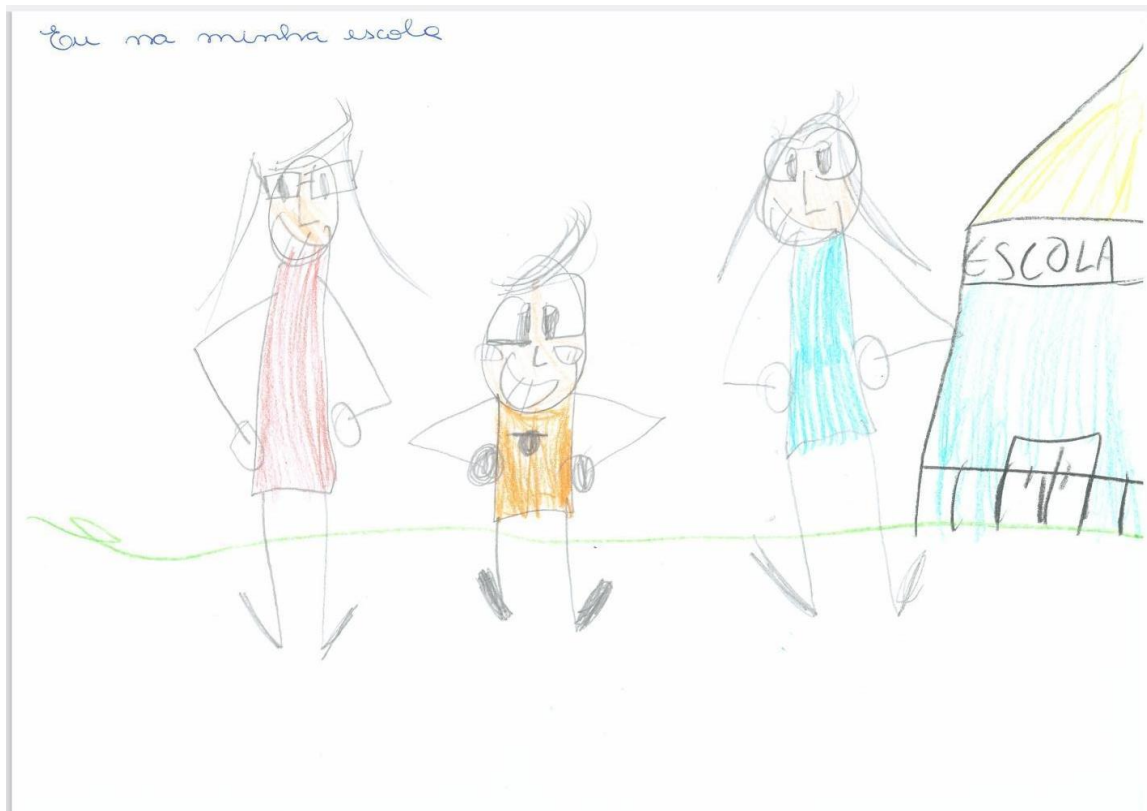
Jangles, 04/08/2025



Clow, 05/08/2025



Dave, 04/08/2025



Bing Bong, 07/08/2025



Riley, 07/10/2025